



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

LAPORAN KINERJA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2023

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Umum/Latar belakang	4
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	4
BAB II	5
GAMBARAN UMUM	5
2.1 Visi	5
2.2. Misi	5
2.3. Motto	5
2.4. 7 Nilai Budi Utama	5
2.5. SOTK	1
BAB III	2
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI	2
3.1 Sumber Daya Manusia	2
3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)	2
3.1.2 Orientasi	6
3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	8
3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf	11
3.2. Pengembangan Pelayanan	12
3.2.1. Analisa SWOT	12
3.2.2. Analisa Dan Mitigasi Risiko	15
3.2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Rumah Sakit	16
3.2.4. Analisa Situasi	16
3.2.6. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)	17
3.2.7. Indikator Kinerja	17
3.2.8. Rencana Pengembangan Pelayanan Medik	18
3.2.8. Rencana Pengembangan Pelayanan Medik	20
3.3. Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi	23
3.3.1. Penunjang	23
3.3.2 Pelayanan Medik	29
3.3.3. Umum	41
3.3.4. Program Nasional (PROGNAS)	49
3.4. Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3	66
3.4.1. Fasilitas Kesehatan	66

3.4.2. Gedung & bangunan	78
3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	80
3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional yang Tidak Di inginkan	91
3.5.3 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit yang Tidak Di inginkan	98
3.6. Kinerja Produktifitas Komite PPI	125
3.7 PKRS.....	146
3.7. Kinerja Produktifitas Tim PKRS	147
3.8. Kinerja Produktifitas Tim Geriatri	165
3.9 Kinerja Produktifitas KFT	166
3.10. Kinerja Produktifitas Tim Review RM.....	171
3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA	171
3.12. Kinerja Produktifitas Komite Keperawatan	176
3.13. Kinerja Produktifitas Komite Medis.....	177
3.14 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kes lain.....	184
BAB IV.....	185
KINERJA KEUANGAN.....	185
BAB V.....	193
KESIMPULAN DAN SARAN.....	193
1.1 Kesimpulan	193
1.2 Saran.....	193
BAB VI	194
PENUTUP	194

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum/Latar belakang

Sebuah Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2005 dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi, produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Salah satu jenis BLU diantaranya rumah sakit yang berperan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyebutkan dalam Pasal 996 bahwa Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Inilah yang menjadi dasar/landasan hukum dalam penyusunan Laporan Tahunan ini.

Laporan Tahunan berisi uraian yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sumber daya (sumber daya manusia, sarana prasarana dan dana), hasil kegiatan program pelayanan dan keuangan, pencapaian kinerja dan masalah, hambatan serta terobosan sebagai upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan program. Laporan Tahunan diharapkan bersifat analitik, interpretative, disertai saran dan tindak lanjut. Laporan tahunan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo disusun berdasarkan data dan masukan dari bagian/bidang dan instalasi-instalasi yang ada dilingkungan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.2. Dasar Hukum

Laporan Tahunan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tahun 2023 disusun berdasarkan :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Tahunan 2023 ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan secara tertulis upaya pengelolaan rumah sakit terhadap pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Disamping itu, laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana fleksibilitas pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Laporan tahunan RS Prima Husada Sukorejo tahun 2023 merupakan rangkuman dari proses pencapaian kinerja kegiatan dan anggaran di masing-masing unit kerja serta sebagai dasar perbaikan dan perencanaan pada waktu yang akan datang.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima Pilihan Seluruh Lapisan Masyarakat

2.2. Misi

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
- 2) Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
- 3) Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

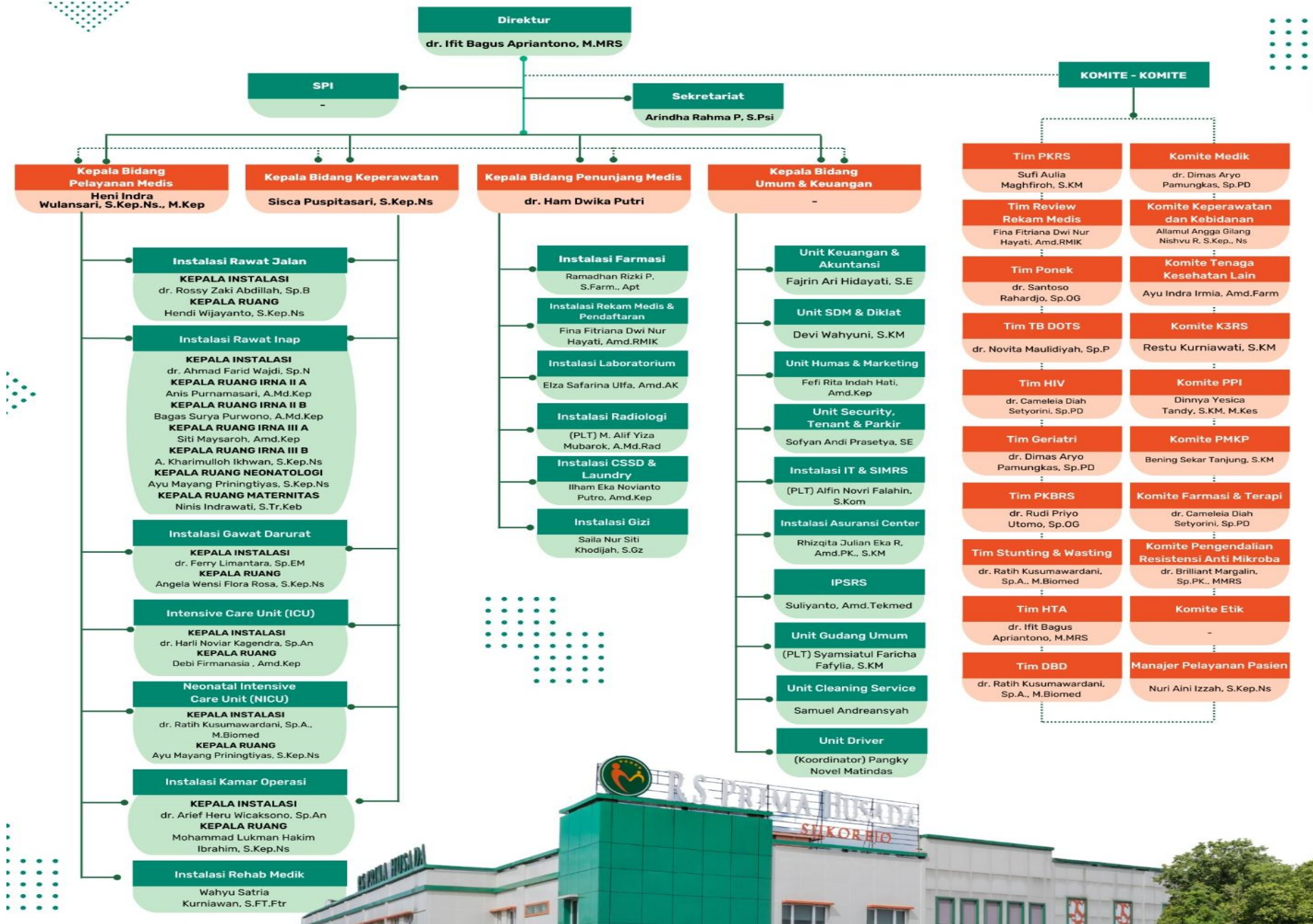
2.3. Motto

Motto kami adalah “**Sahabat Menuju Sehat**”, yang berarti berperan sebagai sahabat kepada pasien (sahabat) dalam memberikan pelayanan kesehatan. Menempatkan setiap pasien sebagai bagian keluarga, memposisikan diri kita sebagai pasien sehingga kami mengerti apa yang harus kami berikan kepada pasien

2.4. 7 Nilai Budi Utama

- 1) JUJUR
- 2) DIPERCAYA
- 3) TANGGUNG JAWAB
- 4) VISIONER
- 5) DISIPLIN
- 6) KERJASAMA
- 7) ADIL
- 8) PEDULI

2.5. SOTK



BAB III

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

3.1 Sumber Daya Manusia

3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)

Kebutuhan tenaga Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mempertimbangkan :

- a. Misi Rumah Sakit

b. Populasi Pasien yang Dilayani dan Kompleksitas serta Kebutuhan Pasien

c. Layanan Diagnostic dan Klinis yang Disediakan Rumah Sakit

d. Jumlah Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan

e. Peralatan Medis yang digunakan untuk Pelayanan Pasien

Berikut data ketenagaan di RS Prima Husada Sukorejo Tahun 2023 yang terhitung sampai 31 Desember 2023 dan yang telah terencana dari Surat Keputusan Mutasi PT. Disa Prima Medika serta perhitungan pola ketenagaan untuk Tahun 2024 yang telah terlaksana :

Tabel Pola Ketenagaan RS Prima Husada Sukorejo

No.	Unit	Kualifikasi	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan
1	Direktur	S2 Magister Kesehatan	1	1	0
2	Kabid Pelayanan Medis	S2 Magister Kesehatan	1	1	0
3	Kabid Keperawatan	S2 Magister Keperawatan	1	1	0
4	Kabid Penunjang Medis	S2 Magister Kesehatan	1	1	0
5	Kabid Umum & Keuangan	S2 Magister Keuangan	1	0	1
6	Ka Ins IRJA	S1 Kedokteran	1	1	0
7	Karu IRJA	Ners	1	1	0
8	Pelaksana Bidan IRJA	D3/S1 Kebidanan	4	3	1
9	Pelaksana Perawat IRJA	D3/S1 Keperawatan	21	18	3
10	Pelaksana NS IRJA	D3/S1 Keperawatan	2	2	0
11	Ka Ins IRNA	S1 Kedokteran	1	1	0
12	Karu IRNA II A	Ners	1	1	0
13	Pelaksana IRNA II A	D3/S1 Keperawatan	21	19	2
14	Karu IRNA II B	Ners	1	1	0
15	Pelaksana IRNA II B	D3/S1 Keperawatan	23	20	3
16	Karu IRNA III A	Ners	1	1	0
17	Pelaksana IRNA III A	D3/S1 Keperawatan	19	16	3
18	Karu IRNA III B	Ners	1	1	0
19	Pelaksana IRNA III B	D3/S1 Keperawatan	18	15	3
20	Ka Ins ICU	Spesialis Anesthesiologi	1	1	0
21	Karu ICU	Ners	1	1	0
22	Pelaksana ICU	D3/S1 Keperawatan	12	11	1
23	Ka Ins IKO	Spesialis Bedah/Anastesiologi	1	1	0
24	Karu IKO	D3/S1 Keperawatan	1	1	0
25	Perawat Anastesi IKO	D3/S1 Keperawatan	3	3	0



No.	Unit	Kualifikasi	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan
26	Perawat Instrument IKO	D3/S1 Keperawatan	5	5	0
27	Perawat Sirkuler IKO	D3/S1 Keperawatan	2	1	1
28	Perawat Recovery Room IKO	D3/S1 Keperawatan	1	1	0
29	Karu Maternitas	Profesi Kebidanan	1	1	0
30	Pelaksana Maternitas	D3/S1 Keperawatan	14	13	1
31	Karu Neonatologi	Ners	1	1	0
32	Pelaksana Neonatologi	D3/S1 Keperawatan	9	3	6
33	Karu NICU	Ners	1	1	0
34	Pelaksana NICU	D3/S1 Keperawatan	8	8	0
35	Ka Ins IGD	Spesialis Emergency	1	1	0
36	Karu IGD	Ners	1	1	0
37	Pelaksana Bidan IGD	D3/S1 Kebidanan	5	5	0
38	Pelaksana Perawat IGD	D3/S1 Keperawatan	20	19	0
39	Karu Rehab Medik	S1 Fisioterapi	1	1	0
40	Fisioterapi	D3/S1 Fisioterapi	3	2	1
41	Terapi Wicara	D3/S1 Terapi Wicara	1	0	1
42	Terapi Okupasi	D3/S1 Terapi Wicara	1	0	1
43	Apoteker	Profesi Apoteker	12	12	0
44	TTK	D3/S1 Farmasi	29	25	4
45	Rekam Medis	D3/S1 Perekam Medis	13	11	2
46	Pendaftaran	D3 Kesehatan/Lainnya	17	17	0
47	Laboratorium	D3 Analisis Kesehatan	14	13	1
48	Radiografer	D3 Radiologi	6	6	0
49	Perawat Radiologi	D3/S1 Keperawatan	1	0	1
50	Admin Radiologi	SMA/SMK	1	1	0
51	Ahli Gizi	D3/S1 Gizi	6	5	1
52	Dapur	SMA/SMK	10	10	0
53	Pantry	SMA/SMK	4	4	0
54	CSSD	SMA/SMK	4	4	0
55	Laundry	SMA/SMK	7	5	2
56	Sekretaris RS	S1 Semua Jurusan	1	1	0
57	Sekretaris Komite	S1 Semua Jurusan	1	0	1
58	Sekretaris Akreditasi & Diklat	S1 Semua Jurusan	1	0	1
59	SDM	S1 Semua Jurusan	2	2	0
60	PPI	S1 Bidang Kesehatan	1	1	0
61	K3RS	D3 K3 / S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0



No.	Unit	Kualifikasi	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan
62	PKRS	D3 Promosi Kesehatan / S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0
63	Mutu	S1 Kesehatan Masyarakat	1	1	0
64	Humas Marketing	D3/S1 Marketing	1	1	0
65	Admin Humas Marketing	D3/S1 Marketing	1	1	0
66	CSO	D3/S1 Semua Jurusan	3	2	1
67	MCU	D3/S1 Keperawatan	1	1	0
68	Keuangan	S1 Keuangan	1	1	0
69	Kasir	D3/S1 Keuangan	10	9	1
70	SIMRS & IT	S1 Teknologi Informasi	4	4	0
71	IPSRS	SMA/SMK	3	3	0
72	ATEM	D3/S1 Elektromedis	1	1	0
73	IPAL / B3	SMA/SMK	3	3	0
74	Tukang	SMA/SMK	4	4	0
75	Gudang Umum	SMA/SMK	1	1	0
76	Rumah Tangga	SMA/SMK	1	1	0
77	Security	SMA/SMK	11	11	0
78	Driver	SMA/SMK	6	6	0
79	Cleaning Service	SMA/SMK	33	33	0
80	Parkir	SMA/SMK	9	9	0
81	Pemulasaran Jenazah	SMA/SMK	2	0	2
82	Asuransi Center	D3/S1 Rekam Medis	14	11	3
83	Adm. Jaminan	D3 Sarjana Lainnya	2	2	0
84	PIPP	S1 Bidang Kesehatan	6	5	1
85	Dokter Umum IGD	S1 Kedokteran	9	7	2
86	Dokter Gigi	S1 Kedokteran Gigi	2	2	0
87	Dokter MCU/Poli Umum/Vaksinasi	S1 Kedokteran	2	0	2
88	Dokter Ruangan	S1 Kedokteran	1	1	0
89	Dokter Spesialis Emergency	Spesialis Emergency	1	1	0
90	Dokter Spesialis Obgyn	Spesialis Obgyn	3	3	0
91	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Penyakit Dalam	3	3	0
92	Dokter Spesialis Anak	Spesialis Anak	3	3	0
93	Dokter Spesialis Bedah Umum	Spesialis Bedah Umum	3	3	0
94	Dokter Spesialis Bedah Plastik	Spesialis Bedah Plastik	1	1	0
95	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	Spesialis Bedah Syaraf	1	1	0
96	Dokter Spesialis Syaraf	Spesialis Syaraf	3	3	0
97	Dokter Spesialis Bedah Anak	Spesialis Bedah Anak	1	1	0
98	Dokter Spesialis Bedah Mulut	Spesialis Bedah Mulut	1	0	1

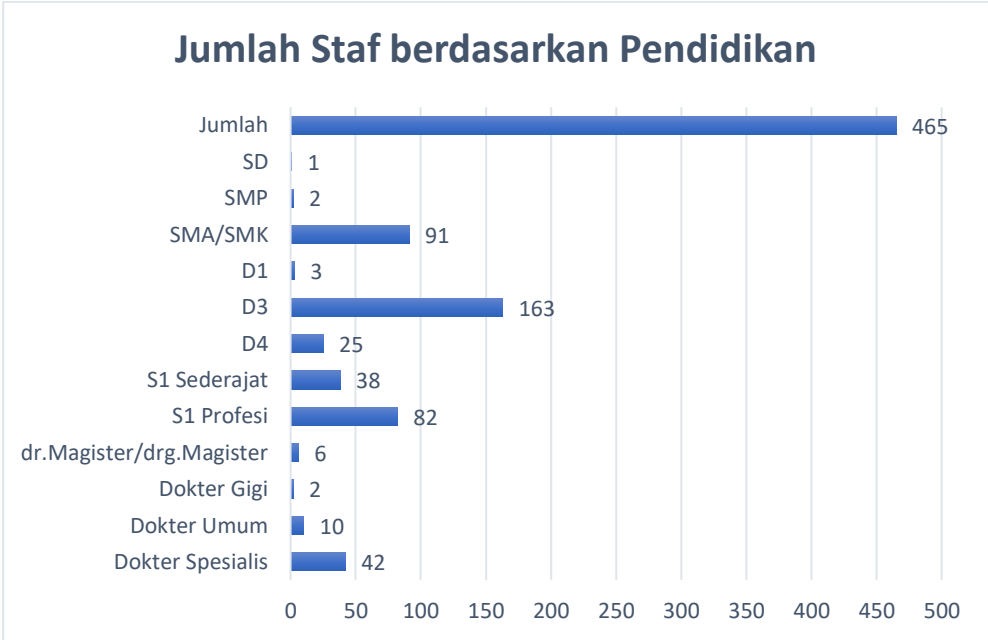


No.	Unit	Kualifikasi	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan
99	Dokter Spesialis Konservasi Gigi	Spesialis Konservasi Gigi	1	1	0
100	Dokter Spesialis Orthopaedi & Traumatologi	Spesialis Orthopaedi & Traumatologi	3	3	0
101	Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	2	2	0
102	Dokter Spesialis Kulit & Kelamin	Spesialis Kulit & Kelamin	1	1	0
103	Dokter Spesialis Rehab Medik	Spesialis Rehab Medik	1	1	0
104	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Spesialis Kesehatan Jiwa	2	2	0
105	Dokter Spesialis THT	Spesialis THT	1	1	0
106	Dokter Spesialis Mata	Spesialis Mata	2	2	0
107	Dokter Spesialis Paru	Spesialis Paru	2	2	0
108	Dokter Spesialis Urologi	Spesialis Urologi	1	1	0
109	Dokter Spesialis Radiologi	Spesialis Radiologi	2	2	0
110	Dokter Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Patologi Anatomi	1	1	0
111	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Klinik	1	1	0
112	Dokter Spesialis Anastesiologi	Spesialis Anastesiologi	3	3	0
TOTAL			521	466	54

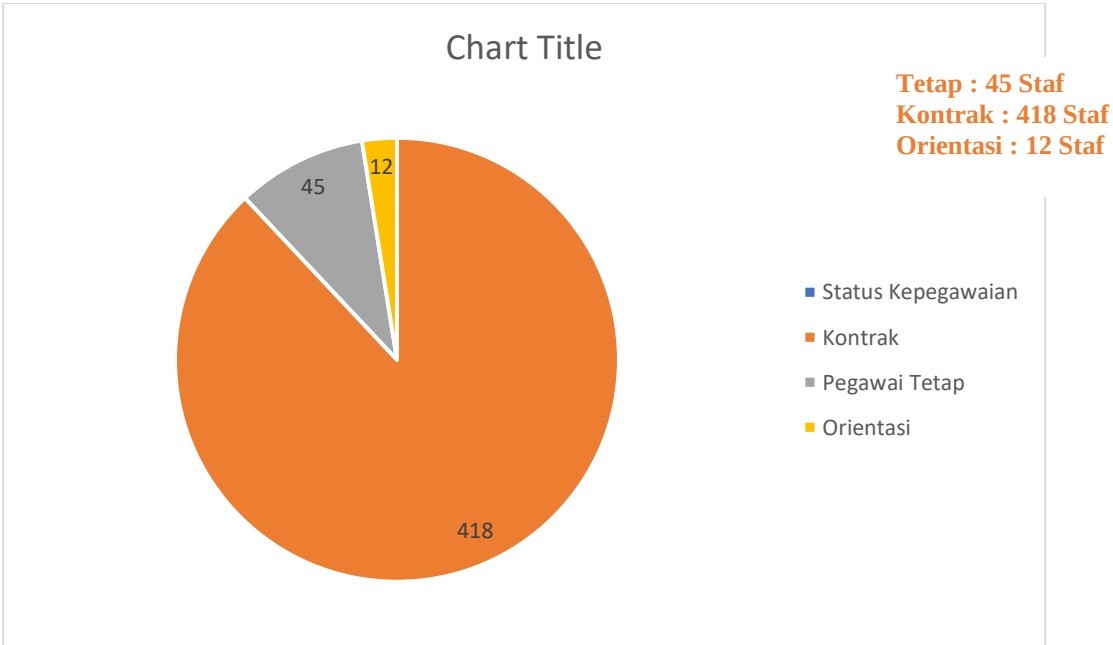
Tabel Staf RS Prima Husada Sukorejo Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Dokter Spesialis	42
2	Dokter Umum	10
3	Dokter Gigi	2
4	dr.Magister/drg.Magister	6
5	S1 Profesi	82
6	S1 Sederajat	38
7	D4	25
8	D3	163
9	D1	3
10	SMA/SMK	91
11	SMP	2
12	SD	1
TOTAL		465

Gambar Staf RS Prima Husada Sukorejo Berdasarkan Pendidikan



Gambar Staf RS Prima Husada Sukorejo Berdasarkan Status Kepegawaian



3.1.2 Orientasi

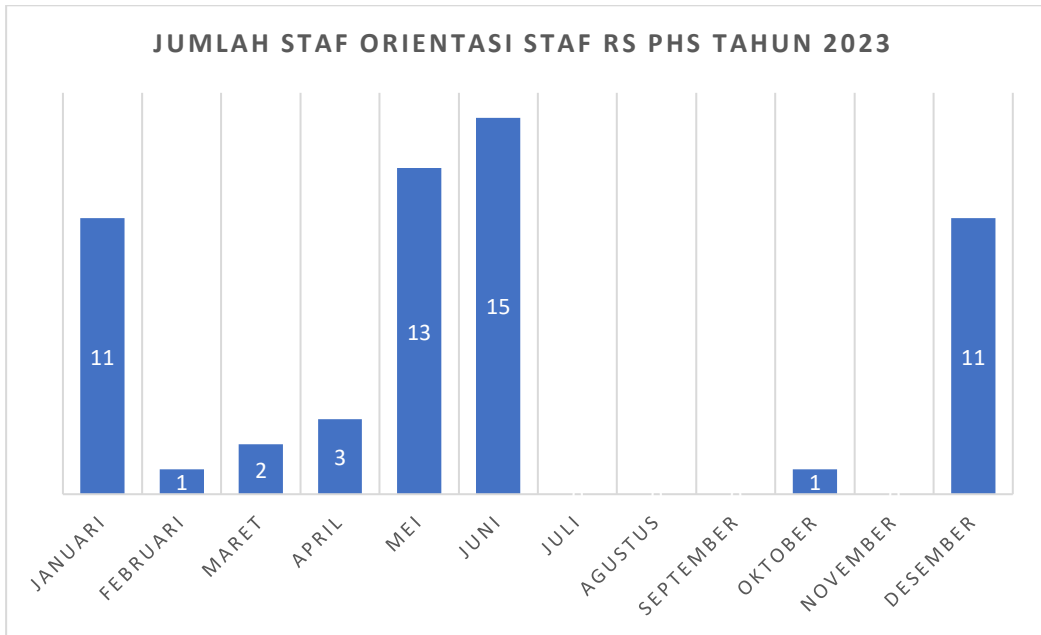
Daftar Staf Masuk Selama 2023

No.	Nama Staf	Profesi	Tanggal Mulai Tugas (TMT)
1	Yudhi Dian Saputra	Security	26 Januari 2023
2	Paiman	Security	26 Januari 2023
3	Miftakh Amalia Putri	Cleaning Service	26 Januari 2023
4	Zaki Amin	Cleaning Service	26 Januari 2023
5	Ronny Junaedy	Cleaning Service	26 Januari 2023
6	Indy Pramudya Rahmawati	Penyaji	26 Januari 2023
7	Wahyu Setiawan, A.Md.Farm	TTK	26 Januari 2023
8	Vera Indri Sari, S.Farm	Penyaji	26 Januari 2023
9	Sofyan Hidayatulloh, S.Farm	Penyaji	26 Januari 2023
10	Noelta Anika Tinanjar, S.Farm	Penyaji	26 Januari 2023
11	Roni Adi Santoso	Tukang	27 Januari 2023
12	Andrew Permadi Sugiarto	Laundry	20 Februari 2023
13	dr. Tri Putra Rahmad Ramadani, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi	27 Maret 2023
14	dr. Khairul Wafa Musthofa	Dokter Umum	18 Maret 2023



No.	Nama Staf	Profesi	Tanggal Mulai Tugas (TMT)
15	dr. Aan Dwi Presetio, Sp.N	Dokter Spesialis Neurologi	10 April 2023
16	dr. Andika Hidaliawan	Dokter Umum	03 April 2023
17	Permata Sari Pratiwi, S.Farm., Apt	Apoteker	01 April 2023
18	Adinda Intan Febriati, A.Md.RMIK	Asuransi Center	08 Mei 2023
19	Nida Nur Hidayatus Surya A.Md.RMIK	Asuransi Center	08 Mei 2023
20	Luvitasari, A.Md.Farm	TTK	08 Mei 2023
21	Sintia Anggriani, A.Md.Kes	TTK	08 Mei 2023
22	Khopnia, A.Md.Farm	TTK	08 Mei 2023
23	Yulia Kristanti, S.Farm	TTK	08 Mei 2023
24	Intan Eka Dwi Endarwati, A.Md.Farm	TTK	08 Mei 2023
25	Rohmah Madya Ayu Fitriana, S.Farm., Apt	Apoteker	08 Mei 2023
26	Bianda Tasyakilla Kindly, S.KM	Pendaftaran	08 Mei 2023
27	Erlina Anwar, S.KM	Pendaftaran	08 Mei 2023
28	Nova Farah Diba, S.Tr.Kes	Pendaftaran	08 Mei 2023
29	Shadilla, S.KM	Pendaftaran	08 Mei 2023
30	Suci Anda Riski, A.Md.AK	Pendaftaran	08 Mei 2023
31	dr. Novita Oktaviana	Dokter Umum	05 Juni 2023
32	Shenfi Ken Rilla, S.Kep., Ns	Perawat	16 Juni 2023
33	Farhah Nahdia Kamilah, A. Md. Kep	Perawat	16 Juni 2023
34	Pratiwi Dwi Lestari, S.Kep., Ns.	Perawat	16 Juni 2023
35	Ranita Sari S.Tr.Kep.Ns	Perawat	16 Juni 2023
36	Riska Cahyanti, S.Kep.,Ners	Perawat	16 Juni 2023
37	Putri Nur Fajaria, A.Md.Kep	Perawat	16 Juni 2023
38	Windha Setyo Oetamie, S.Kep.Ns.	Perawat	16 Juni 2023
39	Dwi Putri Yulianti, S.Tr.Kep.Ns	Perawat	16 Juni 2023
40	Erma Dwi Nurida, S.Kep.,Ns	Perawat	16 Juni 2023
41	Firdatul Shakdiah,S.Kep.Ns	Perawat	16 Juni 2023
42	Sariayu A.Md.Kep	Perawat	16 Juni 2023
43	Ned' Dianti Septika, S.Kep.Ns	Perawat	16 Juni 2023
44	Wiwik Widiyawati A.Md.Kep	Perawat	16 Juni 2023
45	Nadia Salsabella A.Md.Kep	Perawat	16 Juni 2023
46	Gilda Fathia Azizi, A.Md.Kep	Perawat	23 Oktober 2023
47	Ledyna Astri Oktasari, S.Farm.Apt	Farmasi	01 Desember 2023
48	Nabila Avliyatul Faizah, S.Farm.Apt	Farmasi	01 Desember 2023
49	Amelia Giriana	Dapur	08 Desember 2023
50	Fitrah Ardiatasya, A.Md.Farm	TTK	15 Desember 2023
51	Nadiya Mauliduzzahro, A.Md.Farm	TTK	15 Desember 2023
52	Muhammad Rois Maulana, S.Farm	TTK	15 Desember 2023
53	Novya Permataloka, A.Md.Farm	TTK	15 Desember 2023
54	Annisa Nurlaili Khamidah, S.Kes.Ftr	Fisioterapi	15 Desember 2023
55	Summayah Syahidatul Haq, S.Kes.Ftr	Fisioterapi	15 Desember 2023
56	Rachmad Venus Andika, A.Md.Kes	Fisioterapi	15 Desember 2023
57	dr. Cynthia Mustika Anggraini	Dokter Umum	26 Desember 2023

Data Staf Orientasi 2022



Kegiatan orientasi umum Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo terlaksana pada :

- 1) Periode Awal Tahun (Januari)
- 2) Periode pertengahan tahun (Mei dan Juni)
- 3) Periode Akhir Tahun (Desember)

Kegiatan orientasi khusus telaksana dan terhitung 3 bulan sejak staf masuk rumah sakit.

Terlihat dari diagram diatas bahwa staf baru dengan jumlah paling besar adalah di Bulan Juni Tahun 2023, hal itu dikarenakan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo mengalami peningkatan jumlah pasien atau kunjungan sehingga kebutuhan jumlah tenaga / SDM di masing – masing dapat dipenuhi dalam pertengahan tahun tersebut.

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
a. Pendidikan dan Pelatihan Internal yang telah Terlaksana di Tahun 2023

NO	KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PEMATERI	PESERTA
1	Pelatihan Phlebotomy	08 Februari 2023	08:00 - 16:00	Hall Sakura Lantai 3	Elza Safarina Ulfa, Amd.AK	All Perawat
2	Ruptur Uteri	15 Februari 2023	13:00 - 15:00	Hall Sakura Lantai 3	dr. Santoso Rahardjo, Sp.OG	All Bidan
3	Penanganan Pasien Syok	02 Maret 2023	14:30 - Selesai	Hall Sakura Lantai 3	dr. Ferry Limantara, Sp. EM	Dokter IGD, Perawat, Bidan
4	MFK (Keselamatan dan Penanganan B3)	25 Maret 2023	08:00 - 15:00	Hall Sakura Lantai 3	<u>Restu Kurniawati, S.KM</u>	Seluruh staff
5	Audit PPK-CP	27 Maret 2023	10:00 - Selesai	Hall Andalusia Lantai 3	Sisca Puspitasari, S.Kep., Ns	All Perawat, Bidan
6	Sosialisasi PPK CP	28 Maret 2023	08:00 - Selesai	Hall Sakura Lantai 3	Bening Sekar Tanjung, <u>S.KM</u> dan Syamsiatul Faricha Fafyilia, <u>S.KM</u>	All Staf Klinis
7	Pelatihan Pemasangan Infus	06 - 07 Juni 2023	08:00 - 15:00	Hall Sakura Lantai 3	Fefi Rita Indah Hati, Amd.Kep dan Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns	Perawat dan Bidan



8	Pelatihan Terapi Intravena	09 Jun 23	09:00 - Selesai	Hall Sakura Lantai 3	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.An	Perawat dan Bidan
9	Pelatihan Komunikasi Efektif	13-14 Juni 2023	08:00 - Selesai	Hall Sakura Lantai 3	Bu Endang Susilowati Fefi Rita Indah Hati, A.Md.Kep Sufi Aulia Maghfiroh, S.KM	All Sataf
10	MFK (Keselamatan dan Penanganan B3)	23 Juni 2023	08.00 – 11.30	Hall Sakura Lantai 3	<u>Restu Kurniawati, S.KM</u>	All Staf yang belum pelatihan
11	Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	13 Juli 2023	07.00 – 16.00	Hall Sakura Lantai 3	Bening Sekar Tanjung, S.KM <u>Restu Kurniawati, S.KM</u>	Seluruh Staf Klinis 12 dan Non Klinis
12	MFK (Keamanan, Proteksi Kebaran dan Penanganan Bencana)	18 Juli 2023	07.00 -16.00	Hall Sakura Lantai 3	Sofyan Andi Prata,a. S.E Angela Wenis Flora Rosa, S.Kep., Ns	All Staf RS PHS
13	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Dasar	21 – 22 Juli 2023	08.00 – 12.00	Hall Andalusia Lt. 3	Dinnya Yesica Tandy, S.KM	All Cleaning Service
14	Resusitasi Neonatus	05 Agustus 2023	07.00 – 16.00	Hall Sakura Lantai 3	Lailatul izmalia Amd.Ke Higyanti Hijjah Rochmawati, S.Kep.Ns Dhea Ayu Puspita Sar S.Kep.Ns Ayu Mayang priningtya S.Kep.Ns	All Staf Bidang Pelayanan
15	MFK (Keamanan, Proteksi Kebaran dan Penanganan Bencana)	26 Agustus 2023	09.00 – 15.00	Hall Sakura Lantai 3	Sofyan Andi Prata,a. S.E Angela Wenis Flora Rosa, S.Kep., Ns	All Staf yang belum ikut pelatihan
16	Peningkatan Pengetahuan Perawat mengenai Obat – Obatan Anastesi Guna Meningkatkan Patient Safety	20 Oktober 2023	07.30 – 11.00	Hall Sakura Lantai 3	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp.AN Apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm Ns. Mohammad Lukman Hakim Ibrahim, S.Kep	Staff Nama Terlampir
17	Penggunaan Trial Lens	25 Oktober 2023	14.30 – 16.30	Hall Andalusia	dr. Nyoman Indra Bayu, Sp.M	Asisten Mata IRJA dan Staf PHM MS
18	MFK (Keamanan, Proteksi Kebaran dan Penanganan Bencana)	02 November 2023	09.00 – 15.00	Hall Sakura Lantai 3 dan Lahan Parkir Karyawan	Suliyanto, A.Md.Tek.Med Samuel Andreansyah	All Staf RSPHS

b. Pendidikan dan Pelatihan Eksternal yang telah Terlaksana di Tahun 2023

NO	PESERTA PELATIHAN	KEGIATAN	TANGGAL KEGIATAN	WAKTU	Tempat	PENYELENGGARA
1	Saifuddin	Workshop Satu Hari menanggulangi/ memperkeci bahaya Listrik dan sambaran petir di lingkungan Perkantoran/ Perusahaan	18 Jan 23	08:00 - Selesai	Hotel Transit, Jl. Jen A. Yani No. 55 Kota Pasuruan	PJK3 PT. Era Sejahtera Nusantara



2	Dwi Siska Handayani, S.Kep., Ns	KPS Keperawatan	17 Jan 23	08:00 - Selesai	Zoom Meeting	PPNI
3	Dinnya Yesica Tandy	Pelatihan CIPP	20 Feb - 04 Maret 2023	08:00 - Selesai	Zoom Meeting	Yayasan Cinta Kasih Sejati
4	Ilham Eko Novianto Putro, Amd.Kep	PPI Dasar	06-08 Feb 2023	08:00 - Selesai	Zoom Meeting	Yayasan Cinta Kasih Sejati
5	Ida Bagus, Puguh Lutfianto, Rama Surya, Andy Bagus Setiawan, Moh Shoffiudin	Training Supervisi CS	Hold by PT	Hold by PT	Hold by PT	Hold by PT
6	Nikmatul Khoiria, Amd.Kes	Workshop Patologi Anatomi	10-11 Maret 2023	08:00 - Selesai	Harris Hotel & Conventions Surabaya	PW ILKI Jawa Timur
7	dr. Ghuraba Adisurya, Sp.An., M.Ked.Klin	PPI Dasar	27-29 Maret 2023	08:00 - Selesai	Zoom Meeting	Yayasan Cinta Kasih Sejati
8	Izzaty Amalina Rasyadi, S.Kep., Ns	Pelatihan HIPERKES & KK Paramedis	Mundur hingga 24-28 Juli 2023	08:00 - Selesai	Hall WIN Hotel Surabaya	Menara Indonesia
9	Restu Kurniawati, S.KM	Pelatihan Manajemen Risiko di Fasyankes	12-13 Mei 2023	08:00 - Selesai	Savana Hotel Malang	RS UMM Malang
10	Anis Purnamasari, Amd.Kep	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Ruang	21-23 Maret 2023	08.00	Zoom Meeting	PKMKI
11	Apt. Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm	Pengendalian Inventory dan Biaya Rumah Sakit	11 Apr 23	08:00 - Selesao	Zoom Meeting	Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia
12	Suliyanto, Amd Tekmed	Manajemen dan Tata Laksana Computed Radiography Technology di Rumah Sakit	10 Apr 23	12:30-16:30	Zoom Meeting	Siloam Hospitals Group
13	Sufi Aulia Maghfiroh	Pelatihan Peran & Tugas Tim atau Unit Promosi Kesehatan Sesuai Starkes Tahun 2022	05 Apr 23	08:00 - Selesai	Zoom Meeting	KARS
14	Junus Febrianto	Pelatihan & Workshop Manajemen Laundry Rumah Sakit	16-17 Mei 2023	08:00 - Selesai	Hotel Grand Tjokro Klaten	RSU Islam Klaten
15	Lailatul Izmalia, A.Md.Kep	Pelatihan Resusitasi Neonatus	27 – 28 Mei 2023	08.00 - Selesai	On site	Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PERINASIA)
16	Robikatul Adawiyah, Amd. Keb	PPGDON	6-9 Juni 2023	08:00 - Selesai	RSUD Kabupaten Sidoarjo	RSU Kabupaten Sidoarjo
17	Ilham Eko Novianto Putro, Amd.Kep	Seminar PPI "Apakah Implementasi PPI terhadap Penanganan Covid-19 Pasca Pandemi Berbeda?"	03 Jun 23	08:00 - 12:00	Zoom Meeting	Ikatan PPI Indonesia
18	Mariatul Rochmawati	Kelas Online Manajemen Asuahn Pasien	20 Juni 2023	08.00 – 16.00	Zoom Meering	WIA Training



	Nuris Wahyuni, S.Kep.,Ns					
19	Bening Sekar Tanjung, S.KM	Asesor Internal RS	21-22 Juni 2023	08:00 - Selesai	Zoom Meeting	KARS
20	dr. Ifit Bagus Apriantono	Pelatihan Cara Efektif Memahami Laporan Keuangan Rumah Sakit Bagi Pemilik/ Manajemen Non Profesi Keuangan (Untuk Menilai Kinerja dan Pengambilan Keputusan Strategik)	19-21 Juni 2023	08:00 - Selesai	Zoom Meeting	The Rich Jogja Hotel
21	Vennita Epriani Umi Maimunah Bina Anjani Rahmawati Wakhidatul Karima Karimatul Immiyah	Sertifikasi Penjamah Makanan	24 Juni 2023	08.00 - Selesai	Bertemapt di RSI Masyitoh Bangil	Puskesmas Sukorejo
22	Rina Indah Kurniawati, A.Md.Kep	Kelas Online Manajer Pelayanan Pasien (MPP – Case Manager)	12 – 13 Juli 2023	08.00 – 16.00	Zoom Meeting	Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
23	Ninis Indrawati, S.Tr.Keb & Luhdy Rachmi, S.Keb., Bd	Pelatihan Contraception Technologu Update (CTU) atau paska	8 – 14 Juli 2023	08.00 – Selesai	Zoom Meeting & Hotel Platinum Tunjungan Surabaya	BKKBN Provinsi Jawa Timur
24	Risky Rahmawan, S.Kep., Ns	Pelatihan Perioperatif Anestesia Bagi Perawat di Kamar Operasi	10 Juli – 30 September 2023	Daring dan Luring	Zoom meeting dan Luring	PW HIPANI Jawa Tengah
25	Muhammad Suasana Iqbal Maulana, A.Md.Kes	Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik sesuai Permenkes R.I No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	25 Juli 2023	08.00 – 16.00	Zoom Meeting	KARS
26	Jajaran Manajemen RS PHS dan All Karu Pelayanan Penunjang	Develop Employees with Coaching Counseling	11 Agustus 2023	08.00 – 11.00	Hall Sakura Lt. 3 RS Prima Husada Sukorejo	KALBE
27	Bening Sekar Tanjung, S.KM	Penyusunan Program dan Laporan Kegiatan PMKP Berbasis Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai HK.01.07/Menkes/1122/2022	24 – 25 Agustus 2023	08.00 - Selesai	Zoom Meeting	PERSI dan KARS
28	Ramadhan Rizki Putranto, S.Farm., Apt	Internasional Conference and Scientific Meeting (ICSM) In Current Health Anda Drug Development	04 November 2023	08.00 - Selesai	Luring	Universitas Brawijaya
29	Samuel Andreansyah	Workshop Manajemen Cleaning Service di Rumah Sakit	02 – 03 Desember 2023	08.00 - Selesai	Mandiri Mansion Hotel	FKTSLRS Korwil Jawa Timur

3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf

Evaluasi kinerja di Tahun 2023 berjalan dan terbagi menjadi dua periode :

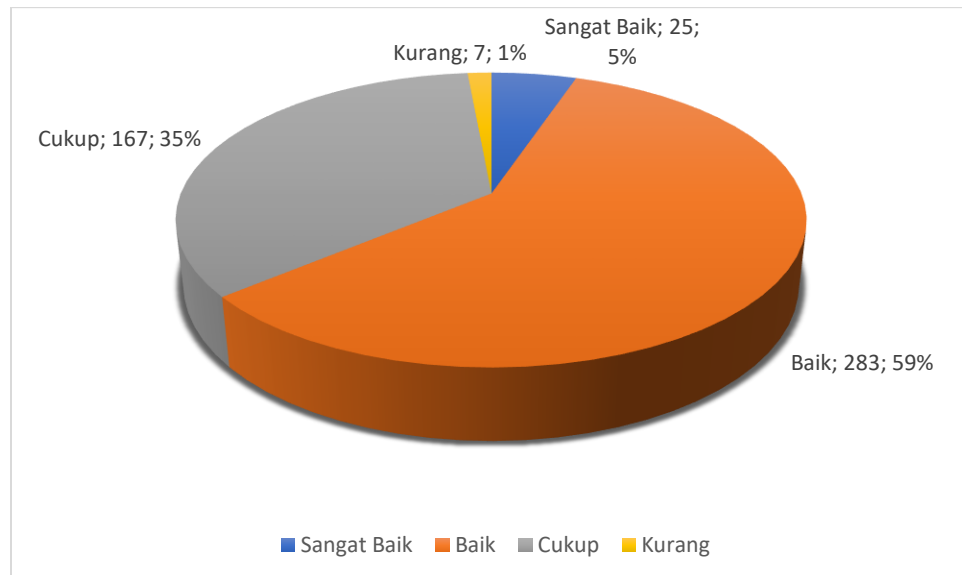
A. Periode Semester I (Januari – Juni)



B. Periode Semester II (Juli – Desember)

Pengumpulan evaluasi kinerja kepada SDM pada tanggal 30-31 periode semester berakhir.

Adapun berikut rata-rata nilai staf :



Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa hasil kategori evaluasi kinerja staf Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo tergolong dalam kategori Baik.

Adapun tindak lanjut dari SDM perihal staf dengan catatan atau staf dengan penilaian kategori kinerja kategori cukup dan kurang adalah pemanggilan staf serta monitoring evaluasi kinerja selama beberapa bulan kedepan. Jika tidak ada perubahan maka akan dipertimbangkan kembali untuk kelanjutan kontrak kerja.

3.2. Pengembangan Pelayanan

3.2.1. Analisa SWOT

Penyusunan strategi didasarkan pada analisis SWOT yang mencermati kondisi lingkungan internal organisasi berupa kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*) dan kondisi lingkungan eksternal organisasi, yaitu peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Dengan tehnik SWOT dapat diketahui kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal organisasi yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan (*scanning*) terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Komitmen Pemilik RS
- 2) Terakreditasi Paripurna
- 3) Jenis pelayanan kesehatan sesuai standar kelas tipe C
- 4) Sarana prasarana sesuai standar kelas tipe C
- 5) Lokasi rumah sakit yang strategis
- 6) Rumah Sakit sudah lama dikenal
- 7) Akses RS mudah dijangkau

b. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) SIMRS tidak terintegrasi dan tidak berjalan optimal
- 2) Jadwal dokter spesialis yang tidak terdistribusi dengan merata
- 3) Angka keterlambatan praktek dokter spesialis tinggi
- 4) Kinerja SDM rumah sakit kurang optimal
- 5) *Turn over* yang cukup tinggi



- 6) Tidak maksimal pemanfaatan alat medis
- 7) Penataan lokasi pelayanan belum optimal
- 8) Angka kepuasan stakeholder rendah
- 9) Penetapan tarif lebih didasarkan pada kompetitor daripada unit cost
- 10) Marketing belum optimal
- 11) Kompetensi tenaga kesehatan yang rendah
- 12) Retensi DPJP terhadap tenaga medis baru
- 13) Terbatasnya lahan
- 14) Efisiensi belum optimal

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. *Opportunity* (Peluang)

- 1) Pembiayaan JKN dan asuransi Kesehatan lainnya
- 2) Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dengan pelayanan kesehatan lainnya
- 3) Banyak perusahaan yang berada disekitar RS
- 4) Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat
- 5) Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan terus meningkat
- 6) Adanya sosial media
- 7) Banyaknya tenaga medis yang berminat bergabung di RS Prima Husada Sukorejo
- 8) Kemajuan teknologi di bidang Kesehatan yang terus berkembang

b. *Threats* (Ancaman)

- 1) Jarak dengan rumah sakit kompetitor dekat
- 2) ketidakpuasan pasien pada dokter spesialis
- 3) Managemen kurang kuat
- 4) Struktur gaji yang tidak sesuai standart
- 5) Munculnya rumah sakit baru
- 6) Informasi hoaks yang beredar di masyarakat
- 7) Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi
- 8) Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi)
- 9) Citra RS masih negative

3. Matriks IFAS dan EFAS

a. IFAS Posisi Strategi RS Prima Husada Sukorejo

No.	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
1	2	3	4	5
A	Kekuatan (Strength)			
1.	Komitmen pemilik RS	0.20	80	16
2.	Terakreditasi Paripurna	0.15	75	11.25
3.	Lokasi RS yang strategis	0.15	80	12
4.	Rumah sakit sudah lama dikenal	0.15	80	12
5.	Sarana prasarana yang telah sesuai dengan standar	0.15	80	12
6.	Jensi pelayanan Kesehatan yang banyak	0.20	80	16
Total A				79.25
B	Kelemahan (weakness)			
1.	SIMRS tidak terintegrasi dan tidak berjalan optimal	0,10	80	8
2.	Jadwal dokter spesialis yang tidak terdistribusi dengan merata	0,10	80	8
3.	Angka keterlambatan praktek dokter spesialis tinggi	0,10	80	8
4.	Kinerja SDM rumah sakit kurang optimal	0,07	75	5.25
5.	Turn over yang cukup tinggi	0,04	60	2.4



6.	Tidak maksimal pemanfaatan alat medis	0,04	60	2.4
7.	Penataan lokasi pelayanan belum optimal	0,04	60	2.4
8.	Angka kepuasan stakeholder kurang	0,07	80	5.6
9.	Tidak ada costing rs	0,07	70	4.9
10.	Marketing belum optimal	0,06	70	4.2
11.	Kompetensi tenaga kesehatan yang rendah	0,09	70	6.3
12.	Retensi DPJP terhadap tenaga medis baru	0,10	85	8.5
13.	Efisiensi belum optimal	0.08	80	6.4
14.	Terbatasnya lahan	0.05	70	3.5
Total B		1		77.85
Total A+B				157.1

b. EFAS Posisi Strategi RS Prima Husada Sukorejo

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
1	2	3	4	5
A	Opportunity (Peluang)			
1.	Pembiayaan JKN dan asuransi Kesehatan lainnya	0,15	85	12.75
2.	Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dengan pelayanan 14 esehatan lainnya	0,15	85	12.75
3.	Banyaknya perusahaan yang berada disekitar RS	0,13	75	9.75
4.	Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 14 esehatan terus meningkat	0,10	70	7
5.	Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan 14esehatan terus meningkat	0,10	70	7
6.	Banyaknya tenaga medis yang berminat bergabung di RS Prima Husada Sukorejo	0,15	85	12.75
7.	Adanya media sosial	0,12	80	9.6
8.	Kemajuan teknologi di bidang Kesehatan yang terus berkembang	0,10	75	7.5
Total A		1		79.1
B	Ancaman (Threats)			
1.	Jarak dengan rumah sakit kompetitor dekat	0,12	80	9.6
2.	Ketidakpuasan pasien pada dokter spesialis	0,10	80	8
3.	Manajemen kurang kuat	0,13	85	11.05
4.	Struktur gaji yang tidak sesuai standar	0,10	75	7.5
5.	Munculnya RS baru	0,07	60	4.2
6.	Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi	0,08	60	4.8
7.	Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi)	0,06	60	3.6
8.	Citra RS negatif	0,11	80	8.8
9.	Kebijakan JKN dan pentarifan (terutama INA CBG's) yang berubah-ubah	0,15	85	12.75
10.	Informasi hoaks yang beredar di masyarakat	0,08	80	6.4
Total B		1		76.8
Total A+B				155.05



Dalam diagram kartesius dapat dilakukan sebagai berikut :
Nilai sumbu X = nilai bobot kekuatan (S) dikurangi bobot kelemahan (W)
Nilai sumbu X = $79.25 - 77.85 = 1.4 (+ 1.4)$
Nilai sumbu Y = nilai bobot peluang dikurangi bobot ancaman
Nilai sumbu Y = $79.1 - 76.8 = 2.3 (+ 2.3)$
Sehingga posisi peta kekuatan organisasi rumah sakit berdasarkan data tersebut diatas berada pada kuadran I Tahap berikutnya berdasarkan Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan External tersebut ditentukan strategi yang tepat untuk menjadi critical success factor dengan membagi kedalam 4 (empat) strategi sebagai berikut:

1. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk meraih peluang)
Pada kuadran SO merupakan pertemuan dua elemen kekuatan dan peluang sehingga memberikan kemungkinan bagi suatu organisasi untuk bisa berkembang lebih cepat dengan strategi antara lain :
 - a. Menambah jam pelayanan specialist dan sub specialist
 - b. Menambah tenaga speslist dan sub specialist tetap
 - c. Mengeembangkan program unggulan sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK
 - d. Mengoptimalkan pelayanan dengan kerjasama BPJS Kesehatan dan asuransi lain
2. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)
Merupakan interaksi antara ancaman dan kekuatan. Di sini harus dilakukan upaya mobilisasi sumber daya yang merupakan kekuatan organisasi untuk memperlunak ancaman dari luar tersebut, bahkan kemudian merubah ancaman itu menjadi sebuah peluang.
 - a. Membangun kerjasama dengan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain yang merupakan pesaing untuk menjadi mitra kerja
 - b. Meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa, pengawasan yang ketat penggunaan fasilitas RS
 - c. Meningkatkan sistem mutu dengan standarisasi, dan sertifikasi untuk menghadapi pelayanan yang bermutu
3. Strategi WO (Menekan kelemahan untuk meraih peluang)
Merupakan interaksi antara kelemahan organisasi dan peluang dari luar. Peluang yang tersedia sangat meyakinkan namun tidak dapat dimanfaatkan karena kekuatan yang ada tidak cukup untuk menggarapnya.
 - a. Meningkatkan produktivitas setiap tenaga medis, paramedis dan non medis dengan membentuk budaya kerja yang mengarah pada kualitas pelayanan
 - b. Meningkatkan jumlah jam praktek dokter dengan menambah tenaga medis dengan SMF yang sama
 - c. Manfaatkan program cost containment untuk efisiensi belanja operasional
 - d. Optimalkan utilisasi alat kedokteran dengan mejalin kerjasama pihak ketiga/jejaring pelayanan RS
4. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman)
Area ini merupaka kondisi yang paling lemah dari semua sel karena merupakan pertemuan antara kelemahan organisasi dengan ancaman dari luar, dan karenanya keputusan yang salah akan membawa bencana yang besar bagi organisasi. Strategi yang harus diambil adalah mengendalikan kerugian, sehingga tidak menjadi lebih parah dari yang diperkirakan.
 - a. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keluhan pelanggan untuk ditangani secara tuntas dan professional
 - b. Melaksanakan promosi program pelayanan unggulan untuk menghadapi pesaing

3.2.2. Analisa Dan Mitigasi Risiko

1. Identifikasi Risiko

Sasaran Strategis		Risiko
Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran		
1	Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kesehatan	1. SDM yang berkompeten Pindah Ketempat Lain 2. Direkrut oleh instansi lain



2	Terwujudnya sarana prasarana sesuai standar klasifikasi kelas RS	1. Anggaran meningkat 2. SDM tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompeten
Perspektif Bisnis		
1	Terwujudnya IT yang terintegrasi	1. Tenaga yang tidak siap dengan penggunaan IT 2. Anggaran yang besar 3. Tidak bisa support dengan kebutuhan eksternal
2	Terwujudnya pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terkendali dalam pembiayaan	1. Jadwal pelayanan yang tidak merata 2. Kedatangan DPJP yang terlambat dalam praktek dan visite 3. Tidak tersedia PPK 4. Tarif RS > Tarif Ina CBGs 5. Ketidaksiapan sarpras dan SDM
3	Terwujudnya keypartners yang memadai	Ketidaksiapan SDM, sarpras, anggaran, dalam pelayanan
Persepektif Stakeholders		
1	Terwujudnya Kepuasan Stakholders Internal dan Eksternal	Menurunnya kualitas pelayanan (sarpras dan SDM)
Persepektif Keuangan		
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan RS	1. Tidak ada alokasi penganggarn yang tepat 2. Struktur gaji yang tidak memadai

3.2.3. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Rumah Sakit

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Prima Husada. Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, meliputi:

1. SIMRS tidak optimal
2. Belum efektif dan efisiennya perencanaan kegiatan serta pemanfaatan sarana dan prasarana, sehingga menjadikan biaya tinggi.
3. Fungsi pemasaran yang belum optimal, menjadikan masyarakat tidak mengetahui secara menyeluruh perkembangan dan kemajuan pelayanan rumah sakit.
4. Jumlah kamar yang kurang untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat kurang mampu akan pelayanan rumah sakit.
5. Luas kamar yang tidak sesuai dengan standar
6. Semakin banyaknya rumah sakit dan klinik kesehatan merupakan pesaing yang perlu diwaspadai.
7. Meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga meningkatkan potensi terjadinya tuntutan hukum.
8. Perubahan organisasi rumah sakit dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

3.2.4. Analisa Situasi

1. Analisis Pesaing
 - a. Lokasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dikelilingi rumah sakit umum swasta lain yang relatif dekat, dan memiliki kompetensi pelayanan dan fasilitas yang lebih lengkap.
 - b. Terdapat pula sarana pelayanan kesehatan lain yang memberikan pelayanan penunjang, klinik, rumah bersalin, dan lain-lain.
 - c. Jadwal dokter yang merata setiap jam
2. Analisis Stake Holder
 - a. Lokasi Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berdekatan dengan pusat-pusat industri besar, yang memiliki jumlah karyawan yang cukup banyak sehingga mempunyai potensi sebagai cakupan pelayanan.
 - b. Masyarakat di sekitar Rumah Sakit Prima Husada dengan strata menengah ke atas merupakan pasar potensial bagi cakupan pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
 - c. Pelayanan bagi masyarakat yang tidak mampu dijamin oleh Pemerintah melalui program BPJS Kesehatan.
 - d. PT. Disa Prima Medika memiliki dana yang cukup sebagai sumber dana untuk pengembangan pelayanan Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

3.2.6. Rancangan Peta Strategi Balanced Scorecard (BSC)



3.2.7. Indikator Kinerja

No	Perspektif	Sasaran Strategis	KPI	
1	Stakeholders	Terciptanya kepuasan stakeholders	1	Tingkat Kepuasan Pasien
			2	Persentasi klomplain yang ditindak lanjuti
			3	Tingkat Kepuasan Pegawai
			4	Tingkat Kepuasan jejaring
2	Proses Bisnis	Terwujudnya pelayanan prima yang terintegrasi	1	Terwujudnya akreditasi paripurna
			2	Capaian Indikator mutu
			3	Capaian PPK dan CP yang ditindak lanjuti
		Terwujudnya jejaring dan system rujukan yang optimal	1	Jumlah jejaring dengan RS, FKTP dan lainnya
			2	Jumlah rujukan dari FKTP yang optimal
		Persentase nilai indikator pelayanan rawat inap rumah sakit yang sesuai standar Kemenkes	3	BOR, AVLOS, BTO, TOI, GDR dan NDR
		Standar Sarana Prasarana	4	Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai dengan yang ditetapkan pada standar Rumah Sakit Kelas C
3	Learning and Growth	Kalibrasi Alat Medis	5	Persentasi sarana prasarana yang terlaibrasi
		Tersedianya Modul SIMRS	6	Modul SIMRS
		Terwujudnya SDM yang kompeten	1	Persentasi SDM medik tetap
			2	Pesentasi SDM Sub. Spesialist
			3	Persentasi SDM yang memiliki kualifikasi perawat intensif care
		Terbangunnya sistem manajemen kinerja terpadu berbasis IT	1	Maturitas IT
		Terwujudnya budaya kinerja	1	Persentase kehadiran pegawai yang tepat waktu
			2	Persentasi pegawai berkinerja baik
4	Financial	Terwujudnya peningkatkanrevenue	1	Persentase Peningkatan Revenue
		Terwujudnya efisiensi	2	Cost Recovery



3.2.8. Rencana Pengembangan Pelayanan Medik

No	Unit	Rencana Pengembangan	Analisa
1	IGD	Pelebaran ruang IGD yang sesuai dengan standart dengan dipenuhi 3 bed PONEK	Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo merupakan RS type C yang berada di sekitrar wilayah Pasuruan, sehingga ini menyebabkan banyak masyarakat sekitar yang melakukan pemeriksaan kesehatan di RS ini. Membuat kebutuhan bed di IGD semakin meningkat, karna load pasien yang semakin meninggi.
2	ICU	1. Penambahan ruang tunggu bagi keluarga pasien ICU 2. Melengkapi kebutuhan ICU isolasi yang sesuai standart 3. Ruang ICU yang standart dengan alat observasi yang mendukung 4. Diadakannya ruang PICU	1. Mengingat pasien ICU yang merupakan pasien tergolong high care maka penunggu pasien juga membutuhkan kenyamanan. Karena pasien tidak ditunggu di side bed, namun di luar. 2. Memenuhi kebutuhan sesuai dengan standar pelayanan RS Type dengan adanya ruang ICU isolasi. 3. Dibutuhkan media observasi yang mendukung seperti tersedianya TV yang bisa merekam semua monitor pasien secara central, serta UPS yang bisa membackup data pasien jika ada pemadaman. 4. Saat ini RS Prima Husada Sukorejo tidak memiliki ruang PICU, di tahun 2023 kebutuhan akan ruang pasien observasi pediatric sangat meningkat dibanding tahun 2022, maka disarankakn untuk dilakukan pembangunan PICU. Selama ini jika ada pasien pediatric dilakukan observasi di ruang ICU (dewasa)
3	IKO	1. Ruang Tunggu Kamar Operasi dengan Sistem Informasi Daftar Tunggu Pelayanan Operasi dan Edukasi Keluarga secara elektronik 2. Pelayanan Kamar Operasi dengan C-Arm	1. Mengingat pasien yang dilakukan operasi merupakan psaien yang sangat high risk yang membuat kecemasan tersendiri pada keluarga/ pendamping pasien. Maka diharapkan adanya sebuah media informasi yang dapat menyampaikan kondisi psaien secara terkini di ruang opeerasi. 2. Dengan adanya pelayanan C-Arm, maka dapat dipekirakan dapat menambah pelayanan dan daftar pasien operasi yang membutuhkan C-Arm
4	IRJA	Pelayanan Poli Eksekutif	RS Prima Husada Sukorejo berada di area industry, dimana banyak pasien yang menggunakan asuaransi lain selain BPJS ataupun pasien dengan pembayaran umum. Yang dari kesekian membutuhkan pelayanan poli yang tidak bercampur dengan sistem BPJS. Maka dari itu, dibutuhkan segera untuk ditambahkan Poli Eksekutif yang bisa melayan=I sesuai dengan standart eksekutif.



5	Maternitas	Pembukaan layanan Mom SPA untuk ibu hamil dan pasca melahirkan	Dengan adanya Mom SPA dapat memberikan layanan yang lebih kepada pasien sehingga bisa menaikkan income untuk RS.
6	Neonatologi	1. Layanan Baby SPA  2. Layanan photo new born 	Dengan adanya Baby SPA dapat memberikan layanan yang lebih kepada pasien sehingga bisa menaikkan income untuk RS. Dan jika ada layanan foto new born, akan memberikan kenangan tersendiri bagi keluarga pasien dan mmeberikan dampak positif bagi peningkatan jumlah pasien di RS Prima Husada Sukorejo khususnya di bagian Neonatologi.
7	NICU	Ruang tunggu untuk ibu yang bayinya sakit dengan dilengkapi fasilitas untuk memompa ASI (ruang ibu menyusui)	Untuk saat ini ruang tunggu khusus tidak ada, jika ada ibu pasien yang sedang di rawat bayi di NICU bisa lebih dekat dengan pasien dan memberika ASI yang fresh pada pasien.
8	IRNA 2A	1. Adanya smart lock door untuk ruang isolasi 2. Ruang KIE yang nyaman untuk keluarga pasien yang privasi	1. Area RS Prima Husada merupakan area yang endemic dengan penyakit TB Paru, namun banyak dari keluarga pasien yang tidak paham akan proses pengobatan serta penularan penyakitnya. Dibuktikan dengan penunggu pasien bisa lebih dari 1 dan masih tidak menggunakan APD serta masih sering keluar masuk area perawatan isolasi. Maka dari itu dibutuhkan pintu smart lock yang membuat keluarga pasien/ penunggu akan patuh dan bisa membantu memutus tali penularan TB Paru itu sendiri 2. Untuk saat ini, ruang KIE masih tidak ada yang sesuai dengan standar yang dapat memberikan hak privasi dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi informasi dan edukasi.
9	IRNA 2B	Nurse station yang layak dan nyaman disertai dengan ruang edukasi yang nyaman bagi keluarga pasien yang privasi	Nurse station yang dilengkapi dengan kebutuhan dan luas yang disesuaikan dengan standart dan ruang KIE yang bisa memberikan hak privasi dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi informasi dan edukasi.

10	IRNA 3A	Membuat playground untuk pasien anak 	Dengan adanya playground yang dekat dengan nurse station bisa bermanfaat untuk pasien anak sehingga tidak menimbulkan trauma hospital. Dan bisa memberikan kenyamanan serta rasa tidak jenuh kepada pasien anak. Dekat dengan nurse station juga bisa memberikan pantauan secara menjangkau kepada perawat Irna Anak (3A)
----	---------	---	--

3.2.8. Rencana Pengembangan Pelayanan Medik

Unit	Kegiatan Pokok	Analisa	Anggaran Dana
Rekam Medis	a. RM-elektronik	- Sesuai dengan Permenkes yang berlaku agar fasyankes menggunakan RM-elektronik paling lambat 31 Desember 2023. - Saat ini RM-elektronik telah diterapkan di instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap akan diterapkan secepatnya. - Melakukan efisiensi terhadap penggunaan kertas, tempat, waktu, petugas dan melakukan pemanfaatan terkait perkembangan teknologi. - Melakukan penyempurnaan terkait RM-elektronik yang sudah berjalan.	Rp 15.000.000,00
	b. Retensi	- Sesuai dengan Peraturan perundang-undangan rekam medis yang tidak aktif lebih dari 5 tahun dapat di musnahkan. - Melakukan pemilahan dokumen rekam medis inaktif dan disimpan di ruang/ rak tersendiri, untuk bisa disimpan dan dimusnahkan sesuai dengan kriteria rekam medis. - Melakukan efesiensi tempat penyimpanan dokumen rekam medis, yang selanjutnya akan menggunakan RM-elektronik.	Rp 10.000.000,00
Laboratorium	a. LIS	- Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kesalahan penginputan hasil Laboratorium. - Melakukan efisiensi waktu, kertas dan petugas dalam melakukan kinerja.	Rp 150.000.000,00



		- Aplikasi yang dapat melakukan penarikan data QC secara otomatis.	
	b. Pneumatic Tube	- Sistem yang dapat digunakan untuk efisiensi waktu dan petugas dalam melakukan pengiriman sampel. - Dalam aplikasinya akan difokuskan untuk titik tertentu yang mudah diakses oleh unit pelayanan. Total titik 4 (Laboratorium, IGD, Lantai 2 dan Lantai 3)	Rp 68.000.000,00
	c. Paket "Catin"	- Meningkatnya angka pernikahan saat ini, adanya beberapa persyaratan untuk yang harus dilengkapi saat mendaftar ke KUA. Maka Laboratorium Prima Husada dapat melayani pemeriksaan skrining 3 (tiga) eliminasi penyakit menular seksual; yaitu adalah Hepatitis B, HIV dan Sifilis. - Paket tambahan yang bisa disertakan dengan untuk dilakukan oleh Laboratorium adalah darah lengkap dan golongan darah. - Bisa disertakan paket konsultasi atau Vaksin TT yang bisa dikolaborasikan dengan unit pelayanan, farmasi dan tim vaksin terkait ini.	Koordinasi dengan tim keuangan dan PKRS.
	d. PKS dengan RS terkait pemeriksaan Troponin, FT4 dan TSH	- Penambahan jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium Troponin, FT4 dan TSH sejak bulan Desember 2023 maka bisa dilakukan pengajuan PKS dengan RS sekitar yang membutuhkan (RS Sahabat, RS Mitra Sehat Medika, RS Asih Abyakta, dll) - Adanya permintaan pemeriksaan laboratorium Troponin, FT4 dan TSH, sebelum rumah sakit menambah jenis pelayanan.	Rp 200.000,00
Farmasi	a. Depo Farmasi IKO dan Depo Farmasi IGD	- Banyaknya ketidak sesuaian dan kontroling yang kurang di unit IKO dan IGD, maka diperlukan pembuatan Depo IKO ataupun IGD.	Pemaksimalan ruangan setelah pembangunan IGD baru selesai
	b. Gratis pengantaran atau maksimal Rp5.000,00 atau Promo Beetu di hari-hari kesehatan.	- Antrean yang panjang yang sering terjadi saat melakukan pengambilan obat dari poli terutama di jam-jam tertentu, dilakukan pemecahan antrean yang bertujuan untuk mengurangi antrean. - Penggunaan Beetu yang cukup diminati namun masih	Koordinasi dengan vendor Beetu dan tim keuangan.



		tetap terjadi antrean panjang di saat pengambilan obat, maka dilakukan Promo Beetu untuk lebih menarik minat pelanggan di Hari-hari Kesehatan tertentu.	
	c. Iterisasi resep	- BPJS menargetkan untuk melakukan iterisasi 100%. - Selama ini beberapa DPJP sudah melakukan iterisasi namun tidak maksimal, petugas harus menginput lagi di non pasien karena tidak ada sistem iter di SIMRS. - Pemaksimalan SIMRS dengan mengadakan sistem Iterisasi terutama pasien BPJS. - Efisiensi waktu dan antrean pasien.	Pemaksimalan pemanfaatan SIMRS.
	d. Aplikasi Formularium Rumah Sakit	- Pada tahun 2023 telah dilakukan penyusunan formularium rumah sakit namun masih belum disahkan. - Perlu dilakukan penyusunan ulang formularium rumah sakit tahun 2024, yang disesuaikan dengan PPK-CP sehingga dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pemesanan, distribusi ataupun penggantian obat yang lebih terstruktur.	Rp 600.000,00
Radiologi	a. PACS (<i>Picture Archiving Communicating System</i>)	- Aplikasi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko kesalahan penginputan hasil Radiologi. - Melakukan efisiensi waktu, kertas dan petugas dalam melakukan kinerja.	Pemaksimalan pemanfaatan SIMRS atau penggunaan vendor.
Gizi	a. Variasi menu anak	- Masukan ataupun komplain pasien terhadap menu anak yang kurang variatif dan menarik sehingga pasien anak kurang tertarik untuk memakannya. - Menu anak yang disarankan mengandung kuah untuk memudahkan anak makan.	Mengikuti kebutuhan dapur dan sesuaikan dengan jumlah kunjungan.
	b. Konsultasi gizi melalui WA personal ataupun komunitas seperti Diabetes, Hipertensi dan Gagal Ginjal.	- Meningkatnya jumlah pasien diabetes, hipertensi dan gagal ginjal. - Akan diadakan pelayanan hemodialisa di Rumah Sakit Prima Husada. - Membantu promosi kesehatan dan mengontrol pasien dengan diagnosa tersebut.	Menggunakan WA massage modalitas Wifi dan HP yang sudah tersedia.
CSSD	a. Mesin plasma untuk sterilisasi alat semikritikal	- Bertambahnya jumlah kunjungan dan tindakan yang membutuhkan alat semikritikal lebih banyak. - Selama ini sterilisasi alat semikritikal menggunakan metode DTT dan pengeringan	Rp 460.000.000,00

		menggunakan handuk yang memiliki risiko kontaminasi jauh lebih tinggi.	
Laundry	a. Mesin Cuci Infeksius dengan kapasitas 15 kg.	- Bertambahnya jumlah kunjungan terutama rawat inap dan IKO yang menyebabkan meningkatnya jumlah linen infeksius. - Sering terjadinya kerusakan pada mesin infeksius yang menyebabkan tertundanya pengelolaan laundry.	Rp 150.000.000,00
	b. Mesin Jahit untuk perbaikan linen rusak secara mandiri	- Banyaknya linen yang mengalami kerusakan dan masih bisa diperbaiki secara mandiri oleh unit laundry.	Rp 1.000.000,00
	c. Printer Linen	- Penulisan inventarisasi di linen yang masih menggunakan stempel, membutuhkan waktu yang lama dan kurang rapi. - Menggunakan printer linen otomatis menuliskan inventarisasi linen secara rapi dan dan cepat.	Rp 1.700.000,00

3.3. Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi

3.3.1. Penunjang
A. Farmasi

Layanan Farmasi Tahun 2023

No	Jenis Resep	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Umum	2.695	1.966	2.695	2.105	2.224	2.023	2.044	2.260	2.312	2.257	2.337	2.727
2	BPJS	18.824	18.038	19.827	17.563	21.918	20.001	20.104	22.552	21.504	21.947	23.275	22.065
3	Lainnya	252	318	544	376	410	452	374	442	986	184	248	442
Total		21.771	20.322	23.391	20.044	24.622	22.476	22.522	26.052	24.802	24.388	25.860	25.234

Analisis Layanan Farmasi

Problem	Jumlah pelayanan resep mengalami fluktuatif pada tahun 2023.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak jumlah pelayanan resep yang fluktuatif
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab jumlah pelayanan resep yang fluktuatif di tahun 2023. Harapan : Peningkatan permintaan resep di Tahun 2024. Tindakan : a. Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai peresepan. b. Berkoordinasi dengan Gudang Farmasi terkait ketersediaan stock. c. Melakukan supervisi terkait stock barang di Gudang dan Depo Farmasi.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi capaian jumlah pelayanan resep.
Study	Apa yang anda pelajari ? Jumlah pelayanan resep di Instalasi Farmasi fluktuatif. Pada bulan Desember 2023 jumlah pelayanan resep mengalami penurunan dari bulan sebelumnya padahal jumlah kunjungan di rumah sakit pada bulan Desember 2023 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dikarenakan dari efek sistem proporsi yang telah diberlakukan.
Action	Apa yang anda pelajari ?



Secara keseluruhan bila dibandingkan dengan bulan Januari 2023 jumlah pelayanan resep pada Desember 2023 mengalami peningkatan.

Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut

- Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2024
- Evaluasi persediaan stock Gudang dan Depo Farmasi.

B. Radiologi

Pemeriksaan Radiologi tahun 2023

No	Pemerik saan	Jenis Pemeriksaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	USG	Abdomen/ urologi	255	293	261	201	330	247	284	291	279	364	356	350	
		Abdomen cito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		Thorax	3	7	7	8	5	4	3	6	4	4	-	1	2
		Mammæ	8	4	6	5	7	4	9	7	6	9	10	8	
		Thyroid/ colli	14	30	17	13	28	13	25	26	24	22	15	35	
		Testis	5	14	13	7	12	10	4	14	9	13	7	6	
		Parotis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		Vaskuler	3	7	3	4	2	9	8	1	2	4	2	3	
		Ankle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Femur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kepala	4	3	3	-	2	2	2	2	2	-	4	2	2
Total			151	210	292	358	310	238	386	289	335	419	394	402	
2	Radiodia gnostik	Skull	5	11	9	6	22	17	14	16	9	12	4	11	
		Thorak	845	947	830	649	901	881	833	919	1004	990	991	945	
		Ekstermitas atas	94	101	98	73	98	110	86	106	116	100	85	118	
		Ekstermitas bawah	101	116	114	91	113	110	100	124	103	120	123	110	
		BNO	93	92	102	74	82	91	100	79	73	130	109	96	
		Pelvis	19	27	22	12	19	7	8	15	21	20	13	20	
		Babygram	11	29	16	20	18	16	14	18	22	16	10	19	
		Cervical	6	7	16	9	17	4	6	14	10	10	5	11	
		Thoracolumb al	7	16	7	6	5	6	7	10	3	5	6	4	
		Lumbosacral	67	79	74	51	60	51	71	84	54	60	62	55	
		IVP + kontras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Uretrografi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Colon in loop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Panoramik	104	99	87	28	122	119	67	52	26	45	10	14	
		Waters	2	2	2	5	2	2	8	11	2	6	9	1	
Total			1020	1109	1354	1526	1377	1024	1459	1414	1314	1511	1427	1404	
3	CT-Scan	Kepala	73	100	53	66	124	106	84	150	101	105	102	106	
		Kepala dengan kontras	9	15	8	8	12	8	7	6	2	10	1	3	
		Kepala trauma	31	29	33	18	34	35	28	43	25	60	33	25	
		Thorax	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
		Thorax dengan kontras	3	3	1	3	5	2	2	2	2	1	3	-	
		Abdomen	1	1	2	2	6	4	1	10	1	2	-	1	
		Abdomen dengan kontras	2	1	-	4	2	1	3	-	--	-	2	2	
		Pelvis	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Vertebrae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Cervical vertebrae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Lumbosacral	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	Thoracal vertebrae non kontras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Thorax vertebrae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Cruris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lumbosacral vertebrae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekstermitas lain	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	1
Total		120	151	97	102	184	156	127	211	133	179	143	139	

Analisis Layanan

Problem	Jumlah permintaan pemeriksaan radiologi secara keseluruhan mengalami tren penurunan sejak bulan Oktober 2023.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak penurunan permintaan pemeriksaan radiologi di tahun 2023.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab penurunan permintaan pemeriksaan radiologi di tahun 2023. Harapan : Peningkatan permintaan pemeriksaan radiologi di Tahun 2024 sesuai dengan PPK-CP Tindakan : a. Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai permintaan pemeriksaan radiologi.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi capaian permintaan pemeriksaan radiologi.
Study	Apa yang anda pelajari ? Permintaan pemeriksaan radiologi bila dibandingkan dengan bulan Januari 2023, bulan Desember 2023 mengalami peningkatan. Namun terdapat penurunan sejak bulan Oktober 2023 dikarenakan penerapan sistem proporsi.
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan pemeriksaan radiologi di bulan Desember 2023 mengalami peningkatan dibandingkan bulan Januari 2023. Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut - Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2024 - Menambah jenis pelayanan radiologi yang banyak di lakukan namun tidak ada di Unit radiologi saat ini. a. Penambahan fasilitas C-Arm pada IKO yang rencana akan mulai beroperasi 2024.

C. Laboratorium

Pemeriksaan Laboratorium Tahun 2023

No	Jenis Pemeriksaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Hematologi	2001	2052	1949	1648	2145	1879	2057	2055	2040	2199	2073	2071
2	Faal Hemostasis	879	996	897	667	1049	900	1017	864	882	1011	897	899
3	Urinalisis	304	316	360	241	333	344	329	376	330	341	325	280
4	Analisis Feses	28	20	31	36	33	33	36	35	33	23	18	27
5	Fungsi Hati	933	1051	1226	1017	1235	1083	1007	999	902	876	695	549
6	Lemak Darah	864	847	810	664	773	957	659	709	510	455	442	289
7	Ginjal Hipertensi	1778	1630	1606	1642	1958	1980	1783	1764	1603	1519	1474	1235
8	Gula Darah	2709	2859	2499	2376	2739	2734	2534	2591	2462	2438	2442	2332
9	Elektrolit (BGA)	727	830	788	715	935	780	858	920	906	835	867	629
10	Rapid Antigen	187	174	161	180	188	122	114	112	136	114	85	135

Daftar pemeriksaan lab yang dilakukan di luar rumah sakit

No	Jenis Pemeriksaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	PCR Swab	17	5	12	8	63	9	5	0	1	0	1	5
2	Faal Tiroid	90	87	68	65	108	79	98	104	103	81	43	77
3	Histo PA	67	97	84	85	115	85	122	108	99	122	134	110

Daftar pelayanan darah di BDRS
PRC (Packed Red Cell)

No	Jenis Pemeriksaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Golda A	11	16	18	7	20	48	37	16	22	22	12	19
2	Golda B	23	17	13	18	17	20	29	18	24	24	25	33
3	Golda O	38	48	9	24	43	53	44	48	28	28	25	55
4	Golda AB	2	0	0	0	0	0	2	3	2	0	2	0

Daftar pelayanan darah luar BDRS

No	Jenis Pemeriksaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	PRC A	0	0	0	0	0	0	3	2	1	0	0	0
2	PRC B	1	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PRC O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PRC AB	7	21	4	7	14	6	4	12	3	4	0	14
5	Komponen TC	0	0	2	0	2	7	7	6	1	0	0	2
6	Komponen FFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Daftar kerusakan/expired kantong darah di BDRS

No	Jenis Pemeriksaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Golda A	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Golda B	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Golda O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Golda AB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisis Layanan

Problem	Jumlah permintaan pemeriksaan laboratorium secara keseluruhan mengalami tren penurunan sejak bulan Juni 2023.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak penurunan permintaan pemeriksaan laboratorium di tahun 2023.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab penurunan permintaan pemeriksaan laboratorium di tahun 2023. Harapan : Peningkatan permintaan pemeriksaan laboratorium di Tahun 2024 sesuai dengan PPK-CP Tindakan : a. Mengevaluasi jumlah stok reagen di Laboratorium. b. Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai permintaan pemeriksaan laboratorium. c. Melakukan penambahan fasilitas pemeriksaan pelayanan Laboratorium di Rumah Sakit.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Jumlah stok reagen di Laboratorium.
Study	Apa yang anda pelajari ? Penyebab terjadinya tren penurunan permintaan pemeriksaan laboratorium berkaitan dengan jumlah kunjungan baik terutama kunjungan rawat inap. Namun salah satu yang berdampak pada permintaan pemeriksaan laboratorium adalah penerapan sistem proporsi mulai Oktober 2023.
Action	Apa yang anda pelajari ?



Jumlah permintaan pemeriksaan laboratorium paling rendah didapatkan pada bulan April 2023, hal ini berkaitan dengan jumlah kunjungan yang juga menurun karena memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya. Setelahnya sempat mengalami kenaikan pada bulan Mei 2023. Sejak Juni 2023 mengalami tren yang cenderung menurun hingga Desember 2023.

Salah satu faktor yang dapat diketahui memberikan dampak penurunan terhadap permintaan pemeriksaan laboratorium adalah karena diberlakukannya sistem proporsi sejak Oktober 2023.

Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut

- Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2024
- Menambah jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium yang banyak di lakukan namun tidak ada di Unit Laboratorium.
 - a. Pemeriksaan patologi anatomi dan sitologi cairan sudah bekerja sama dengan RS Prima Husada Malang sejak 7 Desember 2023.
 - b. Pemeriksaan Free T4, TSH dan Troponin sudah dapat dilakukan di Unit Laboratorium sejak 21 Desember 2023.

D. Rekam Medik

Kinerja Rekam Medik tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	BOR	88	68.8	68	66.7	77.7	68.4	62.7	71.9	77.7	77.5	81.59	77.34
2	ALOS	3.8	3.8	3.8	4	4	4	4	4	3	3.37	3.32	0.7
3	TOI	0.4	1.2	0.9	1	1	1	1.5	1	1	1	0.5	3.33
4	BTO	9.9	7.2	7.6	7	8	8	7.6	9	10	10	10.5	10.5

E. Gizi

Laporan Pelayanan Gizi Tahun 2023

No	Jenis Diit	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Diabetes Mellitus	156	159	167	147	164	158	149	155	168	154	179	208
2	Rendah Garam	187	161	154	158	152	143	165	174	184	195	205	231
3	Jantung	51	43	34	28	33	25	22	48	38	49	38	24
4	Rendah Serat	188	162	193	176	184	201	197	220	350	402	407	484
5	TKTP	657	648	689	573	686	594	567	587	595	570	584	557
6	Makanan Biasa	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Makanan Lunak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rendah Lemak	149	168	137	148	154	158	168	159	142	158	162	154
9	Rendah Protein	179	158	165	178	158	145	132	121	114	117	107	112
10	Bubur Halus	22	15	19	15	14	10	12	15	10	9	12	28
11	Cair	74	84	82	74	89	78	82	76	72	74	68	71
12	Rendah Purin	29	37	34	28	35	27	15	35	45	51	44	57
13	Tinggi Protein												
14	Blender	8	6	8	6	12	13	10	12	20	15	21	25
Total		1520	1705	1641	1682	1531	1681	1558	1602	1740	1794	1827	1851



Analisis Layanan

Problem	Jumlah permintaan pemberian diit pada pasien mengalami peningkatan pada tahun 2024
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak peningkatan permintaan diit.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab peningkatan permintaan diit di tahun 2023. Harapan : Peningkatan permintaan diit di Tahun 2024. Tindakan : a. Berkoordinasi dengan bidang pelayanan mengenai permintaan diit.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi capaian permintaan diit kepada instalasi gizi.
Study	Apa yang anda pelajari ? Permintaan pemberian diit kepada instalasi gizi secara umum trennya meningkat pada tahun 2023. Hal ini sesuai dengan jumlah kunjungan pasien rawat inap yang meningkat.
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan permintaan pemberian diit mengalami peningkatan dibandingkan bulan Januari 2023. Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut - Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2024 - Menambah jenis pelayanan oleh instalasi gizi.

F. Laundry

No	Jenis Linen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Infeksius (kg)	3.466	3.541	3.520	3.320	3.511	3.581	3.540	3.466	4.328	4.438	4.902	4.159
2	Non Infeksius (kg)	1.296	1.330	1.310	1.305	1.315	1.019	1.121	1.296	1.290	1.447	1.350	1.648

Analisis Layanan Laundry

Problem	Jumlah Linen Infeksius dan Non Infeksius yang dilayani oleh unit laundry memiliki tren yang fluktuatif pada tahun 2023.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak pola yang fluktuatif pada pengelolaan linen.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab terjadinya pola yang fluktuatif pada pengelolaan linen di tahun 2023. Harapan : Pengelolaan linen memiliki grafik yang stabil di tahun 2024. Tindakan : a. Melakukan pencatatan pengelolaan linen secara teratur. b. Melakukan supervisi pada kegiatan pengelolaan linen secara berkala. c. Melakukan evaluasi kinerja pada staf laundry.
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi hasil pencatatan pengelolaan linen.
Study	Apa yang anda pelajari ? Jumlah linen infeksius dan non infeksius yang masuk ke unit laundry sesuai dengan jumlah kunjungan dan pelayanan pada unit IKO. Hal ini lah yang mempengaruhi naik turunnya pengelolaan linen. Peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada bulan September 2023 dikarenakan meningkatnya kepatuhan staf laundry dalam melakukan pencatatan pengelolaan linen.
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan pengelolaan linen infeksius dan non infeksius pada bulan Desember 2023 mengalami peningkatan dibandingkan bulan Januari 2023. Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut - Evaluasi pencapaian pada periode tahun 2024

G. CSSD

No	Jenis Chemical	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Chemical Alkacide	600 ml	610 ml	590 ml	520 ml	500 ml	500 ml	600 ml	500 ml	550 ml	500 ml	800 ml	750 ml
2	Chemical Alkazyme	175 gr	180 gr	170 gr	150 gr	110 gr	100 gr	150 gr	125 gr	125 gr	125 gr	200 gr	150 gr

Analisis Layanan

Problem	Jumlah chemical yang digunakan fluktuatif.
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk evaluasi dampak pola yang fluktuatif pada jumlah chemical yang digunakan.
Plan	Rencana : Mengetahui penyebab terjadinya pola yang fluktuatif pada penggunaan chemical di tahun 2023. Harapan : Pengelolaan linen memiliki grafik yang stabil di tahun 2024. Tindakan : - Melakukan pencatatan penggunaan chemical secara teratur. - Melakukan supervisi pada kegiatan pengelolaan di unit CSSD secara berkala. - Melakukan evaluasi kinerja pada staf CSSD
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Evaluasi hasil pencatatan penggunaan chemical.
Study	Apa yang anda pelajari ? Jumlah penggunaan chemical di Unit CSSD dipengaruhi oleh jumlah alat yang telah digunakan oleh Unit Pelayanan. Hal ini lah yang mempengaruhi naik turunnya pengelolaan linen.
Action	Apa yang anda pelajari ? Secara keseluruhan penggunaan chemical mengalami peningkatan dibandingkan dengan Januari 2023. Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi penggunaan pada periode tahun 2024.

3.3.2 Pelayanan Medik

A. Kinerja Produktifitas Instalasi Gawat Darurat

a. Tabel 01. Kinerja Produktivitas IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2023

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	BPJS	580	580	691	698	771	709	797	933	972	1001	1043	1014
2	JKK	25	21	18	17	21	22	34	43	50	42	33	37
3	UMUM	184	139	164	182	160	149	127	142	139	108	124	143
4	Jasa Raharja	0	0	0	0	0	76	74	82	68	39	12	21
5	Asuransi Lain	43	38	83	53	72	38	83	53	72	48	78	78
6	Kemenkes	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		830	698	956	951	1026	956	1032	1200	1229	1238	1290	1293

Keterangan :

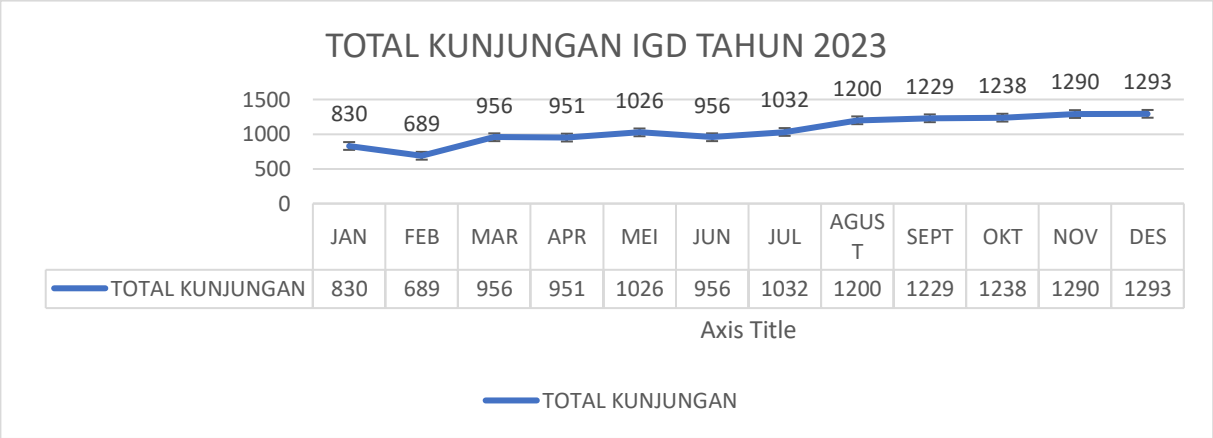
Berdasarkan tabel 01. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada bulan Mei dan terjadi penurunan sebesar 6,8 % pada bulan Juni. Pada bulan Juli terjadi peningkatan kunjungan kembali sejumlah 1032 pasien. Selama periode tahun 2023 dominasi kunjungan sebesar 50 % pasien IGD dengan penjamin BPJS kesehatan, 20 % pasien umum dan 30 % terdiri dari pasien JKK, jasaraharja, dan asuransi.

Grafik 01.



Analisa Grafik :
Berdasarkan grafik 01. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada bulan Mei dan terjadi penurunan sebedar 6,8 % pada bulan Juni. Pada bulan Juli terjadi peningkatan kunjungan kembali sejumlah 1032 pasien. Selama periode tahun 2023 dominasi kunjungan sebesar 50 % pasien IGD dengan penjamin BPJS kesehatan, 20 % pasien umum dan 30 % terdiri dari pasien JKK, jasaraharja, dan asuransi.

Grafik 02. Total Kunjungan IGD Tahun 2023



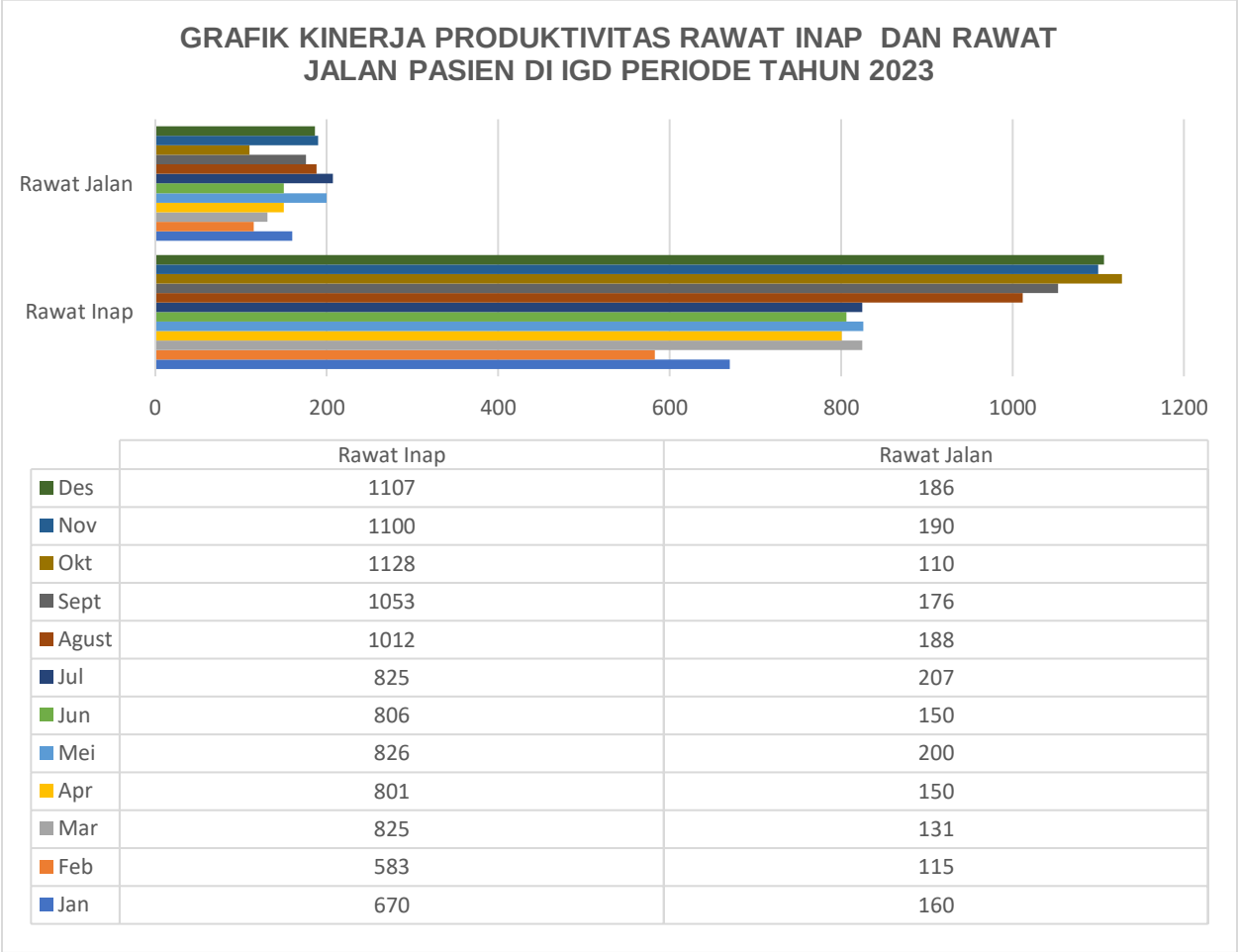
Berdasarkan grafik 02. Menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada bulan Februari sebesar 16% pada bulan Februari, akan tetapi meingkat kembali pada bulan Maret menjadi 956 kunjungan dan 1293 pada bulan Desember 2023.

b. Tabel 02. Kinerja Produktifitas IGD Berdasarkan Status Pasien Tahun 2023

No	Status Pasien	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rawat Inap	670	583	825	801	826	806	825	1012	1053	1128	1100	1107
2	Rawat Jalan	160	115	131	150	200	150	207	188	176	110	190	186
TOTAL		830	698	956	951	1026	956	1032	1200	1229	1238	1290	1293

Berdasarkan tabel 02. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan rawat jalan dan rawat inap di IGD pada tahun 2023. Jumlah kunungan pada bulan Januari sejumlah 830 dan terus meningkat sampai bulan Desember dengan jumlah 1293 kunjungan.

Grafik 03. Kinerja Produktivitas Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan di IGD Tahun 2023



Berdasarkan Grafik 03. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan rawat inap dengan pintu masuk melalui IGD mulai bulan Januari sampai dengan Desember. Dimana pada bulan Desember kunjungan rawat inap melalui IGD sejumlah 1107 pasien. Pada kunjungan rawat jalan IGD mengalami peningkatan pada bulan Juli sejumlah 207, akan tetapi mengalami penurunan pada bulan Agustus sampai Desember 2023.

c. PDSA IGD

Tabel 03. PDSA Kinerja Produktivitas IGD periode Tahun 2023

Problem	Ketidakstabilan kunjungan rawat jalan di IGD mulai bulan Agustus 2023
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kestabilan kunjungan pasien rawat jalan di IGD
Plan	Rencana : mengetahui penyebab kunjungan rawat jalan IGD tidak stabil Harapan : Seluruh staf di IGD memberikan pelayanan prima dan dilengkapi dengan ruang yang memadai untuk menampung lonjakan di IGD. Tindakan : d. melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkesinambungan e. melakukan peneguran kepada staff saat melakuka penolakan pasien di IGD f. koordinasi dengan kepala instalasi dan kepala ruang untuk lebih memantau kinerja dari staff di IGD g. Melakukan evaluasi kinerja melalui OPPE
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Cara memberikan pelayanan pasien di IGD
Study	Apa yang anda pelajari ? Cara memberikan pelayanan di IGD sesuai dengan kriteria triage Waktu memberikan pelayanan pasien di IGD
Action	Apa yang anda pelajari ? Pada kunjungan rawat jalan IGD mengalami peningkatan pada bulan Juli sejumlah 207, akan tetapi mengalami penurunan pada bulan Agustus sampai Desember 2023.

	Ditemukan penolakan pasien yang dilakukan oleh perawat IGD, kemudian dilakukan rotasi staf tersebut ke unit lain Pembangunan ruang IGD baru Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 20224
--	---

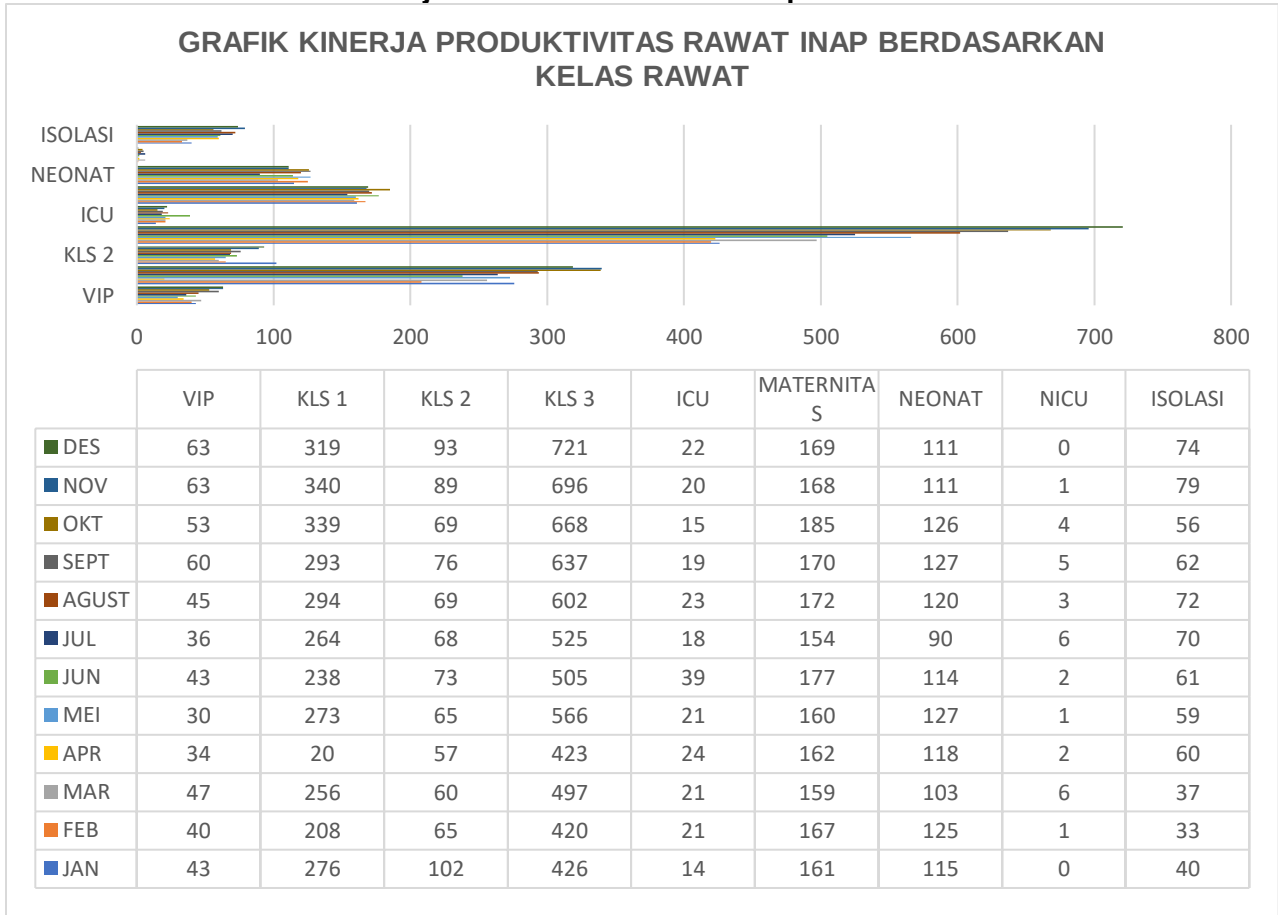
B. Kinerja Produktifitas Instalasi Rawat Inap

a. Tabel 05. Kinerja Produktivitas Rawat Inap Berdasarkan Kelas Rawat Tahun 2023

No	Kelas Rawat	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	VIP	43	40	47	34	30	43	36	45	60	53	63	63
2	KELAS 1	276	208	256	20	273	238	264	294	293	339	340	319
3	KELAS 2	102	65	60	57	65	73	68	69	76	69	89	93
4	KELAS 3	426	420	497	423	566	505	525	602	637	668	696	721
5	ICU	14	21	21	24	21	39	18	23	19	15	20	22
6	MATERNITAS	161	167	159	162	160	177	154	172	170	185	168	169
7	NEONATOLOGI	115	125	103	118	127	114	90	120	127	126	111	111
8	NICU	0	1	6	2	1	2	6	3	5	4	1	0
9	ISOLASI	40	33	37	60	59	61	70	72	62	56	79	74
TOTAL		1176	1080	1182	1080	1302	1252	1231	1400	1449	1515	1567	1572

Berdasarkan tabel 05. Menunjukkan bahwa 42,3% pasien di RS Prima Husada Sukorejo menempati rawat inap di kelas 3, 19,7 % menempati kelas 1 , 8,7% pasien adalah neonatologi dan 5,6% menempati kelas 2. Pada tabel diatas juga menunjukkan apabila terjadi peningkatan jumlah pasien rawat inap mulai bulan Januari sampai Desember 2023, dimana jumlah kunjungan bulan Desember adalah 1572 pasien.

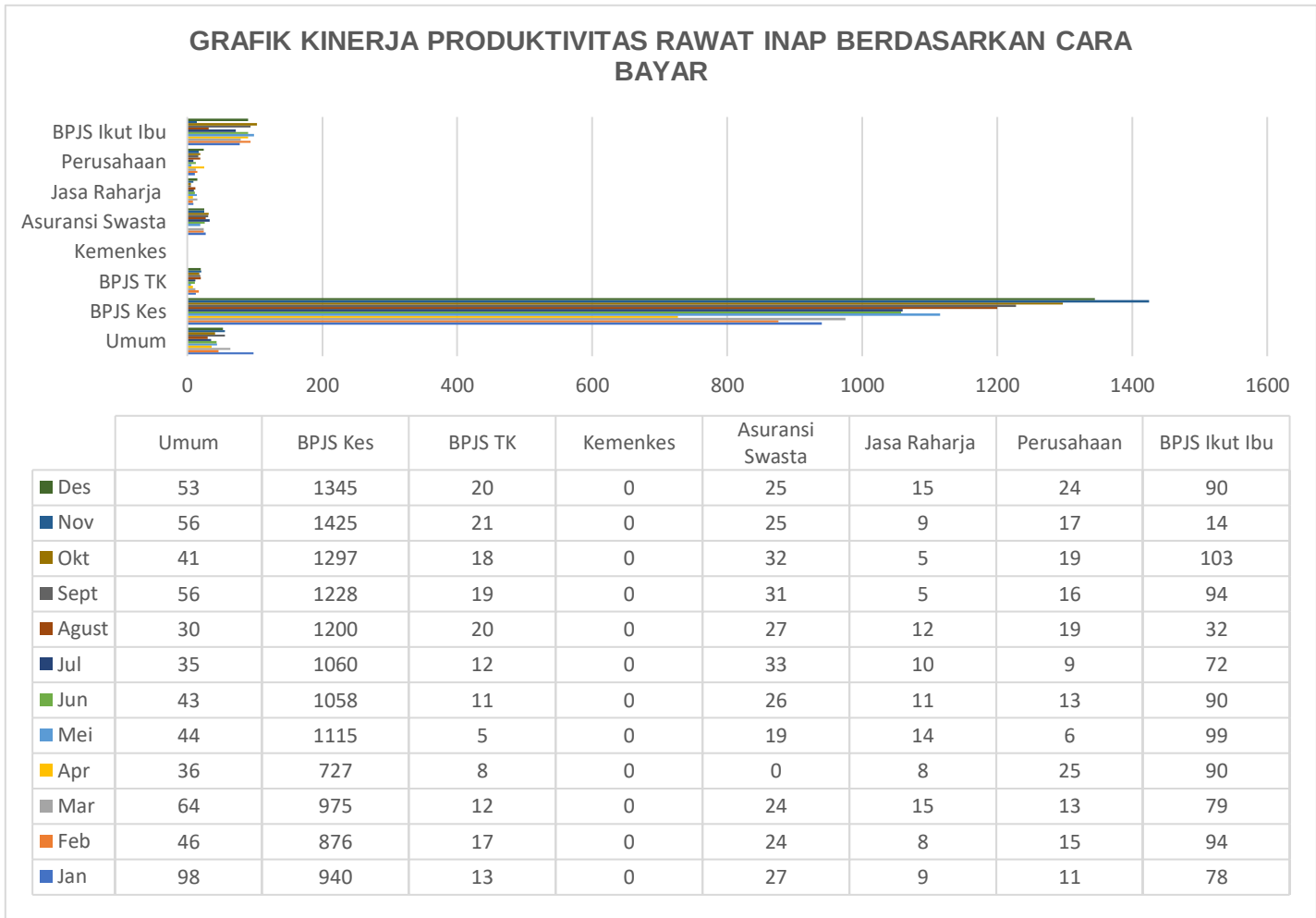
b. Grafik 04 Kinerja Produktivitas Rawat Inap Berdasarkan Kelas Rawat 2023



Berdasarkan grafik 04. Menunjukkan bahwa 42,3% pasien di RS Prima Husada Sukorejo menempati rawat inap di kelas 3, 19,7 % menempati kelas 1, 8,7% pasien adalah neonatologi ,dan 5,6% menempati kelas 2. Pda tabel diatas juga menunjukkan apabila terjadi peningkatan jumlah pasien rawat inap mulai bulan Januari sampai Desember 2023, dimana jumlah kunjungan bulan Desember adalah 1572 pasien.

c. Tabel 06. Kinerja Produktivitas Rawat Inap Berdasarkan Cara Bayar Tahun

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Umum	98	46	64	36	44	43	35	30	56	41	56	53
2	BPJS Kes	940	876	975	727	1115	1058	1060	1200	1228	1297	1425	1345
3	BPJS TK	13	17	12	8	5	11	12	20	19	18	21	20
4	Kemenkes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Asuransi Swasta	27	24	24	0	19	26	33	27	31	32	25	25
6	Jasa Raharja	9	8	15	8	14	11	10	12	5	5	9	15
7	Perusahaan	11	15	13	25	6	13	9	19	16	19	17	24
8	BPJS Ikut Ibu	78	94	79	90	99	90	72	32	94	103	14	90
TOTAL		1176	1080	1182	894	1302	1252	1231	1400	1449	1515	1567	1572



Berdasarkan tabel 06. Menunjukkan bahwa 85 % pasien rawat inap di RS Prima Husada Sukorejo menggunakan pembayaran BPJS kesehatan, 6% pasien menggunakan BPJS ikut bayi, 3,8 % pasien menggunakan umum.

d. PDSA

Tabel 03. PDSA Kinerja Produktivitas Rawat Inap periode Tahun 2023

Problem	Rendahnya pasien rawat inap dengan menggunakan cara bayar BPJS TK
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk meningkatkan pasien rawat inap dengan menggunakan BPJS TK
Plan	Rencana : mengetahui penyebab rendahnya kunjungan pasien rawat inap dengan penjamin BPJS TK Harapan : Meningkatnya kunjungan pasien rawat inap dengan penjamin BPJS TK. Tindakan : a. Melakukan koordinasi dengan humas dan marketing untuk promosi pelayanan di Rs Prima Husada sukorejo ke perusahaan

	b. Koordinasi dengan PKRS untuk promosi pelayanan melalui sosial media c. Melakukan supervise berjenjang untuk meningkatkan mutu rujukan dan pelayanan ke pasien d. Melakukan evaluasi kunjungan pasien dengan penjamin BPJS TK
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Cara meningkatkan kunjungan pasien rawat inap dengan penjamin BPJS TK
Study	Apa yang anda pelajari ? Cara memberikan pelayanan pasien BPJS TK mulai dari IGD/ POLI sampai rawat inap Mutu pelayanan
Action	Apa yang anda pelajari ? Pada kunjungan pasien rawat inap dengan penjamin BPJS TK, Kecepatan IGD dalam merespon rujukan dengan penjamin BPJS TK, Mutu pelayanan dan respon cepat DPJP saat menerima konsulan rawat inap pasien dengan penjamin BPJS TK. Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi pencapaian pada periode tahun 20224

Tabel 04. Rencana Tindak Lanjut

N o	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Melakukan koordinasi dengan humas dan marketing untuk promosi pelayanan di Rs Prima Husada sukorejo ke perusahaan												
2	Koordinasi dengan PKRS untuk promosi pelayanan melalui sosial media												
3	Melakukan supervise berjenjang untuk meningkatkan mutu rujukan dan pelayanan ke pasien												
3	Melakukan evaluasi kunjungan pasien dengan penjamin BPJS TK												

C. IRJA (Instalasi Rawat Jalan)

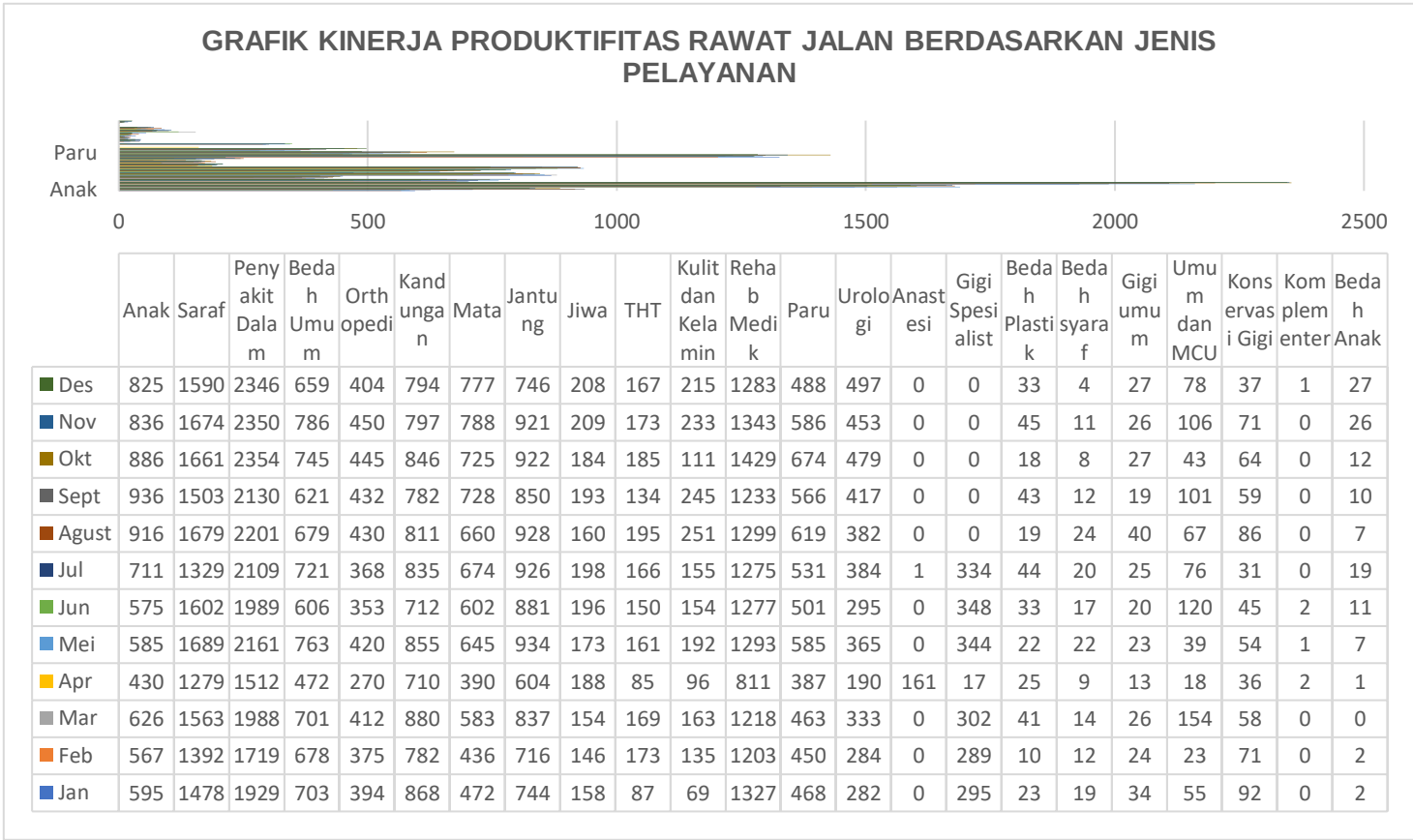
a. Tabel 08. Kinerja Produktivitas Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pelayanan 2023

No	Jenis Layanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Anak	595	567	626	430	585	575	711	916	936	886	836	825
2	Saraf	1478	1392	1563	1279	1689	1602	1329	1679	1503	1661	1674	1590
3	Penyakit Dalam	1929	1719	1988	1512	2161	1989	2109	2201	2130	2354	2350	2346
4	Bedah Umum	703	678	701	472	763	606	721	679	621	745	786	659
5	Orthopedi	394	375	412	270	420	353	368	430	432	445	450	404
6	Kandungan	868	782	880	710	855	712	835	811	782	846	797	794
7	Mata	472	436	583	390	645	602	674	660	728	725	788	777
8	Jantung	744	716	837	604	934	881	926	928	850	922	921	746
9	Jiwa	158	146	154	188	173	196	198	160	193	184	209	208
10	THT	87	173	169	85	161	150	166	195	134	185	173	167
11	Kulit Kelamin	69	135	163	96	192	154	155	251	245	111	233	215
12	Rehab Medik	1327	1203	1218	811	1293	1277	1275	1299	1233	1429	1343	1283
13	Paru	468	450	463	387	585	501	531	619	566	674	586	488
14	Urologi	282	284	333	190	365	295	384	382	417	479	453	497
15	Anastesi	0	0	0	161	0	0	1	0	0	0	0	0
16	Gigi Spesialist	295	289	302	17	344	348	334	0	0	0	0	0

17	Bedah Plastik	23	10	41	25	22	33	44	19	43	18	45	33
18	Bedah syaraf	19	12	14	9	22	17	20	24	12	8	11	4
19	Gigi umum	34	24	26	13	23	20	25	40	19	27	26	27
20	Umum & MCU	55	23	154	18	39	120	76	67	101	43	106	78
21	Konservasi Gigi	92	71	58	36	54	45	31	86	59	64	71	37
22	Komplemen ter	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	1
23	Bedah Anak	2	2	0	1	7	11	19	7	10	12	26	27
TOTAL		10094	9487	10685	7706	11333	10489	10932	11453	11014	11818	11884	11206

Berdasarkan tabel 08. Menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan terjadi mulai Bulan Januari sejumlah 10.094 menjadi 11.206 pada Bulan Desember. Penutupan Poli Gigi Spesialis pada Bulan Agustus tidak memberikan dampak penurunan jumlah kunjungan pada poli, akan tetapi pada bulan Desember terjadi penurunan menjadi 11206 dibanding bulan sebelumnya yakni November sebesar 11884. Penurunan ini disebabkan karena adanya libur panjang karena natal tahun baru

b. Grafik 07. Kinerja Produktivitas Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pelayanan Tahun 2023



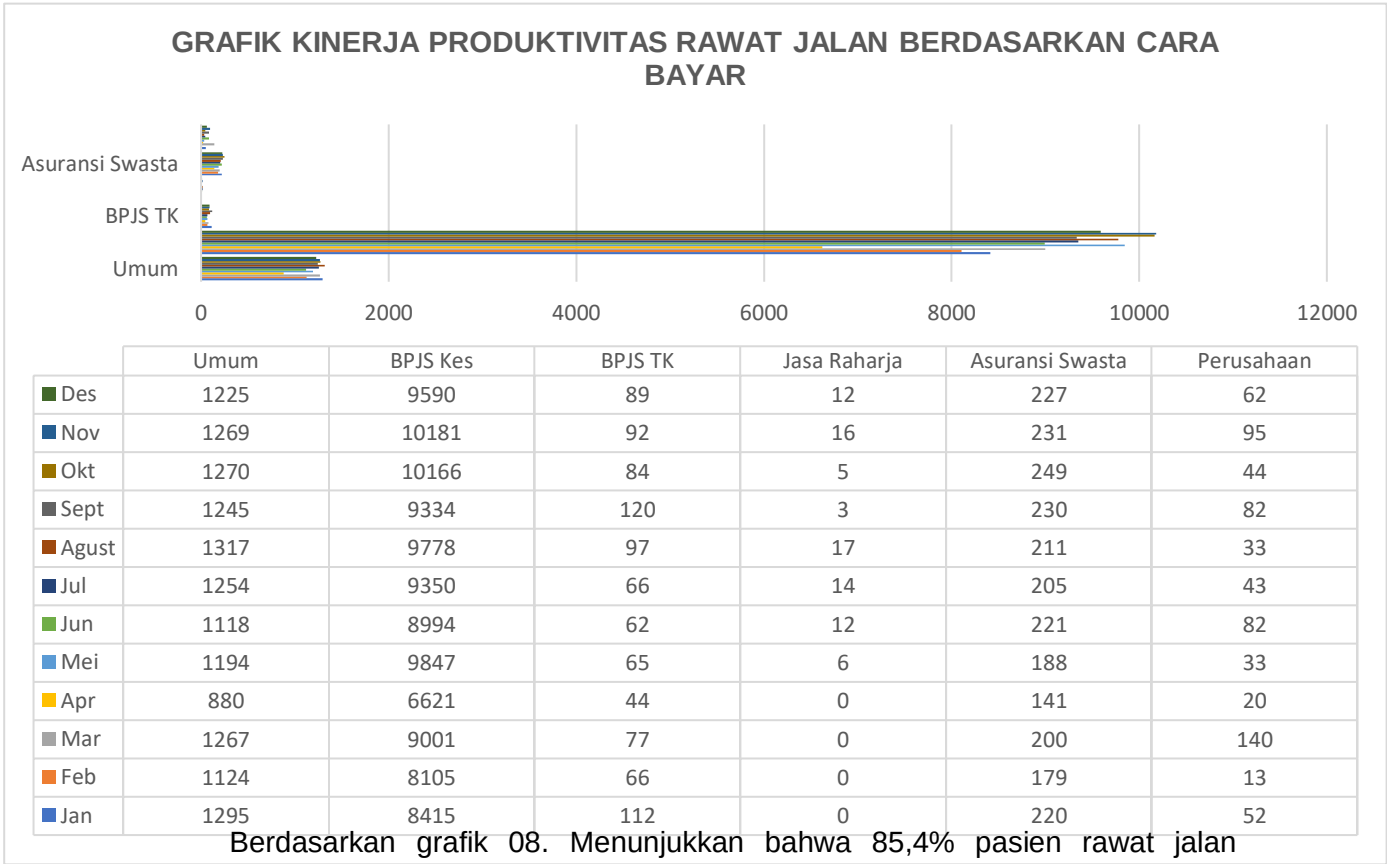
Berdasarkan grafik 07. Menunjukkan bahwa peningkatan kunjungan terjadi mulai Bulan Januari sejumlah 10.094 menjadi 11.206 pada Bulan Desember. Penutupan Poli Gigi Spesialis pada Bulan Agustus tidak memberikan dampak penurunan jumlah kunjungan pada poli , akan tetapi pada bulan Desember terjadi penurunan menjadi 11206 dibanding bulan sebelumnya yakni November sebesar 11884.

c. Table 09. Kinerja Produktivitas Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar 2023

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Umum	1295	1124	1267	880	1194	1118	1254	1317	1245	1270	1269	1225
2	BPJS Kes	8415	8105	9001	6621	9847	8994	9350	9778	9334	10166	10181	9590
3	BPJS TK	112	66	77	44	65	62	66	97	120	84	92	89
4	Jasa Raharja	0	0	0	0	6	12	14	17	3	5	16	12
5	Asuransi Swasta	220	179	200	141	188	221	205	211	230	249	231	227
6	Perusahaan	52	13	140	20	33	82	43	33	82	44	95	62
TOTAL		10094	9487	10685	7706	11333	10489	10932	11453	11014	11818	11884	11206

Berdasarkan Tabel 09. Menunjukkan bahwa 85,4% pasien rawat jalan menggunakan pembayaran BPJS Kesehatan, 11,3 % adalah pasien umum, asuransi swasta sebanyak 2%, BPJS TK sebanyak 0,8%, perusahaan sebanyak 0,5% dan jasaraharja 0,1 %.

Grafik 08. Kinerja Produktivitas Rawat Jalan Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2023



Berdasarkan grafik 08. Menunjukkan bahwa 85,4% pasien rawat jalan menggunakan pembayaran BPJS Kesehatan, 11,3 % adalah pasien umum, asuransi swasta sebanyak 2%, BPJS TK sebanyak 0,8%, perusahaan sebanyak 0,5% dan jasaraharja 0,1 %. Pada Bulan Desember terjadi penurunan kunjungan pasien rawat dengan dengan penjamin BPJS

d. PDSA

Tabel 10. PDSA Kinerja Produktivitas Rawat Jalan periode Tahun 2023

Problem	Potensi penambahan jumlah kunjungan rawat jalan
Step	Open recrutmen dokter gigi spesialis, dokter urologi dan dokter THT
Plan	Rencana : Membuka open rekrutmen dokter gigi spesialis, dokter urologi dan dokter THT Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan rawat jalan periode tahun 2024 Tindakan : a. Koordinasi dengan ketua dokter gigi spesialis di pasuruan b. Koordinasi dengan dokter urologi serta THT di PHM untuk praktek di PHS c. Koordinasi dengan para DPJP untuk membantu mencari rekanan dokter gigi spesialis, dokter urologi, dan THT d. Membuka lowongan pekerjaan yang disebarakan di sosial media

Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Membuka lowongan pekerjaan dokter gigi spesialis, urologi dan THT
Study	Apa yang anda pelajari ? Menyiapkan sloting dokter gigi spesialis , urologi dan THT
Action	Apa yang anda pelajari ? a. Koordinasi dengan ketua dokter gigi spesialis di pasuruan b. Koordinasi dengan dokter urologi serta THT di PHM untuk praktek di PHS e. Koordinasi dengan para DPJP untuk membantu mencari rekanan dokter gigi spesialis, dokter urologi, dan THT c. Membuka lowongan pekerjaan yang disebarakan di sosial media Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Pembulakaan lowonga kerja dokter gigi spesialis

Tabel 11. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Koordinasi dengan ketua dokter gigi spesialis di pasuruan												
2	Koordinasi dengan para DPJP untuk membantu mencari rekanan dokter gigi spesialis												
3	Membuka lowongan pekerjaan yang disebarakan di sosial media												

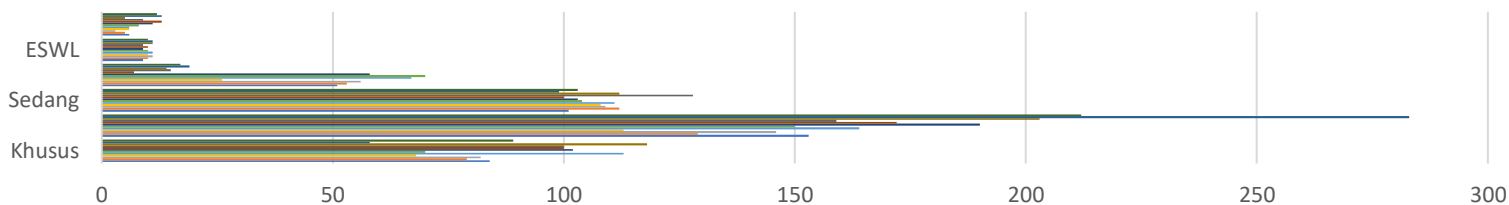
D. Instalasi Kamar Operasi (IKO)
Kinerja Produktivitas IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan Tahun 2023

No	Klasifikasi Pembedahan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Khusus	84	79	82	68	113	70	102	100	100	118	58	89
2	Besar	153	129	146	113	164	150	190	172	159	203	283	212
3	Sedang	101	112	109	108	111	104	103	100	128	112	99	103
4	Kecil	51	53	56	26	67	70	58	7	15	14	19	17
5	ESWL	9	10	11	10	11	10	9	10	9	11	11	10
6	PHACO	6	5	3	6	6	8	11	13	9	5	13	12
TOTAL		404	388	407	331	472	412	473	402	420	463	483	443

Berdasarkan tabel 12. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pasien operasi mulai bulan Januari sampai dengan Juli, dan mengalami penurunan sebesar 15% di bulan Agustus. Pada bulan September mengalami peningkatan sampai bulan November dan menurun menjadi 443 kunjungan pada bulan Desember 2023. Sebanyak 40% jenis operasi masuk dalam kategori besar, 25% masuk dalam kategori sedang dan 20% masuk dalam kategori khusus.

Grafik Kinerja Produktivitas IKO Berdasarkan Klasifikasi Pembedahan 2023

GRAFIK KINERJA PRODUKTIVITAS IKO BERDASARKAN KLASIFIKASI PEMBEDAHAN



	Khusus	Besar	Sedang	Kecil	ESWL	PHACO
Des	89	212	103	17	10	12
Nov	58	283	99	19	11	13
Okt	118	203	112	14	11	5
Sept	100	159	128	15	9	9
Agust	100	172	100	7	10	13
Jul	102	190	103	58	9	11
Jun	70	150	104	70	10	8
Mei	113	164	111	67	11	6
Apr	68	113	108	26	10	6
Mar	82	146	109	56	11	3
Feb	79	129	112	53	10	5
Jan	84	153	101	51	9	6

Berdasarkan grafik 09. Menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pasien operasi mulai bulan Januari sampai dengan Juli, dan mengalami penurunan sebesar 15% di bulan Agustus. Pada bulan September mengalami peningkatan sampai bulan November akan tetapi terjadi penurunan kembali menjadi 443 kunjungan pada bulan Desember 2023. Sebanyak 40% jenis operaasi masuk dalam kategori besar, 25% masuk dalam kategori sedang dan 20% masuk dalam kategori khusus.

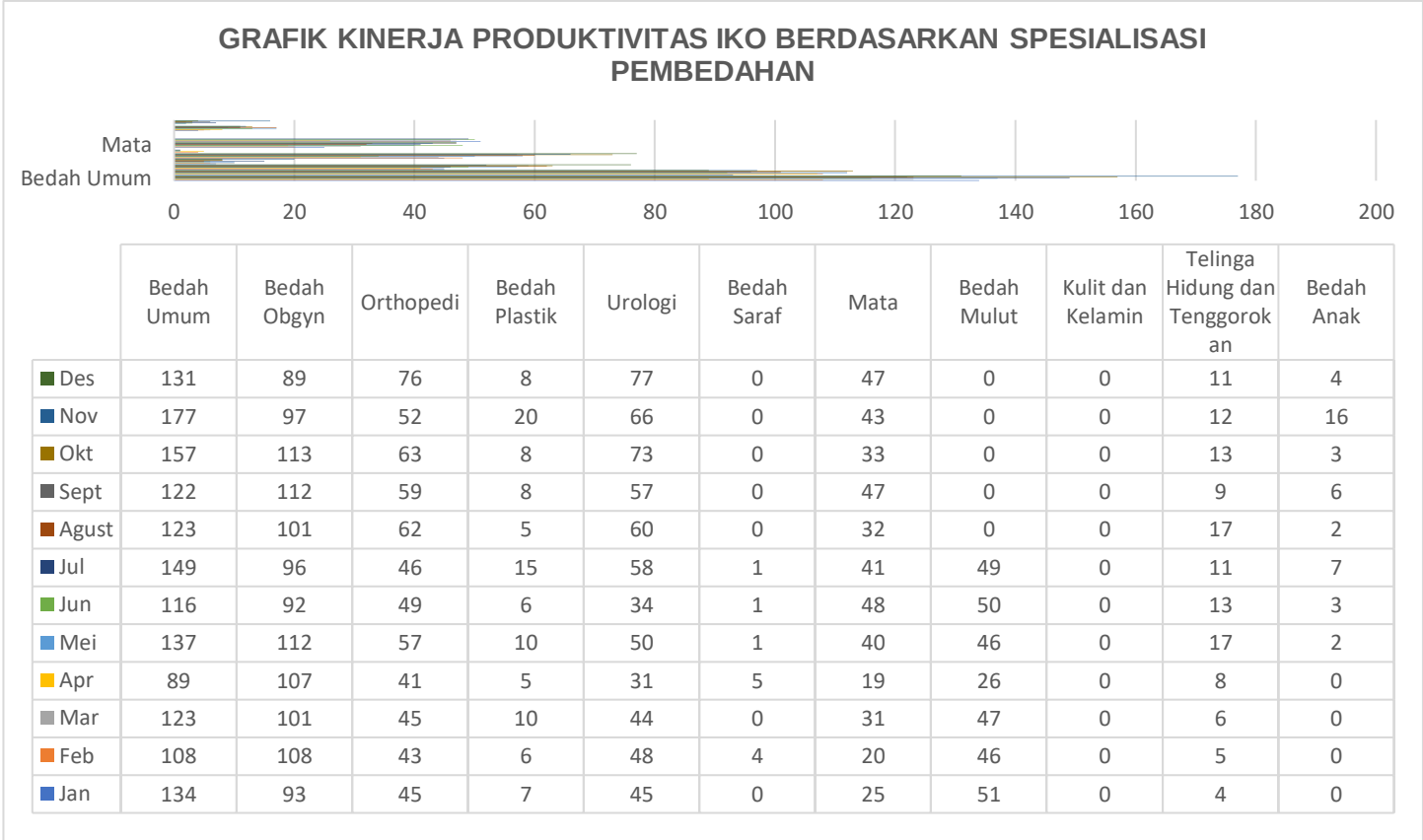
A. Tabel 13. Kinerja Produktivitas IKO Berdasarkan Spesialisasi Pembedahan Tahun 2023

No	Spesialisasi Pembedahan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Bedah Umum	134	108	123	89	137	116	149	123	122	157	177	131
2	Bedah Obgyn	93	108	101	107	112	92	96	101	112	113	97	89
3	Orthopedi	45	43	45	41	57	49	46	62	59	63	52	76
4	Bedah Plastik	7	6	10	5	10	6	15	5	8	8	20	8
5	Urologi	45	48	44	31	50	34	58	60	57	73	66	77
6	Bedah Saraf	0	4	0	5	1	1	1	0	0	0	0	0
7	Mata	25	20	31	19	40	48	41	32	47	33	43	47
8	Bedah Mulut	51	46	47	26	46	50	49	-	-	0	0	0
9	Kulit dan Kelamin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Telinga Hidung dan Tenggorokan	4	5	6	8	17	13	11	17	9	13	12	11
11	Bedah Anak	-	-	-	-	2	3	7	2	6	3	16	4
TOTAL		404	388	407	331	472	412	473	402	420	463	483	443

Berdasarkan tabel 13. Menunjukkan bahwa 30 % pasien operasi pada periode tahun 2023 adalah pasien bedah umum, 23 % adalah pasien obgin, 12% adalah pasien orthopedi dan urologi, 8 % pada pasien mata, 6% pada pasien bedah mutut dan 2% pada pasien bedah mulut. Peningkatan jumlah pasien operasi mulai bulan Januari sampai dengan Juli, dan mengalami penurunan sebesar 15% di bulan Agustus. Pada bulan September

mengalami peningkatan sampai bulan November akan tetapi terjadi penurunan kembali menjadi 443 kunjungan pada bulan Desember 2023.

Grafik Kinerja Produktivitas IKO Berdasarkan Spesialisasi Pembedahan 2023



Berdasarkan grafik 10. Menunjukkan bahwa 30 % pasien operasi pada periode tahun 2023 adalah pasien bedah umum, 23 % adalah pasien obgin, 12% adalah pasien orthopedi dan urologi, 8 % pada pasien mata, 6% pada pasien bedah mutut dan 2% pada pasien bedah mulut. Peningkatan jumlah pasien operasi mulai bulan Januari sampai dengan Juli, dan mengalami penurunan sebesar 15% di bulan Agustus. Pada bulan September mengalami peningkatan sampai bulan November akan tetapi terjadi penurunan kembali menjadi 443 kunjungan pada bulan Desember 2023.

B. PDSA

PDSA Kinerja Produktivitas IKO periode Tahun 2023

Problem	Penurunan jumlah pasien operasi pada pertengahan tahun
Step	Melakukan telusur penyebab terjadinya penurunan pasien operasi
Plan	Rencana : Menambah sarana dan intrumen untuk diversifikasi tindakan operasi Harapan : Peningkatan jumlah kunjungan pasien operasi periode tahun 2024 Tindakan : a. Koordinasi dengan DPJP bedah terkait diversifikasi tindakan dan penambahan sarana serta instrument di kamar operasi b. Koordinasi dengan SDM untuk open recrutmen dokter gigi spesialis c. Koordinasi dengan humas dan marketing terkait promosi pengembangan pelayanan di kamar operasi d. Koordinasi dengan PKRS terkait pengembangan kamar operasi yang disampaikan di sosmed
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Cara meningkatkan kunjungan pasien IKO periode tahun 2023
Study	Apa yang anda pelajari ? Cara meningkatkan kunjungan pasien IKO Cara penambahan diversifikasi tindakan IKO
Action	Apa yang anda pelajari ? a. Diversifikasi tindakan dan penambahan sarana serta instrument di kamar operasi b. Open recrutmen dokter gigi spesialis d. Penyebaran terkait pengembangan IKO melalui sosmed Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi jumlah pasien operasi periode tahun 2023

Tabel 11. Rencana Tindak Lanjut

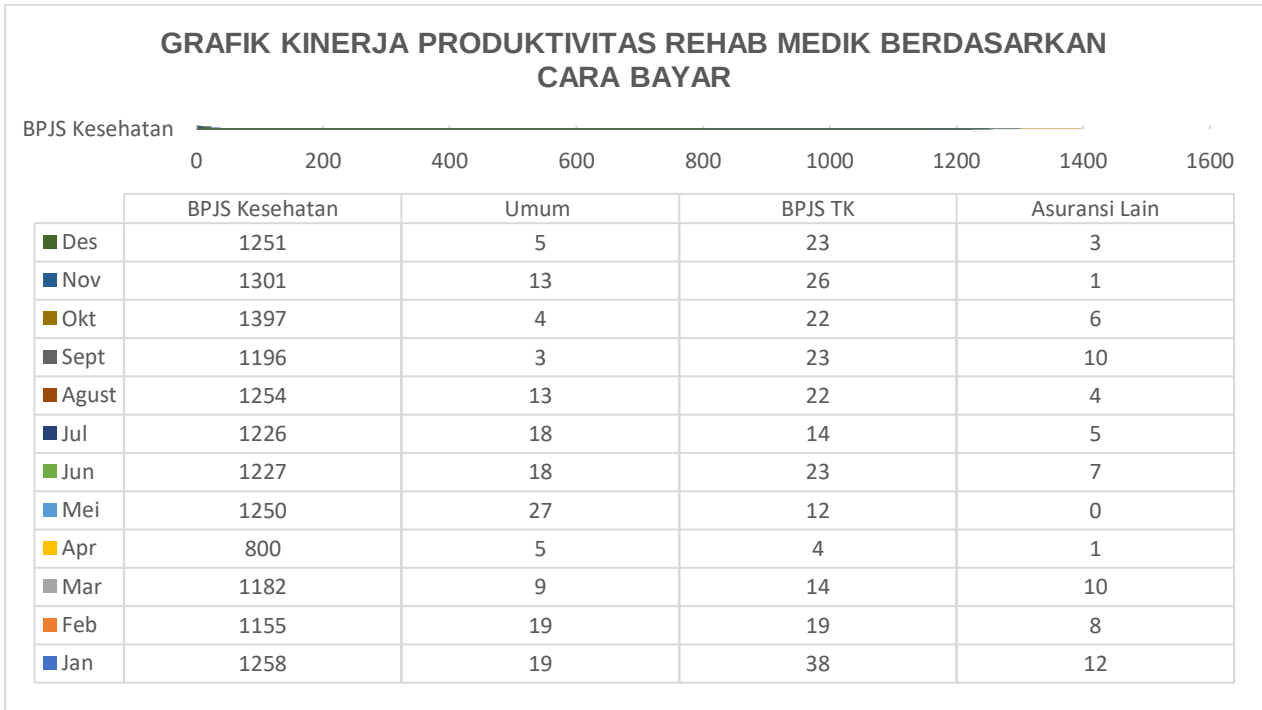
No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Koordinasi dengan DPJP bedah terkait diversifikasi tindakan dan penambahan sarana serta instrument di kamar operasi												
2	Koordinasi dengan SDM untuk open recrutmen dokter gigi spesialis												
3	Koordinasi dengan humas dan marketing terkait promosi pengembangan pelayanan di kamar operasi												
4	Koordinasi dengan PKRS terkait pengembangan kamar operasi yang disampaikan di sosmed												

E. Rehab Medik
Tabel Kinerja Produktivitas Rehab Medik Berdasarkan Cara Bayar 2023

No	Cara Bayar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	BPJS Kesehatan	1258	1155	1182	800	1250	1227	1226	1254	1196	1397	1301	1251
2	Umum	19	19	9	5	27	18	18	13	3	4	13	5
3	BPJS TK	38	19	14	4	12	23	14	22	23	22	26	23
4	Asuransi Lain	12	8	10	1	0	7	5	4	10	6	1	3
TOTAL		1236	1201	1215	810	1289	1273	1264	1293	1232	1429	1341	1282

Berdasarkan tabel 12. Menunjukkan cara bayar pasien rehab medik 97 % menggunakan BPJS kesehatan, 1,6% menggunakan BPJS TK, 1 % menggunakan umum dan 0,4 % menggunakan asuransi lain. Pada bulan Oktober adalah kunjungan rehab medik tertinggi yaitu sebanyak 1397 pasien menggunakan BPJS kesehata

A. Grafik 11. Kinerja Produktivitas Rehab Medik Berdasarkan Cara Bayar 2023



Berdasarkan grafik 11. Menunjukkan cara bayar pasien rehab medik 97 % menggunakan BPJS kesehatan, 1,6% menggunakan BPJS TK, 1 % menggunakan umum dan 0,4 % menggunakan asuransi lain. Pada bulan Oktober adalah kunjungan rehab medik tertinggi yaitu sebanyak 1397 pasien menggunakan BPJS kesehatan

B. PDSA

Tabel 03. PDSA Kinerja Produktivitas Rehab Medik periode Tahun 2023

Problem	Rendahnya kunjungan rehan medik dengan cara bayar umum
Step	Analisa dilakukan untuk meningkatkan kunjungan pasien rehab medik dengan menggunakan pembayaran umum
Plan	Rencana : mengetahui penyebab kunjungan rehab medik dengan cara bayar umum yang rendah Harapan : Meningkatnya kunjungan pasien rehab medik dengan cara bayar umum Tindakan : - Melakukan koordinasi dengan humas dan marketing serta PKRS untuk mempromosikan pelayanan rehab medik - Koordinasi dengan bagian keuangan untuk membuat promo paketan rehab medik saat hari besar - Melakukan evaluasi kunjungan pasien umum setiap bulan
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Cara meningkatkan kunjungan pasien rehab medik dengan cara bayar umum
Study	Apa yang anda pelajari ? Cara mempromosikan rehab medik melalui sosial media dan ke perusahaan Membuat promo pelayanan rehab medik
Action	Apa yang anda pelajari ? Pada kunjungan pasien rehab medik dengan cara bayar umum. Membuat paket promo pelayanan rehab medik Follow-up dan Rencana Tindak Lanjut Evaluasi kunjungan rehab medik pada periode tahun 20224

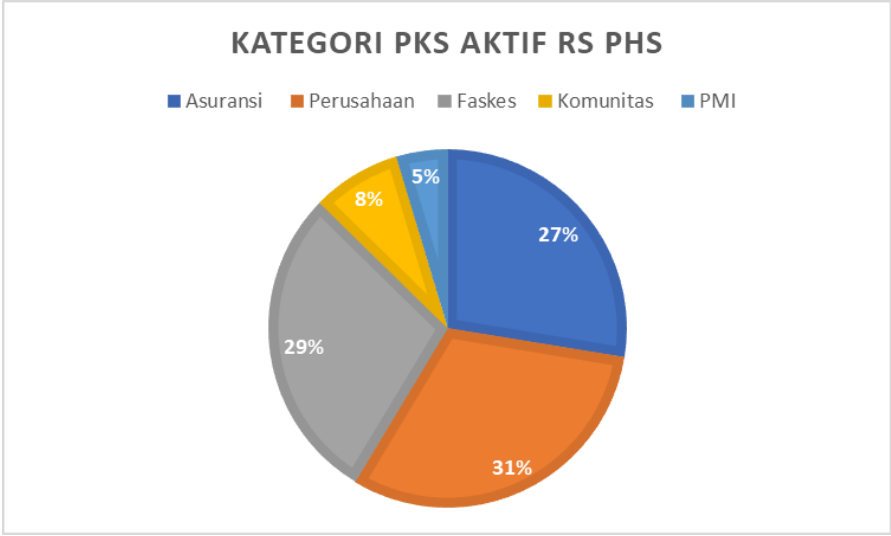
Tabel 04. Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Tindak Lanjut	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES
1	Melakukan koordinasi dengan humas dan marketing serta PKRS untuk mempromosikan pelayanan rehab medik												
2	Koordinasi dengan bagian keuangan untuk membuat promo paketan rehab medik saat hari besar												
3	Melakukan evaluasi kunjungan pasien umum setiap bulan												

3.3.3. Umum

A. HUMAS dan MARKETING
IKS/PKS, Data Perjanjain Kerjasama RS Prima Husada Sukorejo

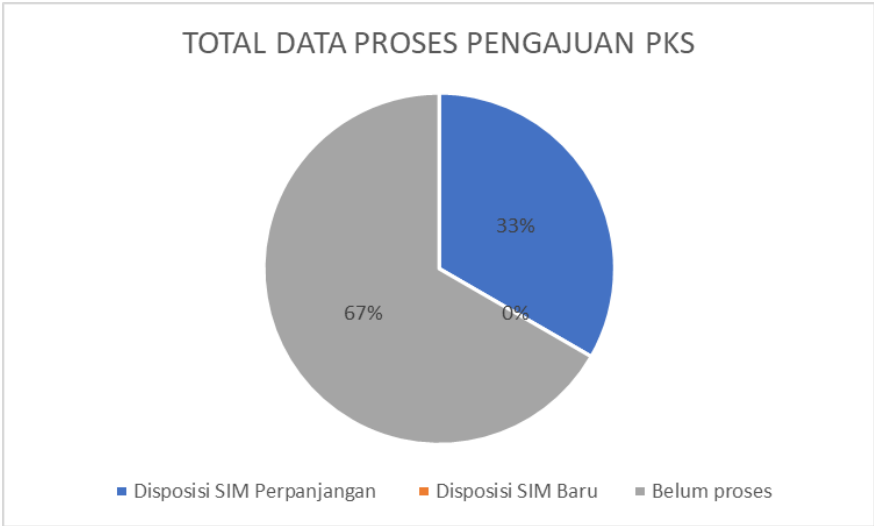
DATA PKS RS PHS	TOTAL	KETERANGAN
Berlaku/Tidak Expired	83	Masih aktif
Expired	7	Masa berlaku habis
Proses perpanjangan	5	Sudah menghubungi dan dalam sedang proses perpanjangan
Pengajuan Baru	1	Pengajuan PKS ke perusahaan
	96	



Gambar 3.1.1. Grafik pie distribusi IKS

Tabel Data Perjanjain Kerjasama Proses Pengajuan RS Prima Husada Sukorejo

DATA PKS PROSES PENGAJUAN RS PHS	TOTAL
Disposisi SIM Perpanjangan	1
Disposisi SIM Baru	0
Belum proses	2
	4



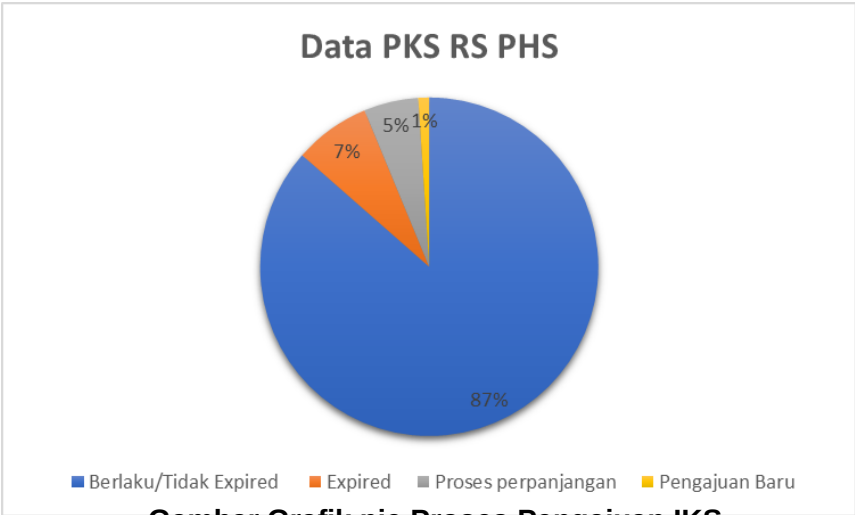
Gambar Grafik pie Proses Pengajuan IKS

Analisis :
Dari 5 data PKS yang harus di perpanjang sudah menghubungi yg terkait dan sudah kirim draft baru dan 1 PKS pengajuan baru masih tahap pengisian oleh pihak kedua.

RTL:
Rencana tindak lanjut: Follow Up PIC perusahaan, Melakukan rencana untuk kunjungan perusahaan.

Jenis kelompok Lembaga Yang Bekerjasama Dengan RSPHS

DATA KATEGORI PKS AKTIF RS PHS	TOTAL
Asuransi	24
Perusahaan	27
Faskes	25
Komunitas	7
PMI	4
	87

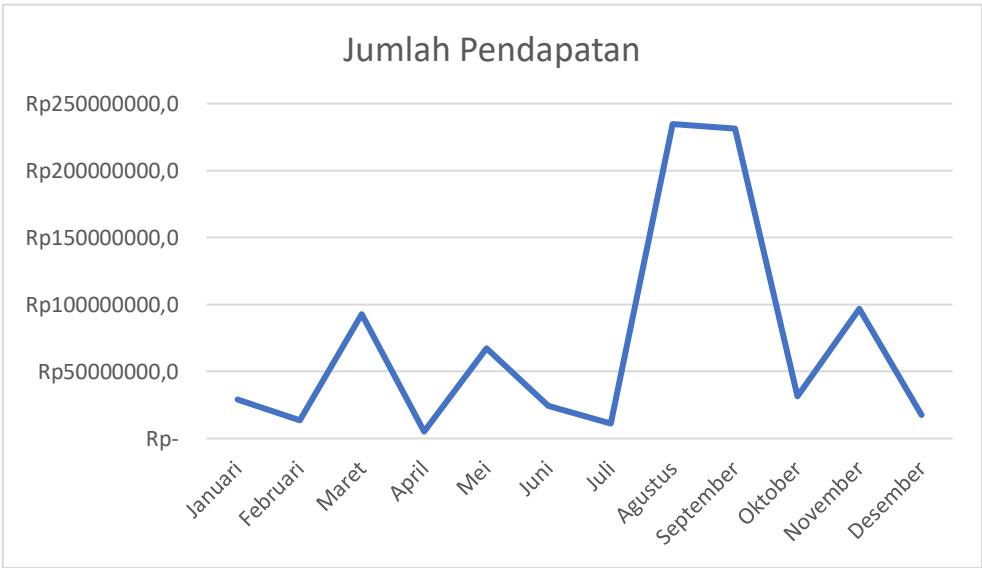


Gambar Grafik pie Proses Pengajuan IKS

1.4. Penjualan

Tabel. Laporan Penjualan Humas dan Marketing 2023

Bulan	Jumlah Pendapatan
Januari	Rp. 29.166.150
Februari	Rp. 13.710.650
Maret	Rp. 92.728.650
April	Rp. 5.148.650
Mei	Rp. 67.369.484
Juni	Rp. 24.443.700
Juli	Rp. 11.288.300
Agustus	Rp. 234.727.053
September	Rp. 231.474.262
Oktober	Rp. 31.651.150
November	Rp. 96.796.350
Desember	Rp. 17.527.950



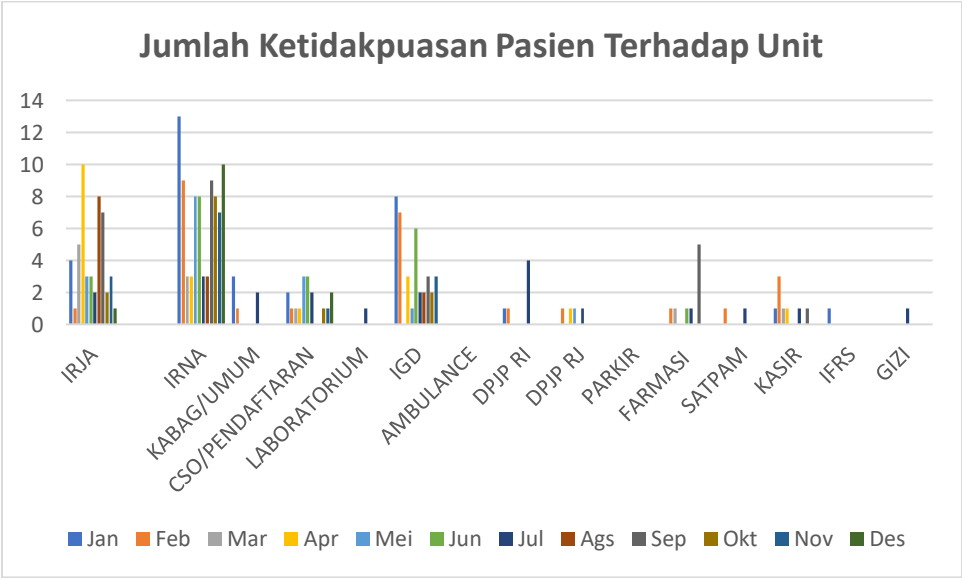
Gambar Grafik Pendapatan Marketing

B. MOD / PIPP

Kinerja Produktifitas

a. Jumlah ketidakpuasan pasien

Jumlah Ketidakpuasan Pasien Terhadap Unit	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
IRJA	4	1	5	10	3	3	2	8	7	2	3	1
IRNA	13	9	3	3	8	8	3	3	9	8	7	10
KABAG/UMUM	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
CSO/PENDAFTARAN	2	1	1	1	3	3	2	0	0	1	1	2
LABORATORIUM	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
IGD	8	7	0	3	1	6	2	2	3	2	3	0
AMBULANCE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DPJP RI	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
DPJP RJ	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
PARKIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FARMASI	0	1	1	0	0	1	1	0	5	0	0	0
SATPAM	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
KASIR	1	3	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
IFRS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GIZI	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0



Analisa	Jumlah ketidakpuasan pasien di tiap unit, jumlah paling tinggi terdapat di rawat inap
Rencana Tindak Lanjut	Koordinasi dan rapat dengan kabid tujuannya untuk meningkatkan pelayanan

b. Fasilitas Kesehatan dan K3

Nama MPP/MOD/PIPP	MCU	SAKIT	IZIN	KECELAKAAN KERJA	VAKSIN
Nuri Aini Izzah S.Kep.,Ns	Dilakukan mcu tanggal 27/06/23	-	-	-	Sudah vaksin dosis 4
Khotimah S.Tr.Keb	Dilakukan mcu tanggal 27/06/23	-	-	-	Sudah vaksin dosis 4
Desi Alimatus F, A.Md.Keb	Dilakukan mcu tanggal 27/06/23	-	-	-	Sudah vaksin dosis 4
Rina Indah K, A.md. Kep	Dilakukan mcu tanggal 27/06/23	-	-	-	Sudah vaksin dosis 4

3.5 Mutu

No	Indikator	Standar
1	Angka ketidakpuasan pasien rawat inap	0 %
2	Angka kecepatan respon terhadap complaint terkait pelayanan Rawat Inap	100%

C. ASURANSI CENTER

Kinerja Produktifitas

a. Jumlah Klaim Reguler JKN

NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	9.261	8.027	8.927	7.447	10.881	10.000	10.358	10.952	10.499	11.404	11.473		109.229
2	Pending	30	35	88	41	27	25	17	16	38	27	21		365
3	Tidak Layak	14	5	2	2	3	-	7	1	-	-	-		34
	Jumlah	9.305	8.067	9.017	7.490	10.911	10.025	10.382	10.969	10.537	11.431	11.494	-	109.628

b. Jumlah Nominal klaim JKN

NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	6.352.527.192	6.219.395.965	6.576.695.468	5.762.370.700	7.865.480.312	7.142.479.150	7.226.918.249	8.022.790.800	8.080.099.994	8.706.155.783	9.096.621.061		81.051.534.674
2	Pending	179.282.200	328.033.500	599.610.200	280.430.100	302.015.000	385.518.900	361.764.100	252.185.000	411.417.600	27.839.800	326.638.200		3.454.734.600
3	Tidak Layak	3.074.900	1.175.100	392.200	392.200	1.071.600	-	1.934.100	323.800	-	-	-		8.363.900
	Jumlah	6.534.884.292	6.548.604.565	7.176.697.868	6.043.193.000	8.168.566.912	7.527.998.050	7.590.616.449	8.275.299.600	8.491.517.594	8.733.995.583	9.423.259.261	-	84.514.633.174

c. Jumlah Klaim Alkes

NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	45	47	48	54	51	72	67	72	102	82	74		714
2	Pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tidak Layak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Jumlah	45	47	48	54	51	72	67	72	102	82	74	-	714

d. Jumlah Nominal Klaim Alkes

NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	23.973.436	28.387.672	25.606.904	29.610.336	28.361.440	34.916.804	37.250.636	40.061.561	53.805.864	44.504.820	40.128.189		386.607.662
2	Pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tidak Layak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Jumlah	23.973.436	28.387.672	25.606.904	29.610.336	28.361.440	34.916.804	37.250.636	40.061.561	53.805.864	44.504.820	40.128.189	-	386.607.662

3.3.5 Jumlah Klaim Ambulance

NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	8	13	13	10	13	15	16	7	9	12	9		125
2	Pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tidak Layak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Jumlah	8	13	13	10	13	15	16	7	9	12	9	-	125

3.3.6 Jumlah Nominal Klaim Ambulance

NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	2.870.000	5.005.000	5.005.000	3.850.000	5.005.000	5.775.000	5.940.000	2.695.000	2.863.000	4.620.000	3.465.000		47.093.000
2	Pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
3	Tidak Layak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Jumlah	2.870.000	5.005.000	5.005.000	3.850.000	5.005.000	5.775.000	5.940.000	2.695.000	2.863.000	4.620.000	3.465.000	-	47.093.000

3.3.7 Jumlah Klaim Apotik Online

NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	2.616	2.530	2.903	2.375	3.112	2.977	3.235	3.284					23.032
2	Pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tidak Layak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.616	2.530	2.903	2.375	3.112	2.977	3.235	3.284	-	-	-	-	23.032

3.3.8 Jumlah Nominal Apotik Online

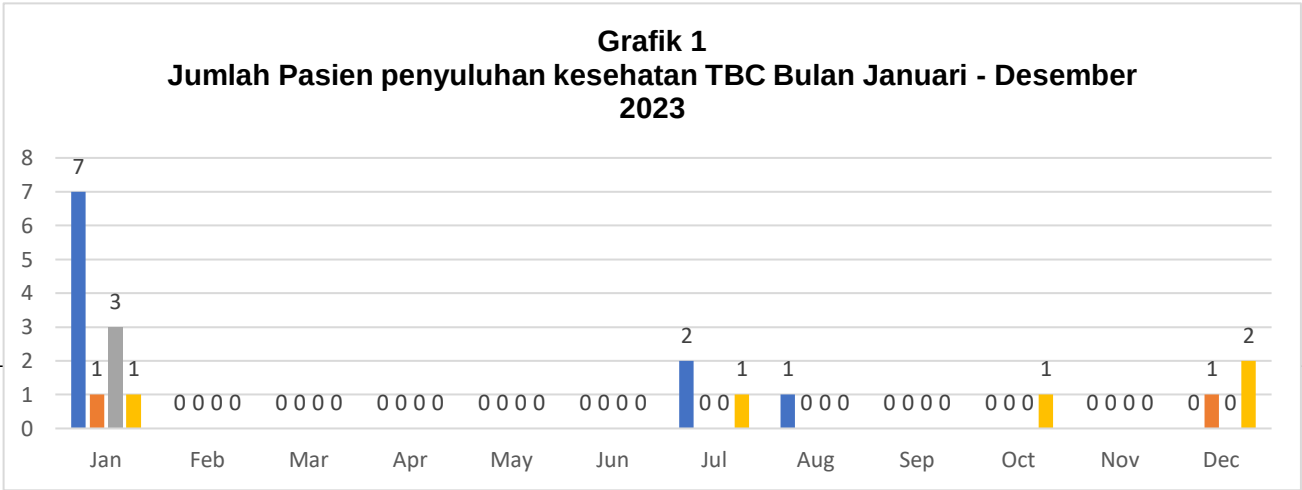
NO	Keterangan	Bulan												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Layak	332.403.251	317.885.870	344.127.724	304.641.906	387.227.707	382.865.180	395.421.413	402.547.087					2.867.120.138
2	Pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tidak Layak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	332.403.251	317.885.870	344.127.724	304.641.906	387.227.707	382.865.180	395.421.413	402.547.087	-	-	-	-	2.867.120.138

Analisa	- Berdasarkan jumlah klaim pasien BPJS Kesehatan mengalami kenaikan dan cenderung stabil. - Klaim Reguler BPJS Kesehatan yang belum terselesaikan adalah bulan oktober dan November. Klaim pending terdiri dari penentuan resource ketepatan pengkodean diagnose dan tindakan, terapi terkait dengan diagnose yang diberikan - Terdapat klaim yang tidak layak yaitu kasus MRS pada hari yang sama, Dimana pasien mendapatkan pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang sama maka yang diakui oleh BPJS Kesehatan adalah rawat inap - Sedangkan untuk klaim apotik online yang masih belum diajukan adalah bulan September sampai dengan desember, kendala yang dihadapi yaitu perubahan tarif/katalog obat dari BPJS Kesehatan awal tahun dimana sistem apotik online masih belum sepenuhnya dilakukan update tarif obat-obat kronis tidak dapat diinputkan di apotik online dan dapat diinputkan di apotik online pada pertengahan tahun, yang mengakibatkan penumpukan inputan yang berdampak pada mundurnya jadwal klaim
Rencana Tindak Lanjut	- Berkoordinasi dengan DPJP terkait dengan klaim pending agar dapat segera diajukan ke BPJS Kesehatan - Melakukan pengecekan Kembali terkait pasien yang mendapatkan pelayanan RJ dan RI dihari yang sama - Melakukan koordinasi dengan tim farmasi dan verifikator BPJS Kesehatan untuk membuat jadwal klaim apotik online agar dapat segera terdapat dan mengejar ketertinggalan

3.3.4. Program Nasional (PROGNAS)
A. TB DOTS

1. Jumlah pasien TBC yang diberi Penyuluhan Kesehatan tentang TBC

No	Jenis Pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penyuluhan kesehatan tentang tuberculosis	15	15	15	20	20	20	25	20	15	15	20	23



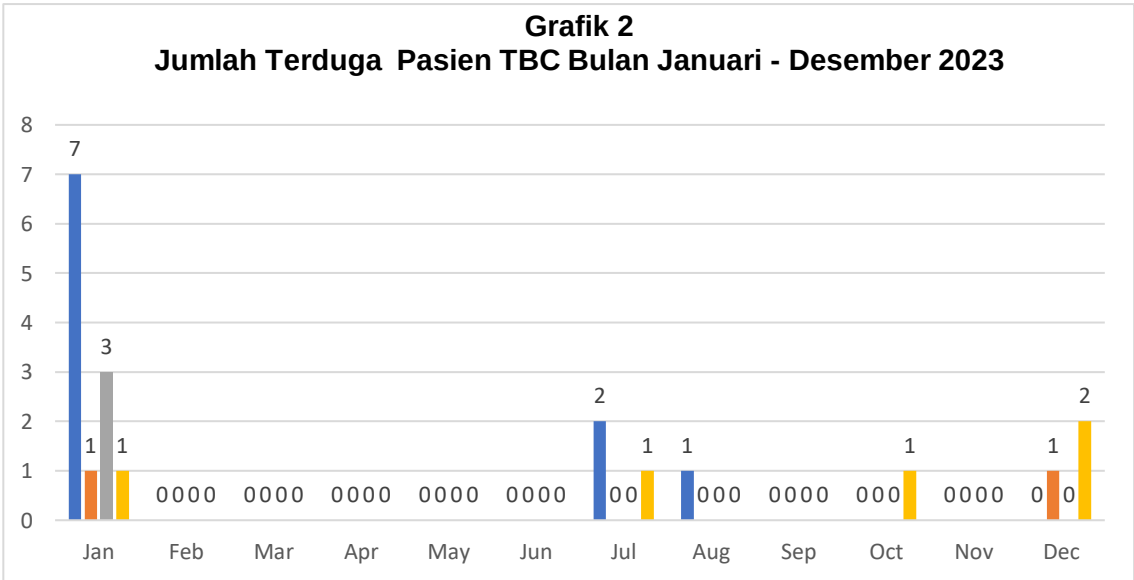
Analisis Jumlah pasien TBC yang diberi Penyuluhan Kesehatan

Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan promosi Kesehatan pada pasien TBC tentang tuberculosis.
 - Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB

2. Jumlah Pasien Terduga TBC

No	Jumlah	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Terduga pasien TBC	51	46	38	32	36	35	38	53	57	42	49	48



Analisis

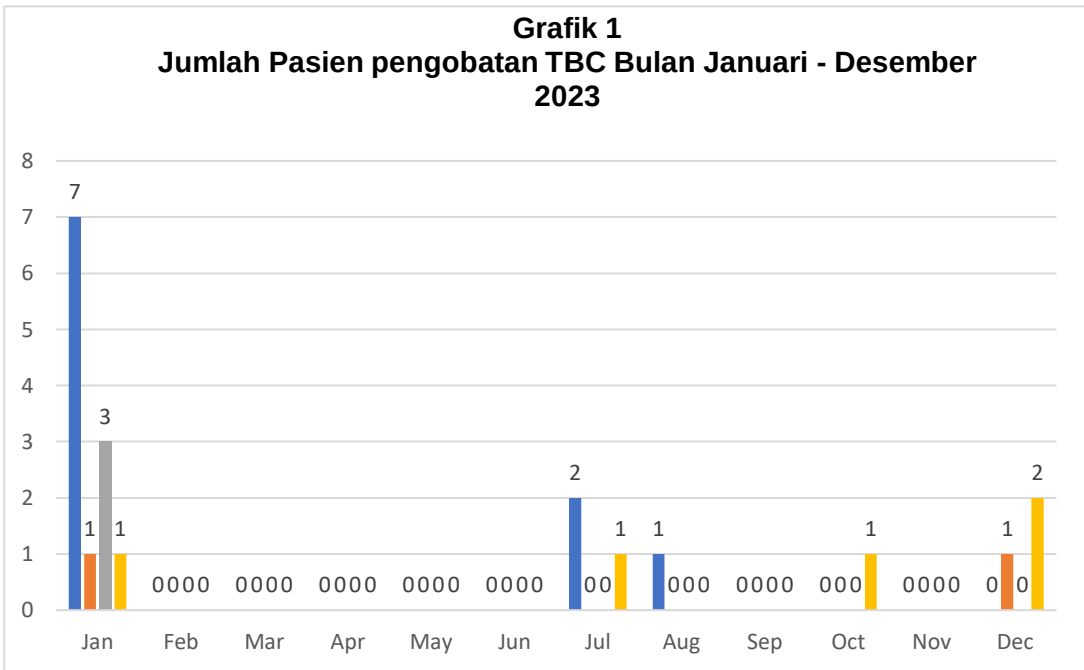
Pada Bulan Januari terdapat 51 terduga pasien kemudian pada bulan februari Hingga Desember mengalami penurunan dan kenaikan jumlah kasus terduga TBC hingga 48 pasien terduga TBC

Rencana Tindak Lanjut

Melakukan edukasi terhadap keluarga pasien dengan kontak TB untuk melakukan skrining TB

3. Jumlah pasien TBC yang pengobatan di tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pasien TBC yang pengobatan	8	8	4	3	3	4	4	3	5	7	5	4



Analisis

Pada bulan Januri terdapat 7 pasien yang pengobatan kemudian mangalami penurunan kasus pasien TBC yang pengobatan hingga bulan desember dengan jumlah 4 pasien.

Rencana Tindak Lanjut

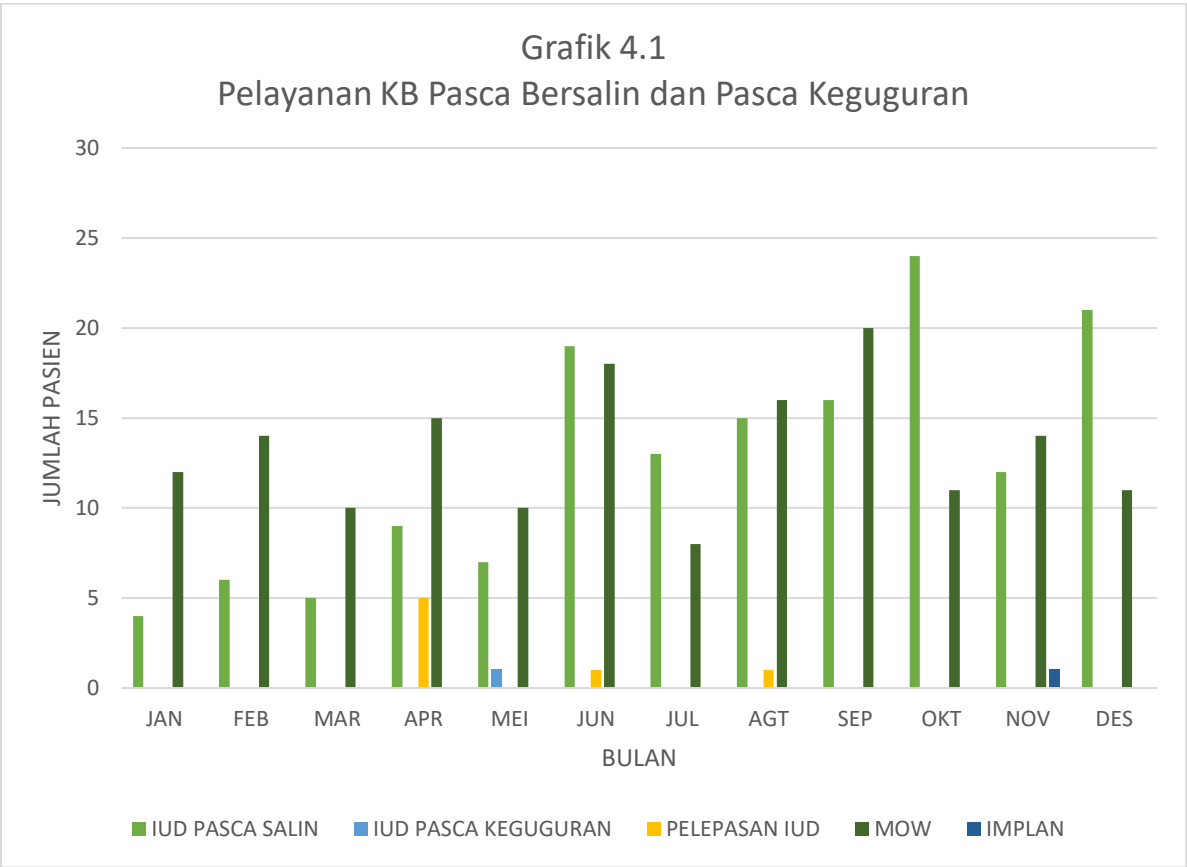
- 1) Menginformasikan kepada pasein dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan dengan teratur dan sesuai jadwal, serta mengedukasi kepada keluarga pasie untuk melakukan skrinning TB
- 2) Mempertahankan pelayanan yang terbaik untuk pasien sesuai pilihan pasien untuk berobat.
- 3) Menetapkan pengambilan obat setiap ada pasien tb baru

B. PKBRS

Jumlah Kegiatan Pelayanan PKBRS

NO	BULAN	PEMASANGAN IUD		PELEPASAN IUD	TINDAKAN MOW	IMPLAN
		PASCA SALIN	PASCA KEGUGURAN			
1.	JANUARI	4	-	-	12	-
2.	FEBRUARI	6	-	-	14	-
3.	MARET	5	-	-	10	-
4.	APRIL	9	-	-	15	-
5.	MEI	7	1	-	10	-
6.	JUNI	19	-	1	18	-
7.	JULI	13	-	-	8	-
8.	AGUSTUS	15	-	1	16	-
9.	SEPTEMBER	16	-	-	20	-
10.	OKTOBER	24	-	-	11	-

11.	NOVEMBER	12	-	-	14	1
12.	DESEMBER	21	-	-	11	-
TOTAL		151	1	2	159	1

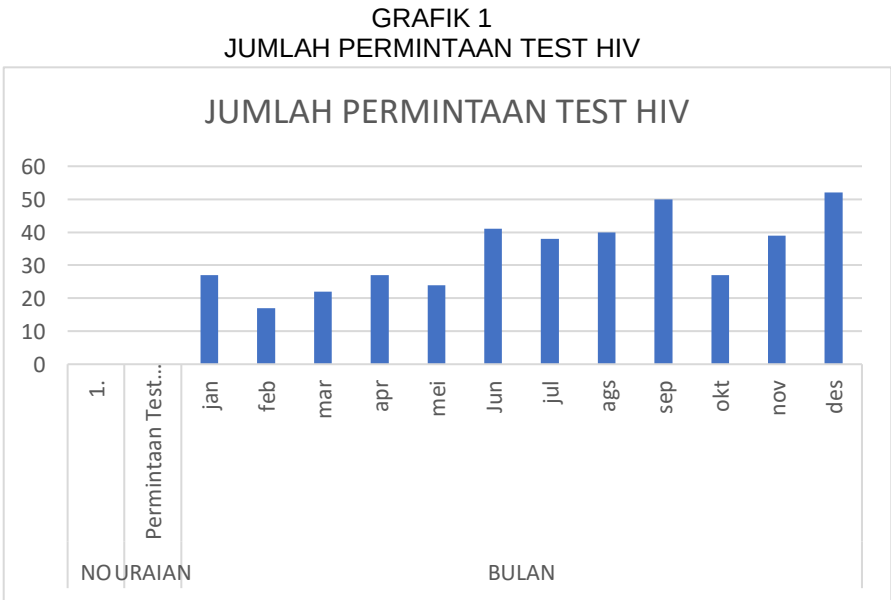


Analisis :
 Pada tahun 2023 terdapat akseptor KB pasca salin sangat fluktuatif dibandingkan dengan KB pasca keguguran.
 Rencana Tindak Lanjut :
 Melakukan promosi kesehatan pada pasien pasca keguguran mengenai pentingnya kontrasepsi pasca keguguran

C. HIV AIDS

1. Jumlah permintaan Tes HIV/AIDS

NO	URAIAN	BULAN											
		jan	feb	mar	apr	mei	Jun	jul	ags	sep	okt	nov	des
1.	Permintaan Test HIV/AIDS	27	17	22	27	24	41	38	40	50	27	39	52





Analisis Jumlah Permintaan Test HIV/AIDS:

Permintaan test HIV/AIDS tertinggi pada bulan desember 2023 terdapat 52 permintaan testing HIV/AIDS.

Rencana dan Tindak Lanjut :

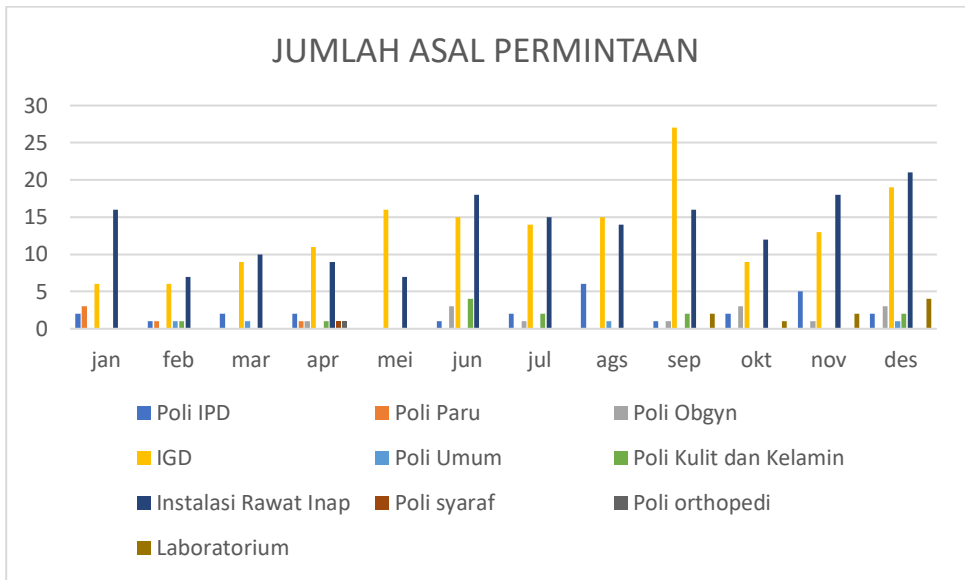
Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.

1. Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
2. Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
3. Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA.
4. Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pasien TB yang status HIV nya tidak diketahui
5. Melakukan edukasi dan sosialisasi terduga TB yang status HIV nya tidak diketahui.

ASAL PERMINTAAN TES HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN											
		jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des
1	Poli IPD	2	1	2	2	0	1	2	6	1	2	5	2
2	Poli Paru	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Poli Obgyn	0	0	0	1	0	3	1	0	1	3	1	3
4	IGD	6	6	9	11	16	15	14	15	27	9	13	19
5	Poli Umum	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
6	Poli Kulit dan Kelamin	0	1	0	1	0	4	2	0	2	0	0	2
7	Instalasi Rawat Inap	16	7	10	9	7	18	15	14	16	12	18	21
8	Poli syaraf	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Poli orthopedi	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	4

GRAFIK 2
JUMLAH ASAL PERMINTAAN TEST HIV/AIDS



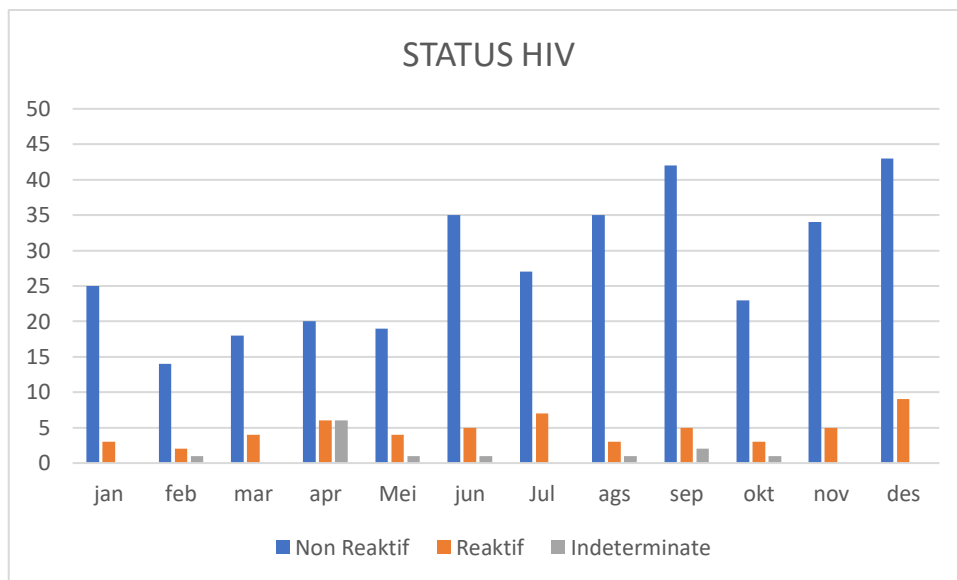
Analisis Asal Permintaan Tes HIV/AIDS
Peningkatan permintaan test HIV/AIDS terdapat di IGD pada bulan September 2023.

- Rencana dan Tindak Lanjut:
- 1. Kolaborasi dengan bagian marketing rumah sakit terkait jumlah kunjungan pasien.
 - 2. Melakukan edukasi kepada pasien hamil untuk pemeriksaan ANC.
 - 3. Melakukan edukasi kepada pasien dengan populasi kunci seperti WPS, waria, LSL dan penasun.
 - 4. Melakukan edukasi untuk tes HIV/AIDS pada pasien TB, pasien hepatitis, wargabinaan pemasyarakatan (WBP), pasien IMS, pasangan tetap ataupun tidak tetap ODHA

STATUS HIV		BULAN											
No	URAIAN	jan	feb	mar	apr	Mei	jun	Jul	ags	sep	okt	nov	des
1	Non Reaktif	25	14	18	20	19	35	27	35	42	23	34	43
2	Reaktif	3	2	4	6	4	5	7	3	5	3	5	9
3	Indeterminate	0	1	0	1	1	1	0	1	2	1	0	0



GRAFIK 3
STATUS HIV DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI-DESEMBER 2023



Analisis Status HIV/AIDS:

Pada bulan Januari 2023 terdapat 25 non reaktif HIV/AIDS dan 3 pasien reaktif HIV/AIDS. Pada bulan Februari 2023 terdapat pasien 14 non reaktif HIV/AIDS, 2 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 pasien inkonklusif, pada bulan Maret 2023 terdapat 18 pasien non reaktif HIV/AIDS dan 4 pasien reaktif HIV/AIDS. Pada bulan April 2023 terdapat 20 non reaktif HIV/AIDS, 6 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 indeterminate. Pada bulan Mei 2023 terdapat 19 non reaktif HIV/AIDS, 4 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 indeterminate. Pada bulan Juni 2023 terdapat 35 non reaktif HIV/AIDS, 5 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 indeterminate. Pada bulan Oktober 2023 terdapat 23 non reaktif HIV/AIDS, 3 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 indeterminate. Pada bulan November 2023 terdapat 24 non reaktif HIV/AIDS, 5 pasien reaktif HIV/AIDS dan 0 indeterminate. Pada bulan Desember 2023 terdapat 43 non reaktif HIV/AIDS, 9 pasien reaktif HIV/AIDS dan 0 indeterminate.

- a. Apabila hasil positif : Bila hasil A1 reaktif. A2 reaktif dan A3 reaktif
Apabila hasil Negatif :
1. Bila hasil A1 non reaktif
 2. Bila hasil A1 reaktif tapi pada pengulangan A1 dan A2 non reaktif
 3. Bila salah satu reaktif tapi tidak berisiko
dan apabila Hasil indeterminate
1. Bila dua hasil reaktif
 2. Bila hanya 1 tes reaktif tapi berisiko atau pasangan berisiko

Rencana Tindak Lanjut:

1. Tindak lanjut hasil positif
 - a. Rujuk ke pengobatan HIV
2. Tindak lanjut hasil negatif
 - a. Bila hasil negatif dan berisiko dianjurkan pemeriksaan ulang minimum 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama
 - b. Bila hasil negatif dan tidak berisiko dianjurkan perilaku sehat
3. Tidak lanjut hasil indeterminate



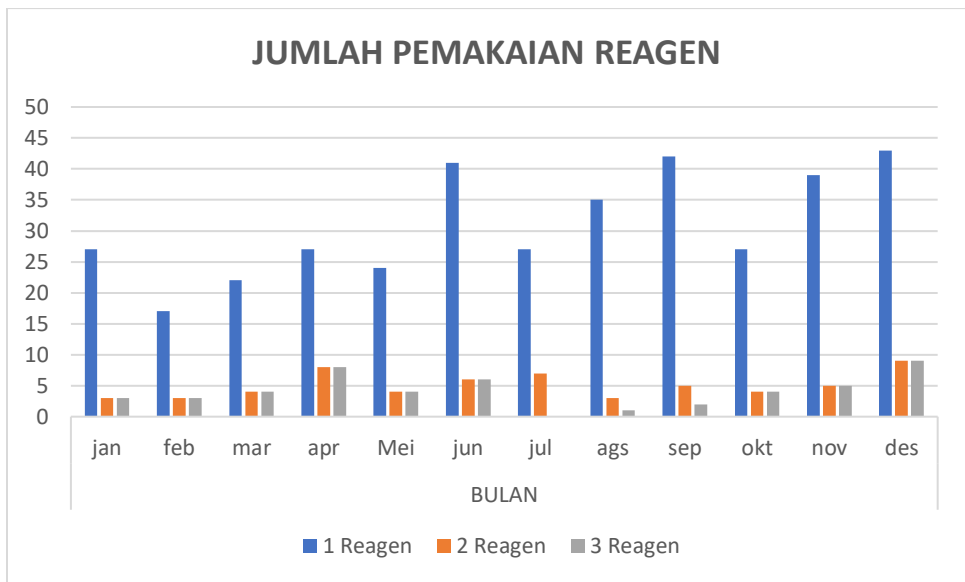
- Tes perlu diulang dengan spesimen baru minimum setelah duaminggu dari pemeriksaan yang pertama
- Bila hasil tetap indeterminate, dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR
- Bila tidak ada akses ke pemeriksaan PCR, rapid tes diulang 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan pertama.
- Bila sampai setahun tetap “indeterminate” dan faktor risiko rendah, hasil dinyatakan sebagai negative.

2. JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN

No	URAIAN	BULAN											
		jan	feb	mar	apr	Mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des
1	1 Reagen	27	17	22	27	24	41	27	35	42	27	39	43
2	2 Reagen	3	3	4	8	4	6	7	3	5	4	5	9
3	3 Reagen	3	3	4	8	4	6	0	1	2	4	5	9

GRAFIK 4

JUMLAH PEMAKAIAN REAGEN DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA



Analisis jumlah pemakaian reagen:

Pada bulan Januari 2023 ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV, pada bulan Februari ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV dan pada bulan Maret 2023 ada 0 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV. Pada bulan Juni 2023 terdapat 41 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 6 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 6 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan Juli 2023 terdapat 27 non reaktif HIV/AIDS, 7 pasien reaktif HIV/AIDS dan 0 indeterminate. Pada bulan Agustus 2023 terdapat 35 non reaktif HIV/AIDS, 3 pasien reaktif HIV/AIDS dan 1 indeterminate, dan Pada bulan September 2023 terdapat 42 non reaktif HIV/AIDS, 5 pasien reaktif HIV/AIDS dan 2 indeterminate. Pada bulan Oktober 2023 terdapat 27 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 4 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 4 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan November 2023 terdapat 39 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 5 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 5 pasien menggunakan jenis reagen 3. Pada bulan Desember 2023 terdapat 52 pasien yang menggunakan pemeriksaan dengan jenis reagen 1, 9 pasien yang menggunakan jenis reagen 2 dan 9 pasien menggunakan jenis reagen 3.

Rencana tindak lanjut:

- Pemeriksaan dilakukan secara serial dengan menggunakan 3 jenis reagen yang berbeda sesuai dengan pedoman nasional.

- Penyimpanan reagen HIV dilakukan sesuai dengan instruksi yang tertera dilembar informasi dan digunakan sebelum tanggal kedaluwarsa.

3. PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS

No	URAIAN	BULAN											
		jan	feb	mar	apr	mei	jun	jul	ags	sep	okt	nov	des
1	Pelayanan Rujukan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

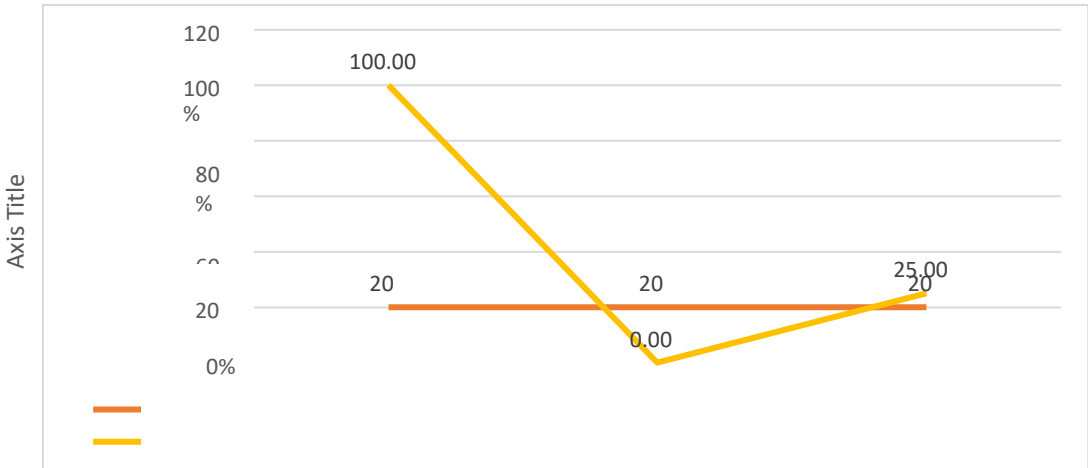
GRAFIK 5
 PELAYANAN RUJUKAN PASIEN DENGAN HIV/AIDS
 BULAN **JANUARI-DESEMBER 2023**



Analisis Pelayanan rujukan pasien dengan HIV/AIDS
 Pada bulan November 2023 ada 1 pasien yang dirujuk untuk pengobatan ARV.
Rencana Tindak Lanjut:
 Penemuan kasus HIV lebih dini meningkatkan akses perawatan dan pengobatan yang memadai sehingga mengurangi angka kematian.

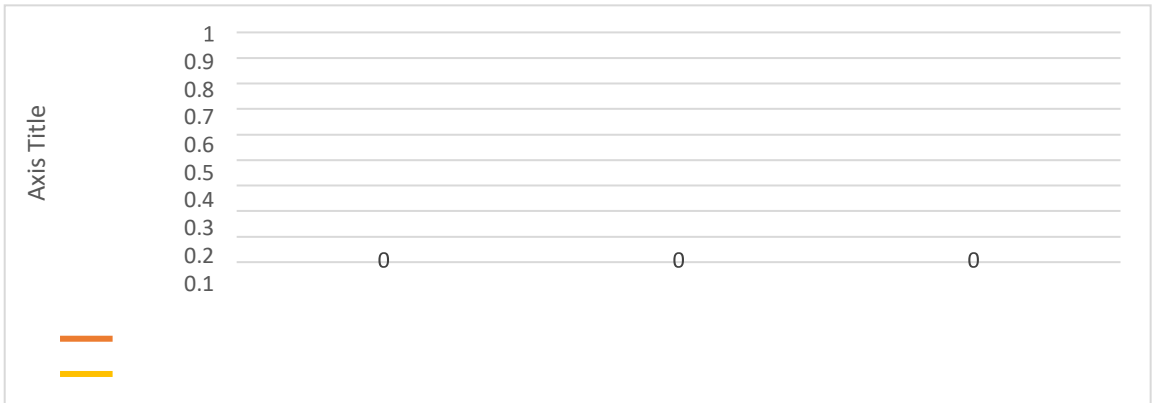
KUNCI INDIKATOR MUTU HIV/AIDS			
INDIKATOR MUTU	OKT	NO V	DES
Kejadian tidak teridentifikasi pasien HIV pada pasien bedah	0%	0%	0%
Angka kesakitan HIV/ AIDS	100%	0%	25%

GRAFIK 6
 KUNCI INDIKATOR MUTU ANGKA KESAKITAN HIV/ AIDS
 DI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
 BULAN **JANUARI-DESEMBER 2023**



GRAFIK 7

KUNCI INDIKATOR MUTU KEJADIAN TIDAK TERIDENTIFIKASI PASIEN HIV/AIDS
PADA PASIEN BEDAHDI RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
BULAN JANUARI-DESEMBER 2023



	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
STANDARD	0	0	0
CAPAIAN	0	0	0

Analisis kunci indikator mutu HIV/AIDS:

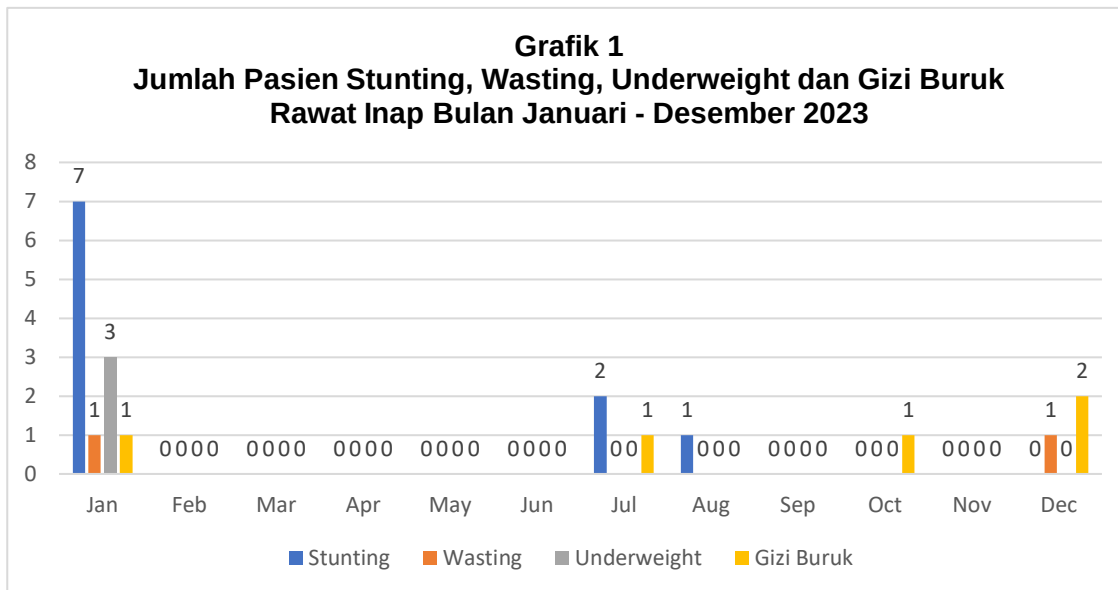
Pada bulan Oktober 2023 ada 3 angka kesakitan HIV/AIDS. Pada bulan November 2023 ada 5 angka kesakitan HIV/AIDS. Pada bulan Desember 2023 ada 9 angka kesakitan HIV/AIDS

- Rencana Tindak Lanjut:**
- a. Melakuakn upaya pencegahan meliputi beberapa aspek yaitu penyebaran informasi, promosi penggunaan kondom, skrining darah pada donor darah, pengendalian IMS.
 - b. Mengedukasi dan penyebaran informasi perlu menekankan manfaat tes HIVdan pengobatan ARV.

D. STUNTING

4. Jumlah Pasien Stunting, Wasting, Underweight, dan Gizi Buruk Rawat Inap

No	Masalah Gizi	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Stunting	7	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
2	Wasting	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Underweight	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Gizi Buruk	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2



Analisis Jumlah Pasien Stunting, Wasting, Underweight, Gizi Buruk

Pada bulan Januari terdapat 7 pasien stunting, 1 pasien wasting, 3 pasien underweight dan 1 pasien gizi buruk. Pada bulan Februari sampai Juni tidak terdapat pasien stunting, wasting, underweight dan gizi buruk. Di Bulan Juli terdapat 2 pasien stunting dan 1 pasien gizi buruk. Sedangkan pada bulan Agustus terdapat pasien Stunting. Bulan September tidak terdapat masalah gizi dan pada Bulan Oktober terdapat 1 pasien dengan masalah gizi buruk. Bulan November tidak terdapat masalah gizi pada pasien anak dan di Bulan Desember terdapat 1 pasien wasting dan 2 pasien gizi buruk.

Rencana Tindak Lanjut Pasien Stunting, Wasting, Underweight, Gizi Buruk

Petugas medis melakukan pemantauan asupan makan pasien, perubahan berat badan selama rawat inap dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait kondisi fisik klinis pasien.

5. Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staff, pasien, dan keluarga tentang masalah stunting dan wasting

Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan dan penanganan stunting dan wasting	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan. Pemberian anjuran konsumsi protein hewani sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan. Pemberian anjuran konsumsi protein hewani sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang	Peningkatan pemahaman tentang stunting dan wasting serta cara pencegahannya kepada pasien dan penunggu pasien di ruang



	tunggu poli anak dan poli kandungan. Pemberian anjuran konsumsi protein hewani sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting	tunggu poli anak dan poli kandungan	tunggu poli anak dan poli kandungan	tunggu poli anak dan poli kandungan. Pemberian anjuran konsumsi protein hewani sebagai upaya pencegahan stunting dan wasting	tunggu poli anak dan poli kandungan	tunggu poli anak dan poli kandungan
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Analisis :

Penyuluhan diadakan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan karena merupakan sasaran 1000 HPK dimana merupakan periode emas yang sangat penting bagi perkembangan otak dan pertumbuhan fisik untuk pencegahan dan menangani stunting dan wasting sejak dini.

Rencana Tindak Lanjut :

Sosialisasi tentang stunting dan wasting perlu terus ditingkatkan dengan disertai pemberian contoh makanan selingan tinggi kalori kepada ibu hamil dan balita.

6. Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik

Program	Kegiatan	Lokasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Program 1000 HPK	Penyuluhan terkait 1000 Hari Pertama Kehidupan	Poli Anak dan Poli Kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang rawat inap	Telah dilakukan di ruang rawat inap	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan	Telah dilakukan di ruang tunggu poli anak dan poli kandungan
Suplementasi asam folat pada ibu hamil	1. Penyuluhan tentang pentingnya konsumsi asam folat pada ibu hamil 2. Pembagian tablet tambah darah dan asam folat	1. Kelas Bumil Dolina 2. Poli Kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di kelas Bumil Dolina	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan
Pemberian PMT Ibu Hamil	Pemberian PMT dengan tinggi kalori terutama pada ibu hamil yang terindikasi KEK	Kelas Bumil Dolina	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan	Telah dilakukan di Kelas Bumil Dolina	Telah dilakukan di Kelas Bumil Dolina	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan	Belum dilakukan penyuluhan
Promosi dan Konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Penyuluhan mengenai pentingnya Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif	Poli Kandungan dan Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Kandungan	Telah dilakukan di poli kandungan dan ruang rawat inap maternitas	Telah dilakukan di poli kandungan dan ruang rawat inap maternitas	Telah dilakukan di Poli Kandungan	Telah dilakukan di ruang maternitas	Telah dilakukan di ruang maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas	Telah dilakukan di Ruang Maternitas
Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	1. Penyuluhan tentang stunting, makanan sehat pada bayi dan balita 2. Pembagian	-	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi	Pemberian PMT bagi balita masih belum diberikan di luar rumah sakit. Akan tetapi



	PMBA		memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit	memberikan PMT bagi balita yang memiliki berat badan kurang di wilayah rumah sakit
Pemantauan Pertumbuhan (Pelayanan Tumbuh Kembang Bayi dan Balita)	Melakukan Pencatatan dan plotting pada buku KIA setelah pengukuran berat badan dan tinggi badan anak	Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak
Pemberian Imunisasi	Memastikan ketersediaan imunisasi agar selalu tersedia di poli anak	Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak	Telah dilakukan di Poli Anak
Pemberian Vitamin A	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian vitamin A	Posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu	Belum terdapat intervensi berupa pemberian vitamin A di posyandu
Pemberian Makanan Tambahan Gizi Kurang	Memberikan PMT tinggi kalori dengan membantu menyusun menu yang sesuai dengan ketersediaan bahan	Rumah Sakit	Tidak terdapat balita dengan kondisi stunting ataupun wasting selama bulan april	Tidak terdapat balita dengan kondisi stunting ataupun wasting selama bulan februari	Tidak terdapat balita dengan kondisi stunting ataupun wasting selama bulan maret	Tidak terdapat balita dengan kondisi stunting ataupun wasting selama bulan april	Telah memberikan PMT Tinggi kalori kepada pasien rawat inap dengan masalah gizi stunting,	Telah memberikan PMT Tinggi kalori kepada pasien rawat inap dengan masalah gizi stunting	Telah diberikan PMT untuk pasien stunting dan gizi buruk di bulan Juli selama rawat inap.	Telah diberikan PMT untuk pasien Stunting di Bulan Agustus selama rawat inap	Telah diberikan PMT untuk pasien anak di Bulan September selama rawat inap	elah diberikan PMT untuk pasien gizi buruk di bulan Oktober selama rawat inap.	Tidak terdapat balita dengan kondisi stunting ataupun wasting selama bulan November	Telah diberikan PMT untuk pasien wasting dan gizi buruk di bulan Desember selama rawat inap.

	pangan di lingkungan						wasting, gizi buruk dan underweight	dan underweight						
Pemberian Taburia pada Baduta	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian bubuk taburia	Posyandu	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian bubuk taburia
Pemberian Obat cacing pada ibu hamil	Bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mendukung program pemerintah mengenai pemberian obat cacing pada ibu hami	Posyandu	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil	Belum terdapat kerjasama terkait pembagian obat cacing pada ibu hamil

Analisis :

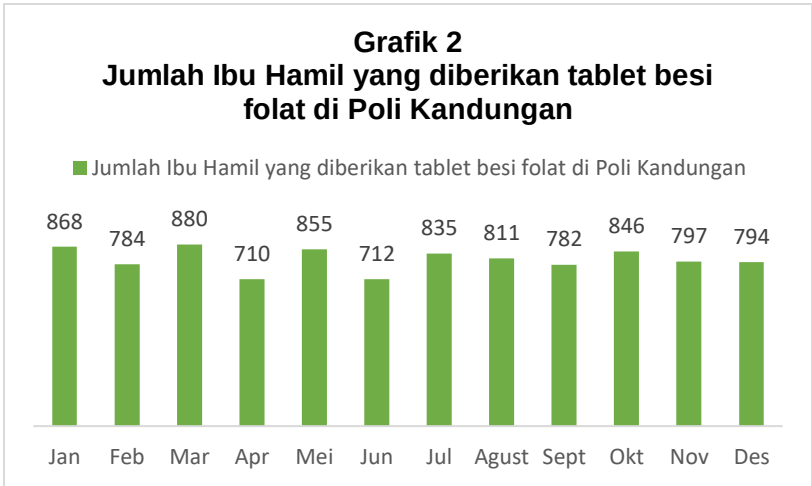
Sebagian besar intervensi gizi spesifik yang dapat dilaksanakan di Rumah Sakit telah dilaksanakan. Akan tetapi pada intervensi gizi spesifik berupa pemberian taburia dan vitamin A pada balita, pemberian obat cacing pada ibu hamil masih belum dilakukan karena ketresediaan taburia, obat cacing, dan vitamin A terdapat pada faskes 1.

Rencana Tindak Lanjut :

Bekerjasama dengan puskesmas setempat agar dapat melakukan pendampingan intervensi spesifik di posyandu disekitar wilayah rumah sakit.

7. Pemberian Tablet Besi Folat bagi Ibu Hamil

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah Ibu Hamil yang diberikan tablet besi folat di Poli Kandungan	868	784	880	710	855	712	835	811	782	846	797	794

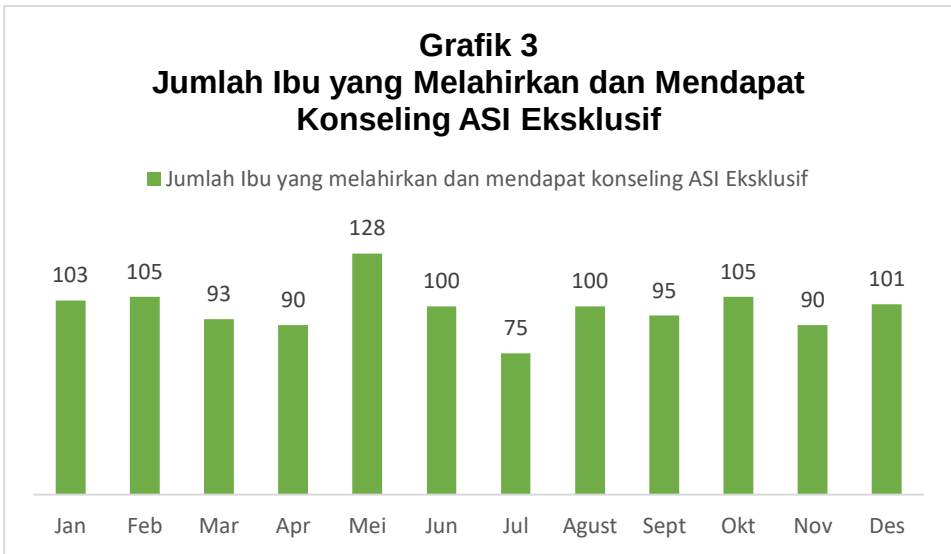


Analisis:
Seluruh ibu hamil yang melakukan kunjungan di poli kandungan di rumah sakit prima husada malang telah mendapat tablet tambah darah. Terutama pada kehamilan trimester pertama.

- Rencana Tindak Lanjut:**
 - Koordinasi dengan tim farmasi untuk mendukung penyediaan tablet tambah darah, agar program suplementasi tablet tambah darah kepada ibu hamil terus berlanjut
 - Koordinasi dengan tim humas rumah sakit agar ibu hamil yang bergabung semakin banyak agar program suplementasi tablet besi folat semakin baik.

8. **Angka Capaian Ibu yang melakukan IMD dan Mendapat Konseling ASI Eksklusif**

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah ibu yang melahirkan dan mendapat konseling ASI Eksklusif	103	105	93	90	128	100	75	100	95	105	90	101

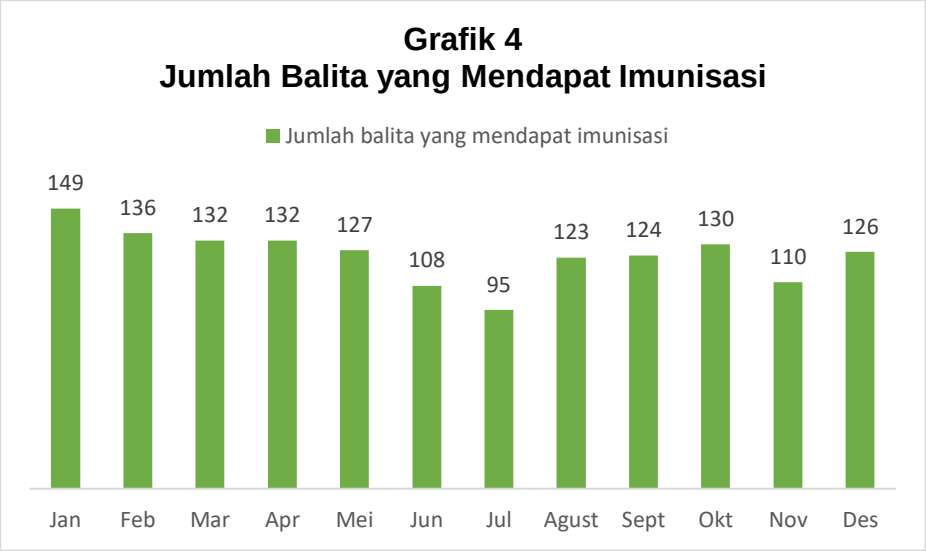


Analisis :
100% ibu melahirkan telah mendapatkan edukasi menyusui. Untuk mendukung pemberian ASI secara eksklusif.

- Rencana Tindak Lanjut:**
Tingkatkan koordinasi dengan dokter kandungan dan bidan rumah sakit dalam pemberian edukasi tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif serta mendokumentasikan bukti telah melakukan edukasi kepada ibu melahirkan pada lembar edukasi

9. **Jumlah Balita yang mendapat imunisasi**

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah balita yang mendapat imunisasi	149	136	132	132	127	108	95	123	124	130	110	126



Analisis:
Balita yang datang untuk melakukan imunisasi adalah balita yang telah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya imunisasi oleh dokter anak dan perawat pada saat kunjungan sebelumnya. Balita yang datang telah mendapat imunisasi lengkap meliputi imunisasi BCG, DPT 1-3, POLIO 1-3, IPV, dan Campak yang merupakan imunisasi lengkap dasar yang wajib diberikan kepada setiap balita.

Rencana Tindak Lanjut :
Memberikan penyuluhan tentang pentingnya imunisasi kepada keluarga pasien agar jumlah balita yang datang untuk imunisasi di poli anak terus meningkat untuk mendukung program pemerintah dalam pemberian imunisasi lengkap sebagai upaya pencegahan stunting.

10. **Penerapan Rumah Sakit sayang Ibu dan Bayi**
Mendukung pemeliharaan ruangan (pojok laktasi) agar memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu menyusui.

Analisis :
Pojok laktasi sudah tersedia untuk ibu dan bayi yang akan menyusui di wilayah rumah sakit prima husada sukorejo.

Rencana Tindak Lanjut :
Mengajukan perlengkapan untuk keperluan menyediakan pojok laktasi yang nyaman bagi bayi, balita, dan ibu menyusui seperti pampers dan tissue basah jika terdapat pasien atau pengunjung yang membutuhkan.

11. **Pelayanan Rujukan Pasien Stunting dan Wasting**

Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
Jumlah baduta stunting dan wasting yang dirujuk di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analisis :
Pada Bulan Januari hingga Desember tidak ada pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi

Rencana Tindak Lanjut :
Tetap memberikan asuhan gizi yang baik pada pasien dengan masalah gizi Stunting, Wasting, Underweight, dan Gizi Buruk serta melakukan monitoring dan evaluasi asupan makan pasien.

3.4. Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3

3.4.1. Fasilitas Kesehatan

Peralatan Medis

a. Inventarisasi Peralatan Medis dan Kalibrasi Peralatan Medis

Tabel Inventaris Peralatan Medis

No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
1	Timbangan Bayi	One Med	OD-231B	TBY-001	Iko	2019
2	Anesthesi	Mindray	Watoe Ex-35	KG- 8A002969	Iko	2019
3	Anestesi	Soft Lander	SL-210	0811012V	Iko	2018
4	Lampu Operasi	Panalex	LED - 2	LO - 001	Iko	2018
5	Lampu Operasi	Steris Harmony	VLED	.419916052	Iko	2018
6	Lampu Operasi	Panalex	LED - 2	LO - 002	Iko	2018
7	ESU	MGB	Zeus 400	AO3BTAT0418	Iko	2019
8	ESU	MGB	Zeus 400	AO3BTAT0401	Iko	2019
9	ESU	Maxer	Bimax 350	2043-05,17	Iko	2019
10	Nebulizer	Omron	NE-C28	20180508126UF	IGD Reguler	2020
11	Nebulizer	Omron	NE-C29	20110100258 UF	lantai 2 Covid	22 January 2018
12	Nebulizer	Omron	NE-C28	20180508128 UF	Maternitas	2020
13	Nebulizer	Omron	NE-C28	20180814473 UF	Irna / ICU lantai 3	2019
14	Tensi Digital	Happy Sheep	HP- 808E	130800641 (1)	IGD Reguler	2019
15	Tensi Digital	Happy Sheep	HP- 808E	130800641 (2)	Irja / Poli	2019
16	Tensi Digital	Happy Sheep	HP- 808E	130800641 (3)	Irja / Poli	2019
17	Tensi Digital	Happy Sheep	HP- 808E	130800641 (4)	Irja / Poli	2019
18	Tensi Digital	Happy Sheep	HP- 808E	130800641 (5)	Irja / Poli	2019
19	Tensi Digital	Happy Sheep	HP- 808E	130800641 (6)	Irna / ICU lantai 3	2019
20	Tensi Digital	Happy Sheep	HP- 808E	130800641 (7)	Irna / ICU lantai 3	2019
21	Syringe Pump	Mindray	Sk- 500	SK- 80605763	Irna / ICU lantai 3	
22	Syringe Pump	Fresenius	Agillia	21248330	Irna / ICU lantai 3	
23	Syringe Pump	Med Captain	MP-30	30180804821	Irna / ICU lantai 3	
24	Syringe Pump	Mindray	Sk- 500	Sk- 80605726	Iko	



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
25	Syringe Pump	Mindray	Sk- 500	Sk-80603759	Irna / ICU lantai 3	01 December 2018
26	Syringe Pump	Mindray	Sk- 500	Sk- 80605719	IGD Reguler	
27	Infuse Pump	Mindray	Sk- 600	Sk- 80605795	IKO	
28	Infuse Pump	One Med	MP-60	60171004139	IGD Reguler	
29	Infuse Pump	Mindray	Sk - 600	Sk-80605498	IGD Reguler	2019
30	Infuse Pump	Mindray	Sk-600	Sk-80603785	Maternitas	01 December 2018
31	Infuse Pump	Mindray	Sk-600	Sk-80605800	IGD Pinere	
32	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-88031664	Irna / ICU lantai 3	2020
33	Pasien Monitor	Analogic Medical	AM1200	MO 13A005898	IGD Reguler	
34	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-91038010	ICU Lantai3	
35	Pasien Monitor	Inter	UP5000	1810009E	Irna lantai3	
36	Pasien Monitor	Analogic Medical	AM1200	MO13A005909	Irna / ICU lantai 3	2019
37	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-89032539	Maternitas	2018
38	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-88031662	ICU lantai3	
39	Pasien Monitor	Analogic Medical	AM1200	MO13A005927	ICU lantai3	
40	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-88031663	Lantai 2 Covid,,Pindah ke Lantai 3	22 November 2018
41	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-85024966	IGD Reguler	
42	Pasien Monitor	Inter	UP5000	18100080	Irna / ICU lantai 3	03 December 2018
43	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-89032531	IKO	
44	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-85024960	IKO	
45	ECG	Med Cardio	Cardio 3B	3B1803012	Irna lantai2	
46	ECG	Med Cardio	Cardio 3B	3B1803009	ICU lantai 3	28 Des 2018
47	ECG	Med Cardio	Cardio 3B	3B1803011	IGD Reguler	
48	ECG	Med Cardio	Cardio 3B	3B1803007	Irja / Poli	2019
49	ECG	Philips	TC 20	CN 11506474	IGD Umum	
50	Suction Pump	General Care	7E-A	.00539	Irna / ICU lantai 3	06 Des 2018
51	Suction Pump	General Care	7E -A	.00064	IKO	



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
52	Suction Pump	General Care	7E-A	2018040366	IKO	
53	Suction Pump	General Care	7E-A	2018040584	Irna / ICU lantai 3	19 December 2018
54	Suction Pump	General Care	7E-A	.00063	Maternitas	2020
55	Suction Pump	General Care	7E-B	2018040584	Maternitas	
56	Suction Pump	One Med	YB-DX23B	17N3.069	IKO	
57	Baby Incubator	GEA	YP-100	01AHZB02015	Maternitas	03 December 2018
58	Fetal Dopler	-	FD - 200A	FD316110001	Maternitas	
59	NST	Bistos	BT - 300	AAJ80013	IGD Reguler	
60	Defibrilator	Mindray	D3	EZ-88008933	IGD Reguler	2018
61	Centrifuge	Oregon	ECO45	71121429	Laboratorium	08 January 2021
62	Cpap	Stephan	Cpap Easy	SO111501107	Maternitas	30/02/2019
63	Phototeraphy	GEA	XHZ-90	42AHAZ03020	Maternitas	28 December 2018
64	Sterilisator Kering	Memert	UN 260	B618-0818	CSSD	2018
65	Infant Warmer	GEA	HKN - 90	21AHAB02012	IKO	
66	Infant Warmer	GEA	HKN - 90	21AHZ101028	IGD Reguler	
67	Infant Warmer	GEA	HKN - 90	21AHAA01010	Maternitas	2019
68	Infant Warmer	GEA	HKN - 90	V3 / 1809010003	Maternitas	2020
69	USG	Mindray	DCN3	CA18800901	Poli Kandungan	
70	USG	Mindray	DP-10	GN-7C015628	Maternitas	28 December 2018
71	USG	Hanstech	TD - 90	22718008W	Radiologi / ESWL	
72	USG	GE	Versana Essensial	6023253WX0	Radiologi	2019
73	Blood Warmer	Animec	AM301	201700155	IKO	
74	Meja Operasi	GEA	-	-	IKO	
75	HFNC	Gerlip HFNC-10	GLP HFNC-01		Irna Covid lantai2	21 December 2020
76	Bed Operasi Elektrik	Panalex	GM - 1		IKO	
77	ECG	Mindray	Beneheart R3	FK-OC025592	IGD Pinere	05 March 2021



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
78	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81084327	Irna 2B	18 February 2021
79	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81084332	Irna 2B	18 February 2021
80	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81084331	Lantai 3 Irna Umum	18 February 2021
81	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81084330	Lantai 2 Covid	18 February 2021
82	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81084325	Maternitas	18 February 2021
83	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81084324	Icu lantai3	18 February 2021
84	Infusions Pump	Infusia	VP7 S	81077675	Lantai 2 Covid	18 February 2021
85	Infusions Pump	Infusia	VP7 S	81077679	Lantai 2 Covid	18 February 2021
86	Infusions Pump	Infusia	VP7 S	81077678	Icu lantai3	18 February 2021
87	ECG	Cardiocare 2000	Cardiocare 2000	E1U1000191	Lantai 2 Covid	18 February 2021
88	Infusions Pump	One Med	MP - 60	601808033201	Icu lantai3	03/12/2018
89	USG Echo With 3 Probes +2 Printer	Mindray	DC-N3 Pro	CA2-13001405	Poli Jantung	19 April 2021
90	Soft Non Contact	Takagi,Seiko	SNT 700	2054319	Poli Mata	16 April 2021
91	Operating Microscope	Takagi,Seiko	OM-9	IKO 55566	IKO	16 April 2021
92	Tensi Digital	One Med	1A	B2012017324	IRJA	21 April 2021
93	Suction Pump	GEA	YX930D	IKO YX930D	Poli THT	26 April 2021
94	Suction Pump	GEA	YX930D	IKO YX930D	Stock ada di Gudang ips Lama (di pakai IKO Tgl 05-02-22).	05 April 2021
95	Baby Incubator Transport Chart	Poly Medical	Poly 021 TC		Maternitas	29 June 2021
96	Ventilator	Mindray	Syno Vent E5	EEC 14035301	Covid Lantai 2	29 June 2021
97	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004071	Isolasi Covid 2	04 July 2021
98	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004033	Isolasi Covid 2	04 July 2021
99	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004048	Isolasi Covid 2	04 July 2021
100	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004023	Isolasi Covid 2	04 July 2021
101	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004008	Isolasi Covid 2	04 July 2021
102	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004097	Isolasi Covid 2	04 July 2021
103	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004002	Irna 2B	04 July 2021



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
104	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004009	Isolasi Covid 2	04 July 2021
105	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004003	Isolasi Covid 2	04 July 2021
106	Pasien Monitor	Yonker	E 12	202104061004079	Irna2B	04 July 2021
107	PC Central Monitor	Window 10	window 10		Isolasi Covid 2	04 July 2021
108	ECG (Bonus pembelian Pasien monitor)	Yonker	ECG 3	21030913010102	Di kirim ke Bunda Sadi	04 July 2021
109	Devibrilator - Monitor	DM 7000	DM 7000	DM 2012006P	ICU Covid Lt2	08 July 2021
110	Infuse Pump	Infusia	VP7 S	81100541	ICU Covid Lt2	13 July 2021
111	Infuse Pump	Infusia	VP7 S	81100525	Irna 2B	13 July 2021
112	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81100155	ICU Covid Lt2	13 July 2021
113	Syringe Pump	Infusia	SP 7 S	81100165	ICU Covid Lt2	13 July 2021
114	X Ray Mobile	Ecoview	Ultra 200	Emsa - 2107015	IGD Pinere	30 August 2021
115	NST	Bistos	BT-350	AFK 80074	Maternitas	06 September 2021
116	ESU	Zerone	Zeus 400	A03CLAQ1176	IKO	06 September 2021
117	Cpap	Stephan	Cpap Easy	SO111301076	Maternitas	08 October 2020
118	Cpap	Lokal	AD-1	201261006	Maternitas	06 September 2021
119	Cpap	Lokal	AD-1	201261032	Maternitas	06 September 2021
120	NST	Bistos	BT-350	AFM 20092	Poli Obgin	13 September 2021
121	US Zimmer	Zimmer	Zimmer	1720010291	Poli Rehab	08 July 2020
122	ES Zimmer	Zimmer	Zimmer	2120003045	Poli Rehab	08 May 2021
123	SWD Zimmer	Zimmer	Zimmer	1720001939	Poli Rehab	28 July 2021
124	Lamp IR	Zimmer	Zimmer	19082804359	Poli Rehab	08 July 2020
125	Baby Incubator	GE Medical	YP-100	OIBAKD10018	Maternitas	16 August 2021
126	USG	Versana Essensial	Versana Essensial	6023211WXO	Irja / Poli	2019
127	USG	Zonare	Zonare	87988C314C	Irja / Poli	
128	X Ray Mobile	Ecoview	Ultra 200 /DF - 183	OC25149	Irna Covid lantai2	29 April 2021
129	Syringe Pump	One Med	Injectomat	21248990	IGD Reguler	



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
130	Neopuff	Neonate	Infant	210111A051	IGD Reguler	17 June 2021
131	Pasien Monitor	YKD Med	YKD - 1000	ORD2012041	IGD Reguler	
132	Lampu Kepala	Bistos	Eye Cope	ECDC0078	IGD Reguler	
133	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-9B055458	Irna / ICU lantai 3	
134	Pasien Monitor	Analogic Medical	AM-1200	MO 13A005809	Irna / ICU lantai 3	
135	Pasien Monitor	Mindray	Umec 10	KN-89031663	Irna / ICU lantai 3	
136	Suction Pump	General Care	7E-A	.00064	Irna / ICU lantai 3	19 December 2018
137	Laringoskope				Irna / ICU lantai 3	2018
138	GDA	Family	MHD-1	mmr2cos230899	Irna / ICU lantai 3	2021
139	Infusions Pump	One Med	MP-60	60180803201	Irna / ICU lantai 3	03 December 2018
140	Infusions Pump	Infusia	VP7 S	81084260	Irna / ICU lantai 3	22 June 2021
141	Nebulizer	Omron	NE-C900	20190800140UF	Irna / ICU lantai 3	
142	Buble Matress	QDC-303	QDC - 303	YH 1711A15	Irna / ICU lantai 3	2018
143	Timbangan Badan DWS	One Med	Manual		Irna / ICU lantai 3	
144	GDA	Achu check			Irna / ICU lantai 3	2018
145	Dental Unit	Lokal	Lokal		IRJA	
146	Scaller	Wood Pecker	UDS-J2		IRJA	
147	Kompresor Air				IRJA	
148	Sterilisator Kering	Electra			IRJA	
149	Led Dental Curing light	XSLite			IRJA	
150	Nebulizer	Omron	NE-C28	20180814475UF	IRJA	
151	Suctions Pump	One Med	7E-G	.00030	Maternitas	23 September 2021
152	ESU	Zerone	Zeus 400	AD3CLAN104	Poli kulit dan Kelamin	21 September 2021
153	Ultrasound tend (Laser)	Chattanoga	Mobile Combo	T16914	Poli Rehab	23 September 2021
154	Nebulizer	Airjollie	3A Airjollie II	15/26481	Poli Rehab (Bonus Alat Ultra sound)	23 September 2021
155	Ventilator	Mindray	SUV-300	GA-17006428	Bantuan Aqua	31 August 2021



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
156	HFNC	Gerlip HFNC- 10	GLP HFNC-01	13072101AEAASPF0011848	Bantuan Aqua	31 August 2021
157	Centrifuge	Oregon	ECO45	71121429	Laboratorium	08 January 2021
158	Hematocrite Centrifuge	Zenithlab	HC-12A	90629108	Gudang IPS lama	16 June 2021
159	HFNC	Gerlip HFNC-10	GLP HFNC-01	29062101AEAASFCO11639	Irna Covid lantai2	10 June 2021
160	Ventilator	Mindray	SUV-300	GB-07025369	ICU lantai3	12 January 2021
161	Ventilator	Mindray	SUV-300	GB-07025352	Irna Covid Lantai 2	12 January 2021
162	Ventilator	Mindray	SUV-300	GB-07025370	Irna Covid lantai 2	12 January 2021
163	Baby Incubator	GEA Medical	YP-100	01BAKD10010	Maternitas	27 September 2021
164	Centrifuge (Bank Darah Alat K S O)	Imunofuge-12	Imunofuge-12	046-18932-21040004	Laboratorium	05 October 2021
165	Incubator (Bank Darah Alat K S O)	Imunofuge-24	Imunofuge-24	049-18932-21040003	Laboratorium	05 October 2021
166	Frizer Darah (Bank Darah Alat K S O)	GEA	Expo-26FC	202061	Laboratorium	05 October 2021
167	EMS	Stimate	N607	20336565	Poli Rehab	07 October 2021
168	Centrifuge	Oregon	PLC-05	1911024	Laboratorium	12 October 2021
169	Satu Set DRTech	EVS 3643W	EVS 3643 W	WJ92P211502	Radiologi	30 October 2021
170	Lampu Tindakan	GEA	KD -201B		Maternitas	2018
171	Lampu Tindakan	GEA	KD -201B		Maternitas	2018
172	Cuvis	Lokal	Lokal		Maternitas	2018
173	Cuvis	Lokal	Lokal		Maternitas	2018
174	Cuvis	Lokal	Lokal		Maternitas	2018
175	Baby Incubator	GEA Medical	YP-100	OIB22D01015	Maternitas	2020
176	Sterilisator Kering	Elitech	ZTP 80		Maternitas	2018
177	Ventilator	Newport	e 360		Irna / ICU lantai 3	05 June 2020
178	Termogan	Omron	mc-720		Irna / ICU lantai 3	2020
179	Termometer Ampit				Irna / ICU lantai 3	2020
180	Termogan	DT-8806C			Irna / ICU lantai 3	2020
181	GDA	Achu Check		92513007701	Irna / ICU lantai 3	2021
182	Oximetri	Jumper	jpd-500E		Irna / ICU lantai 3	2021



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
183	Lampu UV	Lokal	Lokal		Irna lantai 2 Covid	2020
184	Timbangan Bayi	GEA	Manual		Irna lantai 2 Covid	2020
185	Oximetri	Yuwell			Irna lantai 2 Covid	2021
186	GDA	Achu check	NC	68826378895	Irna lantai 2 Covid	2020
187	GDA	Achu check	NC	68826378891	Maternitas	2019
188	Infuse Pump	Fresensius Kabi	Infusia VP7 S	81107200	Maternitas	02 December 2021
189	Infuse Pump	Fresensius Kabi	Infusia VP7 S	81107209	Maternitas	02 December 2021
190	Infuse Pump	Fresensius Kabi	Infusia VP7 S	81107203	Maternitas	02 December 2021
191	Infuse Pump	Fresensius Kabi	Infusia VP7 S	81107199	Maternitas	02 December 2021
192	Infuse Pump	Fresensius Kabi	Infusia VP7 S	81107182	Maternitas	02 December 2021
193	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136859	Maternitas	02 December 2021
194	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136865	Maternitas	02 December 2021
195	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136862	Maternitas	02 December 2021
196	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136856	Maternitas	02 December 2021
197	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136888	Maternitas	02 December 2021
198	Oximetri	Bionet	Oxy 9 Wave (Neonate)	ENA A0107	Maternitas	02 December 2021
199	Oximetri	Bionet	Oxy 9 Wave (Neonate)	ENA A 0108	Maternitas	02 December 2021
200	Oximetri	Bionet	Oxy 9 Wave (Neonate)	ENA A0109	Maternitas	02 December 2021
201	Oximetri	Bionet	Oxy 9 Wave (Neonate)	ENA A 0110	Maternitas	02 December 2021
202	Satu Set DRTech	EVS 3643W	EVS 3643 W	WJ92P211502	Radiologi	30 October 2021
203	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107190	ICU Lantai3	02 December 2021



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
204	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107195	ICU Lantai 3	02 December 2021
205	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107201	ICU Lantai 3	02 December 2021
206	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107206	ICU Lantai 3	02 December 2021
207	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107205	ICU Lantai 3	02 December 2021
208	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107197	ICU Lantai 3	02 December 2021
209	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107194	ICU Lantai 3	02 December 2021
210	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136884	ICU Lantai 3	02 December 2021
211	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136863	ICU Lantai 3	02 December 2021
212	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136886	ICU Lantai 3	02 December 2021
213	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136861	ICU Lantai 3	02 December 2021
214	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136866	ICU Lantai 3	02 December 2021
215	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136857	ICU Lantai 3	02 December 2021
216	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136885	ICU Lantai 3	02 December 2021
217	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136889	IGD Reguler	02 December 2021
218	Syringe Pump	Frensensius Kabi	Infusia SP7 S	81136860	IGD Reguler	02 December 2021
219	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107207	IGD Reguler	02 December 2021
220	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107193	IGD Reguler	02 December 2021
221	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107192	IRNA Lantai 3	02 December 2021
222	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107196	IRNA Lantai 3	02 December 2021



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
223	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107188	IRNA Lantai 3	02 December 2021
224	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136883	IRNA Lantai 3	02 December 2021
225	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136887	IRNA Lantai 3	02 December 2021
226	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136853	IRNA Lantai 3	02 December 2021
227	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136854	Irna lantai 2	02 December 2021
228	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136855	Irna lantai 2	02 December 2021
229	Syringe Pump	Fresensius Kabi	Infusia SP7 S	81136864	Irna lantai 2	02 December 2021
230	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107208	Irna lantai 2	02 December 2021
231	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107204	Irna lantai 2	02 December 2021
232	Infuse Pump	Frensensius Kabi	Infusia VP7 S	81107181	Irna lantai 2	02 December 2021
233	Treadmill	Trackmaster	TMX428220	FVDC-07927	Poli Jantung	26 November 2021
234	Defibrilator	Mindray	Mindray	DZ- 8B002908	Poli Jantung	03 December 2021
235	Cpap	Yuwell	YH 830	PHS 830	Ada di Gudang	11 December 2021
236	Cpap	Yuwell	YH 830	PHS 831	Ada di Gudang	11 December 2021
237	Cpap	Yuwell	YH 830	PHS 832	Ada di Gudang	11 December 2021
238	Cpap	Yuwell	YH 830	PHS 833	Ada di Gudang	11 December 2021
239	Trainer Hand and Leght	Lokal	Lokal	RHB 0021	Poli Rehab	
240	Mikroskope	Yakumi		LAB 00022	Laboratorium	
241	Acliya	Mindray	CL-9001	BB1-04001195	Laboratorium	
242	Indiko (clinical Analizer)	Indiko	Indiko	863000001020	Laboratorium	



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
243	DXH 500S	Beckman	DXH 500S	BA 080550	Laboratorium	
244	GEM 3500	GEM 3500	GEM 3500	21014739	Laboratorium	
245	Trombosit	Trombotimer	2 Chanel	010202-00412	Laboratorium	
246	Caretium	Caretium			Laboratorium	
247	Hipro	Hipro	Hipro		Laboratorium	
248	Pasien Monitor	Yongker	Yongker	21081910030130	IGD Reguler	13 December 2021
249	Pasien Monitor	Yongker	Yongker	21081910030138	IGD Reguler	13 December 2021
250	Pasien Monitor	Yongker	Yongker	21081910030142	IGD Reguler	13 December 2021
251	Spirometry	MIR	MIR	A23-OJ.03376	Irja / Poli	2017
252	ECG	Yonker	ECG 3	21030913010101	IGD Reguler	16 December 2021
253	Defibrilator	Mindray	Beneheart D3	E2-12055293	ICU Lantai 3	16 December 2021
254	Pasien Monitor	Yonker	E12	21081910030168	Maternitas	13 December 2021
255	Tensi meter berdiri	One med	Aneroid	JT 00101 phs	Poli Jantung	18 December 2021
256	HFNC	Gerlip HFNC-10	GLP HFNC-01		Irna Covid lantai2	21 December 2020
257	Ventilator	Lotus	1200	091007U	Iko	2018
258	Mesin Anestesi	Mindray	Watoex - 20	DW-05010510	Iko	2018
259	USG 4D	GEA MEDICAL	Versana Essensial	6051829 WOX	IGD Reguler	03 January 2022
260	ECG	Mindray	Beneheart R3	FK-1A029198	Ada di Gudang	20 December 2021
261	ECG	Mindray	Beneheart R3	FK-1A029217	Irna 3	20 December 2021
262	Pasien Monitor	Yongker	E12	21081910030113	Irna 2A	13 December 2021
263	Pasien Monitor	Yongker	E12	21081910030151	ICU Lantai 3	13 December 2021
264	Pasien Monitor	Yongker	E12	21081910030103	ICU Lantai 3	13 December 2021



No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
265	Pasien Monitor	Yongker	E12	21081910030140	ICU Lantai 3	13 December 2021
266	Pasien Monitor	Yongker	E12	21081910030131	ICU Lantai 3	13 December 2021
267	Pasien Monitor	Yongker	E12	21081910030108	Irna 2A	13 December 2021
268	Tensimeter Digital	Tensione	Tensione	B2105013786	Maternitas	17 January 2022
269	Sterilisator Kering	Memert	UNB 500	C508U65	CSSD	
270	Auto Clave	GEA	50 L	18L-2177	CSSD	
271	Siller	Hualian	FRB 7701	1111117040861	CSSD	
272	Sterilisator Kering	Memert	UN 260	BG 18-0818	CSSD	
273	Sterilisator Kering	Memert	UN 450	B721.0588	CSSD	05 March 2022
274	Panoramic	Papaya plus 2 G	Genoray	GDP-111309-40420	Lantai 3 panoramic	16 March 2022
275	Alat Fundus (Eidon True Confocal Scanner)	Centervue	Centervue	1224	Poli Mata	Kamis,14 April 2022
276	Alat DL	Mindray	BC - 5000		Laboratorium	22 April 2022
277	Indiko (clinical Analizer)	Indiko	Indiko	864100003280	Laboratorium	2020 (Di Instal,Uji fungsi dan di gunakan tgl 10 - Mei - 2022)
278	CT Scan	Philips	Philip 16 Slide	310306	Radiologi	
279	ESWL	Wikkon	IMD XRO4	5712	Radiologi	
280	D-AR X Ray Kaset			Rad 001	Radiologi	
281	Injections	Optione	Optione	Rad 003	Radiologi	
282	D-AR X Ray Kaset			Rad 002	Radiologi	
283	Bor Orthopedi	Inlu	Inlu	SK 2342220905054	Iko	12 April 2023
284	Suction Pump	One Med	One Med 7 E-G	PT2209190139	Irna 3	14-Apr-23
285	Syringe Pump	Fresenius Kabi/ SP TIVA	Fresenius Kabi/ SP TIVA	25384239	Irna 3	14-Apr-23
286	Infusions Pump	Fresenius Kabi / Vp 7s	Fresenius Kabi / Vp 7s	81224831	Irna 3	14-Apr-23
287	Infusions Pump	Fresenius Kabi / Vp 7s	Fresenius Kabi / Vp 7s	81224829	Irna 3	14-Apr-23

No	Nama Alat	Merk Alat	Type Alat	Nomor Seri	Ada di Ruangan	Tahun Beli Alat
288	Oximetri	Oxy 9 Wave (Neonate)	Bionet	02ACENA0151	IGD	12-Apr-23
289	Oximetri	Oxy 9 Wave (Neonate)	Bionet	02ACENA0152	Irna 3	12-Apr-23
290	Oximetri	Oxy 9 Wave (Neonate)	Bionet	02ACENA0154	Perinatologi	12-Apr-23

3.4.2. Gedung & bangunan

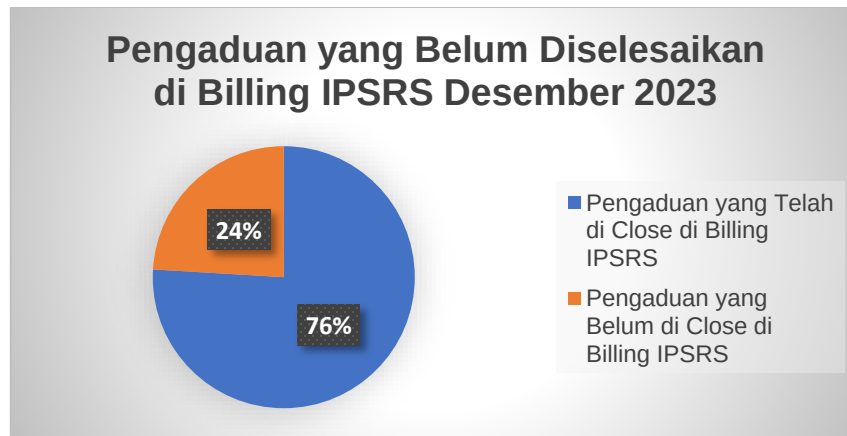
Program pengembangan pelayanan yaitu berupa Pembangunan Gedung IGD 5 Lantai dan juga pembangunan IKO 4. Terdapat pula program yang akan direncanakan ditahun 2024 yaitu penambahan daya di area Masjid dari daya 53 KVA menjadi 197 KVA. Proses penambahan daya listrik sudah dilakukan Pak Lambang.

a. Pengaduan IPSRS

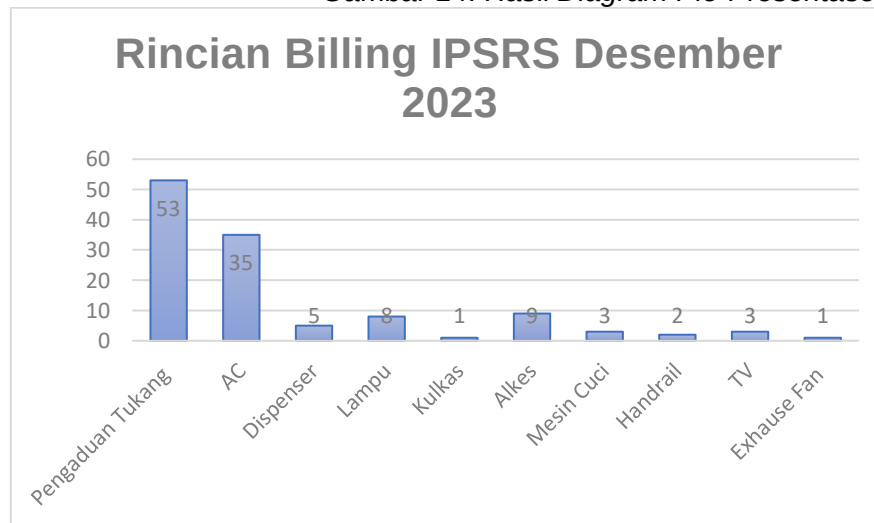


Gambar 13. Hasil *Diagram Pie* Prosentase terkait Pengaduan Kerusakan dari IPSRS Bulan Desember 2023

Pada Bulan Desember 2023, terdapat 120 pengaduan yang berhasil di Billing IPSRS, Dimana 53 pengaduan terkait tukang bangunan (44%) dan 67 pengaduan terkait IPSRS (67%) Dari 153 pengaduan, 120 pengaduan (76%) telah di close di Billing SIM IPSRS dan 38 pengaduan (24%) belum di close di Billing SIM IPSRS selama Desember 2023. Terdapat 38 billing pengaduan (24%) yang belum diselesaikan (10 pengaduan tukang ; dan 26 pengaduan IPSRS dan 2 pengaduan IT).



Gambar 14. Hasil *Diagram Pie* Prosentase terkait Pengaduan yang belum berhasil diselesaikan November 2023



Gambar 14. Hasil *Diagram Batang* Prosentase terkait Rincian Pengaduan Billing IPSRS yang belum diselesaikan

Terdapat 67 pengaduan terkait IPSRS dimana terbanyak yaitu pengaduan ac yang berjumlah 35 pengaduan; pengaduan alkes sebanyak 9 pengaduan; pengaduan lampu sebanyak 8 pengaduan.

3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

a. Kesehatan Kerja

Pengukuran Suhu dan Kelembapan Ruangan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 35. Hasil Pengukuran Suhu Kelembapan

No	Ruangan/ Unit	Suhu (°C)	Kelembapan (%)	Hasil Pengukuran Suhu (°C)	Hasil Pengukuran Kelembapan (%)
1	Kamar Operasi	22-27	40-60	21	42
2	Bersalin	24-26	40-60	27	59
3	Pemulihan/ Perawatan	22-23	40-60	22	56
4	Observasi Bayi (Bayi NICU)	27-30	40-60	26	46
5	Perawatan Bayi (Bayi Sakit yang tidak butuh obeservasi)	32-34	40-60	26	48
6	Perawatan (Mawar 2.1)	32-34	40-60	26	66
7	ICU	22-23	40-60	20	40
8	Jenazah	21-24	40-60	28	65
9	Laboratorium	20-22	40-60	26	41
10	Radiologi	17-22	40-60	25	47
11	Sterilisasi	21-30	40-60	26	47
12	Dapur	22-30	40-60	28	67
13	IGD	20-24	40-60	23	87
14	Administrasi	20-28	40-60	26	58

Suhu atau temperatur merupakan salah satu aspek lingkungan kerja yang perlu dikendalikan dalam suatu industri, karena suhu berhubungan langsung dengan tenaga kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, terdapat perbedaan Nilai Ambang Batas (NAB) antara suhu dan kelembapan di setiap ruangan. Sehingga, suhu di area kerja tidak diperbolehkan melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) yang telah ditetapkan. Nilai suhu yang berada di atas NAB pada area kerja dapat menyebabkan penurunan kondisi fisik serta tingkat produktivitas karyawan.

Monitoring suhu juga diperbaiki mengacu berdasarkan Permenkes 7 Tahun 2019 tentang Kesling RS dan Permenkes 2 Tahun 2023 tentang Kesling dimana untuk monitoring suhu dari masing-masing unit dilakukan perbaikan terkait indikator suhu sesuai permenkes tersebut dengan berkoordinasi dengan PPI RS.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyadi dan Kurniawan (2012) dalam Rezalti dan Susetyo (2020) yang menyatakan bahwa penilaian suhu dan kelembapan di dalam ruangan kantor pos tidak memenuhi syarat, sehingga dapat menimbulkan berbagai kondisi seperti gangguan perilaku dan performansi kerja, dehidrasi, keadaan keringat (*heat rash*) atau gatal karena kulit terus basah, hilangnya garam natrium (*heat champs*) dari tubuh yang dapat menyebabkan kejang otot dan kelelahan pada tubuh. Tenaga kerja yang terpapar panas di lingkungan kerja akan mengalami *heat strain* atau regangan panas, merupakan efek yang diterima tubuh atas beban iklim kerja tersebut (Santoso, 2004 dalam Rezalti dan Susetyo, 2020). Indikator *heat strain* adalah peningkatan denyut nadi, tekanan darah, suhu tubuh, pengeluaran keringat dan penurunan berat badan (Wignjosoebroto, 2003 dalam Rezalti dan Susetyo, 2020).

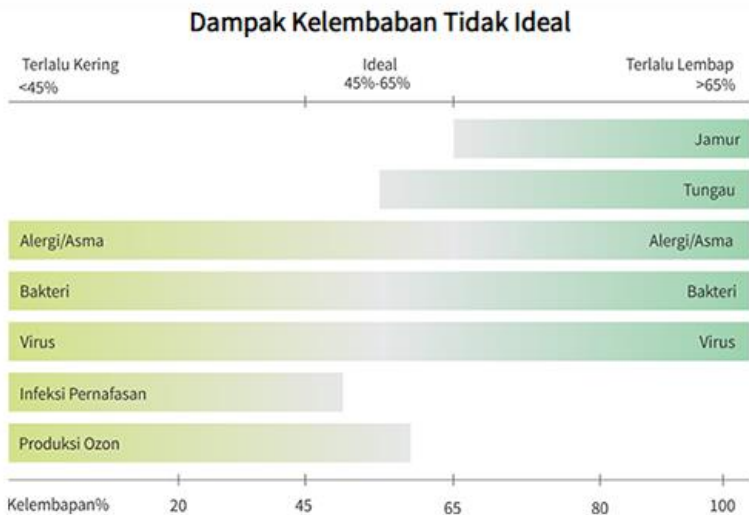
Untuk mengendalikan suhu lingkungan kerja yang panas, maka ada beberapa yang bisa dilakukan menurut Rezalti dan Susetyo (2020) adalah:

1. Mengurangi faktor beban kerja
2. Isolasi sumber panas, adanya ventilasi buatan
3. Menyediakan air minum di setiap tempat kerja
4. Pembatasan terhadap waktu pemaparan panas
5. Mengatur jam kerja dan jam istirahat secara tepat berdasarkan beban kerja pekerja

Beberapa solusi alternatif untuk area tersebut antara lain:

1. Pemasangan ventilasi dan kipas angin pada area yang belum tersedia agar pergantian udara lebih baik.
2. Memastikan ketersediaan air minum yang cukup bagi pekerja untuk membantu rehidrasi tubuh akibat suhu ruangan yang panas.
3. Menanam pohon/tumbuhan di luar lingkungan ruang produksi yang masih kosong agar menjadi teduh.
4. Pemasangan *exhaust fan* pada ruang produksi.

Menurut Rezalti dan Susetyo (2020), kelembapan dipengaruhi oleh suhu/temperatur, kecepatan udara dan radiasi panas dari udara yang akan mempengaruhi keadaan tubuh manusia pada saat menerima atau melepaskan panas dari tubuhnya. Keadaan dengan temperatur udara yang sangat panas dan kelembapan rendah akan menimbulkan pengurangan panas dari tubuh secara besar-besaran karena sistem penguapan. Sehingga berpengaruh pada makin cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Kelembapan pada kondisi yang tidak nyaman akan mempermudah penguapan keringat sewaktu bekerja. Penguapan keringat akan mengambil panas dari tubuh, sehingga suhu tubuh dapat dijaga tetap pada suhu tubuh normal. Terjadi keseimbangan antara panas yang diproduksi dan panas yang dilepaskan oleh tubuh selama bekerja, sehingga suhu tubuh pekerja selama bekerja tetap pada kondisi suhu tubuh normal. Bila kelembapan udara ruang di luar batas dari kelembapan yang nyaman, maka penguapan keringat sewaktu bekerja terhambat, sehingga terjadi hambatan pelepasan panas tubuh ke udara dalam lingkungan kerja. Pekerja akan merasakan kondisi kerja yang pengap, sehingga mengurangi produktivitas dan efisiensi kerja. Sebaliknya bila kelembapan terlalu rendah, sehingga penguapan pada saluran nafas dan keringat lebih cepat sehingga saluran nafas menjadi kering.



Gambar 23. Dampak Kelembapan yang Tidak Ideal

Dampak kelembapan yang terlalu rendah dapat menyebabkan alergi/asma, bakteri, virus, infeksi pernapasan dan sebagainya, sedangkan untuk kelembapan yang terlalu tinggi maka dapat menyebabkan pertumbuhan jamur, tungau, alergi/asam, pertumbuhan bakteri dan virus.

- 3.11.2. Pengukuran Pencahayaan Ruang Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

Tabel 36. Hasil Pengukuran Intensitas Pencahayaan

No.	Ruangan/Unit	Intensitas Cahaya Standar (Lux)	Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux)
1	Ruangan Pasien -Saat tidak tidur	250	680.1 (sinar matahari)
	-Saat tidur	50	576.1 (sinar matahari)



No.	Ruangan/Unit	Intensitas Cahaya Standar (Lux)	Hasil Pengukuran Intensitas Cahaya (Lux)
2	Rawat jalan (Poli spesialis penyakit dalam)	200	180.8
3	IGD	300	184
4	Ruang Operasi Umum	300-500	193.9
5	Meja Operasi	10.000-20.000	9795-∞
6	Anestesi, pemulihan	300-500	188.8
7	Laboratorium	75-100	108.1
8	Koridor	Minimal 100	115.8-133.7
9	Tangga	Minimal 100	3424 (pagi)
10	Administrasi/Kantor	Minimal 100	128.6
11	Ruang Alat/Gudang	Minimal 200	183.6-1865
12	Farmasi	Minimal 200	164.5
13	Dapur	Minimal 200	184.6
14	Ruang Cuci	Minimal 100	147
15	Toilet	Minimal 100	55

3.11.3 Pengukuran Kebisingan Ruangan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

No.	Ruangan/Unit	Maksimum Tekanan Bising / Sound Pressure Level (dBA)	Hasil Pengukuran Tekanan Bising / Sound Pressure Level (dBA)
1	Ruangan Pasien -Saat tidak tidur	45	53.9
	-Saat tidur	40	45.5
2	Ruang operasi	45	60.1
3	Ruang umum (Ruang tunggu lantai 2)	45	63.6
4	Anestesi, pemulihan	50	47.4
5	Laboratorium	65	67.3
6	Koridor	45	63.4
7	Tangga	65	56.4
8	Kantor / lobby	65	53.5
9	Ruang alat / Gudang	65	44.7
10	Farmasi	65	57.3
11	Dapur	70	68
12	Ruang cuci	80	66.3
13	Ruang Isolasi	20	158.1
14	Poli Gigi	65	53.7
15	Ruang ICU	65	63.9
16	Ambulan	40	56.6

3.11.4 Data Karyawan Terkena Covid

Data karyawan yang terkena covid pada Bulan Januari - September 2023 adalah 1 karyawan di Bulan April 2023.

Tabel 38. Data Karyawan yang Terkonfirmasi Covid-19 / Penyakit Menular Lainnya

BULAN	JUMLAH KARYAWAN TERKONFIRMASI COVID / MENULAR/ HEPATITIS DLL
Januari 2023	0 Orang
Februari 2023	0 Orang
Maret 2023	0 Orang

BULAN	JUMLAH KARYAWAN TERKONFIRMASI COVID / MENULAR/ HEPATITIS DLL
April 2023	1 Orang
Mei 2023	0 Orang
Juni 2023	0 Orang
Juli 2023	0 Orang
Agustus 2023	0 Orang
September 2023	0 Orang
Oktober 2023	0 Orang
November 2023	0 Orang
Desember 2023	0 Orang

3.11.5 Rectal Swab Petugas Dapur (Penyaji)

Telah dilakukan rectal swab pada 9 orang petugas dapur (penyaji makanan) pada 26 Januari 2023 dengan berkoordinasi dengan laboratorium Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo. Hasil rectal swab tersebut adalah didapatkan pertumbuhan bakteri pada rectal swab yang belum dapat dipastikan apakah bakteri tersebut merupakan koloni bakteri yang dapat menyebabkan penyakit atau flora normal usus.

Disarankan untuk memastikan hal tersebut perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik medik, kultur dengan media spesifik dengan atau tanpa pemeriksaan serotyping jenis bakteri.

Rectal swab ulangan dilakukan Juli 2023. Didapatkan satu orang yang terdapat biakan bakteri salmonella sp pada satu staf penjamah makanan. Sudah diarahkan ke dokter MCU untuk dilakukan pengobatan kepada staf yang bersangkutan.

REGISTER : 2307210034
NAMA : INDY PRAMUDYA R. (P)
ALAMAT : RS. PRIMA HUSADA

TANGGAL : 21 JULI 2023
UMUR : 19 TAHUN
PENGIRIM : RS. PRIMA HUSADA (LAB)

DIAGNOSA KLINIK : MCU

HASIL UJI KEPEKAAN ANTIBIOTIKA

M.O :

NO.	ANTIBIOTICS	KETERANGAN		
		I	II	d (mm)
1	PENICILLIN DAN DERIVATNYA			
	- Penicillin			
	- Ampicillin			
	- Amoxycillin			
	- Amoxycillin & Clavulanic Acid	S		22
2	CEPHALOSPORINS			
	- Cefadroxil			
	- Cefotaxim			
	- Ceftriaxone			
	- Cefuroxim			
3	FOSFOMYCIN			
	- Fosfomicin			
	AMINOGLYCOSIDES			
	- Gentamycin	S		19
	- Netilmicin	S		19
4	FLUOROQUINOLON			
	- Ciprofloxacin	S		26
	- Levofloxacin	S		26
	MACROLIDES			
	- Erytromycin			
5	CARBAPENEM			
	- Meropenem	S		35
	- Imipenem			
	TETRACYCLINE			
	- Tetracycline	R		
6	LAIN - LAIN			
	- Chloramphenicol	S		24
	- Nalidixic Acid			
	- Nitrofurantoin			
	- Vancomycin			
7				
	- Trimethoprim/Sulfamethoxazole	S		18
	- Colistine			

BAHAN :
RECTAL SWAB
HASIL BIAKAN :
Salmonella sp.
HITUNG KOLONI :

SEDIAAN LANGSUNG :
1. Gram : BATANG GRAM NEGATIF
2. Neisser : -
3. BTA : -

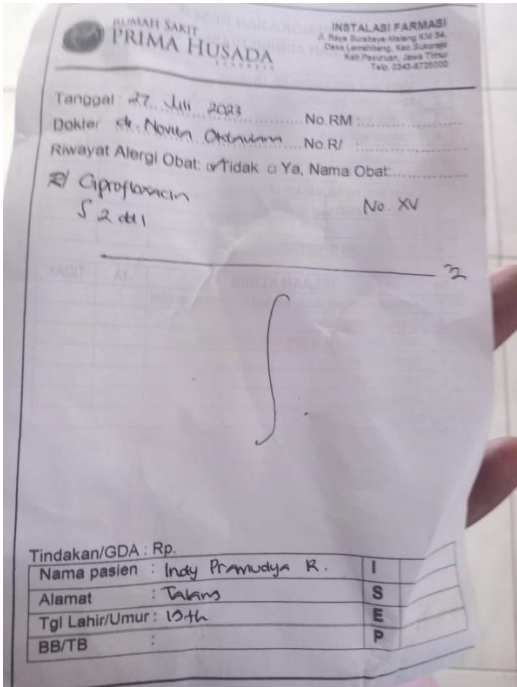
KETERANGAN :
R : Resisten
I : Intermediate
S : Sensitive
d : Diameter
mm : Milimeter
M.O : Mikroorganisme

Penanggung Jawab Laboratorium,

Dr. Singih Pudlo Wahono, Sp.PK

Resilensi kesempatan hidup lebih sukses dengan memelihara kesehatan diri anda secara berkala

Gambar 24. Hasil Rectal Swab Salah Satu Penjamah Makanan Juli 2023



Gambar 25. Pemberian Resep Kepada Staf penjamah Makanan yang Hasil Biakan Bakterinya Tidak Normal Juli 2023

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO NOMOR: 892/RSPHS/I-PM/K3RS/VIII/2023			
Tanggal		23 Agustus 2023	
Pengajuan Dari Unit*		K3RS	
Alasan Pengajuan		Untuk pengajuan termohigro baru dan rectal swab ulangan	
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Termohigrometer	10 Pcs
	2.	Rectal Swab Ulangan	1 orang
	3.	Pasir	1 truk
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk mengukur kelembaban dan suhu 2. Untuk memantau kesehatan penjamah makanan 3. Pemlesteran pondasi ipal di jalan makam warga jombor
3.	Penempatan alat**		1. Lorong IRNA 3A, NS IRNA 3A, NS IRNA 2A dan B Lorong IRNA 2A, Lorong IRNA 2B, NS Mater, Lorong Mater, NS IRNA 3B, Lorong 3B, Neonatus 2. Untuk penjamah makanan atas nama Indy Pramudya Rahmawati 3. IPAL – arah jalan warga dekat pemakaman
4.	Merk/Tipe**		1. Tergantung pengadaan 2. Tergantung pengadaan 3. Tergantung pengadaan
5.	Spesifikasi**		1. Tergantung pengadaan 2. Tergantung pengadaan 3. Tergantung pengadaan

Gambar 26. Pengajuan Rectal Swab Ulangan



RUMAH SAKIT

PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Nama Pasien

: INDY PRAMUDYA RAHMAWATI

No. RM

: 067675

No. Lab

: 2309060128

Tgl. Lahir/Umur

: 01-Mar-04 / 19 th 6 bln 7 hr

Jns. Kel

: Perempuan

Spesimen

: Darah

Alamat

: DGN TALANG RT. 002 RW. 005 KEL. WATUNGUNG Kec. PROGEN KAB PASURUAN JAWA TIMUR

Tgl/Jam diambil

: 08-Sep-2023 / 17:35

Tgl/Jam diterima

: 08-Sep-2023 / 17:37

Cara Bayar

: LUNAS

Tgl/Jam Selesai

: 08-Sep-2023 / 17:55

Asal / Pengirim

: Instalasi Laboratorium /

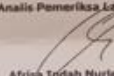
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Jenis Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan	Keterangan
IMUNO SEROLOGI				
Widal :				
Typhi - O	Negatif		Negatif	
Typhi - H	(+) 1/80		Negatif	
Paratyphi - A	(+) 1/80		Negatif	
Paratyphi - B	Negatif		Negatif	

Kesan / Kesimpulan :

Pasuruan, 08/09/2023

Analisis Pemeriksaan Laboratorium



Afrida Indah Nurleni S.Tr.Kes

NIK. DPM 2-4971121

Dokter Penanggungjawab Laboratorium



PRIMA HUSADA

SUKOREJO

dr. Brilliant Margalin Sp.PK., MARS

NIK. DPM 1-3560221

Catatan :

- Kesimpulan di atas ini hanya berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium pada saat ini dan dari keterangan klinis yang dicantumkan

- *j Nilai Kritis

Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan

Telp. (0343)-6745000, info@rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

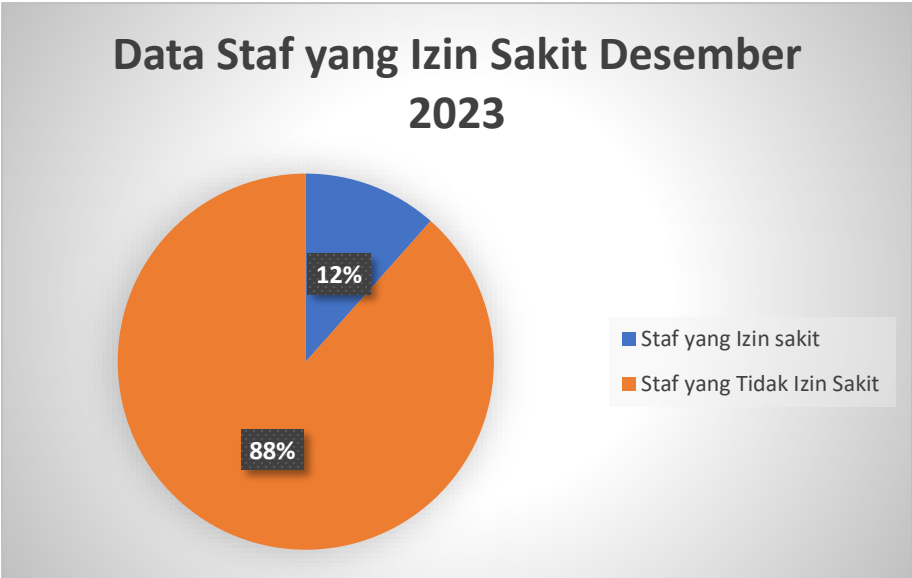
Gambar 27. Hasil Widal Staf a/n Indy-Dapur 08 September 2023

Telah dilakukan rectal swab kepada 6 petugas tenant atau pengolah kantin pada 16 Desember 2023, dari hasil yang telah diterima 2 orang mengalami pengembangbiakan salmonella dan satu orang mengalami hasil biakan staphylococcus koagulase positif. Berdasarkan konsultasi dengan dr Novita Oktaviana selaku dokter MCU RS Prima Husada, bahwa petugas kantin tersebut akan mengikuti diberikan resep dan akan dilakukan pemeriksaan ulang berupa widal.

Untuk petugas kantin yang hasil biakannya staphylococcus koagulase positif, ternyata memiliki gejala yaitu muntaber dan sekarang sudah tidak bergejala lagi. Hasil rectal Swab dan konsultasi dr Novita (*terlampir*).

3.11.7 Angka Izin Mangkir Staf

Berdasarkan hasil telaah dari google Form terkait Izin Sakit, didapatkan bahwa di Bulan Desember 2023, dari 424 Staf (tanpa DPJP sejumlah 51 orang) terdapat 49 orang (12%) yang izin sakit di Bulan Desember 2023 dan 375 orang (88%) yang tidak izin sakit.



Gambar 28. Hasil *Diagram Pie* Prosentase terkait Data Staf yang Izin Sakit Bulan Desember 2023

Dimana hasil tracking sakit staf yaitu :



Gambar 29. Hasil *Diagram Batang* Rincian terkait Data Staf yang Izin Sakit Desember 2023

Dimana angka terbanyak pada izin sakit staf dikarenakan Diare yaitu 9 orang dan ISPA sebanyak 7 orang.

Tabel 40. Rekapitulasi Jumlah Izin Sakit Staf dan Prosentasenya

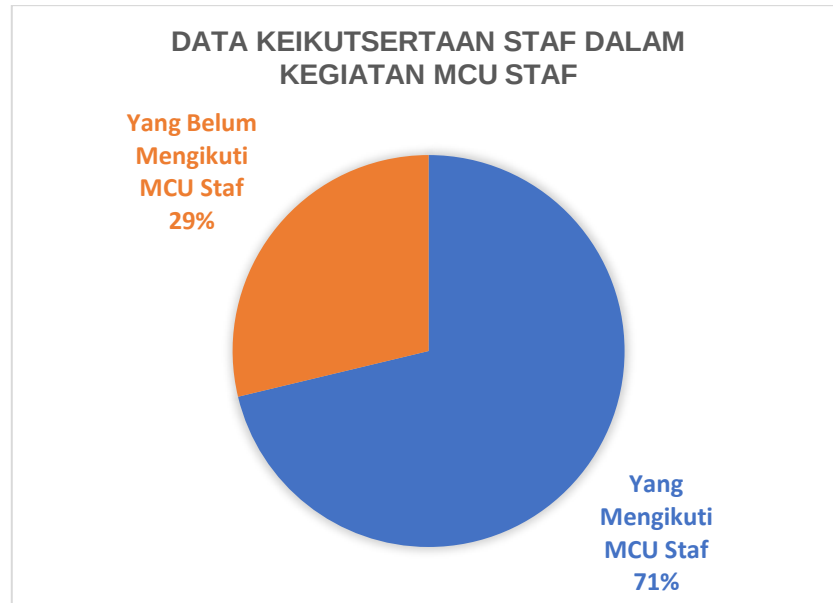
Bulan (2023)	Jumlah Izin Sakit Staff
Mei	36 orang (8%)
Juni	34 orang (8.35%)
Juli	58 orang (14%)
Agustus	62 orang (15%)
September	40 orang (10%)
Oktober	43 orang (10%)
November	43 orang (10%)
Desember	49 orang (12%)
Rata-Rata/Bulan	45.62 orang / Bulan



3.11.8 Data Medical Check Up Karyawan

Terdapat 407 karyawan (non DPJP) yang menjadi sasaran terkait *Medical Check Up* berkala yang diadakan. Medical Check Up dimulai pada tanggal 3 Maret 2023 dan telah diikuti oleh sekitar 290 orang sampai Juni 2023. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan umum dilakukan oleh dokter MCU terkait pemeriksaan jasmani dari pasien yang bersangkutan. Terkait pemeriksaan khusus berupa foto thorax dan ditujukan kepada petugas IRNA 2A dan CS Lantai 2 serta perawat poli TB yang berisiko terkait penularan pasien di ruangan isolasi dan poli TB.

a. Tingkat kepatuhan pemeriksaan MCU Staf

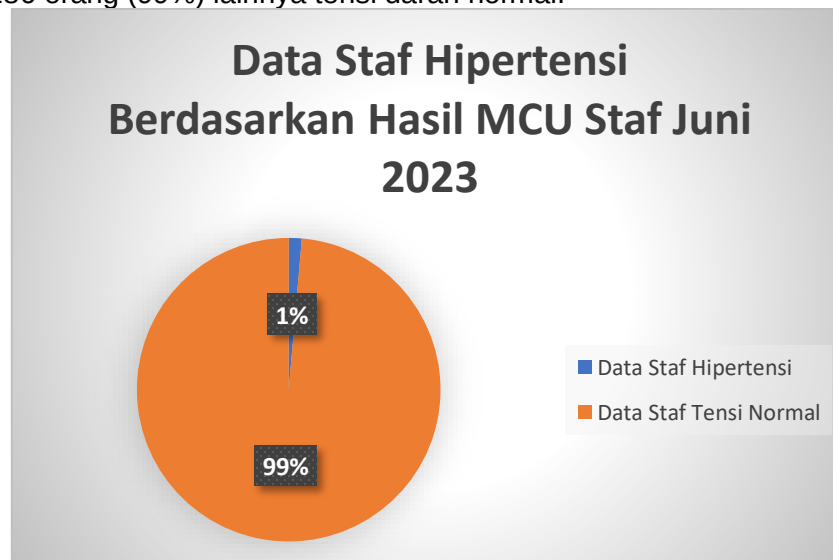


Gambar 30. Hasil *Diagram Pie* Prosentase terkait Data Keikutsertaan Kegiatan MCU Staf Tahun 2023

Dari 407 staf yang ada, 290 orang (71%) telah mengikuti MCU Staf dan 117 orang belum mengikuti MCU Staf.

b. Data Pemeriksaan MCU terkait Tekanan Darah Staf

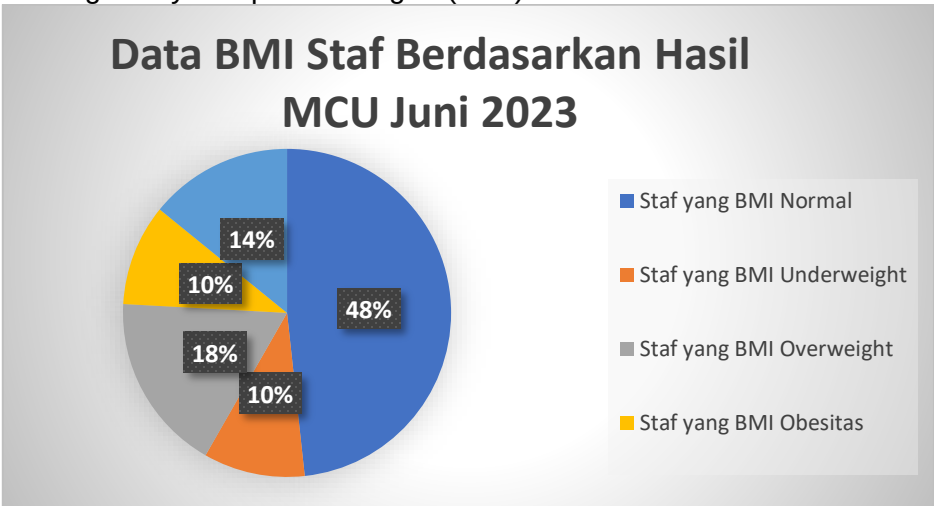
Dari 290 orang yang sudah di MCU, 4 orang (1%) mengalami hipertensi dan 286 orang (99%) lainnya tensi darah normal.



Gambar 31. Hasil *Diagram Pie* Prosentase terkait Data Staf yang Hipertensi berdasarkan Hasil MCU Staf Tahun 2023

c. Data Pemeriksaan MCU kategori *Body Mass Index (BMI)*

Dari 290 orang yang sudah melakukan MCU, 140 orang (48%) BMI dalam kategori normal, 29 orang (10%) mengalami obesitas, 51 orang (18%) mengalami overweight dan 29 orang mengalami underweight (10%) dan 41 orang lainnya tanpa keterangan (14%).



Gambar 32. Hasil *Diagram Pie* Prosentase terkait Data BMI Staf berdasarkan Hasil MCU Staf Tahun 2023



Pasuruan, 16 Mei 2023

Nomor : 415RSPHS-UNDIRV2023

Lampiran : 1 (Satu)

Perihal : Pemeriksaan Kesehatan Berkala / Medical Check Up (MCU)

Kepada Yth.

Staf Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo

(Terlampir) di Tempat

Dengan hormat

Dengan ini kami beritahukan bahwa akan diadakan pemeriksaan kesehatan berkala kepada staf terlampir di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo, pada :

Hari / tanggal : Jumat – Sabtu, 19-20 Mei 2023

Pukul : 09.00 – 12.00 WIB

Tempat : Poli Vaksin (Cafetaria)

Agenda : Pemeriksaan Kesehatan Staf Berkala.

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka diwajibkan untuk hadir dan tetap mematuhi protokol kesehatan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terimakasih.

*harus datang 15 menit sebelum acara dimulai dan membawa bucinot

Hormat kami,

Direktur RS Prima Husada Sukorejo



dr. Ifti Baqius Ariantono



LAMPIRAN JADWAL PEMERIKSAAN

Nama Staf	Unit	Tanggal Pemeriksaan
Eno Harsono, A.Md.Kep	IRNA II A	Jumat, 19 Mei 2023
Siti Rahayu Kusumawati, S.Kep.Ns	IRNA II A	Jumat, 19 Mei 2023
Husada Pradiha, S.Kep.Ns	IRNA II A	Jumat, 19 Mei 2023
Nafa Mahyuning Lyes, Amd.Kep	IRNA II A	Jumat, 19 Mei 2023
Margah Rochmawati N.W, S.Kep.Ns	IRNA II A	Jumat, 19 Mei 2023
M. Yusuf Anif Alamsi, Amd.Kep	IRNA II A	Jumat, 19 Mei 2023
Bagas Suno Puwono, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Bayu Ali Kurnia, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Siti Khumairah, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Endang Nur Azca, S. Kep. Ns	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
M. Fandi Hamzan, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Linda Sasmita, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Umi Masruch, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Umi Masruch, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Moch. Agung Setiawan, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Zakaria Rahmawati, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Bagus Panuly, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Dewi Acriyanti, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Vella Octaviana, Amd.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Enca Siswanti Apusita, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Ana Nurul, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Iana Setya Wati, S.Kep. Ns	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Yitana Aniky Maiany, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Mega Ayu Setya Ujjaning, S.Kep. Ns	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Siti Wati Setya Amalia, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Kusuma Nisak Arum P.S, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Auliahya Soleha, A.Md.Kep	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Siti Mas Miranda Anggraeni, S.Kep. Ns	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Irina Huska Rahma Hidayah, S.Kep. Ns	IRNA II B	Jumat, 19 Mei 2023
Siti Mayasari, Amd.Kep	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023
A. Khumairah, S.Kep. Ns	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023
Siti Laili Ayu Purni, Amd.Kep	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023
Dewi Wijayanti, Amd.Kep	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023
Suzati Hidayatullah, A.Md.Kep	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023
Nita Marisa Sani, Amd.Kep	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023
Sinta Olivia Rahayu, S.Kep.Ns	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023
Yusana Prihosatirani, S. Kep. Ns	IRNA III	Jumat, 19 Mei 2023

Gambar 33. Undangan untuk Staf yang BMI tidak Normal untuk mengikuti senam bersama

Tindaklanjut untuk staf yang obesitas dan overweight yaitu adanya olahraga bagi karyawan yaitu badminton, senam, zumba, futsal



Gambar 34. Dokumentasi Senam Karyawan

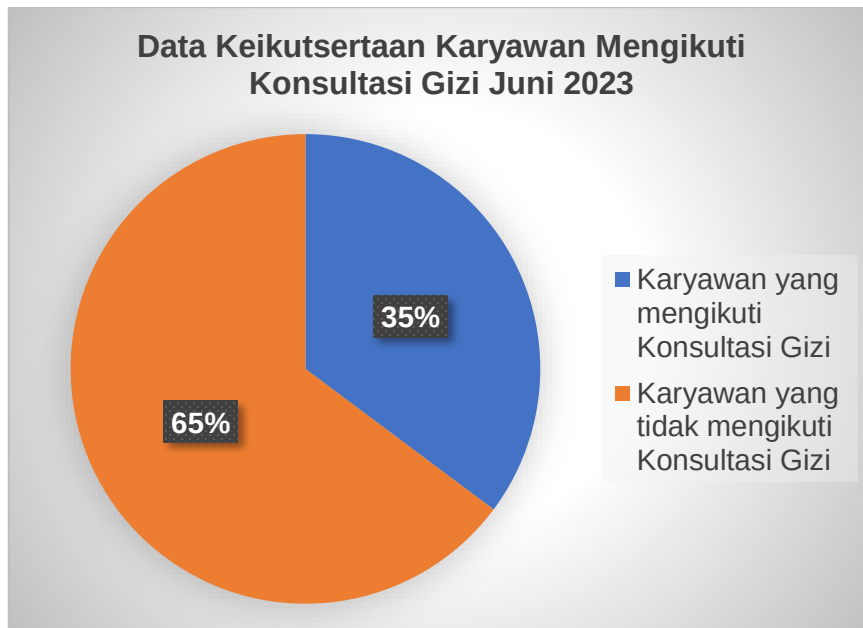
Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Desa Lemahbang Kec. Sukorejo – Pasuruan

Telp : 0343 – 6745000 | Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



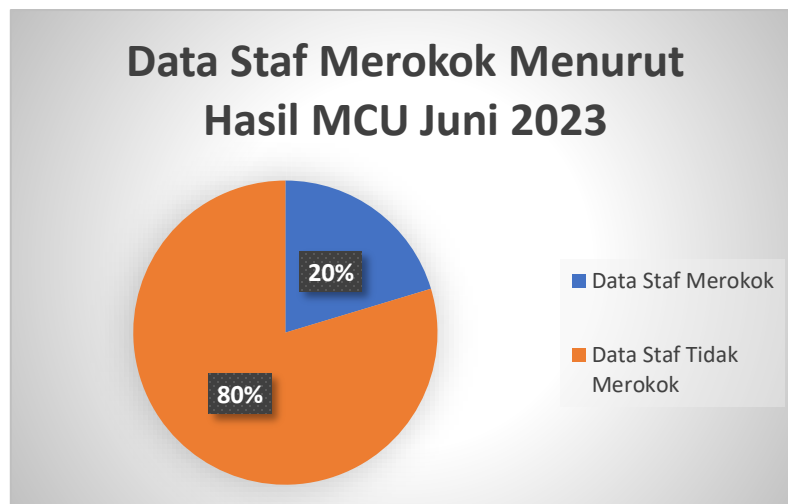
Untuk penanganan karyawan yang obesitas, overweight ataupun yang underweight, maka dilakukan konsultasi gizi pada staf yaitu pada 9 Juni 2023 dan 13 Juni 2023 yang diikuti 25 orang (35%) dari 71 orang (100%) yang dijadwalkan untuk mengikuti konsultasi gizi. Tindak lanjut yaitu melakukan sosialisasi agar karyawan antusias dalam mengikuti kegiatan konsultasi gizi dan olahraga lainnya



Gambar 35. Hasil *Diagram Pie* Prosentase Data Keikutsertaan Karyawan Mengikuti Konsultasi Gizi Juni 2023

d. Data Pemeriksaan MCU terkait Staf yang Merokok

Dari 290 orang yang melakukan pemeriksaan MCU pada Bulan Januari - Juni 2023, terdapat 231 orang (80%) yang tidak merokok dan 59 orang (20%) yang merokok baik merokok vape (elektrik) dan non elektrik.



Gambar 36. Hasil *Diagram Pie* Prosentase Data Staf yang merupakan Perokok Aktif Berdasarkan Hasil MCU Staf Juni 2023

3.5. Kinerja Produktifitas Komite Mutu
3.5.1 Mutu Nasional

Berikut merupakan penjelasan mengenai capaian indikator mutu nasional RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2023.

Tabel 3.1 Indikator Mutu Nasional

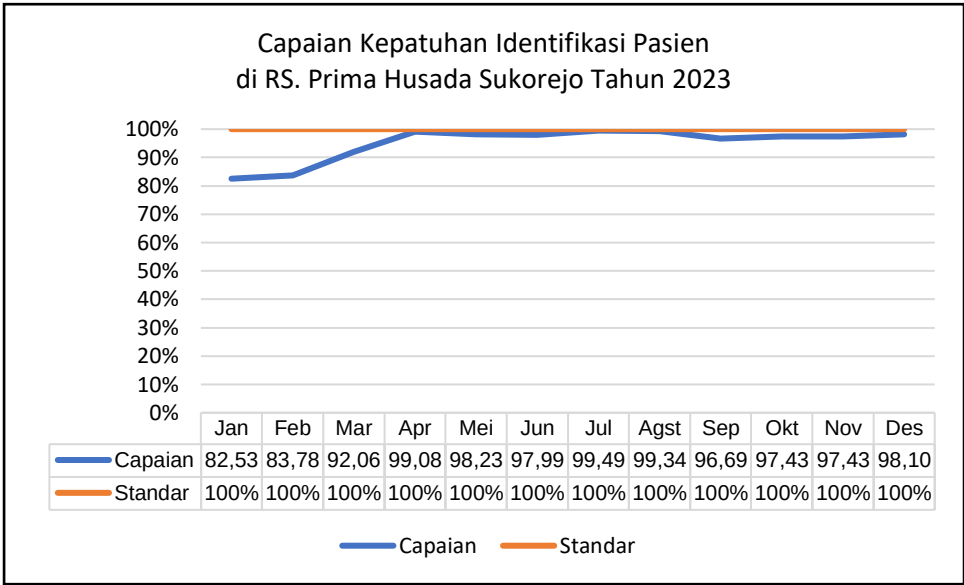
No	Judul Indikator Mutu Nasional	Standar
1	Kepatuhan identifikasi pasien	100%
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency	100%
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan	≥80%
4	Penundaan Operasi Elektif	≤5%
5	Ketpatuhan Waktu Visite DSepter	≥80%
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium	100%
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	≥80%
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	≥85%
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	100%
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	≥80%
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	≥76.61%
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	≥80%
13	Ketidakpatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd)	100%

Tabel 3.2 Capaian Indikator Mutu Nasional RSPH Sukorejo Desember Tahun 2023

N o	Judul Indikator	Bulan												Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	82,53 %	83,78 %	92,06 %	99,08 %	98,23 %	97,99 %	99,4 9%	99,34 %	96,69%	97,43 %	97,43%	98,10%	100%	95,18%	Tidak tercapai
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency	93%	88,09 %	88,37 %	89,28 %	88,70 %	88,46 %	90,9 6%	91,11 %	92,59%	93,75 %	91,11%	96,87%	≥80%	91%	tercapai
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan	96,88 %	98,07 %	99,53 %	100 %	92,45 %	100 %	100 %	100%	98,75%	100%	100%	97,05%	≥80%	99,18%	tercapai
4	Penundaan Operasi Elektif	4,38 %	4,88 %	9,257 %	0,71 %	0,83 %	1,26 %	2,36 %	1,74 %	0,83%	4,41%	1,12%	1,53%	≤5%	2,4%	tercapai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	90,93 %	92,23 %	91,62 %	87,21 %	92,70 %	87,90 %	89,3 8%	86,05 %	89,95%	85,19 %	64,31%	64,37%	≥80%	83,38%	tercapai
6	Waktu Lapor Hasil Tes Kritis Laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	tercapai
7	Kepatuhan Penggunaan For-mularium Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	tercapai
8	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80 %	74,94 %	68,24 %	84%	70%	75%	77,0 8%	82%	78%	90%	78%	83%	≥85%	78,67%	Tidak tercapai
9	Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh	79,38 %	89,13 %	88,84 %	89,69 %	99,82 %	100 %	99,9 3%	99,79 %	98,95%	92,75 %	96,05%	96,25%	100%	94,21%	Tidak tercapai
10	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	66%	61%	62%	87,12 %	85,42 %	-	-	-	66%	93,47 %	90%	90,48%	≥80%	90,78%	tercapai
11	Kepuasan Pasien Dan Keluarga	80%	81,23 %	80,14 %	81,25 %	83,47 %	84,51 %	86,4 4%	77,50 %	78,57%	85,78 %	85,84%	89,54%	≥ 76,61%	82,85%	tercapai
12	Kecepatan Waktu Tanggap Komplain	86%	86,41 %	86,54 %	82,14 %	83,15 %	82,44 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100Z%	≥80%	92,22%	tercapai
13	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd)	83%	84,41 %	85,36 %	85%	83%	90%	88%	96%	94%	69%	91%	88%	100%	87,81%	Tidak tercapai

3.1.2 Analisis Capaian Indikator Mutu Nasional yang Tidak Di inginkan

1. Kepatuhan Identifikasi Pasien



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil capaian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kepatuhan identifikasi pasien di RS. Prima Husada Sukorejo pada Tahun 2023 rata-rata mencapai 95,17%. dari 14 unit yang di observasi unit rawat inap 2A masih memiliki capaian dibawah standar.

Berikut merupakan rata-rata capaian untuk setiap unit :

1. IGD : 100%

2. Irna 2A : 73.38% dari 124 pasien yang di observasi ditemukan 33 pasien yang tidak dilakukan dengan benar pada saat memberikan obat kepada pasien, memberikan diet pada pasien.

3. Irna 2B : 100%

4. Irna 3A : 100%

5. Irna 3B : 100%

6. ICU : 100%

7. Maternitas : 100%

8. Perinatologi : 100%

9. Rawat Jalan : 100%

10. Laboratorium : 100%

11. Radiologi : 100%

13. Rehab Medik : 100%

14. Rehab medik : 100%

Tabel 3.4 PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2023 adalah 95.18%, belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : mengetahui kepatuhan petugas melakukan identifikasi pasien secara berkesinambungan Harapan : seluruh petugas di unit pelayanan melakukan identifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal 2 identitas dari 4 identitas yang dapat digunakan Tindakan : h. melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkesinambungan i. melakukan peneguran kepada staff jika masih melakukan proses identifikasi yang salah / tidak melakukan j. koordinasi dengan kepala ruang untuk lebih memantau kinerja dari staff yang tidak melakukan identifikasi dengan benar / tidak melakukan identifikasi



	k. koordinasi dengan komite sasaran keselamatan pasien untuk terus melakukan supervisi & sosialisasi terkait identifikasi pasien l. Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 2. Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 24. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 25. Waktu dilakukan identifikasi pasien yakni sebelum pemberian obat, pengambilan darah atau specimen lain, pemeriksaan klinis pada pasien, pengobatan atau tindakan kepada pasien belum terkaji secara maksimal 26. Masih ditemukan ketidakpatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien di Rawat Inap 2A yang masih tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada tahun 2023 mencapai 97,43%, grafik tren capaian menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pada bulan januari sampai bulan April. Kemudian di bulan juni terjadi penurunan capaian disebabkan oleh kurangnya tersupervisi masing-masing unit. Setelah dilakukan sosialisasi terjadi peningkatan dari bulan September sampai bulan desember 2. Mayoritas petugas masih belum mengetahui kapan waktu yang di anjurkan untuk melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin. 2. Dilakukan pembentukan kelas-kelas kecil untuk unit yang belum mencapai target sasaran untuk peningkatan pengetahuan petugas 3. Monitoring kepatuhan berdasarkan moment identifikasi pasien

Tabel 3.5 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan melakukan identifikasi sesuai moment identifikasi	Tercapaian peningkatan kepatuhan identifikasi pasien di setiap unit meningkat pada capaian bulan berikutnya	Melakukan training in house dengan pembagian kelas kecil (1 kelas minimal 5 petugas), selanjutnya cek lapangan untuk realisasi hasil pelatihan	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu bulan

2. Kepatuhan Upaya Pencegahan Resiko Cedera Akibat Pasien Jatuh



- Hasil Capaian :**
- Berdasarkan hasil capaian diatas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kepatuhan kepatuhan upaya pencegahan risiko akibat pasien jatuh pada Tahun 2023 adalah 94.21%, angka tersebut belum mencapai target 100%. Dari 10 unit kerja yang di observasi unit rawat inap 2A dan 3B masih belum mencapai target. Berikut rata-rata capaian unit :
- 1. IGD : 100%
 - 2. Rawat Inap 2A : 94.59% : 4 pasien tidak dilakukan Upaya pencegahan resiko jatuh, asesmen ulang tidak dilakukan pada pasien dari 74 pasien yang di observasi.
 - 3. Rawat Inap 2B : 100%
 - 4. Rawat Inap 3A : 100%
 - 5. Rawat Inap 3B : 64%: 19 pasien tidak dilakukan Upaya pencegahan resiko jatuh, asesmen ulang tidak dilakukan pada pasien dari 53 pasien yang di observasi.
 - 6. Maternitas : 100%
 - 7. Perinatologi : 100%
 - 8. Rawat Jalan : 100%
 - 9. Radiologi : 100%
 - 10. ICU : 100%

Tabel 3.7 PDSA Capaian Kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh pada Tahun 2023

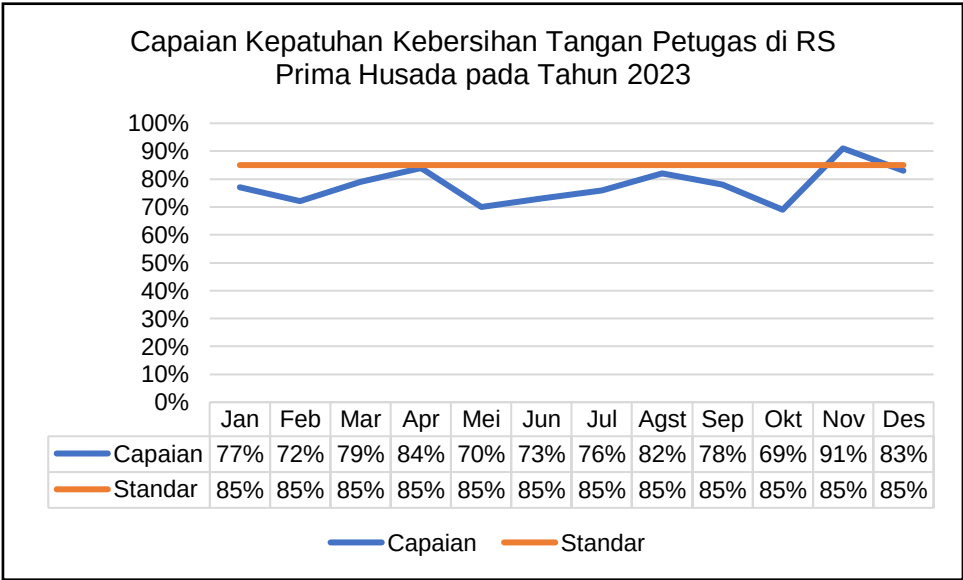
Problem	Rata-rata capaian kepatuhan upaya pencegahan risiko cedera akibat pasien jatuh Tahun adalah 94.21%, angka tersebut belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kepatuhan pencegahan resiko jatuh
Plan	Rencana : a. memantau kepatuhan petugas dalam melakukan asesmen awal resiko jatuh & asesmen ulang terhadap pasien bila di indikasi terjadi perubahan kondisi b. memonitoring kepatuhan petugas dalam menerpakan langkah-langkah untuk mengurangi resiko jatuh bagi pasien yang dianggap beresiko Harapan : semua petugas patuh melakukan asesmen awal / asesmen ulang pasien resiko jatuh di unitnya Tindakan : a. Pengecekan fasilitas penanda resiko jatuh di ruangan b. Ketepatan penggunaan resiko jatuh c. Pelatihan kepada security untuk skrinning resiko jatuh pada pintu masuk d. Supervisi kepatuhan petugas dalam melaksanakan upaya pencegahan resiko jatuh
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Melihat kepatuhan petugas dalam skrinning awal pasien jatuh di pintu masuk 2. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen awal pasien 3. Melihat kepatuhan petugas dalam mengisi asesmen ulang pasien indikasi resiko jatuh

	4. Melihat intervensi yang dilakukan oleh petugas apakah sudah sesuai dengan yang ada di RM
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Berdasarkan hasil capaian resiko jatuh dari Bulan Desember rata-rata capaian nya yakni 94.21% 2. Berdasarkan hasil pengamatan di unit, masih ditemukan petugas yang tidak patuh dalam melakukan pemasangan tanda resiko jatuh pada box pasien, kadang petugas di ruangan juga lupa untuk menilai resiko jatuh pasien pada hari rawat ke berikutnya
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Rata-rata capaian pencegahan upaya risiko pasien cedera akibat jatuh pada Tahun 2023 berdasarkan grafik tand mengalami peningkatan pada bulan januari – desember, namun masih belum mencapai standar, hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan petugas dalam memberikan tanda resiko jatuh yang belum dilaksanakan dengan baik, dan skrinning awal di pintu masuk RS Follow-up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya, monitoring dan supervise oleh kepala ruang secara rutin

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan penulisan di RM	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam menghitung resiko jatuh pada pasien rawat inap	Tercapaiannya peningkatan kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh di beberapa unit rawat inap yang belum mencapai target Menjadi 100%	Mengingatnkan kepada petugas yang bertugas saat ditemukan RM yang tidak terkaji resiko jatuhnya	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu Bulan

3. Kepatuhan Kebersihan Tangan Petugas



Hasil Capaian :
Berdasarkan capaian kepatuhan kebersihan tangan diatas pada bulan Desember belum mencapai > 85%, mencapai 78.67%. pada grafik tersebut dapat diketahui kepatuhan hand hygiene berdasarkan 5 momen bulan Desember 2023 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum ke pasien.

1. IRNA 3 A: 55%

2. IRNA 3B : 93%



3. IRNA 2A : 90%
4. IRNA 2B : 63%
5. ICU : 63%
6. MATERNITAS : 95%
7. NEONATOLOGI : 87%
8. IGD : 89%
9. IKO : 42%
10. IRJA : 74%
11. LAB : 100%

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Tahun 2023

Problem	Persentase kepatuhan hand hygiene pada bulan Desember < 85% yakni 78.67%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan hand hygiene secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit hand hygiene pada pstaf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang hand hygiene c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene staf di unit.
Do	Kepatuhan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
Study	1. kepatuhan hand hygiene bulan Desember 2023 yaitu 83%. 2. kepatuhan terendah adalah IKO dan Irna 3A yaitu sebesar 42% dan 55%, dan kepatuhan tertinggi adalah unit Laboratorium 100%. 3. kepatuhan hand hygiene per profesi tertinggi adalah nakes lain sebesar 80%. 4. kepatuhan hand hygiene berdasarkan 5 momen bulan Desember 2023 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum ke pasien sebesar 51% dan tertinggi momen setelah menyentuh cairan pasien sebesar 96%. 5. fasilitas kebersihan tangan bulan Desember 2023 sudah 100% terpenuhi 6. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan hand hygiene sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	1. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 2. Kolaborasi dengan kbid terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 3. Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 4. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

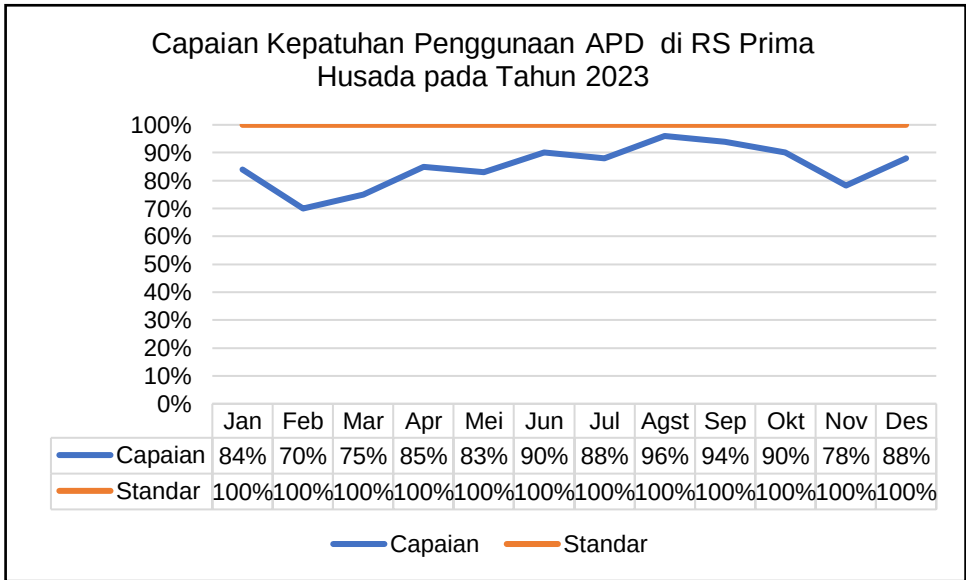
Tabel 3.11 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai SPO (6	Kepatuhan kebersihan petugas rawat inap sesuai dengan SPO hand hygiene	Sosialisasi SPO hand hygiene di setiap ruangan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan



	5 momen.	langkah 5 moment)				
2	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat rutin dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

4. Kepatuhan Penggunaan APD



Hasil Capaian :

Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penggunaan APD pada bulan Desember 2023 adalah 91%. Dari 17 unit yang di observasi masih ditemukan 11 unit yang angka capaiannya belum 100%. Berikut merupakan capaian kepatuhan APD pada masing-masing unit :

1. Irna 3A	: 73%	9. Rawat Jalan	: 89%
2. Irna 3B	: 96%	10. Lab	: 94%
2. Irna 2A	: 84%	11. Farmasi	: 91%
3. Irna 2B	: 82%	12. Radiologi	: 96%
4. ICU	: 86%	13. Gizi & Dapur	: 86%
5. Maternitas	: 85%	14. CSSD	: 92%
6. Perinatologi	: 96%	15. Laundry	: 90%
7. IGD	: 86%	16. B3	: 98%
8. IKO	: 88%	17. CS	: 80%

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2023

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan



	infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD 1. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	1. Masih ditemukan petugas yang tidak tepat dalam penggunaan masker dan handscoon sesuai indikasi (IRNA). Petugas tidak menggunakan APD yang tepat di area dapur. 1. Ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan baik sebelum maupun setelah menggunakan handscoon.
Action	1. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk monitoring penggunaan APD di unit. 4. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 1. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kepatuhan penggunaan APD tangan di setiap pelatihan KDPK.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

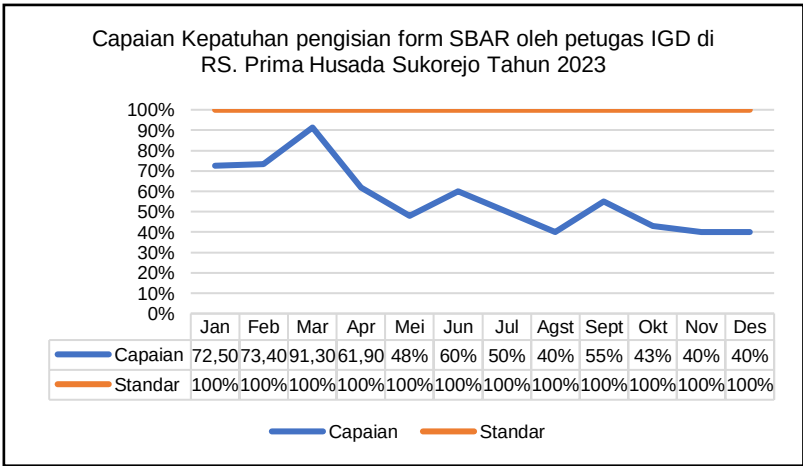
3.5.2 Mutu prioritas Rumah Sakit

Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit pada Tahun 2023

No	Indikator Mutu Prioritas RS	Judul Indikator	Std	Bulan												Rata-rata	KET
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Indikator Sasaran Keselamatan Pasien	Identifikasi pasien : (sudah di laporkan setiap unit) Kepatuhan identifikasi pasien IGD	100%	100%	95.58%	100 %	100%	98,5 %	97,5 %	100%	100%	99.85 %	100%	100%	100%	99.29%	Dipertahankan
		Komunikasi Efektif : Kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD	100%	72,5%	73,4%	91,3 %	61.90 %	48%	60%	50%	40 %	55 %	43%	40%	40%	56.26%	PDSA
		Pelabelan High Alert : Kejadian tidak adanya label high alert pada obat di IGD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertahankan
		Penanda operasi : Kejadian tidak dilaksanakannya penandaan lokasi operasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
		Hand Hygiene : Kepatuhan hand hygiene petugas IGD	100%	100%	100%	86%	75%	73%	87%	85%	86%	89%	83%	77%	89%	85.830%	PDSA
		Resiko Jatuh : Kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	95,74 %	100%	100%	100%	100%	100%	91.96%	PDSA
2	Pelayanan Klinis Prioritas	Angka kelengkapan asesmen awal medis pasien IGD	≥80%	49.52%	83.19%	74.9 1%	70.16 %	79.99 %	94.37 %	97.77 %	96.79 %	92.81 %	93.47 %	89,53%	89.14%	76.84%	Dipertahankan
		Waktu tanggap pelayanan gawat darurat pada pasien ≤ 5 menit setelah pasien datang	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	87.97%	99%	Dipertahankan
3	Renstra RS	Waktu tunggu di IGD sebelum masuk rawat Inap ≥ 3jam (paien P2 & P3)	≤20%	42.38%	12.16%	9.05 %	4.87 %	19%	28.86 %	24,33 %	19.71 %	16.35 %	46.41 %	14,59%	15.52%	17.86%	Dipertahankan
		Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam	≤ 2/ 1000 pasien	7/663 pasien	8/600 pasien	2/64 1	9/697	12/72 6	9/686	9/715	10/87 5	4/899	8/853	8/884	8/966	8/836	PDSA
4	Perbaikan Sistem	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Manajemen Resiko	Angka tidak terpasangnya gelang identitas pasien IGD	0%	0.12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5.44%	0%	0%	0,46%	Dipertahankan

3.5.3 Analisis Capaian Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit yang Tidak Di inginkan

1. Kepatuhan pengisian form SBAR oleh Petugas IGD



Hasil Capaian :

Berdasarkan hasil di atas kepatuhan petugas melakukan pengisian SBAR pada Tahun 2023 mencapai 40%, capaian tersebut belum mencapai target 100%. Banyak sbar yang tidak terisi pada bagian :

1. Appearance: perubahan pola makan, status kesadaran, pencernaan, pernapasan, perubahan kondisi kulit.
2. Keterangan SBAR
3. Tanda tangan pemberi pesan

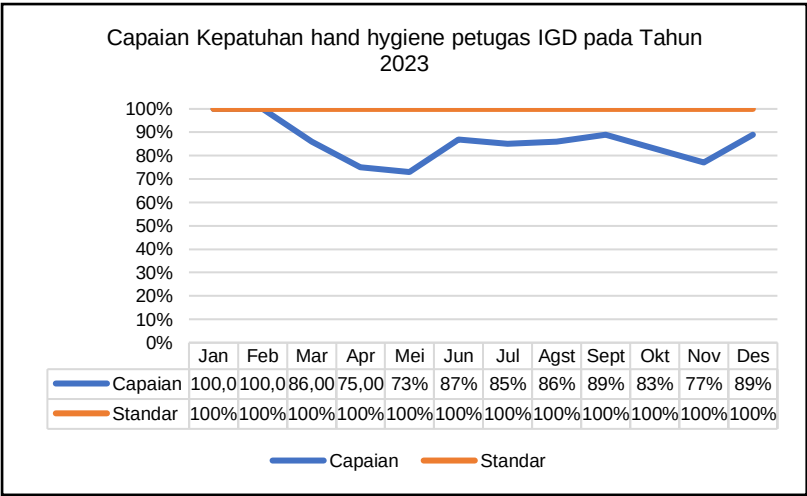
Tabel 3.17 PDSA Capaian Kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD padabulan desember tahun 2023 adalah 40% belum mencapai target 100%
Step	Rencana : Meningkatkan kepatuhan pengisian SBAR petugas IGD dengan melaksanakan monitoring dan supervisi oleh kepala ruangan dengan koordinasi dengan tim PKRS Harapan : Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR di IGD tercapai 100% Tindakan : 1. Monitoring dan supervise secara rutin oleh kepala ruangan 2. Melaksanakan pengisian SBAR sesuai dengan SPO 3. Peneguran secara langsung kepada petugas yang tidak melengkapi form SBAR dan dilakukan pengisian pada hari yang sama 4. Pengecekan kelengkapan form SBAR sebelum pasien dipulangkan / dinaikan ke rawat inap 5. Koordinasi dengan PKRS untuk melakukan monitoring dan supervi kepatuhan petugas
Plan	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kepatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD 2. Form SBAR pasien IGD
Do	Rencana : Meningkatkan kepatuhan pengisian SBAR petugas IGD dengan melaksanakan monitoring dan supervisi oleh kepala ruangan dengan koordinasi dengan tim PKRS Harapan : Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR di IGD tercapai 100% Tindakan : 1. Pelatihan penulisan SBAR pada dokter IGD 2. Pengecekan kelengkapan form SBAR sebelum pasien dipulangkan / dinaikan ke rawat inap 3. Koordinasi dengan PKRS untuk melakukan monitoring dan supervi kepatuhan petugas
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? 1. Kepatuhan petugas dalam pengisian SBAR sesuai dengan SPO 2. Persentase capaian kepatuhan pengisian SBAR oleh petugas IGD pada bulan desember tahun 2023 sebesar 40%, belum mencapai target. ketidakpatuhan dalam melakukan pengisian SBAR disebabkan oleh : a. Masih ditemukannya SBAR yang dituliskan oleh perawat b. Dokter tidak menuliskan SBAR sendiri sesuai dengan tugasnya
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Belum tersosiasinya dengan baik penulisan SBAR kepada dokter di IGD sehingga masih ditemukan SBAR yang tidak lengkap di ruangan Follow-Up dan Rencana Lanjutan Evaluasi pencapaian pada bulan selanjutnya, monitoring dan supervise oleh kepala ruangan dan melakukan koordinasi dengan Tim PKRS

Tabel 3.18 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pelatihan penulisan SBAR	Meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan dalam penulisan SBAR di IGD	Capaian Ketidakpatuhan pengisian form SBAR oleh petugas IGD bulan Desember 40% naik 100% pada tahun berikutnya	Pelatihan online kepada dr. IGD yang dilakukan oleh ka. Bidang pelayanan & ka. Ruang rekam medis	Ka. Bidang Yangmed Ka. Ruang RM Ka. Ruang IGD	Sebulan

2. Angka Kepatuhan Hand Hygiene Petugas IGD



Hasil Capaian :

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian angka kepatuhan hand hygiene petugas IGD pada Desember adalah 89%, angka tersebut belum mencapai target 100%..

Tabel 3.20 PDSA Capaian Angka kepatuhan hand hygiene petugas IGD pada Tahun 2023.

Problem	Rata-rata capaian angka kepatuhan hand hygiene pada Bulan Desember Tahun 2023 adalah 89% belum mencapai target 100%
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke staf di unit IGD mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan hand hygiene secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf igd melakukan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit hand hygiene pada staf IGD secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang hand hygiene c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene staf di unit.
Do	Kepatuhan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
Study	1. kepatuhan hand hygiene bulan Desember 2023 mengalami peningkatan 1% yaitu 89%. 2. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan hand hygiene sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	1. Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 2. Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan. 3. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebersihan tangan di setiap pelatihan KDPK. 4. Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing. 5. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 6. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 7. Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

Tabel 3.21 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan cuci tangan	Kepatuhan kebersihan petugas IGD sesuai	Sosialisasi SPO hand hygiene di setiap ruangan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan



	langkah sesuai 5 momen.	sesuai SPO (6 langkah 5 moment)	dengan SPO hand hygiene			
2	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai dengan SPO	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebersihan tangan di setiap pelatihan KDPK.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat IGD	Rapat rutin dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas IGD melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

3. Kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa, rata-rata capaian Kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh pada Bulan Desember tahun 2023 mencapai 100% namun rata-rata pada tahun 2023 belum mencapai target 100%.

Tabel 3.23 PDSA Capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh pada Bulan Desember Tahun 2023 adalah 91% belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh
Plan	Rencana : Meningkatankan kepatuhan petugas dalam melakukan Kepatuhan Upaya Pencegahan Pasien IGD Jatuh Harapan : 1. Upaya pencegahan resiko jatuh di IGD dapat dilaksanakan sesuai SOP 2. Terjadi peningkatan kepatuhan pencegahan pasien jatuh di IGD agar sesuai target 100% Tindakan : 1. Monitoring fasilitas tanda resiko jatuh di IGD 2. Supervisi oleh kepala ruang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Kepatuhan petugas dalam pemberian tanda resiko jatuh pada pasien

Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Capaian rata-rata kepatuhan upaya pencegahan pasien IGD jatuh pada bulan tahun 2023 mencapai 91% belum sesuai target capaian.
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? - Kepatuhan upaya pencegahan resiko jatuh pasien IGD sudah dilakukan oleh petugas hal ini perlu adanya pemantauan secara rutin untuk mempertahankan capaian Upaya pencegahan pasien IGD jatuh Follow-Up dan Rencana Lanjutan - Supervisi rutin oleh tim SKP

Tabel 3.24 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Pengecekan tanda resiko jatuh di IGD	Meningkatkan penerapan tanda resiko jatuh pasien IGD	Seluruh pasien resiko jatuh dapat dilakukan penandaan resiko jatuh pada bednya dan rekam medisnya	Monitoring dan supervisi penggunaan tanda resiko jatuh	Ka. Ruangan Tim SKP Komite Mutu	Satu Bulan

4. Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam

Tabel 3.28 Analisis Capaian Indikator Prioritas RS yang Tidak Di Inginkan pada Tahun 2023

Stand ar	Judul Indikator	Stan dar	Capaian Bulan												Rat a-rata	Area
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	De s		
Priorit as-RS	Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam	≤ 2/ 1000 pasie n	7/66 3 pasi en	8/60 0 pasi en	2/64 1	9/69 7	12/7 26	9/68 6	9/71 5	10/8 75	4/89 9	8/85 3	8/88 4	8/9 66	8/83 6	IGD

Hasil Capaian :

Berdasarkan Tabel diatas dapat disimpulkan, bahwa rata-rata capaian kematian pasien di IGD ≤24 Jam rata-rata adalah 8 pasien dari 966 pasien. Capaian tersebut belum sesuai dengan target ≤ 2 pasien dari 1000 pasien yang datang di IGD.

Tabel 3.29 PDSA Capaian Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 Jam pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian kematian pasien di IGD ≤ 24 jam pada Bulan Desember 2023 adalah 8 pasien dari 966 pasien yang berkunjung di IGD
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk kematian pasien di IGD ≤ 24 jam
Plan	Rencana : Mengurangi kematian pasien di IGD ≤ 24 jam dengan melaksanakan peningkatan skill maupun kinerja petugas IGD dan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja oleh kepala ruang Harapan : Kematian pasien di IGD ≤ 24 jam tercapai ≤ 2/ 1000 pasien Tindakan : - Evaluasi kinerja petugas IGD oleh Kepala Ruang - Pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai dengan SPO - Bekerja sama dengan spesialis emergency untuk penanganan lebih lanjut - Mengadakan seminar emergency bersama tim dSepter igd dan spesialis emergency untuk penanganan pasien emergency
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Kematian pasien IGD ≤ 24 Jam - Kinerja petugas dalam menangani pasien di IGD
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? - Capaian rata-rata kematian pasien di IGD ≤ 24 jam Bulan Desember tahun 2023 adalah 8/966 angka tersebut belum mencapai target ≤ 2 pasien / 1000, hal ini disebabkan oleh : - Pasien yang datang ke igd sudah dalam kondisi buruk
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ?

Hasil capaian indikator untuk Bulan Desemberr Tahun 2023 diperoleh capaian belum sesuai target yang ditentukan, terjadi penurunan angka kematian pasien dari bulan april sampai Desember

Follow-Up dan Rencana Lanjutan

Evaluasi pencapaian pada bulan berikutnya.

Tabel 3.30 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatatkan softskills dan hardskills petugas igd	Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien yang dalam kondisi buruk	Tercapainya pengurangan angka Kematian Pasien Di Instalasi Gawat Darurat ≤24 dari 8/966 menjadi 2/1000 pasien pada tahun berikutnya	Peningkatan pengetahuan melalui seminar maupun pembahasan studi kasus bersama	Ka.ruang IGD Kabid medis	Satu bulan

3.5.3. Mutu prioritas Internal Unit (tiap unit)/Instalasi/Program

1. Instalasi Gawat Darurat

Tabel 3.31 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Gawat Darurat pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kepatuhan maintenance DJ Shock oleh atem	≤ 1 kali/bulan	1 kali	1 kali	1 Kali	1 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	0 kali	PDSA
2	Angka Respon Time WA Perujuk ≥5 Menit	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4.16%	Dipertahankan
3	Kejadian Tidak Tertutupnya Tirai Pasien IGD	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dipertahankan
4	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku (BLS/PPGD/GELS/ALS)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
5	Ketersediaan Tim penanggulangan bencana Kesiapsiagaan = Instrumennya : pelatihan / simulasi/ review	1 tim	1 tim	1tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	1 tim	Dipertahankan
6	Angka pulang atas permintaan sendiri	0%	1.65%	0.67%	0.15%	0.55%	0.41%	1.02%	0,56%	1,6%	1.66%	1.05%	0.90%	0.93%	0.88%	PDSA



Berdasarkan capaian pada bulan Desember ata-tata angka ketidakpatuhan maintenance DJ Shock oleh atem mencapai 0 kali. Yang artinya dalam bulan Desember atem tidak mengecek sama sekali DJ shock yang ada di IGD.

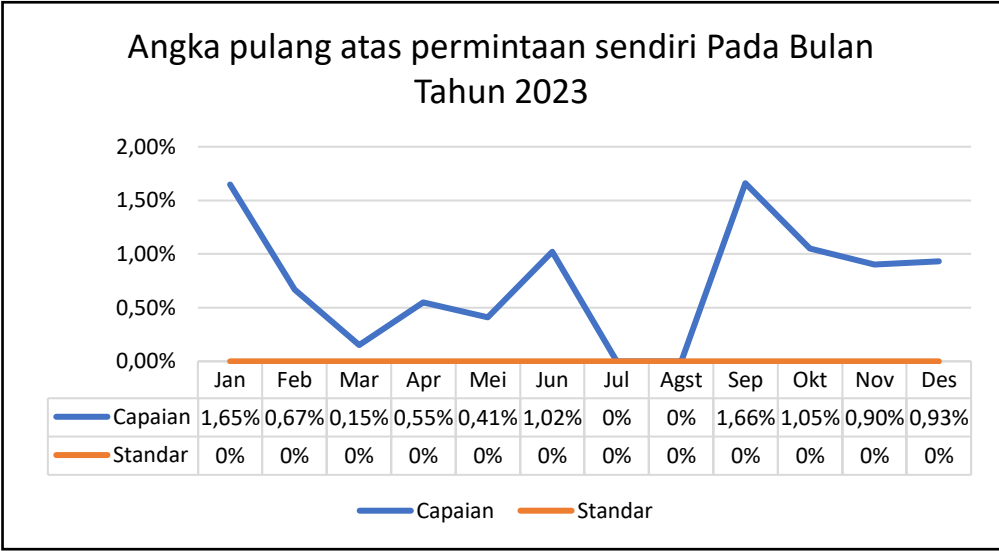


Tabel 3.33 PDSA Capaian Angka kepatuhan *maintenance* DJ Shock oleh atem pada Tahun 2023

Problem	Capaian angka kepatuhan <i>maintenance</i> DJ Shock oleh atem Bulan Deseember Tahun 2023 sebesar 0 kali
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka ketidakpatuhan <i>maintenance</i> DJ Shock oleh atem
Plan	1. Rencana : Meningkatkan kepatuhan atem dalam <i>maintenance</i> DJ shock di IGD 2. Harapan : DJ Shock dapat yermaintenance rutin 1 bulan sekali 3. Tindakan : 1. Peningkatan fungsi PJ alat di ruangan untuk menglist ala tapa saja yang perlu dilakukan <i>maintenance</i> dalam 1 bulan 2. Pengawasan oleh kepala ruangan agar tugas PJ alat berjalan maksimal 3. Koordinasi dengan petugas IPSRS
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ?a 1. Kartu <i>maintenance</i> alat yang ada di IGD apakah sudah terupdate atau belum
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? Capaian Angka ketidakpatuhan <i>maintenance</i> DJ Shock oleh atem pada bulan Desember mencapai 0 kali / tidak dilakukan <i>maintenance</i> pada DJ Shock di IGD. Hal ini disebabkan oleh : a. PJ alat tidak memiliki inventaris alat dengan baik sehingga data mengenai <i>maintenance</i> alat tidak terkondisikan dengan baik b. Kurangnya supervisi oleh kepala ruangan untuk fungsi setiap PJ di unitnya c. Kurangnya koordinasi dengan IPSRS d. Keterbatasan tenaga petugas IPSRS dalam mengkondisikan <i>maintenance</i> alat
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Masih belum berjalan secara maksimal PJ alat di unit untuk melakukan inventasrisasi alat, hal ini dibuktikan dengan hasil inventaris alat baik/rusak yang tidak terupdate / tidak sesuai dengan kondisi lapangan Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Koordinasi dengan kepala ruang dan PJ alat untuk rutin mendata alat-alat yang belum termaintenance dengan baik 2. Koordinasi dengan IPSRS untuk membuat jadwal <i>maintenance</i> alat di IGD secara rutin 3. Koordinasi dengan kepala bidang penunjang agar selalu mensupervsisi kepatuhan petugas IPSRS dalam melakukan pemeliharaan alat

Tabel 3.34 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan fungsi dan tugas PJ alat di IGD	Meningkatkan monitoring dalam pengawasan alat di ruangan	Tercapainya peningkatan kepatuhan atem dalam memaintenance DJ shock di unir	Menjelaskan mengenai tupoksi setiap PJ di unit	Ka.ruangan PJ alat	Satu bulan
2	Supervisi oleh Karu IGD	Meningkatkan kepatuhan PJ alat dalam melaksanakan inventarisasi & <i>maintenance</i> alat dengan baik	Tercapainya proses inventarisasi alat sesuai kondisi alat dilapangan	Supervisi data inventaris unit secara berkala	Ka. Ruangan Ka. Bidang Penunjang	Satu bulan



Hasil Capaian :
Berdasarkan capaian angka pulang atas permintaan sendiri pada bulan Desember mencapai 0.93% belum mencapai target 0%. Dari 966 pasien IGD yang diamati terdapat 9 pasien yang menyatakan pulang atas permintaan sendiri. permintaan sendiri di IGD yang mayoritas dilakukan oleh pasien umum.

- 1. Pada pasien dengan kasus operatif yang berdomisili luar kota cenderung menginginkan operasi di tempat asalnya
- 2. Pasien dengan kategori orang tidak mampu yang terkait biaya
- 3. Keluarga dan pasien menolak dirujuk karnan menurutnya kondisi sudah membaik

Tabel 3.36 PDSA Capaian Angka Pulang Atas Permintaan Sendiri pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka pulang atas permintaan sendiri pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 0.93%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka Pulang Atas Permintaan Sendiri
Plan	Rencana : Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri, dengan melakukan koordinasi antar PPA dan MOD untuk melakukan edukasi mengenai kondisi pasien Harapan : Angka pulang atas permintaan sendiri di IGD tercapai 0% Tindakan : kolaborasi edukasi antar PPA dan MOD untuk mengKIE pasien yang meminta pulang
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. angka pulang atas permintaan sendiri pasien di IGD 2. upaya yang diambil oleh petugas unit ketika terdapat pasien yang ingin pulang atas permintaan sendiri
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? 1. persentase rata-rata capaian angka pulang atas permintaan sendiri di IGD mencapai 0.93%, angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%. Hal ini disebabkan oleh : a. Pasien dengan domisili luar kota b. Pasien dengan tidak adanya jaminan kesehatan c. Asumsi keluarga terhadap kondisi pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. petugas di unit sudah menerapkan KIE mengenai biaya tindakan kepada pasien dan keluarga sebelum dilakukan tindakan tersebut, namun pasien masih berkeinginan untuk pulang karena terkendala dari faktor biaya Follow-up dan Rencana Lanjutan 4. koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri 5. supervisi dan monitoring oleh kepala ruangan mengenai kepatuhan petugas dalam melakukan KIE kepada pasien yang pulang atas permintaan sendiri

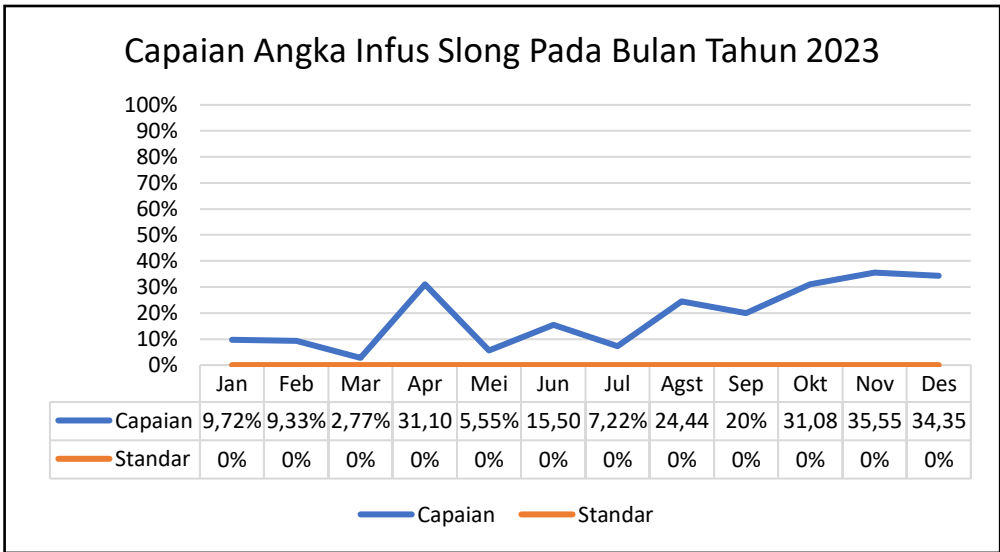
Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri	Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri	Tercapainnya pengurangan pulang atas permintaan sendiri dari 0,93% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Kolaborasi KIE pasien antara petugas dan MOD	Ka. Ruang MOD	Satu bulan

2. Instalasi Rawat Inap 2A

Tabel 3.35 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Inap 2A pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rat a-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Infus Slong	0%	9.72%	9.33%	2.77%	31.1%	5.55%	15.5%	7,22%	24.44%	20%	31.08%	35.55%	34.35 %	18.3 %	PDSA
2	Angka pasien pulang atas permintaan sendiri	0%	4.16%	4%	0.98%	0.98%	0%	1.6%	0,740%	33.3%	2%	0%	0%	0%	3.9 %	PDSA
3	Angka Phlebitis	≤ 1.5%	38.57%	41.09%	3.70%	3.70%	16.6%	12.22%	0%	0%	7%	27.63%	26.58%	24.19 %	16.8 %	PDSA
4	Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pada Pasien KRS ≥24 Jam	≤ 1%	0%	0%	0%	0%	1.25%	0%	6,66%	0%	0%	7.92%	4.50%	3.5 %	1.4 %	Dipertahankan



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian infus slong pada bulan Desember mengalami peningkatan pada bulan sebelumnya mencapai 34.35%. dari 131 pasien yang di observasi terdapat 45 pasien yang mengalami infus slong, hal ini meningkat dari pada pasien pada bulan November mencapai 34.35%.

Tabel 3.40 PDSA Capaian Angka Infus Slong pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka infus slong pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 18.3%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka infus slong
Plan	1. Rencana : Menurunkan capaian angka infus slong di unit Rawat Inap 2A, dengan cara monitoring secara rutin infus yang tersisa untuk segera dilakukan pengantian. 2. Harapan : Angka infus slong di unit rawat inap 2A tercapai 0% 3. Tindakan : 1. Monitoring kepatuhan staff yang berdinas dalam melakukan pergantian infus yang sudah mendekati habis 2. Koordinasi antara Kepala ruang dan PJ Shift dan seluruh petugas untuk memonitoring cairan infus pasien



Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 1. Angka infus slong di unit Rawat Inap 2A 2. Kepatuhan petugas dalam melakukan monitoring cairan infus pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? 1. kepatuhan petugas di unit dalam melakukan pengawasan cairan infus pasien 2. persentase angka infus slong di unit rawat inap 2A pada Bulan Desember Tahun 2023 adalah 18.3%, angka tersebut belum mencapai target 0%. Hal ini disebabkan oleh : a. kurangnya monitoring petugas di unit dalam melakukan pengawasan cairan infus pasien b. tidak segera dilakukan pengantian infus yang baru saat pasien memberitahukan bahwa cairan infus akan habis
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. perhatian petugas di unit rawat inap 2A dikategorikan kurang 2. hasil capaian indikator mutu untuk Bulan Desember Tahun 2023 diperoleh grafik tren meningkat karena pada Bulan agustus mencapai 24.44% dan menurun Kembali di Bulan september dengan capaian 20% dan naik Kembali menjadi 34.35% pada bulan Desember Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. evaluasi dan monitoring pada bulan berikutnya oleh kepala ruangan mengenai kepatuhan petugas di unit dalam melakukan monitoring cairan infus pasien

Tabel 3.37 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan supervisi dalam pengawasan cairan infus pasien	Mengurangi angka infus slong di ruangan	Tercapainya penurunan angka infus slong dari 18.3% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Supervisi kepatuhan petugas dalam pengecekan cairan infus secara berkala	Ka. Ruangan	Satu Bulan



Hasil Capaian :

Berdasarkan capaian diatas, angka pasien pulang atas permintaan sendiri pada bulan Desember mencapai 0%, dari 148 pasien di rawat inap 2A tidak ditemui pasien pulang paksa

Tabel 3.39 PDSA Capaian Angka pasien pulang atas permintaan sendiri pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka pulang atas permintaan sendiri pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 0%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka pasien pulang atas permintaan sendiri
Plan	1. Rencana : Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri, dengan melakukan koordinasi antar PPA dan MOD untuk melakukan edukasi mengenai kondisi pasien 2. Harapan : Angka pulang atas permintaan sendiri di unit Irna 2A tercapai 0% 3. Tindakan : 1. kolaborasi edukasi antar PPA dan MOD untuk mengKIE pasien yang meminta pulang

	2. supervisi dan monitoring oleh kepala ruangan
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - angka pulang atas permintaan sendiri pasien rawat inap 2A - upaya yang diambil oleh petugas unit ketika terdapat pasien yang ingin pulang atas permintaan sendiri
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? persentase rata-rata capaian angka pulang atas permintaan sendiri di Unit Rawat Inap 2A mencapai 4.07%, angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%. Hal ini disebabkan oleh : alasan ekonomi dan alasan pribadi pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? - petugas di unit sudah menerapkan KIE mengenai biaya tindakan kepada pasien dan keluarga sebelum dilakukan tindakan tersebut, namun pasien masih berkeinginan untuk pulang karena terkendala dari faktor biaya & faktor pribadi Follow-up dan Rencana Lanjutan - koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri - supervisi dan monitoring oleh kepala ruangan mengenai kepatuhan petugas dalam melakukan KIE kepada pasien yang pulang atas permintaan sendiri

Tabel 3.40 Rencana Tindak Lanjut

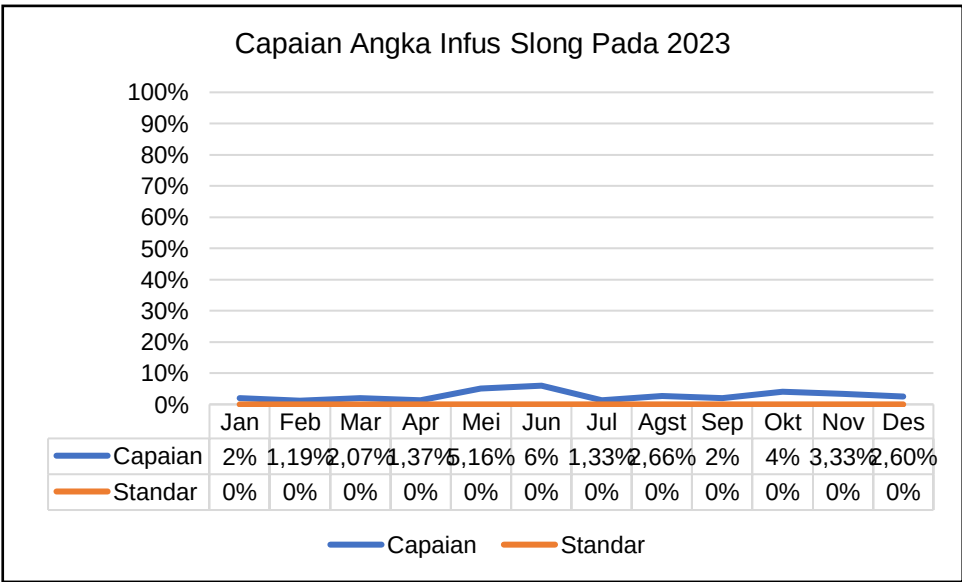
No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri	Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri	Mempertahankan capaian permintaan sendiri sebesar 0% pada Tahun Berikutnya	Kolaborasi KIE pasien antara petugas dan MOD	Ka. Ruangan MOD	Satu bulan

3. Instalasi Rawat Inap 2B

Tabel 3.41 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Inap 2B pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Infus Slong	0%	2%	1.19%	2.07%	1.37%	5.16%	6%	1.33%	2.66%	2%	4%	3.33%	2.6%	2.8%	PDSA
2	Angka pasien pulang atas permintaan sendiri	0%	2.5%	0%	0.69%	1.37%	0.64%	2%	1.33%	2%	2%	4%	4.82%	5.3%	2.2%	PDSA
3	Angka Phlebitis	≤ 1.5%	4.4%	9.63%	0.34%	0%	2.58%	2.6%	2.66%	0.66%	3.33%	4.6%	0.66%	2%	2.6%	PDSA
4	Ketidaklengkapan Dokumen Rekam Medis Pada Pasien KRS ≥24 Jam	≤ 1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2.6%	0.2%	Dipertahankan

Hasil Capaian :



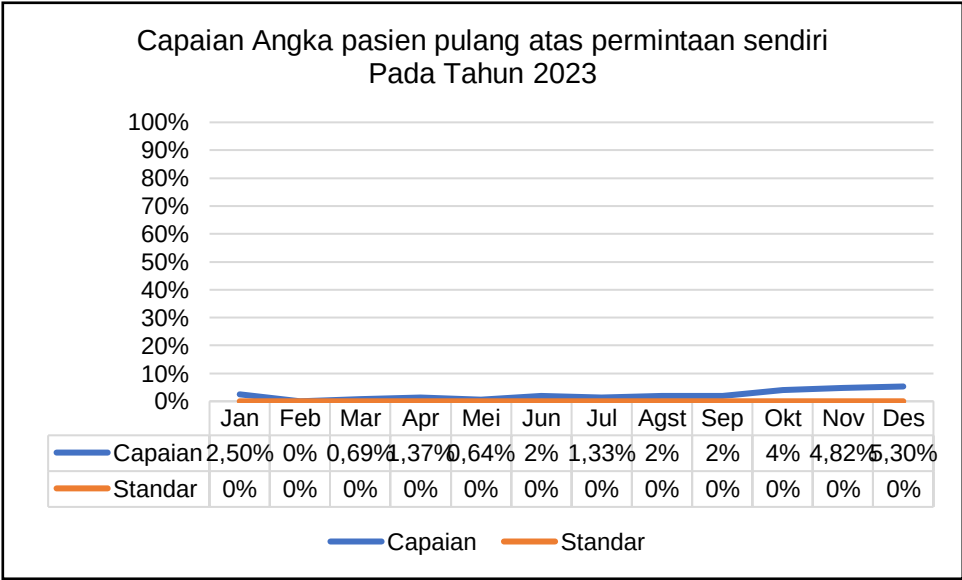
Berdasarkan capaian pada bulan Desember angka infus slong mencapai 2.6%, angka tersebut tidak mencapai target 0%. Dari 150 pasien yang diobservasi ditemukan 4 pasien mengalami infus slong. Capaian ini menurun dibanding pada bulan sebelumnya yang mencapai 3.33% yakni dari 150 pasien yang di observasi di temukan 6 pasien mengalami infus slong

Tabel 3.43 PDSA Capaian Angka Phlebitis pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata angka infus slong pada Bulan Desember Tahun 2023 sebesar 2.8%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka infus slong
Plan	1. Rencana : Menurunkan capaian angka infusslong di unit Rawat Inap 2B, dengan cara monitoring secara rutin infus yang tersisa untuk segera dilakukan pengantian. 2. Harapan : Angka infus slong di unit rawat inap 2A tercapai 0% 3. Tindakan : - Monitoring kepatuhan staff yang berdinass dalam melakukan pergantian infus yang sudah mendekati habis - Koordinasi antara Kepala ruang dan PJ Shift dan seluruh petugas untuk memonitoring cairan infus pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? - Angka infus slong di unit Rawat Inap 2A - Kepatuhan petugas dalam melakukan monitoring cairan infus pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? - kepatuhan petugas di unit dalam melakukan pengawasan cairan infus pasien - persentase angka infus slong di unit rawat inap 2A pada Bulan Desember Tahun 2023 adalah 2.60%, angka tersebut belum mencapai target 0%. Hal ini disebabkan oleh : - kurangnya monitoring petugas di unit dalam melakukan pengawasan cairan infus pasien - tidak segera dilakukan pengantian infus yang baru saat pasien memberitahukan bahwa cairan infus akan habis
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? - perhatian petugas di unit rawat inap 2B dikategorikan kurang - hasil capaian indikator mutu untuk Bulan Desember Tahun 2023 diperoleh grafik tren menurun karena pada Bulan Desember rata-rata capaian 2.60% Follow-up dan Rencana Lanjutan evaluasi dan monitoring pada bulan berikutnya oleh kepala ruangan mengenai kepatuhan petugas di unit dalam melakukan monitoring cairan infus pasien

Tabel 3.43 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan supervisi dalam pengawasan cairan infus pasien	Mengurangi angka infus slong di ruangan	Tercapainnya penurunan angka infus slong dari 2.6% menjadi 0% pada tahun berikut	Supervisi kepatuhan petugas dalam pengecekan cairan infus secara berkala	Ka. Ruangan	Satu Bulan



Hasil Capaian :
 Berdasarkan tabel diatas capaian angka pulang atas permintaan sendiri pada pasien Rawat Inap 2B mencapai 5.30%. dari 150 pasien yang di observasi didapatkan 8 pasien pulang atas permintaan sendiri dengan data sebagai berikut :

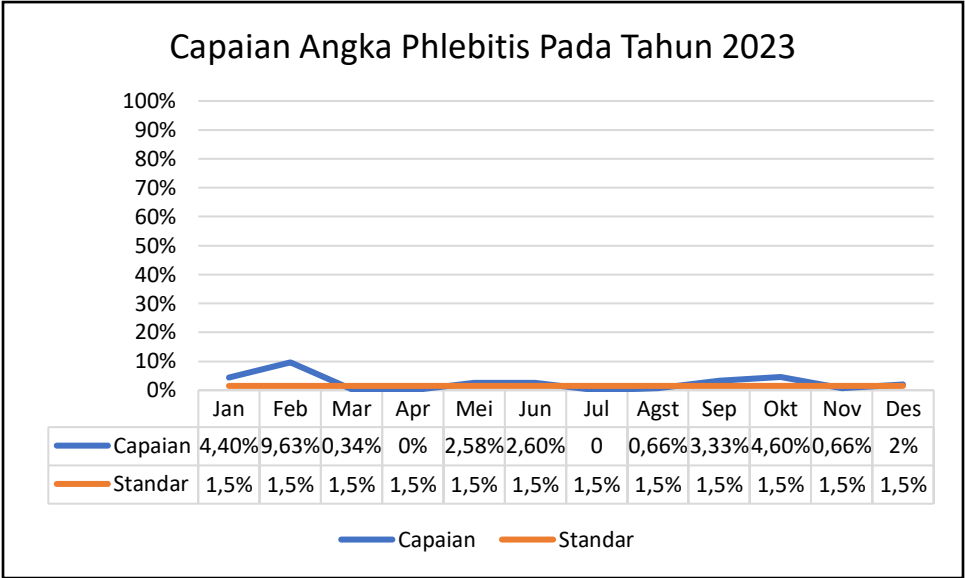
1. penjamin BPJS 100%
2. Alasan APS : Alasan Pribadi & Menolak rujuk

Tabel 3.46 PDSA Capaian Angka Pulang atas permintaan sendiri pada Desember Tahun 2023

Problem	Capaian angka pulang atas permintaan sendiri pada bulan Desember belum mencapai target 0% yakni 5.30%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka pulang atas permintaan sendiri
Plan	Rencana : Menurunkan capaian angka pulang atas permintaan sendiri melalui koordinasi dengan MOD maupun KIE pasien yang bersangkutan Harapan : capaian angka pulang atas permintaan sendiri mencapai 0% Tindakan : 1. mengKIE pasien mengenai konsekuensi jika pulang paksa dilakukan 2. koordinasi dengan MOD untuk mengedukasi pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pasien pulang atas permintaan sendiri di rawat inap
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Capaian angka pulang paksa di rawat 2B pada bulan Desember mencapai 5.30% angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%, hal ini disebabkan oleh : alasan pribadi pasien dan pasien menolak rujuk
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Terjadi peningkatan angka pulang atas permintaan sendiri dari bulan juni sampai Desember 2023. Seluruh petugas IRNA mampu mengkaji dan mengevaluasi alasan pasien dan keluarga yang meminta pulang paksa sebelum ada advice dari dSepter penanggung jawab untuk diijinkan pulang Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pengkajian ulang kepada pasien dan keluarga yang meminta pulang paksa sebelum mendapatkan advice pulang dengan izin dari dSepter penanggungjawab 2. Koordinasi dengan MOD 3. Evaluasi secara berkala

Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	koordinasikan antar PPA dan MOD jika terdapat pasien yang pulang atas permintaan sendiri	Menurunkan angka pulang atas permintaan sendiri	Tercapainnya pengurangan pulang atas permintaan sendiri dari 5.30% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Kolaborasi KIE pasien antara petugas dan MOD	Ka. Ruang MOD	Satu bulan



Hasil Capaian :
Berdasarkan tabel diatas capaian angka phlebitis pada pasien Rawat Inap 2B mencapai 2%. dari 150 pasien yang di observasi didapatkan 3 pasien mengalami phlebitis.

Tabel 3.46 PDSA Capaian Angka Pulang atas permintaan sendiri pada Tahun 2023

Problem	Capaian angka phlebitis Desember belum mencapai target 0% yakni 2%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk Angka pulang atas permintaan sendiri
Plan	Rencana : Menurunkan capaian angka phlebitis pada pasien melalui pemasangan tanggal pada infus untuk monitoring pemasangan infus Harapan : capaian angka phlebitis dapat menurun 0% Tindakan : 1. Monitoring dan supervisi kepatuhan kebersihan tangan, APD dan bundels phlebitis 2. Melakukan audit terhadap hasil monitoring dan supervisi
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Pasien phlebitis di ruangan
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ? Capaian angka phlebitisdi rawat 2B pada bulan Desember mencapai 2% angka tersebut belum mencapai target yang ditentukan 0%,
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? Terjadi penurunan angka phlebitis pasien irna 2b. Seluruh petugas IRNA mampu mengkaji dan mengevaluasi terjadinya phlebitis Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan pengkajian ulang kepada pasien dan keluarga yang meminta pulang paksa sebelum mendapatkan advice pulang dengan izin dari dSepter penanggungjawab 2. Koordinasi dengan MOD 3. Evaluasi secara berkala

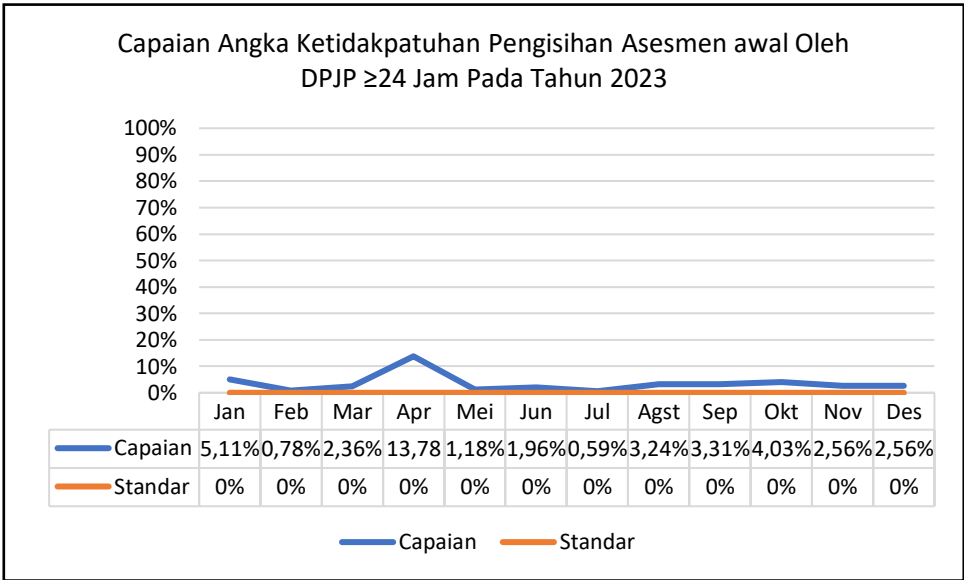
Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kebersihan tangan	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melakukabn kebersihan tangan	Tercapainya penurunan angka phlebitis dari 4.66% menjadi < 1,5% pada bulan berikutnya	Re edukasi HH Audit secara teratur	Ka. Ruangn IPCLN Tim PPI	Satu Bulan

4. Instalasi Rawat Inap 3

Tabel 3.48 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Inap 3 Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep t	Okt	No v	Des		
1	Angka Ketidakpatuhan Pengisian Asesmen awal Oleh DPJP ≥24 Jam	0%	5.11 %	0.78 %	2.36 %	13.78 %	1.18 %	1.96 %	0.59%	3.24%	3.31 %	4.03 %	2.56 %	2.56 %	3.5%	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan Serah Terima Pasien IGD Ke IRNA Tanpa Rekam Medis Lengkap	0%	2.8%	1.06 %	4.76 %	3.47%	1.21 %	0%	1.38%	4.81%	7.5 %	6.38 %	3,24%	1.19 %	2.9%	PDSA
3	Kejadian Tidak Dilakukan Penilaian NEWS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	Kejadian Tidak Terpasangnya Gelang Identitas Pasien	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
5	Abgka Infus Slong	0%	2.01%	1.12%	1.67%	2.12%	0.35%	1.04%	1.79%	1.69%	3.61 %	3.58 %	1,56%	0.60 %	1.6%	PDSA
6	Kejadian Phlebitis	≤1.5%	1.70%	0.05%	0.01%	0.75%	0.82%	0.39%	0,59%	0.84%	0.75 %	0.44 %	0,56%	0.30 %	0.5%	Dipertahankan
7	Angka pulang atas permintaan sendiri	0%	0%	0.05%	0.01%	0%	0.01%	0.01%	0.045%	0.028%	0.001%	0%	0,01%	0.0030%	0%	Dipertahankan



Hasil Capaian :

1.

Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam pada periode Juli-Desember 2023 mengalami penurunan dan kenaikan dari 0,5% di bulan Juli dan mengalami kenaikan sebesar 3,24% pada bulan Agustus dan 4.03% pada bulan Desember.
2.

Rata-rata capaian Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam belum mencapai 0%
3.

Masih ditemukan ketidaklengkapan assesment oleh DPJP >24 jam → penyebab DPJP tidak melakukan visite ataupun DPJP lupa tidak melengkapi assesment spesialis sewaktu visite, dan ketika libur nasional

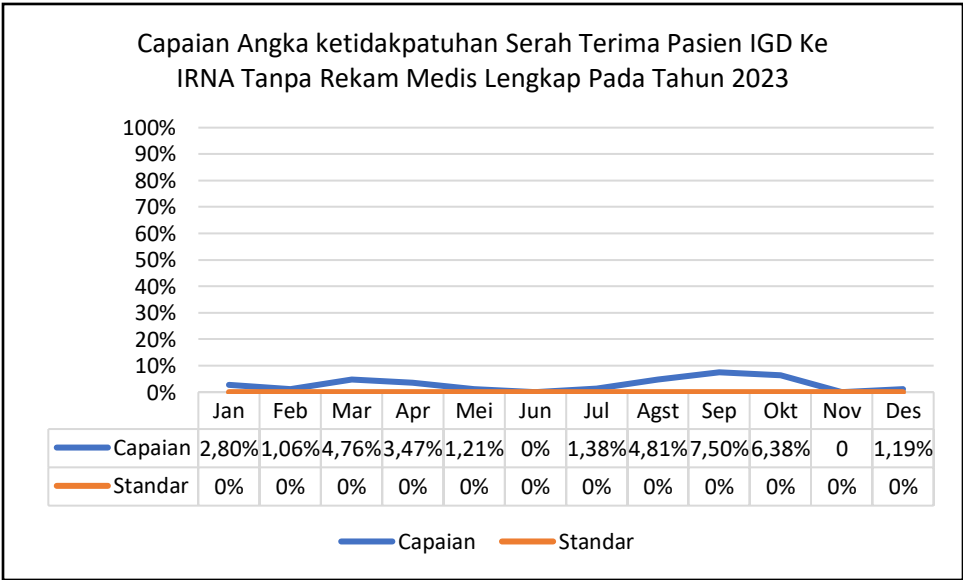
Tabel 3.50 PDSA Capaian Angka Ketidakpatuhan Pengisian Asesmen Oleh DPJP ≥24 Jam pada Bulan Desember Tahun 2023

Problem	Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam belum mencapai target 0%
Step	Menghimbau dan mengingatkan seluruh perawat rawat inap dan IGD untuk selalu melakukan crosscek ulang isi kelengkapan RM

Plan	1. Rencana : Mengetahui angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam 2. Harapan : tidak ditemukan ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam 3. Tindakan : - Melakukan sosialisasi kepada perawat untuk mengingatkan DPJP untuk melakukan pengisian assesment terutama pasien-pasien dengan rencana KRS - Jika DPJP tidak melengkapi assesment, perawat/pj shift/katim membantu untuk melengkapi assesment medis - Supervisi dan evaluasi secara berkala
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Masih ditemukan angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? - Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam pada periode Juli-Desember 2023 sebesar 0,5% menjadi 3,30% - Rata-rata capaian Angka ketidakpatuhan pengisian assesment oleh DPJP >24 jam belum mencapai 0% dengan rata-rata 2,3% - Masih ditemukan ketidakpatuhan DPJP dalam melakukan pengisian lembar assesment DPJP yang bisa disebabkan oleh DPJP tidak melakukan visite, DPJP lupa tidak melakukan visite dan dilakukan visite oleh Dokter spesialis lain
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? - Perawat memahami isi assesmnet DPJP, apabila tidak lengkap perawta hendak membantu untuk melengkapi - Seluruh perawat telah mendapatkan sosialisasi mengenai kelengkapan assesmnet DPJP dan hendak mengkonfirmasi ketidaklengkapan assesment medis - Menginformasikan kepada Dokter spesialis yang setara (waktu memvisite pasien) dalam pengisian assesment pasien di dalam rekam medis - Supervisi dan evaluasi secara berkala Follow-up dan Rencana Lanjutan - Melakukan sosialisasi kepada perawat untuk mengingatkan DPJP untuk melakukan pengisian assesment terutama pasien-pasien dengan rencana KRS - Jika DPJP tidak melengkapi assesment, perawat/pj shift/katim membantu untuk melengkapi assesment medis - Supervisi dan evaluasi secara berkala

Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kepatuhan DPJP dalam pengisian asesmen medis	Asesmen medis DPJP dapat terisi lengkap <24 jam	Tercapainya pengurangan ketidakpatuhan asesmen DPJP dari 3.30% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Mengingatkan DPJP pada saat di ruangan dan saat rapat komite medis	Ka. Ruang Komite medis	Satu bulan





Hasil Capaian :

1. Angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD pada bulan Juli-Desember 2023 mengalami kenaikan dari 1,30% pada bulan Juli, mengalami kenaikan sebesar 4,8% pada bulan Agustus serta mengalami kenaikan sebesar 7,50% pada bulan Desember.
2. Rata-rata angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD belum mencapai target 0%
3. Masih ditemukan ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD seperti,
 - a. Tidak lengkapnya assesment dari IGD
 - b. Tidak lengkapnya pengisian lembar informed consenst tindakan pasien baik pasien dengan tahap terminal atau bukan
 - c. Tidak lengkapnya tanda-tangan petugas IGD atau dokter IGD
 - d. Tidak lengkapnya informasi kondisi pasien ketika di transfer ke Unit rawat inap
 - e. Tidak lengkapnya berkas tilik pasien dari IGD
 - f. Tidak lengkapnya form NEWS dan menjelang akhir hayat

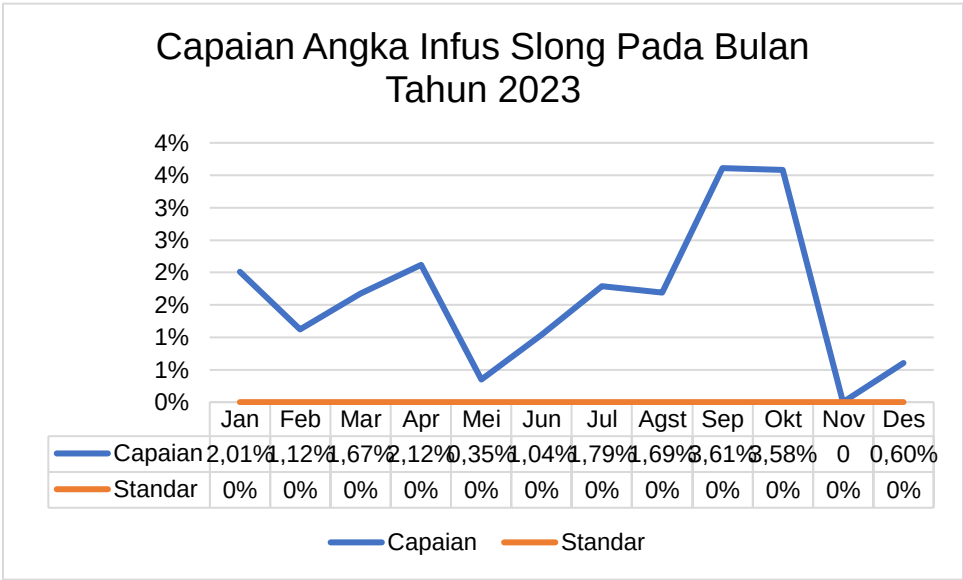
Tabel 3.53 PDSA Capaian Angka ketidakpatuhan Serah Terima Pasien IGD Ke IRNA Tanpa Rekam Medis Lengkap pada Bulan Desember Tahun 2023

Problem	Angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD belum mencapai target 0%
Step	Menghimbau dan mengingatkan perawat rawat inap untuk selalu croscek ulang dan teliti mengenai ketidak lengkapan RM dari unit IGD dan menghimbau untuk perawat IGD lebih lengkap lagi dalam melakukan anamnesa dan pelengkapan isi RM
Plan	1. Rencana : Mengetahui jumlah presentase ketidaklengkapan serah terima RM pasien dari unit IGD dalam satu bulan yang dilakukan evaluasi secara berkala 2. Harapan : Tidak ditemukan kejadian RM ketika serah terima pasien tidak lengkap 3. Tindakan : a. Sosialisasi kepada petugas IGD untuk mengecek kembali RM dan advice dokter/dokterspesialis sebelum memindahkan pasien ke rawat inap b. Sosialisasi kepada perawat ruangan untuk selalu melakukan crosscek ulang isi RM dan advice dokter IGD/dSepter spesialis c. Supervisi dan evaluasi secara berkala
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Masih ditemukan ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD seperti, a. Tidak lengkapnya assesment dari IGD b. Tidak lengkapnya pengisian lembar informed consenst tindakan pasien baik pasien dengan tahap terminal atau bukan c. Tidak lengkapnya tanda-tangan petugas IGD atau dokter IGD d. Tidak lengkapnya informasi kondisi pasien ketika di transfer ke Unit rawat inap
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? 1. Angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD pada bulan Juli-Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,3% menjadi 7,6% 2. Rata-rata angka kejadian ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD belum mencapai target 0% 3. Masih ditemukan ketidaklengkapan serah terima RM dari unit IGD (assesment IGD, lembar informed consent, TTD petugas IGD, informasi kondisi pasien)
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 1. Seluruh petugas IGD atau rawat inap mampu memahami pentingnya kelengkapan RM ketika pasien ditrasnfer ke unit rawat inap beserta RM nya 2. Seluruh perawat IRNA mampu melakukan crosscek ulang kelengkapan RM apabila tidak lengkap maka perawat IRNA hendak melakukan koordinasi kembali dengan perawat IGD yang melakukan transfer pasien keruangan 3. Supervisi dan evaluasi secara berkala Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Sosialisasi kepada petugas IGD untuk mengecek kembali RM dan advice dokter/dokter spesialis sebelum memindahkan pasien ke rawat inap 2. Sosialisasi kepada perawat ruangan untuk selalu melakukan crosscek ulang isi RM dan advice dokter IGD/dokter spesialis 3. Supervisi dan evaluasi secara berkala

Tabel 3.47 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan kepatuhan petugas IGD	Menurunkan ketidaklengkapan RM pasien IGD	tercapainya penurunan ketidakpatuhan	Koordinasi dan re-edukasi	Ka. Ruangan	Satu bulan

	dalam melengkapi RM saat pasien naik ke rawat inap	saat naik ke rawat Inap	petugas IGD dalam melengkapi RM pasien dari 4.56 % menjadi 0% pada bulan berikutnya	kepada seluruh petugas IGD	Ke. Bidang yangmed Komite mutu	
--	--	-------------------------	---	----------------------------	--------------------------------	--



Hasil Capaian :

- Kejadian infus slong di IRNA 3 diperoleh dari bulan Juli-Desember mengalami kenaikan sebesar 1,7% pada bulan Juli dan Agustus, serta mengalami kenaikan 3,06% pada bulan Desember.
- Rata-rata capaian kejadian infus slong di IRNA belum mencapai target 0% kejadian
- Masih ditemukan kejadian infus slong di IRNA yang disebabkan oleh beberapa hal, penggunaan infus 100cc dengan waktu habis cepat, kurangnya pengawasan dari perawat jaga dan kurangnya pengawasan dari keluarga yang menunggu pasien

Tabel 3.56 PDSA Capaian Kejadian Infus Slong pada Bulan Desember Tahun 2023

Problem	Kejadain infus slong di IRNA belum mencapai target 0 kejadian
Step	Menghimbau dan meningkatkan seluruh petugas baik petugas jaga pershift untuk selalu memantau cairan yang terpasang pada pasien
Plan	1. Rencana : Mengetahui jumlah kejadian infus slong di IRNA baik per shift atau pehari 2. Harapan : Tidak ditemukan kejadian infus slong di IRNA 3. Tindakan : a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas untuk selalu mengobservasi penggunaan cairan pada pasien b. Melakukan edukasi kepada keluarga mengenai cairan infus pasien c. Melakukan supervisi dan evaluasi berkala
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? Kejadian infus slong di IRNA belum mencapai target 0 kejadian, hal ini ditinjau dari beberapa hal sepeti, a. penggunaan infus 100cc dengan waktu habis cepat, b. kurangnya pengawasan dari perawat jaga dan c. kurangnya pengawasan dari keluarga penunggu pasien
Study	Apa yang anda pelajari ? apakah sesuai target capaian ? 1. Kejadian infus slong di IRNA pada bulan Juli-Desember sebesar 1,70% menjadi 3,60% 2. Rata-rata capaian kejadian infus slong di IRNA belum mencapai target 0 kejadian 3. Masih ditemukan kejadian infus slong di IRNA yang disebabkan oleh beberapa hal, penggunaan infus 100cc dengan waktu habis cepat, kurangnya pengawasan dari perawat jaga dan kurangnya pengawasan dari keluarga yang menunggu pasien
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ?

	1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas untuk pentingnya monitoring cairan pada pasien 2. Seluruh petugas mampu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada keluarga dan pasien mengenai penggunaan cairan pada pasien 3. Melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala Follow-up dan Rencana Lanjutan 1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh petugas untuk selalu mengobservasi penggunaan cairan pada pasien 2. Melakukan edukasi kepada keluarga mengenai cairan infus pasien 3. Melakukan supervisi dan evaluasi berkala
--	---

Tabel 3.57 Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan supervisi dalam pengawasan cairan infus pasien	Mengurangi angka infus slong di ruangan	Tercapainya penurunan angka infus slong dari 3.60% menjadi 0% pada bulan berikutnya	Supervisi kepatuhan petugas dalam pengecekan cairan infus secara berkala	Ka. Ruangan	Satu Bulan

5. Instalasi Care Unit

Tabel 3.58 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Instalasi Care Unit pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka tidak dilakukan pengkajian dan NEWS pada pasien tahap terminal	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
2	Kejadian phlebitis pada pasien ICU	≤1.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Kejadian kembalinya pasien ke ICU dengan kasus yang sama ≤72jam	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
4	angka tidak dilakukannya pengkajian sesuai kriteria keluar masuk ICU pada pasien ICU	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
5	Angka transfer pasien ke ICU dengan keadaan tidak stabil	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

6. Instalasi Kamar Operasi

Tabel 3.59 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Instalasi Kamar Operasi pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan												Rata-rata	Keterangan
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kerusakan alat penunjang operasi	0%	0.8%	1.07 %	0.31 %	0%	0%	0%	0,78 %	0.29 %	0.27 %	0.49%	0%	0%	0,29%	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan perawat dalam persiapan pasien operasi	0%	7.21 %	7.16 %	2.5 %	1.43 %	0%	1.26 %	2,36 %	3,54 %	0%	0%	0,45%	0%	1,78%	PDSA
3	Angka ketidaklengkapan asesmen awal pasien bedah> 24 jam sesuai kerangka waktu	≤ 20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.54 %	0%	1.71%	1,12%	0%	0,30%	Dipertahankan



4	Kejadian tidak dilakukannya penandaan pada pasien operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	2 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	0 Kejadian	PDSA
5	Angka ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan / penolakan tindakan	≤ 20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.22%	0,67%	0%	0,11%	Dipertahankan
6	Kejadian ketidaklengkapan pengisian asesmen praanestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
7	Kejadian konversi regional anestesi ke general anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
8	Angka efek samping selama sedasi moderat	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
9	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring status fisiologis selama anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
10	Kejadian tidak dilakukannya proses monitoring pemulihan pasca anestesi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	Dipertahankan
11	Kejadian ketidaksesuaian diagnose pre dan post operasi	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
12	Kejadian tidak dilaksanakannya pengisian surgical safety checklist sesuai standart	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
13	Angka ketidaklengkapan laporan operasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1.31 %	1.74 %	0%	1.71%	0,67%	0%	0.49%	PDSA
14	Angka Infeksi Daerah Operasi	≤1,5%	0.94 %	0%	0%	0%	1.5%	0%	0,52 %	0,29 %	0%	1.71%	0,22%	0,76%	0.47%	dipertahankan

7. Maternitas

Tabel 3.63 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Maternitas pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kematian ibu	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	dipertahankan
2	Kejadian perdarahan post partu pada ibu pasca persalinan	0 Kejadian	2 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	PDSA
3	Kejadian partus lama pada saat ibu persalinan	0 Kejadian	0 kejadian	2 kajadian	2 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	dipertahankan
4	Kejadian pre eklamsi pada ibu hamil	0 Kejadian	4 kejadian	14 kejadian	19 kejadian	5 kejadian	9 kejadian	0 kejadian	14 kejadian	PDSA
5	Kejadian infeksi nifas	0 Kejadian	2 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	6 kejadian	1 kejadian	PDSA
6	Kejadian keterlambatan operasi elektif	0	0 kejadian	3 Kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	dipertahankan

8. Perinatologi

Tabel 3.73 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Perinatologi pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kemampuan menangani BBLR 1500gr-2500gr	≤10%	7.69%	5.40%	12.5%	9.09%	10,52%	3.70%	6.40%	Dipertahankan



2	Angka Tidak Dilakukan IMD pada bayi baru lahir	0%	0,035%	4.36%	12%	6%	8%	0%	5.07%	PDSA
3	Angka ketidaklengkapan dokumen RM pada pasien perinatologi	≤20%	20.74%	8.45%	11.15%	5.14%	6,70%	14.83%	11.17%	PDSA
4	Angka Kematian Bayi	23 / 1000 kelahiran hidup	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	2 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan

9. Instalasi Rawat Jalan

Tabel 3.80 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rawat Jalan pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka keterlambatan dokter spesialis di rawat jalan	≤20%	35.41%	41%	32%	38%	56,65%	56.65%	33.84%	PDSA
2	Angka ketidaklengkapan asesmen awal medis DPJP pasien rawat jalan	≤20%	18.24%	20.41%	26%	100%	24,03%	24.03%	31.45%	PDSA
3	Angka ketepatan pengisian PRMRJ	≤20%	19.24%	41.25%	100%	88%	100%	100%	74.75%	PDSA

10. Instalasi Laboratorium

Tabel 3.84 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laboratorium pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kerusakan sampel darah	<5%	0,11%	0,28%	5.07%	0.23%	0,093%	0.46%	1.06%	Dipertahankan
2	Angka kurangnya kelengkapan blanko permintaan pemeriksaan/ status klinis	< 15%	9.075%	8.75%	0.09%	4.52%	6,40%	21.44 %	4.49%	Dipertahankan
3	Kejadian keterlambatan penyerahan labu darah > 2 jam	≤ 10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	Kejadian kesalahan penulisan hasil laboratorium ke simrs	0 kejadian	3 kejadian	4 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
5	Kejadian keterlambatan hasil laboratorium cito	<10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6	Angka tidak terpenuhinya kebutuhan darah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7	Angka reaksi transfuse darah	0%	0.011%	1.29%	0%	0%	0%	0%	0.26%	PDSA
8	Kejadian ketidaktepatan waktu pemeliharaan alat KSO laboratorium oleh teknisi dari vendor	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
9	Kejadian keterlambatan backup alat error (dalam waktu ≤ 24 jam)	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

11. Instalasi Radiologi

Tabel 3.88 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Radiologi pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Ketidaklengkapan Permintaan Foto	0%	38.84%	41.23%	38.78%	35.86%	33,18%	35.12%	37.58%	PDSA

2	Angka ketidakpatuhan edukasi pemeriksaan kepada pasien sebelum dilakukan pemeriksaan radiologi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Angka kesalahan print hasil fot X-Ray	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	Angka Komplain DPJP terhadap bacaan radiologi	0%	0%	0%	0%	0.26%	0.26%	0%	0.10%	Dipertahankan
5	Angka tidak dilakukan maintenance alat setiap satu bulan sekali	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6	Angka keterlambatan hasil bancaan	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

12. Instalasi Rekam Medis

Tabel 3.89 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rekam Medis pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	0 kejadian	6 kejadian	10 kejadian	7 kejadian	12 kejadian	9 kejadian	3 kejadian	8 kejadian	PDSA
2	Angka kejadian tidak tercetaknya SEP	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	Dipertahankan
3	Angka tidak diselesaikannya LMA (Laporan Medis Awal) dan JKK dalam kurun waktu 1x24jam	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
4	kejadian tidak bisa digunakannya surat rujukan FKTP pasien post MRS	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
5	Kejadian ketidaksesuaian identitas pasien pada surat kontrol	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
6	Angka ketidaklengkapan pengkajian awal medis rawat inap 1x24 jam	0%	5.5%	4%	4.9%	4.8%	7%	4.4%	5.24%	PDSA
7	Angka keterlambatan pengembalian dokumen rekam medis rawat jalan >1x24 jam.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
8	Angka pengembalian RM Rawat Inap lebih dari 2 x 24 jam.	0%	77.1%	41.9%	0%	72.9%	85,8%	72.7%	55.54%	PDSA
9	Waktu penyediaan drm rawat jalan <10 menit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

13. Instalasi Gizi

Tabel 3.117 Capaian Indikator Mutu Prioritas Instalasi Gizi Desember pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Ketidakpatuhan Petugas Dalam Cuci Tangan	≤15%	12.5%	12.5%	15%	12.5%	10%	7.5%	12.50%	Dipertahankan
2	Angka Ketidakpatuhan Petugas Dalam Penggunaan APD	≤20%	10%	20%	10%	16.6%	16,67%	16.6%	14.65%	Dipertahankan
3	Angka Ketidakpatuhan Ahli Gizi Dalam	≤20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan



	Edukasi Pasien Tentang Diet									
4	Angka Komplain Pasien Terhadap Makanan Yang Disajikan	0%	0.033%	0.11%	0%	0%	0%	0%	0.03%	Dipertahankan
5	Angka Ketidaktepatan Waktu Distribusi Makanan Pada Pasien Rawat Inap	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
6	Sisa Makanan yang Tidak Termakan oleh Pasien	≤20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
7	Kejadian Kasalahan Pemberian Diet Pada Pasien Rawat Inap	≤10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
8	Kejadian Masuknya Benda Asing Dalam Makanan	0 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA

14. Rehabilitasi Medik

Tabel 3.118 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rehabilitasi Medik Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kepuasan pasien dan keluarga (PMK standar pelayanan fisioterapi)	>80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dipertahankan
2	Kejadian kesalahan Tindakan / intervensi fisioterapi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Angka drop out pasien fisioterapi	<50%	7,04%	4.57%	7.36%	12.22%	10,19%	7.67%	7.80%	Dipertahankan
4	Kejadian kerusakan alat kesehatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

15. Humas & Marketing

Tabel 3.119 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Humas & Marketing Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Perubahan Jadwal DSepter Spesialis Di Rawat Inap	0%								PDSA
2	Angka ketidakpuasan pasien rawat jalan	0%								PDSA
3	Angka ketidakpuasan pasien rawat inap	0%								PDSA

16. Keuangan

Tabel 3.120 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Keuangan Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian complain pelayanan kasir	0 kejadian								PDSA
2	Persentase pembatalan kwitansi di kasir	0%								PDSA
3	Persentase selisih uang setoran kasir dengan	0%								PDSA

	LHK (Laporan harian kasir)									
4	Kejadian kesalahan pengiriman tagihan	0 kejadian								PDSA
5	Keterlambatan realisasi pembayaran dari rekanan	<10%								PDSA
6	Persentase piutang pasien rawat inap (bayar pribadi) bermasalah	0%								PDSA
7	Angka keterlambatan pelayanan kasir saat pelayanan >10menit	<5%								PDSA
8	Kejadian keterlambatan pelaporan rutin ke keuangan PT DPM > tgl 10 di bulan berikutnya	0 kejadian								PDSA

17. Bagian SDM

Tabel 3.121 Capaian Indikator Mutu Prioritas Bagian SDM Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka staf tidak fingerprint lebih dari 3x dalam sebulan	0%	0.039%	0.155%	0.03%	0.04%	0.15%	0.15%	0.09%	PDSA
2	angka staf terlambat lebih dari 3x dalam sebulan	0%	0.03%	0.20%	0.05%	0.20%	0.20%	0.20%	0.15%	PDSA
3	angka staf tidak mengikuti diklat internal	0%	0.1%	0.15%	0%	0.16%	0.16%	0.16%	0.12%	PDSA
4	angka staf terlambat presentasi hasil pelatihan eksternal	0%	0.5%	0%	0%	0%	0%	0%	0.08%	PDSA
5	angka staf tidak lanjut kontrak pasca masa orientasi atau dirumahkan karena legalitas	0%	0.03%	0.15%	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.04%	PDSA

18. Kesekretrariatan

Tabel 3.122 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kesekretariatan Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Keterlambatan Pengumpulan Laporan Bulanan Unit ≥ Tanggal 5	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	PDSA
2	Angka Keterlambatan Pengumpulan Laporan Bulanan Unit Ke PT ≥ Tanggal 9	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PDSA
3	Angka Keterlambatan Rapat, Akibat Persiapan Fasilitas	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	PDSA
4	Persentase Keterlambatan Distribusi Surat Masuk	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PDSA
5	Persentase Keterlambatan Penyelesaian Surat Keluar	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PDSA
6	Persentase Keterlambatan Pembuatan Notulen Rapat	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	PDSA

19. Rumah Tangga

Tabel 3.123 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Rumah Tangga Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan pengunjung menggunakan kartu visitor di rawat inap	0%								PDSA
2	Angka ketidakpatuhan pengunjung membawa anak kecil (non pasien) di Rumah Sakit	0%								PDSA
3	Ketidakpatuhan dalam membersihkan ambulance setelah mengangkut pasien	0								PDSA

20. Kamar Jenazah

Tabel 3.127 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Kamar Jenazah Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Bulan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian Tertukarnya Identifikasi Jenazah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan

21. Laundry

Tabel 3.128 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Laundry Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian tercampurnya linen infeksius dan non infeksius	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan
2	angka kehilangan linen di unit	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Kejadian linen tercampur benda asing	0 kejadian	8 kejadian	3 kejadian	1 kejadian	0 kejadian	3 kejadian	2 kejadian	3 kejadian	PDSA

22. IPSRS

Tabel 3.129 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit IPSR pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian AC Bocor di unit	0 kejadian	58 kejadian	59 kejadian	59 kejadian	59 kejadian	59 kejadian	0 Kejadian	59 kejadian	PDSA
2	Respon Time Genset Ketika Terjadi Pemadaman ≥10 Detik	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Dipertahankan
3	Angka keterlambatan tindaklanjut pelaporan alat rusak > 24 jam	≥80%	83.12%	71.40%	62.05%	91.23%	92.52%	0%	76.95%	PDSA
4	Kejadian tidak dilakukan kalibrasipada alat kesehatan	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 Kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

23. Instalasi SIMRS

Tabel 3.133 Capaian Indikator Mutu Prioritas Instalasi SIMRS Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Ket
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		

1	Angka ketidakpatuhan maintenance komputer > 6 bulan sekali	0%								PDSA
2	Kejadian downtime >30 menit	0 kejadian								PDSA

24. K3RS

Tabel 3.134 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit K3RS Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Ket
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian kecelakaan kerja pada staff	0 kejadian	1 kejadian	2 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	1 kejadian	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan staff dalam mengikuti kegiatan MCU satu tahun sekali	0%	54.87%	71.25%	71.25%	69.15%	69.15%	69.15%	67.47%	PDSA
3	Tersediannya tim penanggulangan bencana	100%	100%	100%	96.77%	96.77%	100%	100%	98.92%	Dipertahankan
4	Kejadian tercampurnya limbah infeksius & non infeksius	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	Dipertahankan

25. CSSD

Tabel 3.138 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit CSSD Pada Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-Rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka keterlambatan pengiriman instrument kotor	0%	5.33%	5.12%	29.92%	0%			13.92%	PDSA
2	Kejadian tercampurnya instrument dengan limbah	0 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian	1 kejadian			1 kejadian	PDSA

26. Komite PPI

Tabel 3.138 Capaian Indikator Mutu Prioritas Komite PPI Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-Rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Petugas Tertusuk Benda Tajam	0%	0%	0%	0%				0%	PDSA
2	Angka Ketidakpatuhan Petugas Dalam Memilah Sampah Medis Dan Non Medis	0%	0%	5%	5%				3.3%	PDSA
3	Angka Infeksi Pada Daerah Operasi	≤1.5%	1%	1.1%	0%				0.7%	PDSA
4	Angka Plebitis	≤1.5%	1%	0.8%	0.8%				0.9%	PDSA
5	Angka Infeksi Saluran Kencing	≤1.5%	0%	0%	0%				0%	PDSA

27. PKRS

Tabel 3.140 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit PKRS Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-Rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan petugas dalam pengisian SBAR	0%	50%	40%	34.45%	43%			41.86%	PDSA
2	Angka ketidakpatuhan petugas dalam	0%	16.67%	50%	42.84%	46.15%			38.92%	PDSA

	memberikan edukasi kelompok									
3	Angka ketidaklengkapan penulisan waktu edukasi pada lembar edukasi kolaborasi	0%	46.15%	13.3%	12.1%	28.57%			25.03%	PDSA
4	Kejadian tidak dilakukannya pembinaan pada komunitas berbasis rumah sakit	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian	0 kejadian			0 kejadian	PDSA

28. Tim HIV

Tabel 3.149 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional HIV Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Kejadian Tidak Teridentifikasi Pasien HIV Pada Pasien Bedah	0%								PDSA

29. TB DOTS

Tabel 3.150 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional TB-DOTS Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan pasien mengambil obat di rumah sakit	0%								PDSA
2	Kejadian Tidak Terpantaunya Pasien TB Oleh Perawat Pelaksana	0%								PDSA

30. Verifikasi

Tabel 3.151 Capaian Indikator Mutu Prioritas Unit Verifikasi Tahun Bulan Desember 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidaktepatan anamnesa dengan diagnose DPJP	0%	10.32%						10.32%	PDSA
2	Kejadian ketidaktepatan klaim >tgl 5 bulan berikutnya	0 kejadian	0 kejadian						0 kejadian	PDSA
3	Klaim pending <3%	< 3%	9.28%						9.28%	PDSA
4	Angka ketidaklengkapan berkas asuransi	0%	0%						0%	PDSA
5	Angka ketidaklengkapan pengisian formulir asuransi	0%	0%						0%	PDSA

31. KB

Tabel 3.152 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional KB Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka ketidakpatuhan pengisian kartu K4 KB	0%								PDSA

32. Stunting

Tabel 3.153 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional Stunting Bulan Desember Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Prevalensi Stunting (Pendek & Sangat pendek) pada balita	14%	1.52%	0.45%	0%	0.37%	0%	1.02%	0.56%	Pertahankan

33. Ponek

Tabel 3.154 Capaian Indikator Mutu Prioritas Program Nasional Ponek pada Tahun 2023

No	Judul Indikator	Standar	Bulan						Rata-rata	Keterangan
			Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Angka Kematian Ibu	0%								PDSA
2	Kejadian Eklamsi Pada Ibu Hamil	0								PDSA
3	Kejadian Perdarahan Post Partum Pada Ibu Pasca Persalinan	0								PDSA
3	Kejadian Partus Lama Pada Ibu Saat Persalinan	0								PDSA

3.6. Kinerja Produktifitas Komite PPI

Kinerja Produktifitas (semua program/kegiatan pelayanan di unit tsb)

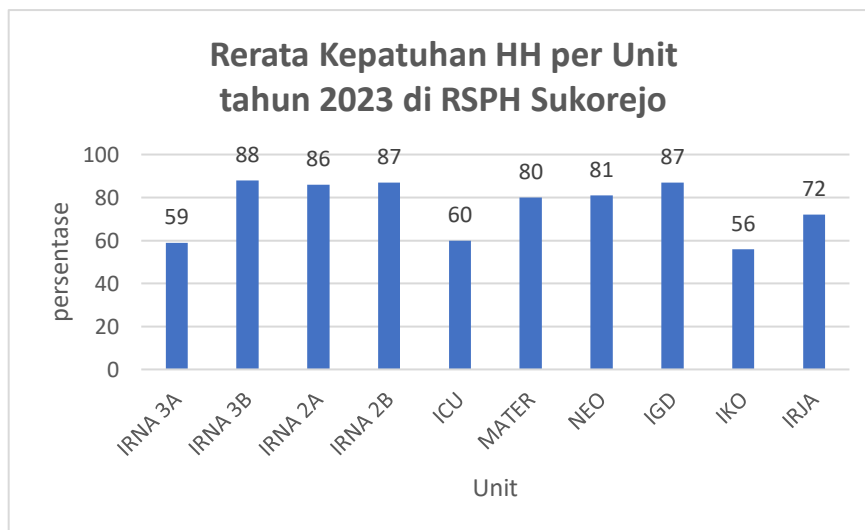
3.3.1 Program PPI

1. Kepatuhan Kebersihan Tangan
- a. Kepatuhan total



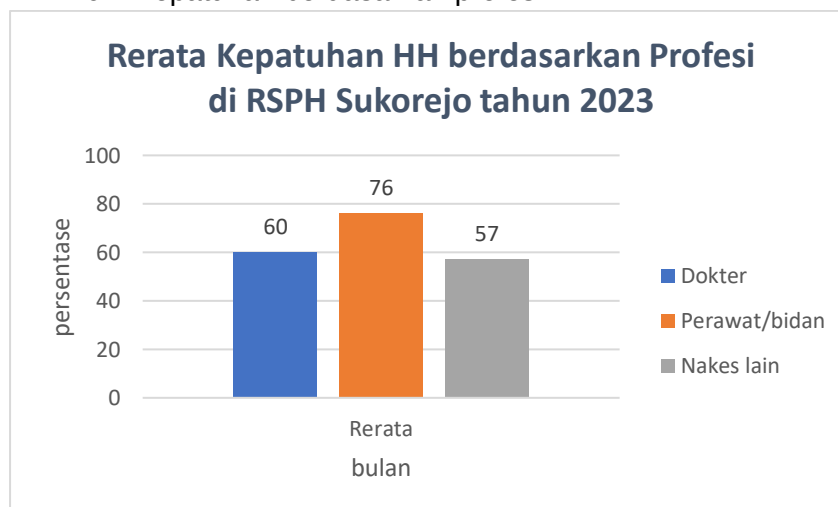
Interpretasi: Pada tabel tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan hand hygiene di tahun 2023 stabil di 76% dibandingkan tahun sebelumnya, dan belum mencapai sasaran.

- b. Kepatuhan per unit (pelayanan medis)



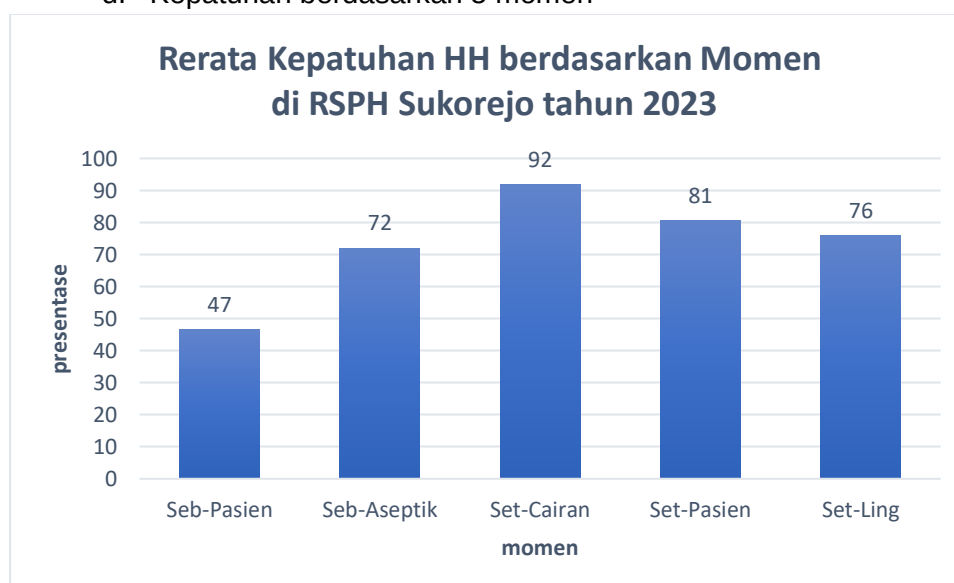
Interpretasi: Pada grafik tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan hand hygiene berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan $\geq 85\%$ adalah IRNA 3B, IRNA 2B, IGD, dan IRNA 2A. Sedang unit dengan rerata kepatuhan terendah adalah unit IKO sebesar 56%.

c. Kepatuhan berdasarkan profesi



Interpretasi: Pada grafik tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan hand hygiene per profesi tertinggi adalah profesi perawat yaitu sebesar 76% namun belum mencapai sasaran.

d. Kepatuhan berdasarkan 5 momen



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui rerata kepatuhan hand hygiene berdasarkan 5 momen tahun 2023 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum menyentuh pasien sebesar 47%, sedangkan momen setelah menyentuh cairan



tubuh pasien sudah mencapai 85%.

e. Kepatuhan fasilitas kebersihan tangan

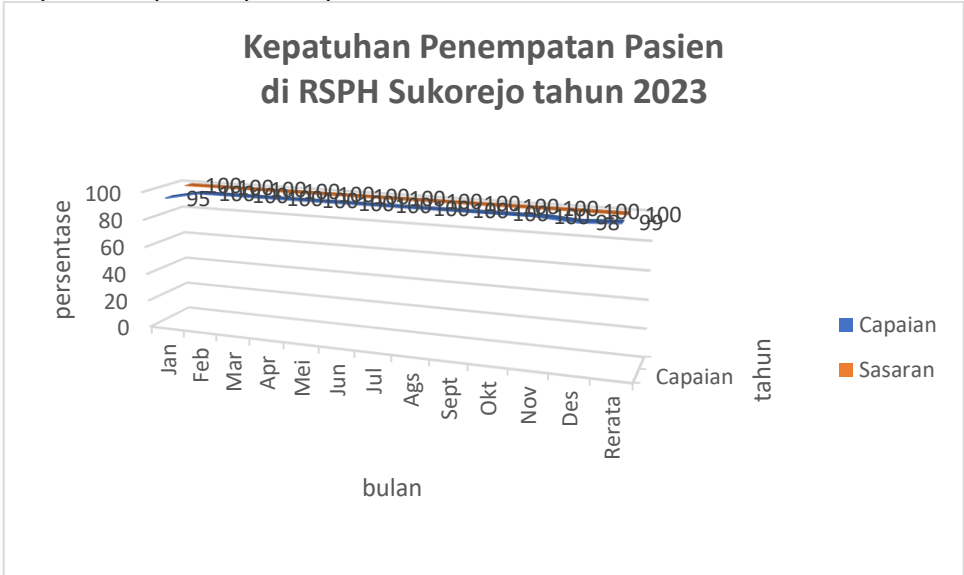


Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata fasilitas kebersihan tangan tahun 2023 sebesar 95% belum mencapai 100%.

PROBLEM	Persentase kepatuhan hand hygiene ≤ 85%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	4. Rencana: Mengetahui kepatuhan hand hygiene secara berkesinambungan 5. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 6. Tindakan d. Melakukan audit hand hygiene pada pstaf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. e. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang hand hygiene f. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene staf di unit.
DO	Kepatuhan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
STUDY	7. rerata kepatuhan hand hygiene di tahun 2023 stabil di 76% dibandingkan tahun sebelumnya, dan belum mencapai sasaran. 8. rerata kepatuhan hand hygiene berdasarkan unit pelayanan, unit dengan rerata kepatuhan ≥ 85% adalah IRNA 3B, IRNA 2B, IGD, dan IRNA 2A. Sedang unit dengan rerata kepatuhan terendah adalah unit IKO sebesar 56%. 9. rerata kepatuhan hand hygiene per profesi tertinggi adalah profesi perawat yaitu sebesar 76% namun belum mencapai sasaran. 10. rerata kepatuhan hand hygiene berdasarkan 5 momen tahun 2023 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum menyentuh pasien sebesar 47%, sedangkan momen

	setelah menyentuh cairan tubuh pasien sudah mencapai 85%. 11. rerata fasilitas kebersihan tangan tahun 2023 sebesar 95% belum mencapai 100%.
ACTION	8. Reeducasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 9. Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan, pertahankan kepatuhan 10. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 11. Koordinasi dengan CS terkait pemenuhan fasilitas hand hygiene 12. Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

2. Kepatuhan penempatan pasien

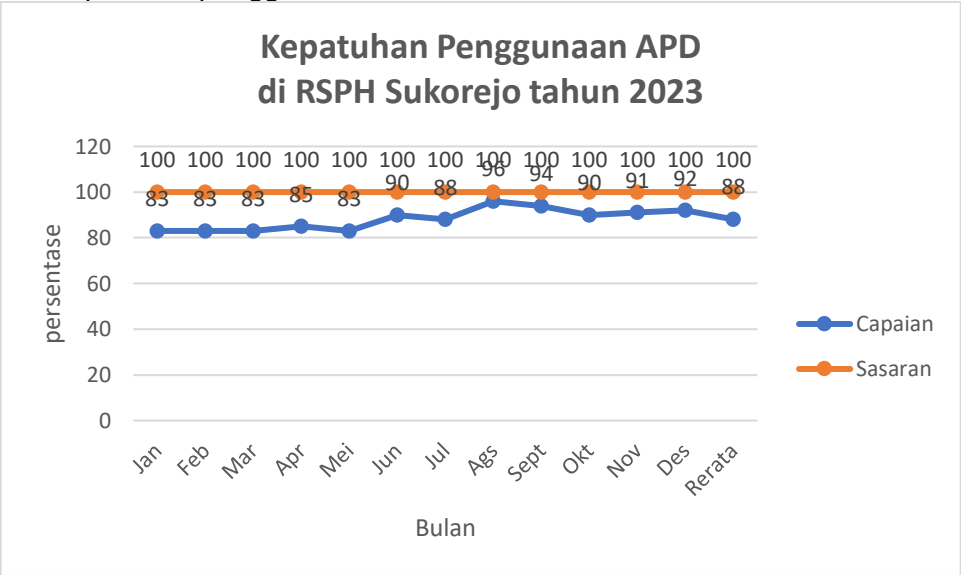


Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penempatan pasien mencapai target 99% di tahun 2023.

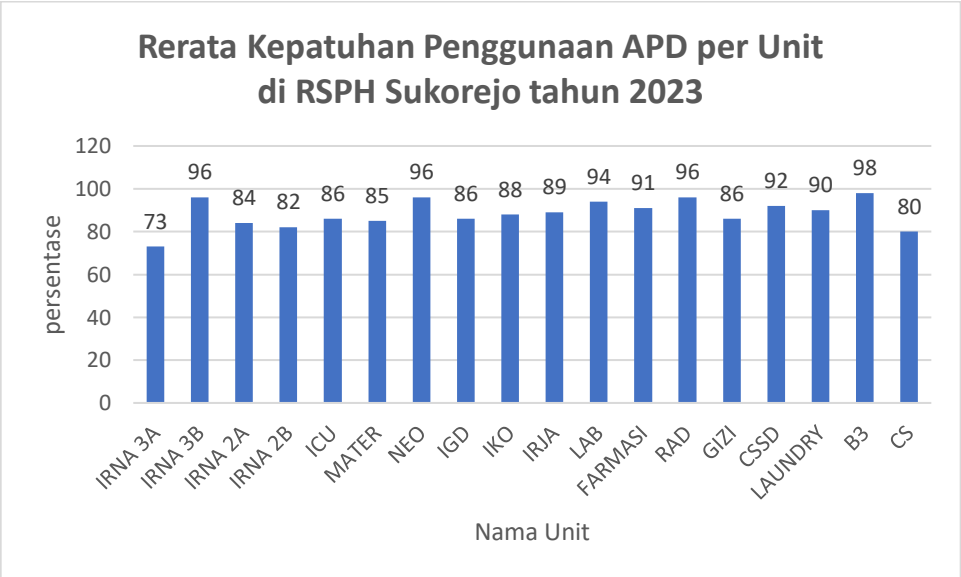
PROBLEM	Persentase kepatuhan penempatan pasien belum mencapai 100%.
STEP	Tetap menghimbau dan mengingatkan ke semua staf terkait penempatan pasien dengan penularan transmisi untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penempatan pasien di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam penempatan pasien di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan - Melakukan audit penempatan pasien di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penempatan pasien. - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penempatan pasien di unit. - Menghimbau unit IGD terkait skrining pertama pasien, jika ada gejala dengan penularan transmisi, pasien wajib diarahkan ke IGD pinere.

DO	Kepatuhan penempatan pasien mencapai 100%
STUDY	1. rerata kepatuhan penempatan pasien mencapai target 99% di tahun 2023 2. Masih ditemukan penunggu pasien isolasi TB yang tidak menggunakan masker, memasang tikar, dan membiarkan pasien dikunjungi banyak orang sehingga berisiko tinggi penularan pasien ke pengunjung. 3. CS selalu melakukan disinfeksi permukaan Ketika ruang isolasi maupun kohorting kosong untuk meminimalisir penularan ke pasien selanjutnya.
ACTION	1. Resosialisasi kepada staf terkait penempatan pasien 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring penempatan pasien di unit.

3. Kepatuhan penggunaan APD



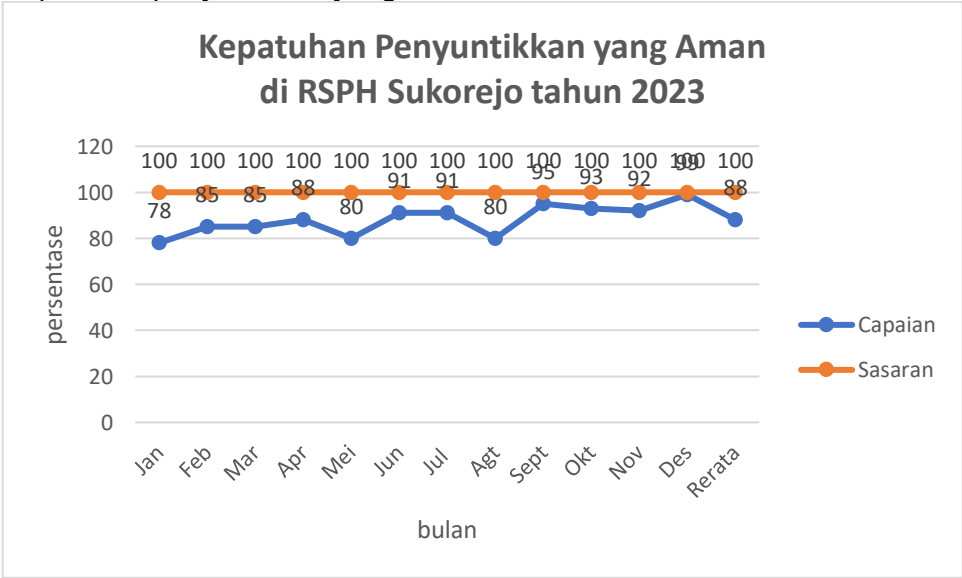
Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD pada tahun 2023 yaitu sebesar 88%, belum mencapai sasaran.



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penggunaan APD tahun 2023 yang terendah adalah unit IRNA 3A sebesar 73%.

PROBLEM	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	2. Rencana: Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan 3. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 4. Tindakan c. Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. d. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD e. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
DO	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di tahun 2023
STUDY	2. rerata kepatuhan penggunaan APD pada tahun 2023 yaitu sebesar 88%, belum mencapai sasaran. 3. rerata kepatuhan penggunaan APD tahun 2023 yang terendah adalah unit IRNA 3A sebesar 73%. 4. Masih ditemukan CS yang menggunakan handscoon saat membuang limbah ke TPS. Masih ditemukan perawat yang menggunakan handscoon saat melakukan TTV non menular.
ACTION	2. Resosialisasi kepada staf terkait penggunaan APD, baik SPO penggunaan maupun pelepasan APD dengan tepat dan indikasinya. 3. Beri feedback pada hasil temuan. 4. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

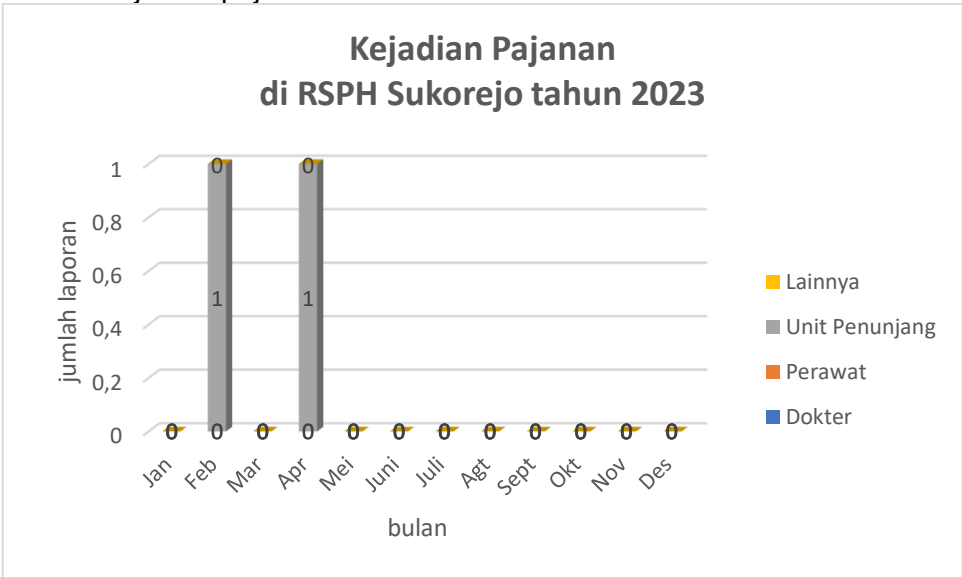
4. Kepatuhan penyuntikkan yang aman dan pencegahan pajanan benda tajam
- a. Kepatuhan penyuntikkan yang aman



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa rerata kepatuhan penyuntikkan yang aman tahun 2023, sebesar 88% tidak mencapai sasaran 100%.

PROBLEM	Hasil audit menunjukkan penyuntikkan yang aman belum keseluruhan mencapai 100%.
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf terkait kepatuhan penyuntikkan yang aman untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien, serta mengurangi risiko tertusuk jarum bekas pakai
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam penyuntikkan yang aman di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai dan risiko tertusuk jarum dapat ditekan. 3. Tindakan a. Melakukan audit penyuntikkan yang aman di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penyuntikkan yang aman c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit.
DO	Mempertahnkan kepatuhan penyuntikkan yang aman mencapai 100%
STUDY	Rerata kepatuhan penyuntikkan yang aman tahun 2023, sebesar 88% tidak mencapai sasaran 100%.
ACTION	1. Resosialisasi kepada staf terkait penyuntikkan yang aman 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan audit penyuntikkan yang aman di unit.

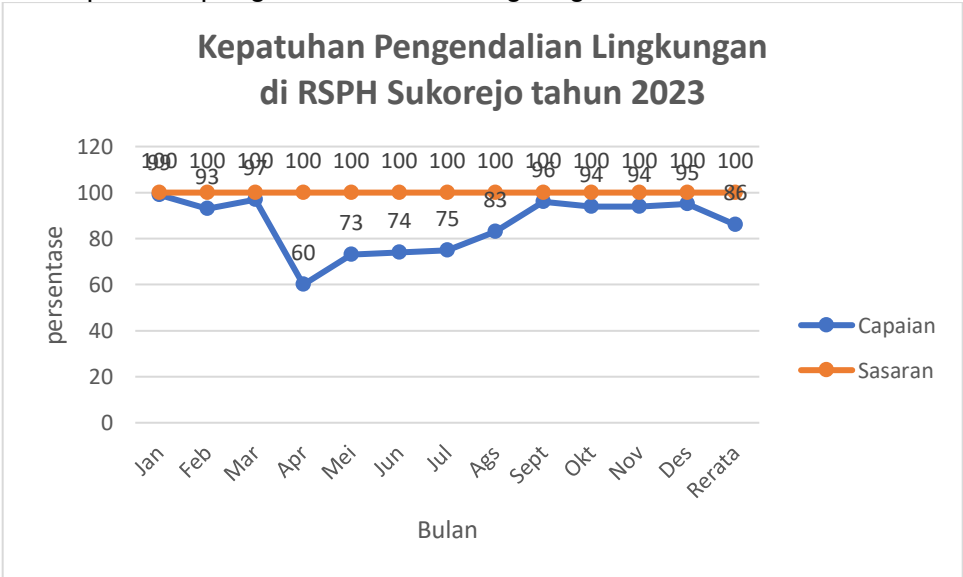
b. Kejadian pajanan



Interpretasi: Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa kejadian pajanan tahun 2023 adalah 2 kejadian di bulan Februari dan April.

PROBLEM	Di tahun 2023 masih ada kejadian tertusuk jarum. Namun dari masalah tersebut belum ada tindak lanjut yang berkaitan dengan efek jangka Panjang staf terpajan
STEP	Tetap menghimbau dan mengingatkan ke semua staf terkait kejadian tertusuk jarum dan pelaporannya.
PLAN	1. Rencana: Meningkatkan kepatuhan pelaporan kejadian pajanan di unit. 2. Harapan Seluruh staf patuh melaporkan kejadian pajanan di unit 3. Tindakan - Melakukan himbauan terkait pelaporan - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penyuntikkan yang aman - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penyuntikkan yang aman di unit.
DO	Mempertahankan kejadian pajanan 0 kejadian dengan kepatuhan pelaporan 100%.
STUDY	1. Menurunnya kejadian pajanan bisa dikarenakan petugas sudah melaksanakan Teknik penyuntikkan yang aman dengan baik. 2. Dapat dimungkinkan juga petugas tidak mengumpulkan form pajanan sesuai alur yang sudah dibagikan. 3. Belum ada tindak lanjut yang dapat mengetahui efek jangka Panjang dari staf terpajan penyakit menular, hal ini dapat memungkinkan rendahnya pelaporan pajanan dari unit.
ACTION	1. Resosialisasi kepada staf terkait pelaporan kejadian pajanan 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Berkoordinasi dengan K3RS dan SDM terkait tindak lanjut staf terpajan penyakit menular. 4. Berkoordinasi dengan K3RS dan SDM terkait skrining penyakit menular melalui pengajuan TOR MCU serta vaksin HBsAg untuk staf yang berisiko tinggi. 5. Beri teguran dan himbauan jika ada kejadian pajanan di unit.

5. Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan





Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui rerata kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan tahun 2023 yaitu sebesar 86%, belum mencapai sasaran 100%.

PROBLEM	Persentase kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan belum mencapai 100%.
STEP	Memonitor berkelanjutan dalam mempertahankan atau meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pengendalian infeksi lingkungan di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pengendalian infeksi lingkungan di unit secara berkesinambungan. b. Meningkatkan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi tentang pengendalian infeksi lingkungan di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan di unit.
DO	Kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan mencapai 100%
STUDY	1. rerata kepatuhan pengendalian infeksi lingkungan tahun 2023 yaitu sebesar 86%, belum mencapai sasaran 100%. 2. Petugas sudah cukup baik dalam pengendalian kebersihan lingkungan. 3. Masih ditemukan debu-debu pada media elektronik seperti komputer, printer, dan sejenisnya. 4. Ditemukan kamar pasien yang tidak segera dibersihkan petugas CS setelah KRS sehingga saat perawat inden pasien, kamar masih dalam kondisi kotor.
ACTION	1. Resosialisasi kepada staf terkait pengendalian infeksi lingkungan. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pengendalian infeksi lingkungan di unit. 4. Monitoring pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan yang berisiko tinggi

6. Kepatuhan penanganan linen

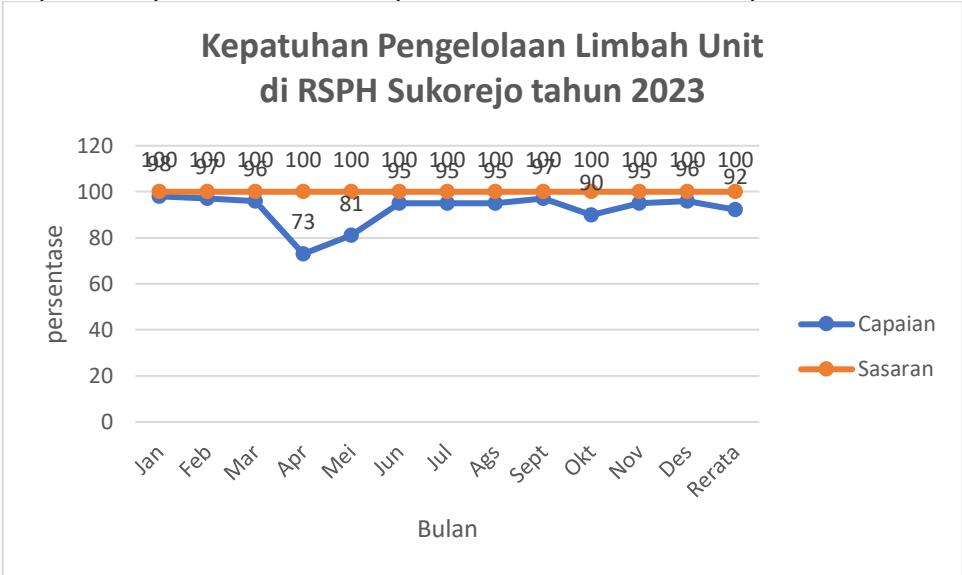


Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa kepatuhan penanganan linen tahun 2023 yaitu sebesar 93%.

PROBLEM	Persentase kepatuhan penanganan linen belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit londri mengenai pentingnya penanganan linen untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun linen
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan penanganan linen di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam penanganan linen di unit laundry sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit penanganan linen di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penanganan linen di unit laundry. c. Koordinasi dengan IP di unit untuk meningkatkan kepatuhan penanganan linen di unit. d. Berkoordinasi dengan laundry terkait temuan limbah maupun alat kesehatan pada linen kotor dan pemilahan linen di unit yang tidak sesuai.
DO	Kepatuhan penanganan linen mencapai 100%
STUDY	1. Kepatuhan penanganan linen di unit belum mencapai 100%. 2. Masih ditemukan petugas yang tidak patuh terhadap prinsip area infeksius dan non infeksius. 3. Masih ditemukan petugas yang tidak menggunakan APD dengan tepat di area infeksius.
ACTION	1. Resosialisasi kepada staf terkait penanganan linen 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring penanganan linen di unit, terutama pemilahan linen infeksius dan non infeksius, serta linen yang tidak terurai saat masuk di tong linen kotor. 4. Monitoring progress pembersihan ruangan

7. Kepatuhan penanganan limbah

a. Kepatuhan pemilahan limbah (infeksius dan non infeksius)



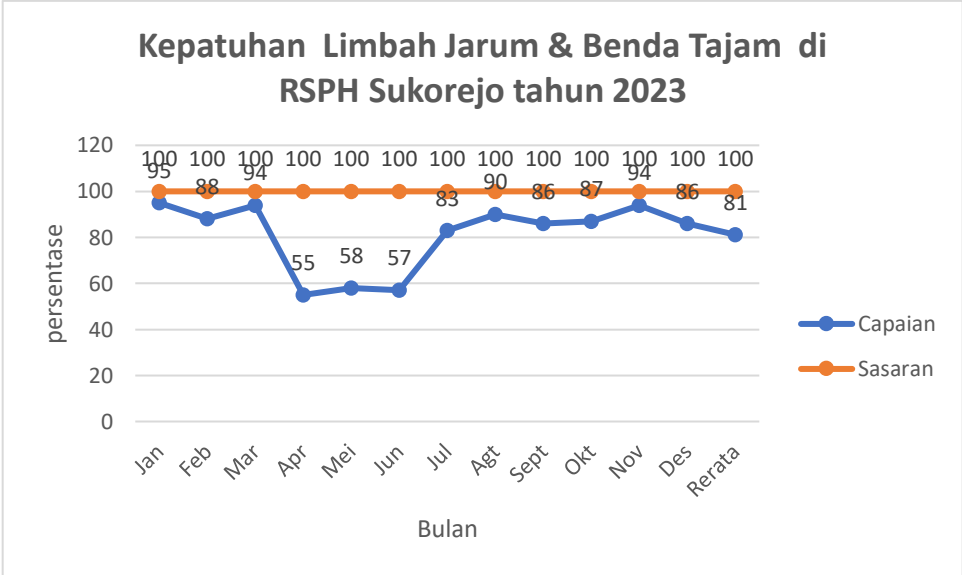
Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan pemilahan sampah di unit tahun 2023 yaitu sebesar 92%, belum mencapai sasaran.

PROBLEM	Persentase kepatuhan pemilahan sampah di unit belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pemilahan sampah di unit baik infeksius maupun non infeksius untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pemilahan sampah di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pemilahan sampah di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pemilahan sampah di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pemilahan sampah di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pemilahan sampah di unit.
DO	Kepatuhan pemilahan sampah meningkat hingga mencapai 100%
STUDY	1. Kepatuhan pemilahan sampah di unit stabil 92% belum mencapai 100%. 2. Masih ditemukan sampah infeksius yang dibuang di sampah non infeksius. 3. Masih ditemukan spuit dibuang di sampah non infeksius.
ACTION	1. Resosialisasi kepada staf terkait pemilahan sampah di unit, motivasi petugas untuk patuh dalam pemilahan limbah di unit. 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Beri teguran saat melakukan monitoring pemilahan sampah yang tidak sesuai. 4. Jika ada sampah yang tercampur, follow up ke unit segera



	untuk dipilah
--	---------------

b. Kepatuhan pembuangan limbah jarum dan benda tajam



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam tahun 2023 yaitu sebesar 81%, belum mencapai sasaran 100%.

PROBLEM	Persentase kepatuhan pembuangan sampah jarum dan benda tajam belum mencapai 100%
STEP	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya pembuangan jarum dan benda tajam untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan serta mengurangi risiko tertusuk jarum pada petugas.
PLAN	1. Rencana: Mengetahui kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan 2. Harapan Seluruh staf patuh dalam pembuangan sampah jarum dan benda tajam di unit sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 3. Tindakan a. Melakukan audit pembuangan jarum dan benda tajam di unit secara berkesinambungan. b. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pembuangan jarum dan benda tajam di unit. c. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam di unit.
DO	Kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam meningkat hingga mencapai 100%
STUDY	1. Rerata kepatuhan pembuangan jarum dan benda tajam tahun 2023 yaitu sebesar 81%, Masih ditemukan pembuangan jarum dan benda tajam menggunakan bahan tidak kedap air dan tidak tahan tusukan. 2. Masih ditemukan penumpukan sampah jarum dan benda tajam yang tidak segera dibuang bila sudah $\frac{3}{4}$ penuh.

ACTION	- Resosialisasi kepada staf terkait pembuangan jarum dan benda tajam. - Beri feedback pada hasil temuan. - Beri teguran saat melakukan monitoring pembuangan jarum dan benda tajam di unit.
--------	---

8. Kepatuhan pemrosesan peralatan Kesehatan (dekontaminasi CSSD)



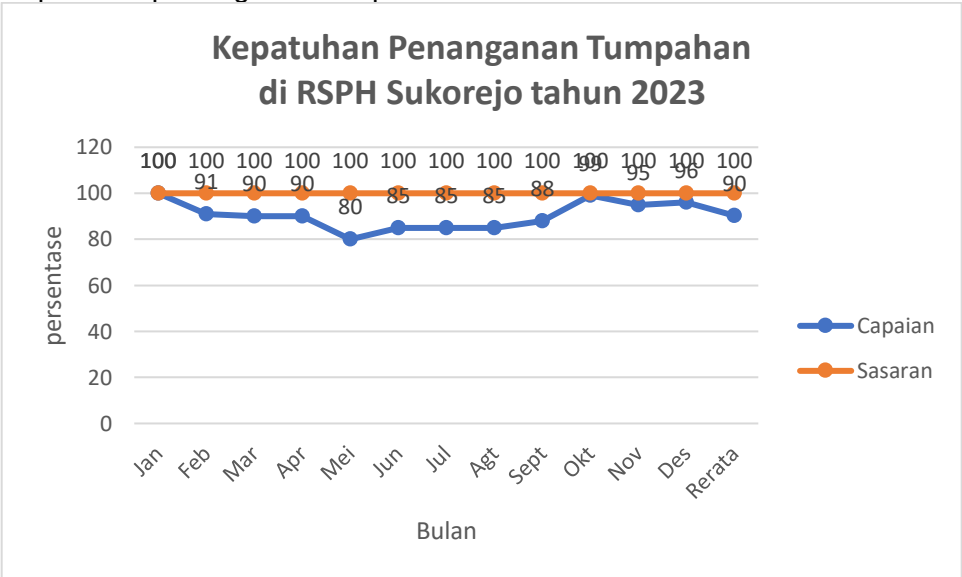
Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui rerata kepatuhan pemrosesan alat tahun yaitu sebesar 91%, belum mencapai sasaran.

PROBLEM	Persentase kepatuhan pemrosesan alat mencapai 100%
STEP	Menghimbau semua staf di unit CSSD mengenai pentingnya pemrosesan peralatan kesehatan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan pada alat yang digunakan.
PLAN	- Rencana: Mengetahui kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan di unit secara berkesinambungan - Harapan Seluruh staf patuh dalam pemrosesan peralatan kesehatan di unit CSSD sehingga target kepatuhan dapat dicapai. - Tindakan - Melakukan audit pemrosesan peralatan kesehatan di unit secara berkesinambungan. - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang pemrosesan peralatan kesehatan di unit CSSD. - Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan di unit. - Berkoordinasi dengan CSSD terkait peningkatan kepatuhan staf unit terkait pengambilan alat bersih maupun pengiriman alat kotor.
DO	Kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan mencapai 100%
STUDY	- Kepatuhan pemrosesan peralatan kesehatan di unit belum mencapai 100%. - Petugas sudah mulai patuh dalam penggunaan APD saat pemrosesan maupun kebersihan tangan - Petugas sudah patuh sesuai jadwal pengiriman alat kotor

	4. Petugas kurang tertib menjaga kebersihan dan kepatuhan area bersih dan kotor.
ACTION	1. Motivasi petugas untuk mempertahankan kepatuhan . 2. Beri feedback pada hasil temuan. 3. Monitoring kepatuhan pengiriman alat kotor dan pengambilan alat bersih sesuai jadwal.

3.3.2 Program Penunjang PPI

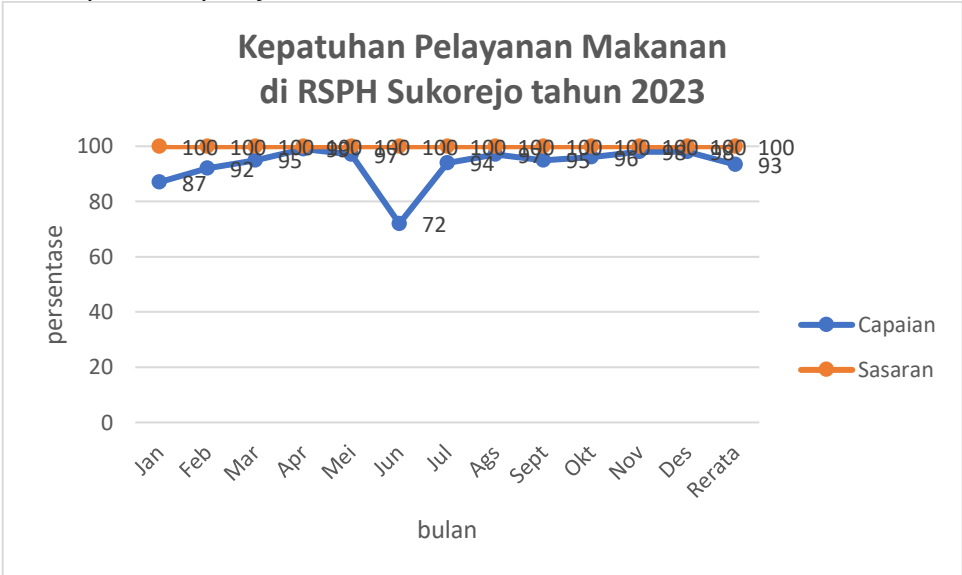
1. Kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh



Interpretasi: Pada grafik tersebut, diketahui bahwa rerata kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh tahun 2023 mencapai 90%, belum mencapai sasaran.

PLAN	Meningkatkan kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh hingga mencapai target yaitu 100%.
DO	1. Pembuatan form tumpahan yang awalnya menggunakan kertas yang mudah hilang dan sobek, dialihkan menggunakan google form (desember 2023). 2. Checklist supervise spilkit belum 100% berjalan.
STUDY	1. rerata kepatuhan penanganan tumpahan darah dan cairan tubuh tahun 2023 mencapai 90%, belum mencapai sasaran. 2. Pelaporan sudah berjalan 90% tepat waktu di google form per desember 2023. 3. Pelaporan sudah mulai berjalan di unit IGD, IRNA, dan IRJA, dan IKO (unit berisiko terjadinya tumpahan cairan tubuh)
ACTION	1. Koordinasi dengan tim umum untuk selalu mengisi ulang bahan box spilkit setelah digunakan 2. Monitoring unit terkait kelengkapan box spilkit. 3. Supervisi terkait pelaporan tumpahan. 4. Analisis kebutuhan spill kit di unit berisiko

2. Kepatuhan pelayanan makanan



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa rerata kepatuhan pelayanan makanan tahun 2023 adalah 93%.

PLAN	Meningkatkan kepatuhan pelayanan makanan di rumah sakit hingga mencapai target 100%.
DO	Melakukan audit kebersihan tangan menggunakan form WHO Melakukan supervise menggunakan checklist form PPI
STUDY	1. rerata kepatuhan pelayanan makanan tahun 2023 adalah 93%. 2. Masih ditemukan lantai kotor dan lengket saat proses pengolahan makanan.
ACTION	1. Koordinasi dengan CS pantry terkait kebersihan ruang dapur dan gizi 2. Berkoordinasi dengan Rentokil jika ditemukan vector rodent terutama di area pelayanan makanan. 3. Monitoring penggunaan APD di dapur

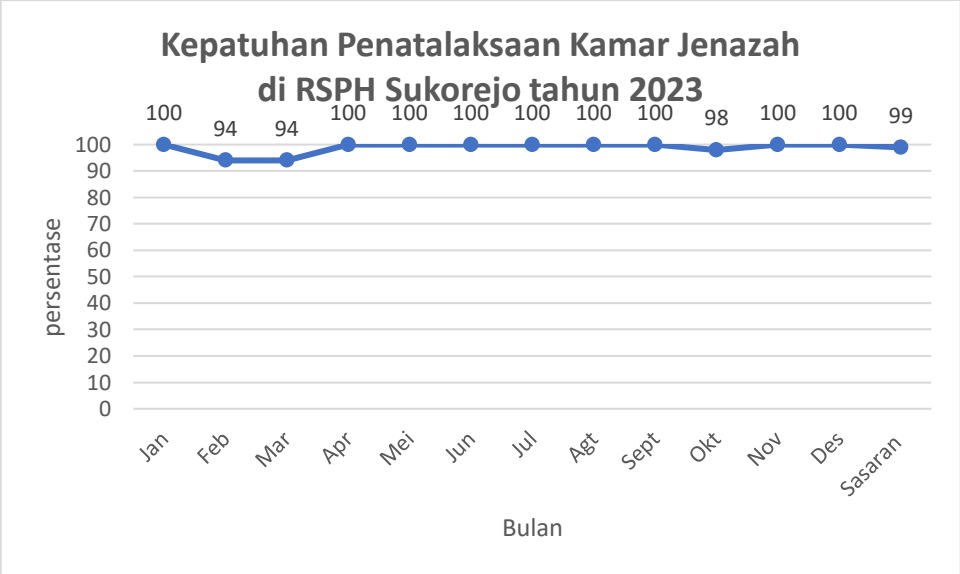
3. Dekontaminasi ambulan



Interpretasi: Pada grafik tersebut dapat diketahui bahwa kepatuhan dekontaminasi ambulan tahun 2023 mencapai 97%.

PLAN	Meningkatkan kepatuhan dekontaminasi ambulan 100%
DO	Menggunakan form monitoring dan supervisi yang telah disusun untuk checklist dekontaminasi ambulan.
STUDY	1. kepatuhan dekontaminasi ambulan tahun 2023 mencapai 97. 2. Pemenuhan fasilitas seperti sprayer sudah dilakukan, namun Ketika setelah transfer pasien dengan penyakit menular, tidak segera dibersihkan total
ACTION	Tingkatkan monitoring oleh coordinator driver ambulan dan IPCP

4. Kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah mencapai 99%.

PLAN	Meningkatkan kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah 100%
DO	Mempertahankan monitoring dan supervisi yang telah dilakukan terhadap penatalaksanaan kamar jenazah.
STUDY	1. Rerata Kepatuhan penatalaksanaan kamar jenazah mencapai 99% 2. Monitoring kebersihan ruangan perlu dipertahankan, serta kesiapan perlengkapan petugas pemulasaran. 3. Pencatatan pelaporan harus dipertahankan.
ACTION	1. Koordinasi dengan petugas untuk pembersihan kamar jenazah secara rutin 2. Tingkatkan supervisi pencatatan terkait serah terima jenazah.

5. Kesehatan karyawan

No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan		Keterangan
			Fisik	Thorax	
1.	Januari	-	-	-	
2.	Februari	-	-	-	
3.	Maret	108	86	22	
4.	April	100	100	-	
5.	Mei	100	100	-	
6.	Juni	90	90	-	Jumlah staf yang sudah



No	Bulan	Jumlah Staf yang MCU	Jenis Pemeriksaan		Keterangan
			Fisik	Thorax	
					MCU 398
7.	Juli	-	-	-	
8.	Agustus	-	-	-	
9.	September	-	-	-	
10.	Oktober	29	29	-	Sisa staf yang belum MCU = 82
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-

Interpretasi: Total staf yang belum melaksanakan MCU 82 orang

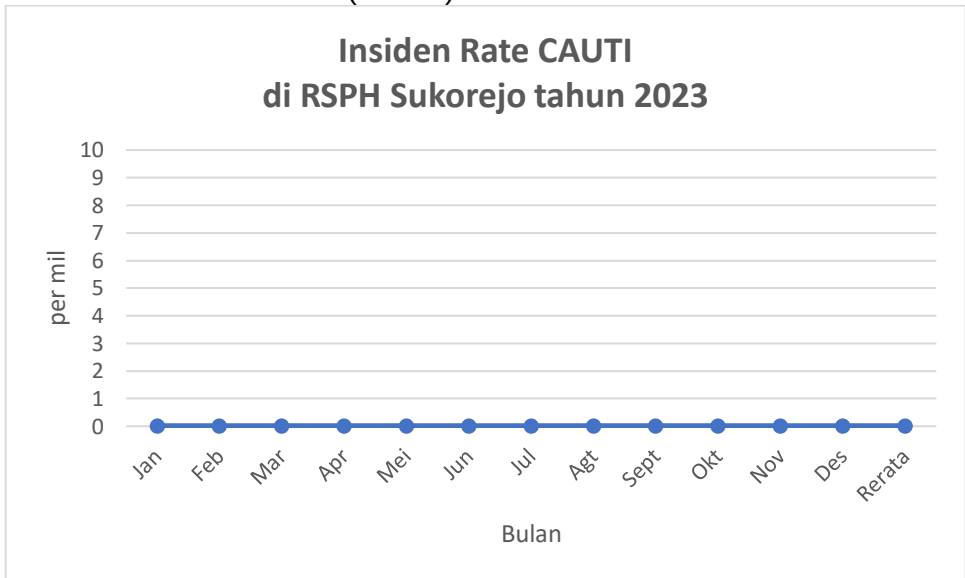
Analisa: Petugas yang belum MCU dikarenakan beberapa hal:

1. Berencana tidak melanjutkan kontrak
2. Penjadwalan masih menunggu poli MCU

Rencana Tindak Lanjut: Koordinasi dengan Komite K3RS terkait pelaksanaan MCU berikutnya.

3.3.3 Surveilans HAIs

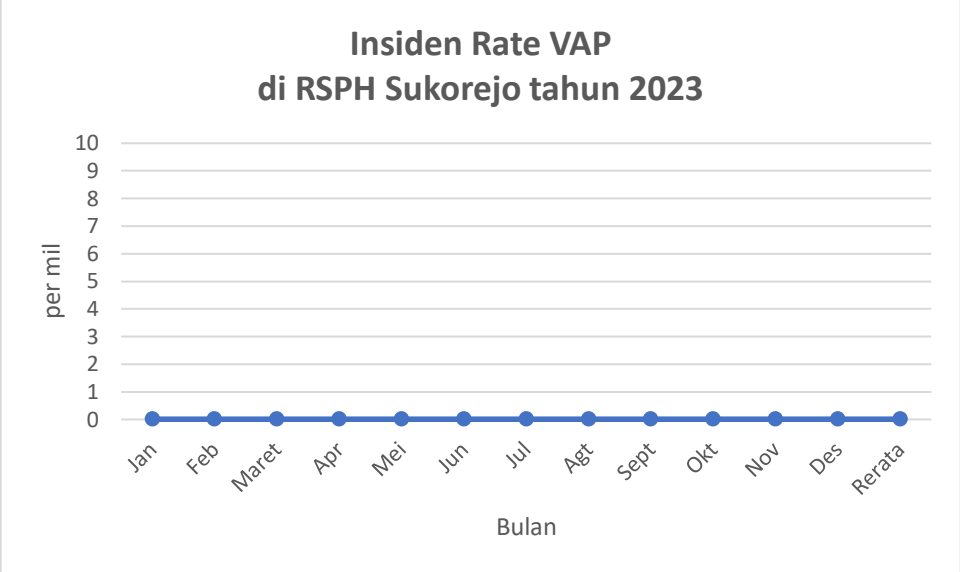
1. Infeksi Saluran Kemih (CAUTI)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa pada tahun 2023 tidak ada kejadian ISK akibat pemasangan urine catheter di rumah sakit.

PLAN	Mempertahankan angka ISK yang sudah sangat baik.
DO	Untuk surveilans menggunakan form surveilans google spreadsheet yang diinput oleh IPCLN
STUDY	Jarangnya kejadian ISK pada unit perawatan dapat disebabkan karena pemakaian kateter yang tidak terlalu lama dan perawatan rutin oleh perawat ruangan serta penggantian rutin kateter setelah 7 hari pemasangan.
ACTION	1. Monitoring pelaksanaan bundles ISK di unit 2. Koordinasi pelatihan pemasangan dan perawatan kateter pasien dengan komite keperawatan.

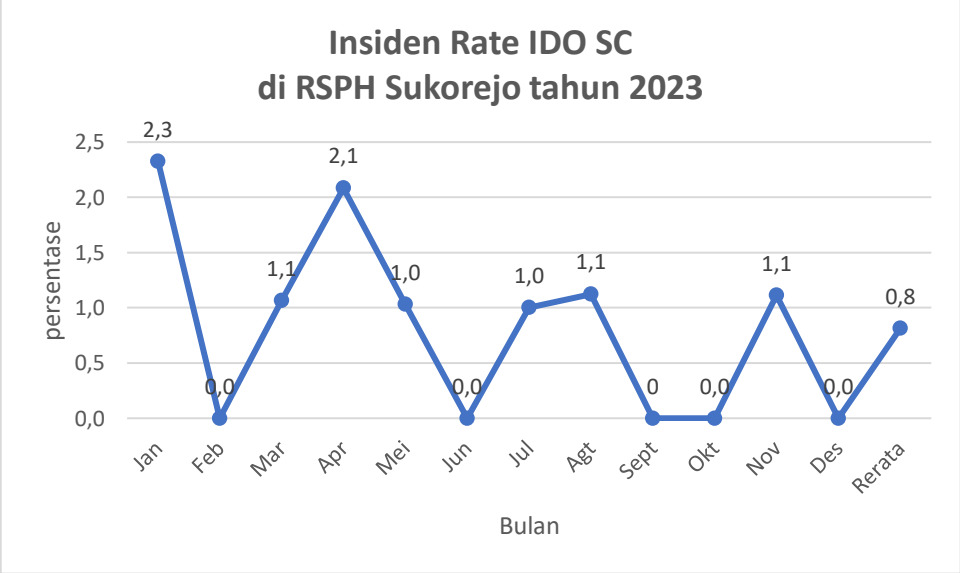
2. Ventilator associated pneumonia (VAP)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa tahun 2023 tidak ada kejadian VAP akibat pemasangan ventilator di rumah sakit.

PLAN	Mempertahankan angka VAP yang sudah sangat baik.
DO	Untuk surveilans menggunakan form surveilans google spreadsheet yang diinput oleh IPCLN
STUDY	Pemakaian ventilator banyak dilakukan di unit ICU dan pemakaiannya langsung dalam pantauan DPJP anastesi dan pemeliharaan alat langsung dilakukan oleh petugas IPSRS.
ACTION	1. Monitoring pelaksanaan bundles VAP di unit 2. Koordinasi perawatan dan pembersihan alat dengan IPSRS

3. Infeksi Daerah Operasi (IDO)



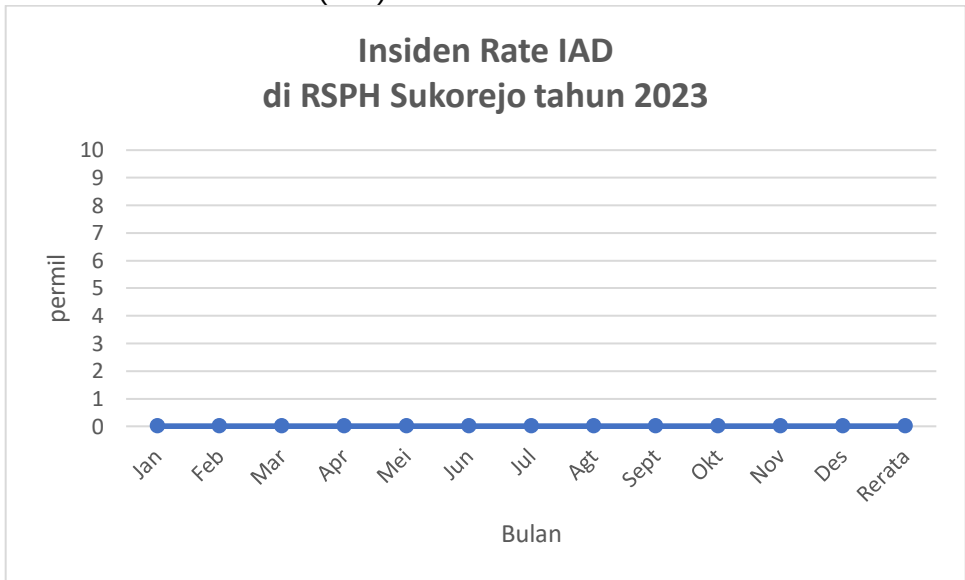
Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa pada tahun 2023 kejadian IDO yaitu 0,8% kasus operasi SC.

PLAN	1. Evaluasi bundles IDO pada tahap pre op, intra op, dan post op. 2. Melaksanakan surveilans dan bundles IDO sesuai prosedur 3. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 4. Supervisi oleh IPCN
DO	1. Membuat form audit bundles pre op yang diinput oleh tim Maternitas melalui google spreadsheet. 2. Membuat form surveilans IDO yang diinput oleh tim



	IKO melalui google spreadsheet
STUDY	1. Rerata kejadian IDO di tahun 2023 adalah sebesar 0,8% kasus operasi. 2. Penyebab yang memungkinkan terjadinya IDO adalah karena kurang terjaganya personal hygiene pasien, kurang cukupnya asupan protein yang menyebabkan luka tidak segera mengering, kurangnya mobilisasi pasien, dan jadwal control yang kadang melebihi waktu yang ditentukan oleh DPJP. 3. Kurang kuatnya edukasi petugas terhadap bundles IDO fase post op.
ACTION	1. Tingkatkan proses edukasi perawatan pasien pasca operasi. 2. Koordinasi dengan dokter operator dan tim IKO lainnya terkait berjalannya bundles operasi SC. 3. Koordinasi dengan tim PKRS dalam pengadaan sumber informasi seperti leaflet terkait bundles IDO fase pre op, intra op, maupun post op 4. Koordinasi dengan DPJP terkait pengajuan swab kultur saat terjadinya IDO

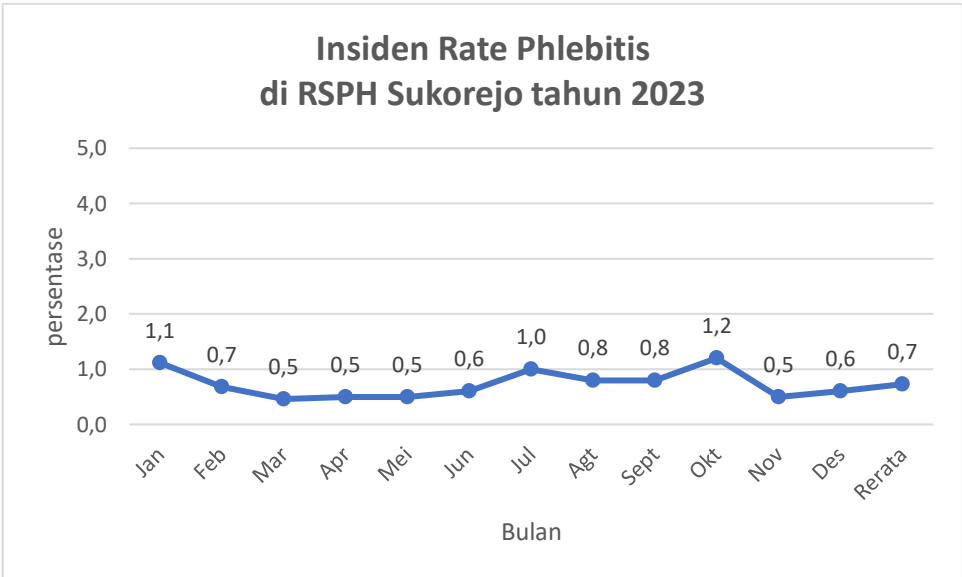
4. Infeksi Aliran Darah (IAD)



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa tahun 2023 tidak ada kejadian IAD akibat pemasangan IVL/CVC di rumah sakit.

PLAN	Mempertahankan angka IAD yang sudah sangat baik.
DO	Untuk surveilans menggunakan form surveilans google spreadsheet yang diinput oleh IPCLN
STUDY	Pemasangan IVL/CVC banyak dilakukan di unit ICU dan pemakaiannya langsung dalam pantauan DPJP anastesi.
ACTION	Monitoring pelaksanaan bundles IAD di unit

5. Surveilans Phlebitis



Interpretasi: Pada grafik tersebut diketahui bahwa rerata angka phlebitis pada tahun 2023 tetap di angka 0,7%.

PLAN	1. Melaksanakan bundles phlebitis sesuai SPO 2. Monitoring dan evaluasi oleh IPCLN 3. Supervisi oleh IPCN
DO	Untuk surveilans menggunakan form surveilans google spreadsheet yang diinput oleh IPCLN
STUDY	Rerata Angka phlebitis masih sudah < 1,5% (berdasarkan standar mutu RS) dapat disebabkan cukup terampilnya petugas dalam memilah cairan infus yang akan masuk ke dalam tubuh pasien (tingkat kepekatan) disertai KIE yang cukup jelas kepada pasien maupun penunggunya.
ACTION	1. Motivasi petugas untuk mempertahankan insiden rate yang menurun. 2. Tetap resosialisasi kepada perawat tentang hand hygiene dan pemakaian APD yang sesuai indikasi. 3. Koordinasi dengan komite keperawatan untuk melakukan pelatihan pemasangan infus serta prosedur perawatan luka infus untuk tahun berikutnya.

3.5 Mutu : INM, IMPRS (jika termasuk), Mutu Prioritas Internal Unit
(disertai Analisa dan Rencana Tindak Lanjut)

No	Indikator Mutu	Sasaran	Capaian												Rerata	Ket
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1.	Kepatuhan kebersihan tangan	≥ 85%	80	72	79	84	70	73	76	82	78	69	71	79	76	Tidak tercapai
2.	Kepatuhan penggunaan APD	100%	83	83	83	85	83	90	88	96	94	90	91	92	88	Tidak tercapai
3.	Kejadian petugas tertusuk jarum	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4.	Angka ketidak patuhan pemilahan sampah	0	2	3	4	27	19	5	5	5	3	10	5	4	8	Tidak tercapai
5.	Angka IDO	1,5%	2,3	0,0	1,1	2,1	1,0	0,0	1,0	1,1	0	0	1,1	0,0	0,8	Tercapai
6.	Angka Plebitis	1,5%	11%	7%	5%	5%	5%	6%	1	0,8	0,8	1,2	0,6	0,6	0,7	Tercapai

Analisa	Indikator mutu yang tidak tercapai adalah: 1. Kepatuhan kebersihan tangan 2. Kepatuhan penggunaan APD 3. Angka ketidakpatuhan pemilahan sampah di unit Analisa masalah sudah dilakukan menggunakan tools PDSA pada kinerja produktivitas.
Rencana Tindak Lanjut	Rencana tindak lanjut dilakukan sesuai hasil kinerja produktivitas pada tools action.

3.7 PKRS

No	Nama Unit	Target	Sasaran	Capaian												Total Edukasi	Ket
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des		
1.	Farmasi	2x edukasi dalam 1 bulan dengan peserta minimal 5 orang dalam satu edukasi	1. Staf 2. Pasien dan penunggu pasien 3. Pengunjung 4. Komunitas	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	22	Tidak tercapai
2.	Gizi & Dapur			2	1	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	11	
3.	ICU			-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
4.	IGD			-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	2	7	
5.	IRJA			-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
6.	IRNA 2A			-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	
7.	IRNA 2B			-	-	-	2	2	2			-	-	1	2	9	
8.	IRNA 3A			-	-	-	1	2	2	4	5	1	2	2	2	21	
9.	IRNA 3B											1	-	2	2	5	
10	Laboratorium			-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
11	Maternitas			1	-	1	2	2	1	2	1	2	1	2	2	17	
12	Neonatalogi			1	-	1	-	1	2	2	1	1	1	1	-	11	
13	RM & PDF			-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	

Analisa	Dari 13 unit yang aktif melakukan edukasi, tidak ada unit yang mencapai 24 edukasi dalam satu tahun. Capaian tertinggi edukasi di tahun 2023 adalah unit farmasi dengan 22 kali edukasi dalam 1 tahun, dan terendah adalah unit RM & PDF dengan 2 kali edukasi dalam 1 tahun.
Rencana Tindak Lanjut	1. Motivasi anggota komite PPI untuk melakukan edukasi sesuai target dan damping 2. Koordinasi dengan tim PKRS terkait pembuatan jadwal edukasi setiap bulan untuk satu tahun.

3.7. Kinerja Produktifitas Tim PKRS

Jenis Leaflet yang tersedia di PKRS Prima Husada Sukorejo Pasuruan Tahun 2023

KATEGORI	MATERI	KODE
UMUM (U)	1. HPK & Tata Tertib	U-001
	2. Etiket Batuk & Bersin	U-002
	3. Cuci Tangan	U-003
	4. Jnais Sampah & Cara Mengolahnnya	U-004
	5. Risiko Jatuh di Rumah Sakit	U-005
	6. Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)	U-006
	7. Plebitis pada Infus	U-007
	8. Dagusibu	U-008
	9. Bahaya Merokok	U-009
	10. Alur Pendaftaran Pasien	U-010
	11. Pencegahan Penyakit yang Sering Terjadi di RS	U-011
	12. Status Penjaminan & Cara Bayar	U-012
	13. Cara Mengatasi Nyeri	U-013
	14. Cara Mengelola Nyeri dengan Relaksasi	U-014
	15. Penanganan Limbah Infeksius	U-015
	16. Asuhan Lanjutan Di Rumah	U-016
	17. Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	U-017
	18. Macam-macam Radiasi	U-018
	19. P3K	U-019
	20. Penggunaan Alat Medis	U-020
	21. Pentingnya Identifikasi Pasien	U-021
	22. Hygiene Kantin	U-022
	23. Kebersihan Lingkungan	U-023
	24. Pengolahan Limbah B3 Medis	U-024
	25. Kawasan Tanpa Rokok	U-025
	26. Mengenal Keputihan	U-026
	27. Nyeri Bahu	U-027



	28. Penularan lewat udara (airborne)	U-028
	29. Pemasangan Alat Endotracheal Tube	U-029
	30. Cedera Kepala	U-030
	31. Pemberian Makanan melalui selang (sonde)	U-031
	32. Penyimpanan Perkembangan Dewasa	U-032
	33. Penyimpangan Perkembangan Remaja	U-033
	34. Teknik duduk dan tidur yang benar	U-034
	35. Pencegahan Cidera Berulang	U-035
	36. Perawatan Luka	U-036
	37. Hygiene Kantin pada Petugas Kantin	U-037
	38. Pemasangan Alat Medis (Suction)	U-038
	39. Penggunaan APD di RS	U-039
	40. Protokol Kesehatan	U-040
	41. Rencana Kepulangan Pasien	U-041
	42. Teknik Rehabilitasi	U-042
	43. Early Warning System (EWS)	U-043
	44. Asuhan Menjelang Akhir Kehidupan Pasien	U-044
	45. Rujukan Edukasi	U-045
	46. Program Rujuk Balik (PRB)	U-046
ANAK (A)	1. Lintas Diare	A-001
	2. Program Pemberian Obat Pencegahan Massal Cacingan	A-002
	3. Pneumonia Balita	A-003
	4. 1000 HPK	A-004
	5. Scarlet Fever pada Anak	A-005
	6. Varicella / Cacar Air pada Anak	A-006
	7. Perawatan Stoma pada Anak	A-007
	8. Radang Tenggorokan pada Anak	A-008
	9. TBC pada Anak	A-009
	10. Eksim pada Anak	A-010
	11. Sakit Telinga pada Anak	A-011
	12. Campak pada Anak	A-012
	13. Pneumonia pada Balita	A-013



	14. Sakit Perut pada Anak	A-014
	15. Perawatan Bayi Prematur dengan Metode Kanguru	A-015
	16. Perawatan Tali Pusat	A-016
	17. Thalasemia	A-017
	18. Memandikan Bayi	A-018
	19. Cara Sederhana Menolong dan Mencegah Diare	A-019
	20. Gagal Ginjal Kronis pada Anak	A-020
	21. Demam Tifoid Pada Anak	A-021
	22. Kejang Demam Sederhana (KDS)	A-022
	23. Imunisasi Dasar Pada Anak	A-023
BEDAH (B)	1. Hernia	B-001
	2. Hidrokel	B-002
	3. Hipospadia	B-003
	4. General Anestesi	B-004
	5. Batu Saluran Kemih	B-005
	6. Cegah Luka Operasi Caesar	B-006
	7. Batu Empedu	B-007
	8. Apendistis	B-008
	9. Abses	B-009
	10. Fraktur	B-010
	11. Hernia	B-011
	12. Hidrosefalus	B-012
	13. Tumor Payudara	B-013
	14. Ulkus Dekubitus	B-014
	15. Ulkus Diabetikum	B-015
	16. Pencegahan Infeksi Post-Operasi	B-016
	17. Perawatan Luka Pasca Operasi	B-017
	18. Luka Bakar	B-018
	19. SADARI	B-019
	20. Soft Tissue Tumor	B-020
	21. Pre-Op Anestesi	B-021
	22. Pre-Op Penandaan	B-022



GIGI (G)	1. Periodontitis	G-001
	2. Karies Gigi	G-002
	3. Perawatan Gigi Susu	G-003
JANTUNG (J)	1. Gagal Jantung	J-001
	2. Penyakit Jantung Koroner	J-002
	3. EKG	J-003
ILMU PENYAKIT DALAM (I)	1. HIV / AIDS	I-001
	2. Hepatitis Ada di Sekitar Anda	I-002
	3. Batuk , Pilek, Demam Belum Tentu Flu	I-003
	4. Demam Cikungunya	I-004
	5. Hipertensi	I-005
	6. Infeksi Saluran Kemih	I-006
	7. Diarhea	I-007
	8. DM	I-008
	9. Maag & Gangguan Lambung	I-009
	10. Demam Berdarah Dengue (DBD)	I-010
	11. Senam Kaki Diabetes	I-011
	12. Rheumatik	I-012
	13. Chirosis Hepatitis	I-013
	14. Ketoasidosis Diabetikum	I-014
	15. Anemia	I-015
	16. Gastroenteritis (muntaber)	I-016
	17.Hidrosefalus	
KULIT & KELAMIN (K)	1. Perawatan Diri Pasien Kusta	K-001
	2. Kenali Kusta Sejak Awal	K-002
	3. Skabies	K-003
PARU (P)	1. TOSS TB	P-001
	2. Pengobatan TB Kebal Obat	P-002
	3. Pneumonia (dewasa)	P-003



	4. TBC Kebal Obat	P-004
	5. Stop TB	P-005
	6. Bronchoscopy	P-006
	7. Asma Bronkial	P-007
	8. ISPA	P-008
MATERNITAS (M)	1. Makanan pelancar ASI	M-001
	2. Tanda Bahaya Postpartum	M-002
	3. ASI Eksklusif	M-003
	4. Pijat Oksitosin	M-004
	5. Perawatan Tali pusat	M-005
	6. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	M-006
	7. Rawat Gabung	M-007
	8. Ketuban Pecah Dini	M-008
	9. Hamil Anggur	M-009
	10. Pre-Eklamsi Berat pada Ibu Hamil	M-010
	11. Abortus	M-011
	12. Kehamilan Lewat Waktu	M-012
	13. Cara Menyusui yang Benar	M-013
	14. Perawatan Metode Kanguru (PMK) pada BBLR	M-014
	15. Cerdas Memilih Kontrasepsi	M-015
FARMASI (F)	1. Cara Menggunakan Obat Konvensional	F-001
	2. Penggunaan Obat Secara Efektif dan Aman	F-002
	3. Efek Samping pada Obat	F-003
	4. Cerdas Menggunakan Insulin	F-004
	5. Perbedaan Waktu Minum Obat	F-005
	6. Cerdas Memilih Obat Flu	F-006
	7. Interaksi antar Obat & Obat dengan Makanan	F-007
	8. Obat Generik dan Obat Paten	F-008
	9. Informasi Penyakit dan Obat	F-009
	10. Penggunaan Obat mengatasi Obesitas	F-010
	11. Obat Non Resep	F-011
	12. Pelayanan Informasi Obat (PIO)	F-012



UROLOGI (UR)	1. Undescendcus Testis (UDT) atau Kriptorkismus	UR-001
	2. Varikokel	UR-002
	3. BPH (benigna Prostat Hipertropi)	UR-003
ORTHOPEDI (O)	1. Osteoarthritis	O-001
	2. Osteoporosis	O-002
	3. Osteomyelitis (Infeksi Tulang)	O-003
	4. Patah Tulang	O-004
THT (T)	1. Karsinoma Nasofaring	T-001
	2. Oklusi Tuba	T-002
JIWA (JW)	1. Ansietas	JW-001
	2. Depresi	JW-002
	3. Skizofrenia	JW-003
REHAB MEDIK (R)	1. Cara Mengatasi Nyeri dengan Pemijatan	R-001
	2. Serba Serbi Fisioterapi	R-002
	3. Latihan Gerak ROM aktif dan pasif	R-003
	4. Rehabilitasi penderita lumpuh separuh pasca stroke	R-004
	5. Alat Bantu Berjalan	R-005
	6. Rehabilitas Nyeri Punggung Bawah atau Nyeri Pinggang	R-006
NEUROLOGI (N)	1. Stroke	N-001
	2. SNH (Stroke Non Haemorigic)	N-002
	3. Parkinson	N-003
	4. Epilepsi	N-004
	5. Demensia	N-005
ONKOLOGI (OG)	1. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim	OG-001
	2. Kanker Paru	OG-002



	3. Deteksi Dini Kanker Prostat	OG-003
	4. Deteksi Dini Kanker Payu Dara	OG-004
	5. Kanker Paru	OG-005
GIZI (Z)	1. Pedoman Gizi Seimbang	Z-001
	2. 10 Pedoman Gizi Seimbang	Z-002
	3. Gizi untuk Ibu Hamil	Z-003
	4. Diet pada penderita GERD	Z-004
	5. Diet Keto	Z-005
	6. Diit pada TBC	Z-006
	7. Obesitas & IMT	Z-007
	8. Diit Rendah Kolesterol	Z-008
	9. Makanan untuk Ibu Menyusui	Z-009
	10. Diit untuk Penyakit Kanker	Z-010
	11. Diit Rendah Garam	Z-011
MATA (MT)	1. Glaukoma	MT-001
	2. Kacamata pada kelainan refraksi	MT-002
	3. Konjungtivitis	MT-003
LABORATORIUM (L)	1. PCR & SWAB	L-001
	2. TATA CARA PENGUMPULAN SPESIMEN DAHAK UNTUK PEMERIKSAAN TBC PARU (TUBERCULOSIS)	L-002

Tabel 2. Jumlah Ketersediaan Leaflet di RSPH Sukorejo Kab. Pasuruan Tahun 2023

KATEGORI (19)	JUMLAH LEAFLET
UMUM (U)	46
ANAK (A)	23
BEDAH (B)	22
GIGI (G)	3

JANTUNG (J)	3
ILMU PENYAKIT DALAM (I)	16
KULIT & KELAMIN (K)	3
PARU (P)	8
MATERNITAS (M)	15
FARMASI (F)	11
UROLOGI (UR)	3
ORTHOPEDI (O)	4
THT (T)	2
JIWA (JW)	3
REHAB MEDIK (R)	6
NEUROLOGI (N)	5
ONKOLOGI (OG)	5
GIZI (Z)	11
MATA (MT)	3
BELUM REVISI / BELUM DIBUAT	128
TOTAL	195

A. EDUKASI DI LUAR GEDUNG / CSR / SEMINAR

Tabel D.1 Rekapitulasi Jumlah Pelaksanaan Edukasi di Luar Gedung / CSR Bulan November Tahun 2023

No	Tanggal Penyelenggaraan	Tempat	Edukator	Materi	Jumlah Sasaran	Dokumentasi
1	Senin, 09 Januari 2023	SMKN 2 Sukorejo	1. Sufi Aulia, S.KM 2. Syamsiatul, S.KM	1. Pencegahan Pernikahan Dini & Sexual Harrasment 2. Kesehatan Reproduksi Remaja	100 siswa	

No	Tanggal Penyelenggaraan	Tempat	Edukator	Materi	Jumlah Sasaran	Dokumentasi
2	Selasa, 10 Januari 2023	Pasar Sukorejo	Restu Kurniawati, S.KM	Sanitasi & Pasar Sehat	50 Pedagang	
3	Selasa, 17 Januari 2023	PT Heinz ABC	dr. Nurul Fatimah	Penyakit Akibat Kerja	50 Karyawan	
4	Rabu, 12 April 2023	Panti Asuhan Ar-Rahman Purwosari	1. Sufi Aulia, S.KM Dinnya Yesica Tandy, S.KM.	1. Pencegahan Pernikahan Dini & Sexual Harrasment Hand Hygiene	40 Anak	



No	Tanggal Penyelenggaraan	Tempat	Edukator	Materi	Jumlah Sasaran	Dokumentasi	
5	Jum'at, 14 April 2023	Panti Muhammadiyah Lawang	1. Sisca, S.Kp.,Ns.	1. Pentingnya Hand Hygiene	40 Anak		
6	Selasa, 09 Mei 2023	PT. NPR	1. Fefi Rita, S.Kep., Ns.	1. Alur pendaftaran & Pentingnya MCU	Tidak tercatat		
7	Kamis, 08 Juni 2023	Kecamatan Sukorejo	1. Sufi Aulia, S.KM 2. Fefi, S.Kep.,Ns	1. Hipertensi 2. Layanan RSPHS	25 Ibu PKK		



No	Tanggal Penyelenggaraan	Tempat	Edukator	Materi	Jumlah Sasaran	Dokumentasi
8	Sabtu, 24 Juni 2023	SMK 1 Muhammadiyah Pandaan	1. Sufi Aulia, S.KM 2. Fefi, S.Kep.,Ns	1. Komunikasi Efektif di RS 2. Service Excellence	61 Siswa	
9	Sabtu, 14 Juli 2023	Hall Sakura RS Prima Husada Sukorejo	1. Dinda Aulia, S.Gz. 2. dr. Ifit Bagus Apriantono	Nutrisi untuk Mencegah Penyakit Degeneratif Company Profile & Layanan RSPHS	60	
10	Selasa, 29 Agustus 2023	PT. Panverta	dr. Novita Oktaviana	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	± 60	

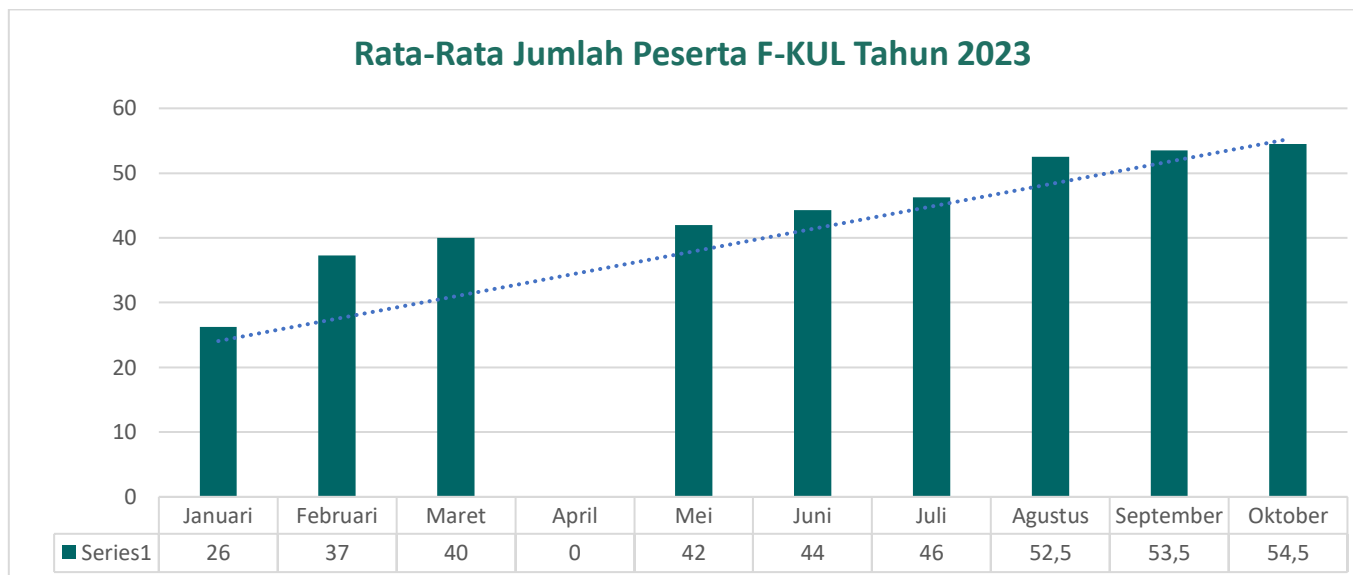


No	Tanggal Penyelenggaraan	Tempat	Edukator	Materi	Jumlah Sasaran	Dokumentasi
						
11	Jum'at, 15 September 2023	Yayasan Darul Mukmin Sukorejo	Adinda Aulia Yuniar, S.Gz	Pemenuhan Gizi Anak Usia Dini	29	

No	Tanggal Penyelenggaraan	Tempat	Edukator	Materi	Jumlah Sasaran	Dokumentasi
12	Jum'at, 17 Oktober 2023	Taman Safari Indonesia	dr. Novita Oktaviana	Kesehatan Mental di Tempat Kerja	± 50	 Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja  PENYULUHAN KESEHATAN <i>di luar Gedung</i> Pada tanggal 17 Oktober 2023, telah dilaksanakan penyuluhan kesehatan tentang "Menjaga Kesehatan Mental di Tempat Kerja" dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia. Penyuluhan dilaksanakan di Taman Safari Indonesia (TSI) Jawa Timur yang merupakan agenda rutin sebagai bentuk kerja sama antara RSPhS dengan TSI Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan para karyawan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kesehatan mental terutama di tempat kerja dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mendukung terbentuknya lingkungan kerja yang sehat. Prima Husada Sukorejo rsprimahusada_sukorejo 0811-957-100

No	Tanggal Penyelenggaraan	Tempat	Edukator	Materi	Jumlah Sasaran	Dokumentasi
13	01 November 2023	SMKN Muhammadiyah 1 Pandaan	1. dr. Novita Oktaviana 2. Restu Kurniawati, S.KM	Basic K3 & Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	± 50	  PENYULUHAN KESEHATAN <i>Perawatan Luka Dasar</i> Pada tanggal 01 November 2023, telah dilaksanakan penyuluhan kesehatan tentang “Perawatan Luka Dasar” yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Pandaan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mudi dalam melakukan perawatan luka dasar sebagai pertolongan pertama dan bentuk pencegahan agar luka tidak bertambah parah dan tidak timbul infeksi.  Prima Husada Sukorejo  rsprimahusada_sukorejo  0811-957-100

B. LAMPIRAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS



Grafik D.1 Rekapitulasi Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Forum Kesehatan Usia Lanjut (F-KUL)



Grafik D.2 Rekapitulasi Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Duta Online Peduli Ibu dan Anak (DOLINA)



C. LAMPIRAN PERAYAAN HARI BESAR

Tabel F.1 Rekapitulasi Kegiatan Memperingati Hari Besar Tahun 2023

BULAN	TANGGAL	HARI BESAR	TERLAKASANA / TIDAK	KEGIATAN
Januari	1 Januari	Hari Keluarga	×	Tidak Terlaksana
	6-13 Januari	HUT RSPHS KE-4	√	Celebration, Mini Challenge, & Charity
	24 Januari	Hari Moebius Syndrome Sedunia	√	Posting Poster di IG
	25 Januari	Hari Gizi Nasional	√	Charity & Posting Poster di IG, WAG, FB
	29 Januari	Hari Kusta Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
Februari	2 Februari	Hari Arthirtis Reumatoid	√	Penyuluhan di komunitas F-KUL
	4 Februari	Hari Kanker Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	7-14 Februari	Pekan Kesadaran Defek Jantung Turunan	×	Tidak Terlaksana
	12 Februari	Hari Kesehatan Wanita Sedunia	×	Tidak Terlaksana
	15 Februari	Hari Kanker Anak Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	18 Februari	Isra Mi'raj	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
Maret	3 Maret	Hari Pendengaran Nasional	√	Penyuluhan & Posting Poster di IG, FB
	8 Maret	Hari Wanita Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	9 Maret	Hari Ginjal Sedunia	√	Penyuluhan & Posting Poster di IG
	14-20 Maret	Minggu Kesadaran Otak	√	Senam Otak (Komunitas F-KUL)
	20 Maret	Hari Kesehatan Mulut Sedunia	√	Live & Posting Poster di IG
	23 Maret	Bulan Ramadhan	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	24 Maret	Hari TBC Sedunia	√	Penyuluhan & Posting Poster di IG, WAG, FB
	26 Maret	Hari Epilepsi Sedunia	×	Tidak Terlaksana
April	1 April	Hari Kanker Tulang	×	Tidak Terlaksana
	2 April	Hari Autisme Sedunia	×	Tidak Terlaksana
	7 April	Hari Kesehatan Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	21 April	Hari Kartini	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	21 April	Hari Raya Idul Fitri	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	24 April	Hari Meningitis Sedunia	×	Tidak Terlaksana
	25 April	Hari Malaria Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
Mei	2 Mei	Hari Pendidikan Nasional	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	5 Mei	Hari Cuci Tangan Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB



BULAN	TANGGAL	HARI BESAR	TERLAKASANA / TIDAK	KEGIATAN
	5 Mei	Hari Bidan Internasional	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	18 Mei	Hari Kenaikan Isa Almasih	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	20 Mei	Hari Kebangkitan Nasional	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	29 Mei	Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)	√	Penyuluhan Kesehatan di Komunitas F-KUL
	31 Mei	Hari Tanpa Tembakau Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
Juni	1 Juni	Hari Lahir Pancasila	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	1 Juni	Hari Anak Sedunia	×	Tidak Terlaksana
	14 juni	Hari Donor Darah Sedunia	√	Event Donor Darah & Posting Poster di IG, WAG, FB
	24 Juni	Hari Bidan Nasional	√	Apresiasi Bidan & Posting Poster di IG, WAG, FB
	26 Juni	Hari Anti Narkoba Sedunia	×	Tidak Terlaksana
	29 Juni	Hari Idul Adha	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	29 Juni	Hari Keluarga Berencana (KB)	√	Konsultasi & Penyuluhan KB
Juli	15 Juli 2023	HUT BPJS Kesehatan	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	19 Juli 2023	Tahun Baru Islam	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	23 Juli 2023	Hari Anak Nasional	√	General Meeting & Posting Poster di IG, WAG, FB
	28 Juli 2023	Hari Hepatitis Sedunia	√	Reels IG Edukasi "Deteksi Dini Hepatitis Melalui Tes HBsAg" – dr. Novita (Poli MCU)
Agustus	01 Agustus 2023	Hari Kanker Paru Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	01-07 Agustus 2023	Pekan Asi Sedunia	√	Video Reels IG Edukasi Tentang Cara Menyusi yang Benar (Share All Social Media)
	17 Agustus 2023	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia	√	Lomba-Lomba, Gebyar Merdeka, Posting Poster di IG, WAG, FB
September	09 September 2023	Hari Olahraga Nasional	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	12 September 2023	Hasi Kesehatan Gigi dan Mulut	√	Video Reels IG Edukasi Tentang Cara Membersihkan Gigi pada Bayi (Share All Social Media)
	26 September 2023	Hari Kontrasepsi Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	27 September 2023	Hari Maulid Nabi SAW	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	28 September 2023	Hari Rabies Sedunia	X	Tidak Terlaksana
	29 September 2023	Hari Jantung Sedunia	X	Tidak Terlaksana

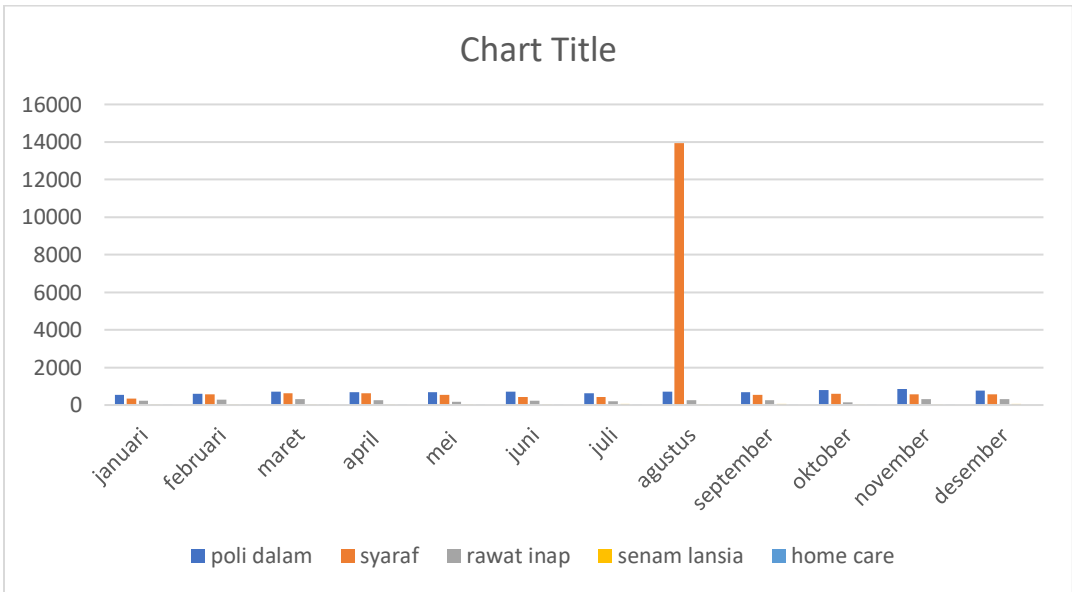


BULAN	TANGGAL	HARI BESAR	TERLAKASANA / TIDAK	KEGIATAN
Oktober	10 Oktober 2023	Hari Kesehatan Mental Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	12 Oktober 2023	Hari Pengelihan Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	15 Oktober 2023	Hari Cuci Tangan Sedunia	√	Edukasi Serentak di ruang tunggu & Posting Poster di IG, WAG, FB
	17 Oktober 2023	Hari Anestesi Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	18 Oktober 2023	Hari Menopause Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	24 Oktober 2023	Hari Dokter Nasional	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	24 Oktober 2023	Hari Sumpah Pemuda	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
November	09 November	Hari Radiologi Internasional	√	Poster Ucapan Apresiasi kepada Staf Radiografer
	10 November	Hari Pahlawan	√	Video Reels & Poster Ucapan di IG, WAG, FB
	12 November	Hari Kesehatan Nasional	√	Edukasi, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Pembagian Susu & Poster Ucapan
	14 November	Hari Diabetes Sedunia	X	Tidak Terlaksana
	17 November	Hari PPOK Sedunia	X	Tidak Terlaksana
Desember	01 Desember	Hari AIDS Sedunia	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	03 Desember	Hari Disabilitas Sedunia	X	Tidak Terlaksana
	22 Desember	Hari Ibu	√	Posting Poster di IG, WAG, FB
	25 Desember	Hari Natal	X	Tidak Terlaksana
TOTAL = 69		Terlaksana	54 (78%)	
		Tidak Terlaksana	15 (22%)	

3.8. Kinerja Produktifitas Tim Geriatri

Jumlah kegiatan pelayanan geriatri di rumah sakit

NO	BULAN	Rawat Jalan		Rawat Inap	Senam Lansia	Home care
		Poli dalam	Syaraf			
	Januari	532	345	230	32 peserta	2
	Februari	612	563	282	36 peserta	1
	Maret	712	634	302	35 peserta	3
	April	692	620	245	40 peserta	2
	Mei	681	542	168	42 peserta	1
	Juni	721	436	234	41 peserta	1
	Juli	624	423	196	48 peserta	5
	Agustus	711	13929	253	45 peserta	5
	September	677	536	254	48 peserta	5
	Oktober	794	605	150	46 peserta	3
	November	844	582	305	46 peserta	4
	Desember	767	562	314	48 peserta	0



Analisa :

Tidak stabilnya pasien geriatric di rumah sakit prima husada sukroejo di tahun 2023

Tindak Lanjut :

Melakukan peningkatan pelayanan di rumah sakit agar tetap menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat serta memberikan edukasi ke pada pasien dan keluarga agar rajin dan teratur untuk periksa ke Rumah Sakit

3.9 Kinerja Produktifitas KFT

a) Kinerja Produktifitas KFT Tahun 2023

	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Pencapaian dan Analisa
	Review Formularium RS	1. Melakukan kegiatan review Formularium 2023.	- Review formularium 2023 dilaksanakan
	Pelaksanaan Pemberian Informasi Antibiotik Rasional	Menyusun dan menetapkan Panduan Pemberian Antibiotik Rasional di RS Prima Husada Melakukan kegiatan pemberian informasi antibiotik yang rasional Pemberian informasi oleh Tim KFT kepada seluruh dokter di RS Prima Husada	Penyusunan Panduan Antibiotik yang Rasional oleh tim PPRA dengan bukti undangan, absensi, dan notulen. Panduan penggunaan antibiotik yang rasional telah tersusun. Pemberian informasi antibiotik yang rasional masih belum berjalan maksimal.
	Pelaksanaan monitoring terhadap kepatuhan Formularium dari aspek penggunaan obat dan aspek persediaan yaitu: Monitoring dan evaluasi permintaan obat diluar formularium Monitoring dan evaluasi ketersediaan obat	Melakukan monitoring setiap hari di rawat inap dan rawat jalan terkait : Monitoring peresepan diluar formularium Monitoring ketersediaan obat di IFRS Melakukan pelaporan terkait hasil monitoring ke tim KFT. Pelaporan hasil monitoring dilaporkan kepada anggota KFT setiap rapat rutin 3 bulan sekali dan dilakukan pembahasan serta tindak lanjut.	Pencatatan monitoring dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait dalam form yang telah dibuat. PIC akan merekap keseluruhan dan melakukan evaluasi setiap 3 bulan untuk dilaporkan kepada sekretaris KFT dan selanjutnya dilaporkan ke ketua KFT. Hasil monitoring akan dilaporkan ke anggota KFT setiap rapat rutin dan akan dianalisa secara bersama oleh anggota KFT.
	Mutu dan keselamatan pasien: Kontrol mutu angka ketidaklengkapan penulisan resep Memantau ketidakpatuhan Identifikasi pasien Memantau obat tidak	Melakukan audit setiap hari di rawat inap dan rawat jalan terkait : Mutu angka ketidaklengkapan penulisan resep Ketidakpatuhan identifikasi pasien Obat tidak	Audit data mutu dilakukan setiap hari oleh PIC di unit terkait PIC akan merekap keseluruhan dan melakukan analisa setiap bulan untuk dilaporkan kepada kepala Instalasi dan selanjutnya dilaporkan



	diberikan dan diberi informasi oleh perawat dan bidan sebelum tindakan Memantau kejadian salah input e-resep Memantau penulisan advice DPJP tidak terbaca Memantau kejadian obat yang diberikan kepada pasien tanpa dilakukan serah terima Supervisi monitoring efek samping obat yang dilakukan oleh apoteker Monitoring dan evaluasi obat baru	diberikan dan diberi informasi oleh perawat dan bidan sebelum tindakan Kejadian salah input e- resep Penulisan advice DPJP tidak terbaca Obat yang diberikan kepada pasien tanpa dilakukan serah terima Monitoring efek samping obat Monitoring efek samping obat, alergi obat, interaksi obat, dan ROTD dari penggunaan obat baru selama 3 bulan Melakukan pelaporan terkait mutu dan keselamatan pasien ke tim PMKP Pelaporan mutu dan keselamatan pasien dilaporkan kepada anggota KFT setiap rapat rutin 3 bulan sekali dan dilakukan pembahasan serta tindak lanjut	ke tim PMKP. - Hasil data mutu akan dilaporkan ke anggota KFT setiap rapat rutin dan akan dianalisa secara bersama oleh anggota KFT.
--	---	---	---

I. Pelaksanaan Dan Hasil Monitoring Evaluasi

5.1 Aspek Penggunaan Dan Aspek Persediaan Obat

A. Permintaan Obat Diluar Formularium

Keterangan	Standar	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah resep di luar formularium	≥85%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Pada data di atas dijelaskan bahwa hasil rekapan peresepan diluar formularium pada tiap bulan memenuhi standar yang ditentukan	Melakukan monitoring secara rutin terhadap penggunaan obat di RS Prima Husada Sukorejo

B. Ketersediaan Obat

Keterangan	Standar	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Jumlah kekosongan obat	0	25	20	24	21	16	30	23	27	25	5	9	4



No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Pada data di atas dijelaskan bahwa hasil rekapan kekosongn obat pada tahun 2023 belum memenuhi standar yang ditentukan.	- Melakukan monitoring secara rutin terhadap persediaan obat di RS Prima Husada Sukorejo - Melakukan konsultasi kepada DPJP terkait opsi substitusi obat - Melakukan kajian ulang untuk perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan pasien pada periode waktu tertentu

5.2 ASPEK MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

A. Monitoring Efek Samping Obat

Bulan	Standar	Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Kejadian terjadinya efek samping obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Pada data di atas dijelaskan bahwa tidak ada pelaporan MESO pada rekapan monitoring efek samping obat pada tahun 2023	Melakukan monitoring secara rutin selama 3 bulan terhadap efek samping dan keamanan obat baru di RS Prima Husada Sukorejo Melakukan monitoring kejadian efek samping obat pada pasien

B. Kejadian Obat yang Diberikan Kepada Pasien Tanpa Dilakukan Serah Terima

Bulan	Standar	Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Kejadian obat yang diberikan tanpa dilakukan serah terima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Analisis	Tindak Lanjut
1	Pada data di atas dijelaskan bahwa hasil rekapan monitoring penyerahan oleh perawat sudah mencapai standar	Melakukan monitoring secara rutin terhadap proses serah terima obat

C. Kesalahan Peresepan

Keterangan	Standar	Jan	Feb	Mar'	Apr'	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Penulisan advice DPJP tidak terbaca	0	0	0	0	0	0	3	4	3	2	0	0	0

	Analisis	Tindak Lanjut
	Pada data di atas dijelaskan bahwa hasil rekapan monitoring advice DPJP pada triwulan II, masih terdapat kasus advice DPJP yang tidak terbaca dengan jelas	Melakukan monitoring dan konfirmasi kepada DPJP secara rutin pada dokumen rekam medis pasien untuk mencegah <i>medication error</i> akibat ketidakterbacaan tulisan DPJP

D. Kejadian Obat tidak diberikan dan diberi informasi oleh perawat dan bidan sebelum tindakan

Bulan	Standar	Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Kejadian obat tidak diberikan dan tidak diedukasi kepada pasien sebelum tindakan oleh perawat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Analisis	Tindak Lanjut
1.	Pada data di atas dijelaskan bahwa hasil rekapan monitoring kejadian obat tidak diberikan ke pasien sudah memenuhi standar	Melakukan monitoring setiap hari saat visite yaitu tentang pemberian obat kepada pasien oleh perawat untuk mengontrol pengobatan pasien tepat sesuai advice DPJP

E. Ketidakpatuhan identifikasi pasien

Bulan	Standar	Jan'	Feb'	Mar'	Apr'	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
Ketidakpatuhan identifikasi pasien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Analisis	Tindak Lanjut
1.	Pada data di atas dijelaskan bahwa hasil rekapan monitoring kejadian ketidakpatuhan identifikasi pasien sudah memenuhi standar	Melakukan monitoring setiap hari pada semua kegiatan yang membutuhkan identifikasi pasien seperti saat visite apoteker, mengisi dokumen rekam medis pasien, melayani resep dan melakukan KIE obat

II. PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2023

	Aspek Kinerja	Kegiatan	Indikator	Tar get	Keterangan
	SDM	Pembentukan Komite Farmasi dan Terapi	Terbentuk Komite Farmasi dan Terapi	100 %	Sudah terbentuk tim KFT



	Fasilitas	Tersedia ruang Komite Farmasi dan Terapi	Ruang Komite Farmasi dan Terapi tersendiri dan khusus	Ada	Tidak ada, masih gabung dengan ruang komite lain
	Pengembangan Pelayanan	Review Formularium RS 2023	Formularium RS 2023 terupdate	100 %	Formularium 2023 terupdate
		Pelaksanaan Pemberian Informasi Antibiotik Rasional	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik oleh PPRA	100 %	Dilaksanakan rapat triwulan II oleh PPRA
	Kepatuhan Formularium dari aspek penggunaan obat dan aspek persediaan	Monitoring dan evaluasi permintaan obat diluar formularium	Meminimalkan permintaan obat di luar formularium	≤15 %	Tidal Terjadi peresepan di luar formularium
		Monitoring dan evaluasi ketersediaan obat	Meminimalkan kejadian kekosongan obat	0 kasus	Masih terjadi kekosongan obat pada periode tertentu
	Mutu dan Keselamatan Pasien	Kontrol mutu angka ketidaklengkapan penulisan resep	Peresepan resep oleh dokter harus memenuhi persyaratan lengkap secara administrasi, farmasetik, dan klinis	0%	Angka ketidaklengkapan penulisan resep mencapai standar
		Kejadian obat yang diberikan kepada pasien tanpa dilakukan serah terima	Tidak ada kejadian obat diberikan kepada pasien tanpa dilakukan serah terima	0%	Semua obat diberikan kepada pasien dengan proses serah terima
		Penulisan advice DPJP tidak terbaca	Advice DPJP terbaca jelas	0 kasus	Masih ditemukan advice yang tidak bisa di baca oleh beberapa DPJP di rawat inap
		Kejadian salah input e-resep	Tidak ada kejadian salah input e-resep	0%	Masih belum memenuhi target karena Ada kejadian salah input e-resep, yaitu : Apr = 2 resep (0,01%)



		Obat tidak diberikan dan diberi informasi oleh perawat dan bidan sebelum tindakan	Tidak ada kejadian obat diberikan dan diberi informasi oleh perawat dan bidan sebelum tindakan	0 kasus	Semua obat diberikan kepada pasien dengan informasi yang jelas
		Ketidakpatuhan identifikasi pasien	Melakukan identifikasi pasien dengan benar	0%	Semua pasien dilakukan identifikasi dengan benar sebelum melakukan pelayanan kefarmasian
		Monitoring efek samping obat	Kejadian efek samping obat dilaporkan dengan dokumentasi lengkap	0%	Tidak ada kejadian ESO pada tahun 2023
		Monitoring dan evaluasi obat baru	Efek samping obat baru terpantau selama 3 bulan	100%	Ada 4 obat baru yang dilakukan pemantauan pada bulan April – Juni.

3.10. Kinerja Produktifitas Tim Review RM

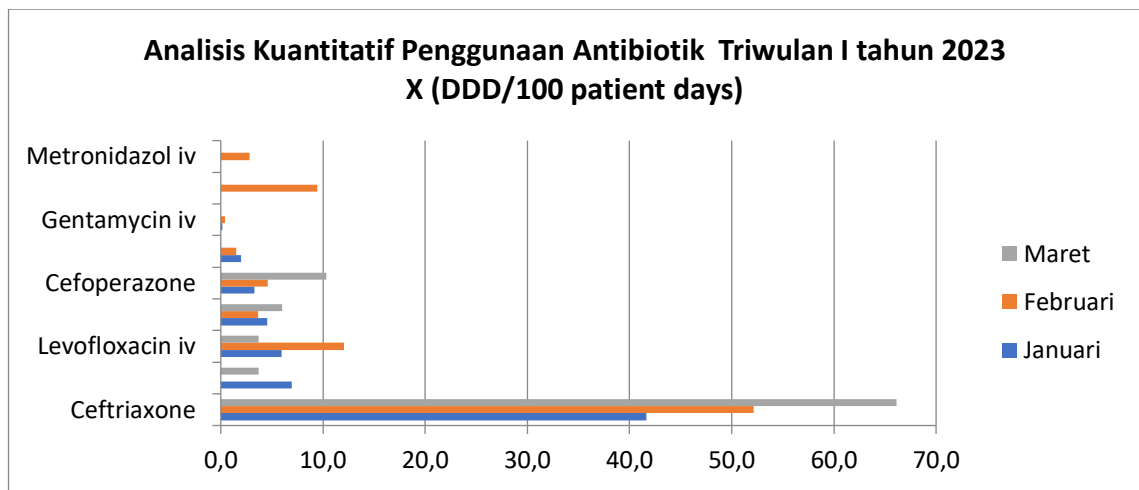
3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA

Kuantitas Penggunaan Antibiotik (DDD)

6.1.1 Kuantitas Penggunaan Antibiotik (DDD) TW I

a. Tabel Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW I Tahun 2023

NO	KODE ATC	NAMA ANTIBIOTIK	BULAN (DDD/100 PATIENT DAYS)		
			JANUARI	FEBRUARI	MARET
1	J01DD04	Ceftriaxone	41,7	52,2	66,1
2	J01DH02	Meropenem	7,0	0,0	3,7
3	J01MA12	Levofloxacin iv	6,0	12,1	3,7
4	J01DD01	Cefotaxim	4,5	3,7	6,0
5	J01DD12	Cefoperazone	3,3	4,6	10,3
6	J01CG01	Ampicillin-Sulbactam	2,0	1,5	0
7	J01GB03	Gentamycin iv	0,1	0,4	0
8	J01MA02P	Ciprofloxacin iv	0,0	9,5	0,0
9	J01XD01	Metronidazol iv	0,0	2,8	0

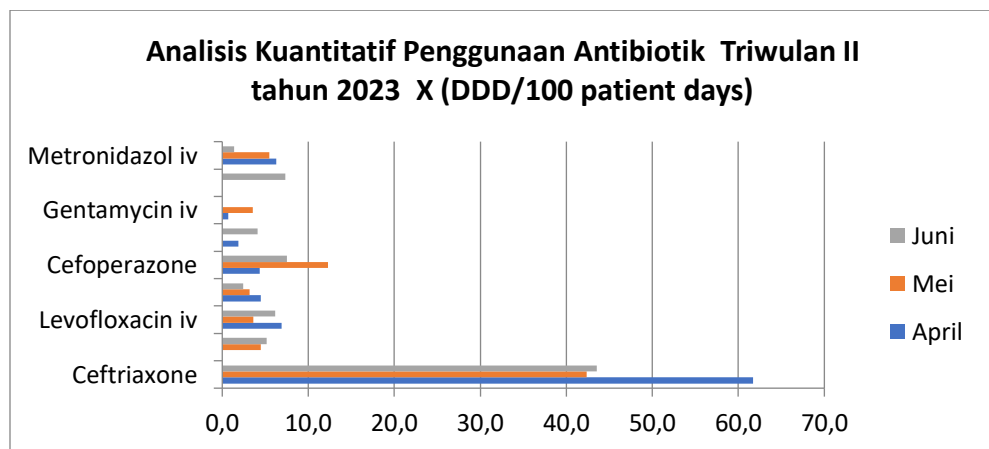


Gambar 6.1 Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW I tahun 2023

6.1.2 Kuantitas Penggunaan Antibiotik (DDD) TW II

a. Tabel Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW II Tahun 2023

NO	KODE ATC	NAMA ANTIBIOTIK	BULAN (DDD/100 PATIENT DAYS)		
			APRIL	MEI	JUNI
1	J01DD04	Ceftriaxone	61,7	42,3	43,6
2	J01DH02	Meropenem	0,0	4,5	5,1
3	J01MA12	Levofloxacin iv	6,9	3,6	6,2
4	J01DD01	Cefotaxim	4,5	3,2	2,5
5	J01DD12	Cefoperazone	4,4	12,3	7,5
6	J01CG01	Ampicillin-Sulbactam	1,9	0,0	4,1
7	JO1GB03	Gentamycin iv	0,7	3,6	0
8	J01MA02P	Ciprofloxacin iv	0,0	0,0	7,3
9	J01XD01	Metronidazol iv	6,3	5,5	1,4



Gambar 6.2 Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW II Tahun 2023

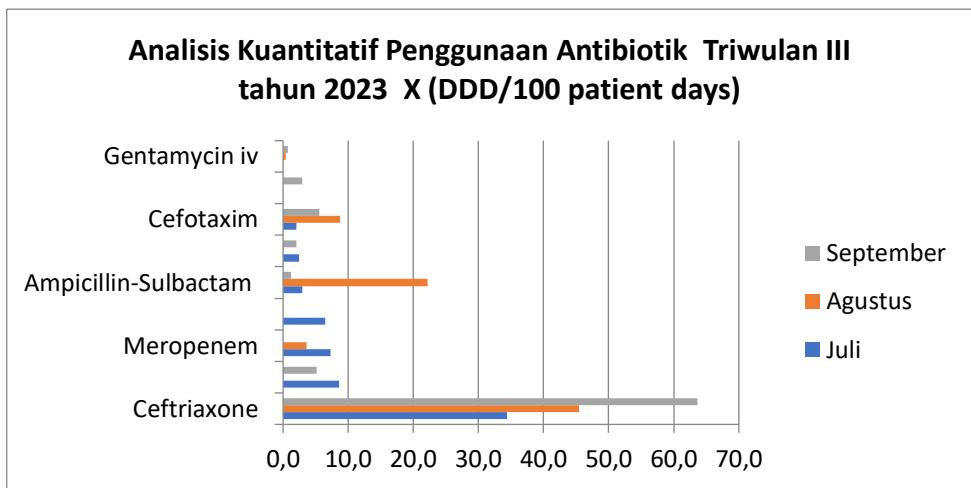
6.1.3 Kuantitas Penggunaan Antibiotik (DDD) TW III

a. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW III Tahun 2023

NO	KODE ATC	NAMA ANTIBIOTIK	BULAN (DDD/100 PATIENT DAYS)		
			JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER
1	J01DD04	Ceftriaxone	34,4	45,5	63,6
2	J01MA02P	Ciprofloxacin iv	8,6	0,0	5,2
3	J01DH02	Meropenem	7,3	3,6	0,0
4	J01DD12	Cefoperazone	6,5	0,0	0,0
5	J01CG01	Ampicillin-Sulbactam	2,9	22,2	1,2



6	J01XD01	Metronidazol iv	2,4	0,0	2,0
7	J01DD01	Cefotaxim	2,1	8,7	5,5
8	J01MA12	Levofloxacin iv	0,0	0,0	2,9
9	JO1GB03	Gentamycin iv	0,0	0,4	0,8

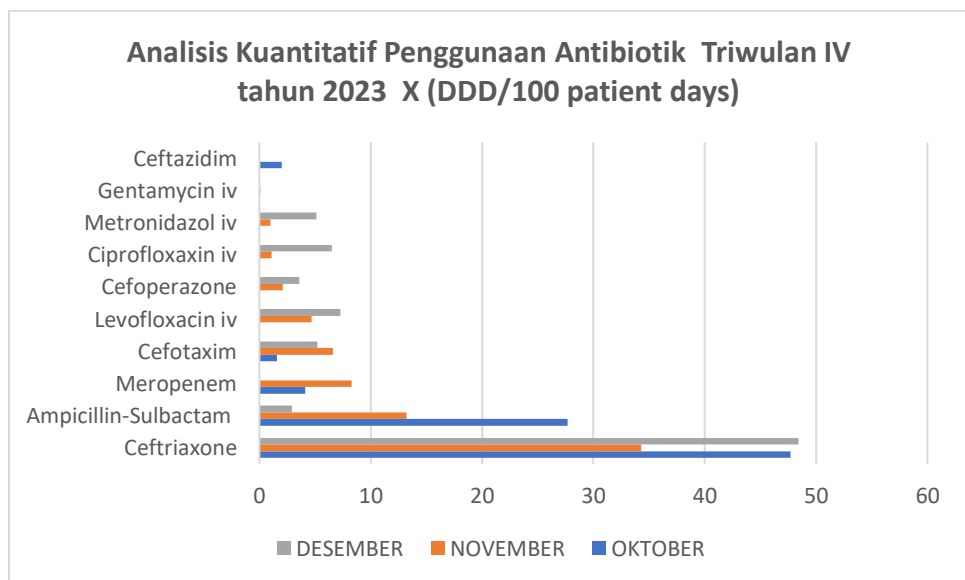


Gambar 6.3 Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW III Tahun 2023

6.1.4 Kuantitas Penggunaan Antibiotik (DDD) TW IV

a. Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW IV Tahun 2023

NO	KODE ATC	NAMA ANTIBIOTIK	BULAN (DDD/100 PATIENT DAYS)		
			OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	J01DD04	Ceftriaxone	47,7	34,3	48,4
2	J01CG01	Ampicillin-Sulbactam	27,7	13,2	2,9
3	J01DH02	Meropenem	4,1	8,3	0,0
4	J01DD01	Cefotaxim	1,6	6,6	5,2
5	J01MA12	Levofloxacin iv	0,0	4,7	7,3
6	J01DD12	Cefoperazone	0,0	2,1	3,6
7	J01MA02P	Ciprofloxacin iv	0,0	1,1	6,5
8	J01XD01	Metronidazol iv	0,0	1,0	5,1
9	JO1GB03	Gentamycin iv	0,0	0,1	0,0
10	J01DD02	Ceftazidim	2,0	0,0	0,0



Gambar 6.4 Grafik Penggunaan Antibiotik secara Kuantitatif pada TW IV Tahun 2023

6.2 Kualitas Penggunaan Antibiotik (Gyssens)

a. Penggunaan Antibiotik secara Kualitatif pada TW I Tahun 2023

No	Kriteria Gyssens	Standar	%		
			Jan	Feb	Mar
1	Katagori 0	≥ 50	83,3	74,2	81,3
2	Katagori 1	0	0	0	0
3	Katagori 2A	0	0	0	0
4	Katagori 2B	0	0	0	0
5	Katagori 2C	0	0	0	0
6	Katagori 3A	0	0	6,5	0
7	Katagori 3B	0	16,7	38,7	21,9
8	Katagori 4A	0	0	0	0
9	Katagori 4B	0	0	0	0
10	Katagori 4C	0	0	0	0
11	Katagori 4D	0	0	0	0
12	Katagori 5	0	3,3	3,2	0
13	Katagori 6	0	0	0	0

b. Penggunaan Antibiotik secara Kualitatif pada TW II Tahun 2023

No	Kriteria Gyssens	Standar	%		
			April	Mei	Juni
1	Katagori 0	≥ 50	83	76	71
2	Katagori 1	0	0	0	0
3	Katagori 2A	0	0	0	0
4	Katagori 2B	0	0	0	0
5	Katagori 2C	0	0	0	0
6	Katagori 3A	0	7	11	3
7	Katagori 3B	0	10	13	26
8	Katagori 4A	0	0	0	0
9	Katagori 4B	0	0	0	0
10	Katagori 4C	0	0	0	0
11	Katagori 4D	0	0	0	0
12	Katagori 5	0	0	0	0
13	Katagori 6	0	0	0	0

c. Penggunaan Antibiotik secara Kualitatif pada TW III Tahun 2023

No	Kriteria Gyssens	Standar	%		
			Juli	Agustus	September
1	Katagori 0	≥ 50	66	97	95
2	Katagori 1	0	0	0	0
3	Katagori 2A	0	0	0	0
4	Katagori 2B	0	0	0	0
5	Katagori 2C	0	0	0	0
6	Katagori 3A	0	0	0	5



7	Katagori 3B	0	34	3	0
8	Katagori 4A	0	0	0	0
9	Katagori 4B	0	0	0	0
10	Katagori 4C	0	0	0	0
11	Katagori 4D	0	0	0	0
12	Katagori 5	0	0	0	0
13	Katagori 6	0	0	0	0

d. Penggunaan Antibiotik secara Kualitatif pada TW IV Tahun 2023

No	Kriteria Gyssens	Standar	%		
			OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
1	Katagori 0	≥ 50	58	81	70
2	Katagori 1	0	0	0	0
3	Katagori 2A	0	0	0	0
4	Katagori 2B	0	0	0	0
5	Katagori 2C	0	0	0	0
6	Katagori 3A	0	0	0	0
7	Katagori 3B	0	42	19	27
8	Katagori 4A	0	0	0	0
9	Katagori 4B	0	0	0	0
10	Katagori 4C	0	0	0	0
11	Katagori 4D	0	0	0	0
12	Katagori 5	0	0	0	3
13	Katagori 6	0	0	0	0

KEGIATAN RUMAH SAKIT UNTUK MENDUKUNG KOMITE PPRA

1. Sosialisasi tentang PPRA
2. Sosialisasi pedoman penggunaan antibiotic
3. Surveilans antibiotik



3.12. Kinerja Produktifitas Komite Keperawatan

1.1.1 Ketenagaan Perawat dan Bidan

a. Berdasarkan Level Klinis

No	Unit	Level Klinis				
		Pra PK	PK 1	PK 2	PK 3	PK 4
1	ICU	0	12	0	0	0
2	IGD	1	24	0	0	0
3	IKO	0	7	4	0	0
4	IRJA	0	21	1	0	0
5	Maternitas	0	14	0	0	0
6	Neonatologi	2	10	1	0	0
7	IRNA 2A	2	18	0	0	0
8	IRNA 2B	4	17	0	0	0
9	IRNA 3A	2	15	0	0	0
10	IRNA 3B	3	13	0	0	0

b. Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Unit	DIII Kep	DIV Kep/Bid	Ners/Bid	S2 Kep
1	ICU	5	0	7	0
2	IGD	14	3	8	0
3	IKO	7	0	4	0
4	IRJA	15	2	5	0
5	Maternitas	4	8	2	0
6	Neonatologi	11	0	3	0
7	IRNA 2A	10	1	9	0
8	IRNA 2B	13	1	7	0
9	IRNA 3A	9	1	7	0
10	IRNA 3B	8	0	8	0

3.1.Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Hasil
1	Pembuatan Perangkat Kerja	a. Membuat program kerja Komite Keperawatan untuk tahun 2024 b. Membuat White Paper Keperawatan c. Merevisi instrument kredensial berdasarkan level jenjang karir dan area keperawatan	Perangkat kerja sudah dilakukan sesuai jadwal
2	Kredensial	a. Mapping staf keperawatan berdasarkan level jenjang karir b. Melakukan Re-Kredensial dan naik tingkat PK c. Melakukan assesmen keperawatan oleh Assesor kompetensi perawat d. Melakukan kredensial berdasarkan hasil assesmen kompetensi perawat	Kredensial staf baru sudah dilakukan sesuai jadwal dan Rencana Re-Kredensial dan Naik tingkat PK
3	Audit Mutu Keperawatan	a. Identifikasi masalah yang terjadi terkait keperawatan b. Analisa masalah c. Tindak lanjut masalah	Masalah Plebitis menurun



4	Audit Etik Keperawatan	a. Identifikasi masalah yang terjadi b. Analisa masalah c. Tindak lanjut masalah	Tidak ada masalah yang terjadi
---	------------------------	--	--------------------------------

3.13. Kinerja Produktifitas Komite Medis

- a. Evaluasi Kinerja Staf
- Evaluasi kinerja staf komite medik dinilai menggunakan OPPE 1 tahun sekali, raport anggota komite medik juga dilakukan untuk pertimbangan perpanjangan SIP.
 - Pada bulan Juli ditemukan pelanggaran oleh dr Farid , Sp.S dengan melakukan peresepan obat Hexadol pada pasien poli syaraf dengan diagnose CVA. Obat tersebut tidak diberikan ke pasien dan digunakan secara pribadi. Tindaklanjut yang dilakukan manajemen rumah sakit adalah melakukan konseling kepada dr farid, merubah status dr Farid Sp.S yang semula home dokter menjadi dokter pelayanan biasa.
 - Tingginya biaya rumah sakit dibanding dengan biaya INACBGS pada pasien BPJS yang disebabkan penggunaan obat dan penunjang tanpa batas oleh semua DPJP sehingga menimbulkan kebijakan rumah sakit dengan munculnya perhitungan proporsi baik pasine rawat jalan dan rawat inap BPJS.

b. Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan	Standart	Target	Hasil	K E T
1	Pelaksanaan E-RM	1. Sosialisasi E-RM pada dokter spesialis 2. Koordinasi dengan programmer 3. Membuat fitur aplikasi E-RM 4. Melakukan trial secara bertahap 5. Melakukan monitoring dan eksekusi apabila ada kendala 6. Melengkapi sarana prasarana yang	100%	Belum memenuhi target 100%, karena pol igigi dan rehab medik masih belum menggunakan ERM	1. Yang sudah melaksanakan E-RM adalah semua dokter per 1 agustus 2023. Kecuali poli rehab medik dan poli gigi 2. Ada beberapa pasien yang di review oleh RM< hasilnya masih ada yang belum connect antara billing IRJA dengan RM dibutuhkan seperti PC, tab , specimen dll	
2	Kredensial dokter baru	1. Menyiapkan berkas kelengkapan kredensial termasuk draft RKK 2. Mengajukan pada ketua	100%	Terpenuhi	Dokter yang melakukan proses kredensial tahun 2023 : 1. dr. Nauval	



		komdik untuk dilakukan kredensial sesuai instruksi direktur 3. Pengisian draft RKK diserahkan bisa softcopy maupun hardcopy 4. Sekomdik mengajukan draft RKK ke Sub Kredensial dan disetujui oleh Ketua Komite Medik 5. Direktur menerbitkan surat penugasan klinis jika RKK sudah ditandatangani oleh sub kredensial dan ketua komdik				
3	Proporsi	Kebijakan PT terkait tarif proporsi dilakukan per September 2023	100%	Sudah terpenuhi	1. Rapat dan diskusi dilakukan oleh PT untuk kedua RS, RPHM dan RSPHS 2. Tarif proporsi dikenakan untuk pasien rawat jalan dan rawat inap 3. Jika ada pasien yang melebihi plafon inacbg's maka DPJP akan dikenakan tarif proporsi, sedangkan jika DPJP melakukan perawatan pada pasien dibawah	



					inacbgs, makan akan surplus 4. Karena banyak DPJP yang tidak puas dengan adanya tarif proporsi, diadakan rapat diskusi baik offline door to door maupun zoom yang dilakukan untuk menjembatani agar kebijakan proporsi dapat diterima dengan bijak 5. Perubahan tarif obat, tindakan maupun ruangan di review ulang oleh PT 6. Diharapkan DPJP dapat bekerjasama dan koordinasi terkait kendala dan solusi dari kebijakan proporsi, agar kebijakan tersebut tetap safety di dpjp maupun pasien	
--	--	--	--	--	--	--

c. Fasilitas

Ruang Komite Medik tersedia di ruang sekre lantai 3. Apabila ada rapat offline dengan kapasitas > 10, maka di fasilitasi di Hall Sakura Lantai 3

d. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan masih layak, sudah pernah dilakukan pengecatan ulang awal tahun 2023. Tersedia meja, kursi, lemari, pigura dan AC beserta berkas-berkas komite medik

e. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

1. Cuti Haji : 1 orang (dr. Farid, Sp.S)
2. Dokter resign : 1 orang (dr. Vanindya Aisyah, SpKFR)

f. Mutu Komite Medis

No	Judul Indikator	Bulan												Std	Rata-rata	Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des			
1	Kepatuhan identifikasi pasien	82,53 %	83,78%	92,06 %	99.08 %	98.23 %	97.99 %	99.49 %	99.34 %	96.69 %	97.43%	97.43%	98.10%	100%	95.18%	Tidak tercapai
2	Waktu Tunggu operasi Seksio Sesarea emergency	93%	88,09%	88,37 %	89.28 %	88.70 %	88.46 %	90.96 %	91.11 %	92.59 %	93.75%	91,11%	96.87%	≥80%	91%	tercapai
3	Waktu Tunggu Rawat Jalan	96,88 %	98,07%	99,53 %	100%	92.45 %	100%	100%	100%	98.75 %	100%	100%	97.05%	≥80%	99.18%	tercapai
4	Penundaan Operasi Elektif	4,38%	4,88%	9,257 %	0.71%	0.83%	1.26%	2.36%	1.74%	0.83%	4.41%	1,12%	1.53%	≤5%	2.4%	tercapai
5	Kepatuhan Waktu Visite Dokter	90.93 %	92.23%	91,62 %	87.21 %	92.70 %	87.90 %	89.38 %	86.05 %	89.95 %	85.19%	64,31%	64.37%	≥80%	83.38%	tercapai
6	Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	≥80%	100%	tercapai
7	Kepatuhan Kebersihan Tangan	83,80 %	74,94%	68,24 %	84%	70%	75%	77.08 %	82%	78%	90%	78%	83%	≥85%	78.67%	Tidak tercapai
8	Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway	66%	61%	62%	87.12 %	85.42 %	-	-	-	66%	93.47%	90%	90.48%	≥80%	90.78%	tercapai
9	Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd)	83%	84,41%	85,36 %	85%	83%	90%	88%	96%	94%	69%	91%	88%	100%	87.81%	Tidak tercapai

Tabel Analisis dan RTL Ketidaktercapainnya Mutu

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan Identifikasi Pasien pada Tahun 2023

Problem	Rata-rata capaian identifikasi pasien pada Tahun 2023 adalah 95.18%, belum mencapai target 100%
Step	Analisa dilakukan setiap bulan untuk identifikasi pasien
Plan	Rencana : mengetahui kepatuhan petugas melakukan identifikasi pasien secara berkesinambungan Harapan : seluruh petugas di unit pelayanan melakukan identifikasi pasien dengan benar menggunakan minimal 2 identitas dari 4 identitas yang dapat digunakan Tindakan : m. melakukan supervisi pada petugas di unit secara berkesinambungan n. melakukan peneguran kepada staff jika masih melakukan proses identifikasi yang salah / tidak melakukan o. koordinasi dengan kepala ruang untuk lebih memantau kinerja dari staff yang tidak melakukan identifikasi dengan benar / tidak melakukan identifikasi p. koordinasi dengan komite sasaran keselamatan pasien untuk terus melakukan supervisi & sosialisasi terkait identifikasi pasien q. Menghimbau dan mengingatkan ke semua staff di unit pelayanan mengenai pentingnya melakukan identifikasi pasien untuk menghindari kesalahan yang mungkin terjadi kepada pasien
Do	Apa pengamatan yang dilakukan ? 3. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 4. Ketepatan waktu dilakukan identifikasi pasien (pemberian produk darah, obat, tindakan, pemeriksaan penunjang, diet)
Study	Apa yang anda pelajari ? Apakah sesuai target capaian ?
	27. Cara mengidentifikasi petugas kepada pasien dengan menggunakan 2 identitas dari 4 identitas yang ditentukan (nama, tgl lahir, nomor RM dan gelang identitas) 28. Waktu dilakukan identifikasi pasien yakni sebelum pemberian obat, pengambilan darah atau specimen lain, pemeriksaan klinis pada pasien, pengobatan atau tindakan kepada pasien belum terkaji secara maksimal 29. Masih ditemukan ketidakpatuhan petugas dalam melakukan identifikasi pasien di Rawat Inap 2A yang masih tidak melakukan identifikasi pasien dengan benar
Action	Apa yang dapat anda simpulkan dari siklus ini ? 3. Rata-rata Kepatuhan identifikasi pasien pada tahun 2023 mencapai 97,43%, grafik tren capaian menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan pada bulan januari sampai bulan April. Kemudian di bulan juni terjadi penurunan capaian disebabkan oleh kurangnya tersupervisi masing-masing unit. Setelah dilakukan sosialisasi terjadi peningkatan dari bulan September sampai bulan desember 4. Mayoritas petugas masih belum mengetahui kapan waktu yang di anjurkan untuk melakukan identifikasi pasien Follow-Up dan Rencana Lanjutan 1. Evaluasi pencapaian pada Bulan berikutnya, monitoring dan supervisi oleh kepala ruang secara rutin. 2. Dilakukan pembentukan kelas-kelas kecil untuk unit yang belum mencapai target sasaran untuk peningkatan pengetahuan petugas 3. Monitoring kepatuhan berdasarkan moment identifikasi pasien

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Meningkatkan pengetahuan petugas mengenai identifikasi pasien	Meningkatkan kepatuhan melakukan identifikasi sesuai moment identifikasi	Tercapaian peningkatan kepatuhan identifikasi pasien di setiap unit meningkat pada capaian bulan berikutnya	Melakukan training in house dengan pembagian kelas kecil (1 kelas minimal 5 petugas), selanjutnya cek lapangan untuk realisasi hasil pelatihan	Ka. Ruangan Tim SKP Mutu	Satu bulan



Tabel PDSA Capaian Kepatuhan kepatuhan kebersihan tangan petugas pada Tahun 2023

Problem	Persentase kepatuhan hand hygiene pada bulan Desember < 85% yakni 78.67%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya kebersihan tangan untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	7. Rencana: Mengetahui kepatuhan hand hygiene secara berkesinambungan 8. Harapan Seluruh staf pelayanan medik melakukan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 9. Tindakan g. Melakukan audit hand hygiene pada pstaf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. h. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang hand hygiene i. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene staf di unit.
Do	Kepatuhan hand hygiene dengan Teknik 6 langkah dan 5 momen sesuai 5 momen
Study	12. kepatuhan hand hygiene bulan Desember 2023 yaitu 83%. 13. kepatuhan terendah adalah IKO dan Irna 3A yaitu sebesar 42% dan 55%, dan kepatuhan tertinggi adalah unit Laboratorium 100%. 14. kepatuhan hand hygiene per profesi tertinggi adalah nakes lain sebesar 80%. 15. kepatuhan hand hygiene berdasarkan 5 momen bulan Desember 2023 terendah adalah momen 1 yaitu sebelum ke pasien sebesar 51% dan tertinggi momen setelah menyentuh cairan pasien sebesar 96%. 16. fasilitas kebersihan tangan bulan Desember 2023 sudah 100% terpenuhi 17. Ditemukannya petugas yang tidak melakukan hand hygiene sebelum menggunakan handscoon. Beberapa titik wastafel ditemukan tidak ada handwash dan handtowel.
Action	13. Review dan evaluasi pelaksanaan pelatihan PPI dasar 14. Kolaborasi dengan kabid terkait monitoring kepatuhan kebersihan tangan 15. Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen. 16. Jika ditemukan petugas yang tidak dapat mempraktikkan kebersihan tangan dengan benar, beri tugas untuk melakukan edukasi kelompok dan dikumpulkan berupa video. 17. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 18. Berikan feedback hasil audit dan monitoring 19. Pemberian teguran saat melakukan supervisi hand hygiene.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksa na	Wak tu
1	Reedukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen.	Meningkatkan kepatuhan petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai SPO (6 langkah 5 moment)	Kepatuhan kebersihan petugas rawat inap sesuai dengan SPO hand hygiene	Sosialisasi SPO hand hygiene di setiap ruangan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
2	Rencanakan pelatihan kebersihan tangan untuk staf baru yang sudah melewati masa training 3 bulan.	Meningkatkan skill petugas baru dalam melakukan kebersihan tangan	Skill petugas dalam melaksanakan cuci tangan sesuai	Pelatihan kebersihan tangan kepada staff baru	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan



			dengan SPO			
3	edukasi SPO hand hygiene berdasarkan 6 langkah sesuai 5 momen.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat rutin dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan kebersihan tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan kebersihan tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi berkala	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

Tabel PDSA Capaian Kepatuhan penggunaan APD pada Tahun 2023

Problem	Persentase kepatuhan penggunaan APD tidak mencapai 100%.
Step	Menghimbau dan mengingatkan ke semua staf di unit mengenai pentingnya penggunaan APD untuk mencegah penularan infeksi atau memutus rantai penularan infeksi yang diperoleh dari kontak dengan pasien maupun lingkungan.
Plan	5. Rencana: Mengetahui kepatuhan penggunaan APD secara berkesinambungan 6. Harapan Seluruh staf pelayanan medik patuh dalam penggunaan APD dengan tepat sehingga target kepatuhan dapat dicapai. 7. Tindakan f. Melakukan audit penggunaan APD pada staf pelayanan medik di unit secara berkesinambungan. g. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi tentang penggunaan APD 8. Koordinasi dengan IPCLN di unit untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan APD staf di unit.
Do	Kepatuhan penggunaan APD meningkat hingga mencapai 100% di bulan berikutnya.
Study	5. Masih ditemukan petugas yang tidak tepat dalam penggunaan masker dan handscoon sesuai indikasi (IRNA). Petugas tidak menggunakan APD yang tepat di area dapur. 6. Ditemukan petugas yang tidak melakukan cuci tangan baik sebelum maupun setelah menggunakan handscoon.
Action	5. Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf. 6. Beri feedback pada hasil temuan. 7. Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk monitoring penggunaan APD di unit. 8. Lakukan audit per nama petugas, koordinasi dengan SDM untuk penilaian kinerja. 9. Beri teguran saat melakukan monitoring penggunaan APD yang tidak sesuai indikasi di unit.

Tabel Rencana Tindak Lanjut

No	Rencana Kegiatan	Tujuan	Sasaran	Strategik	Pelaksana	Waktu
1	Review dan evaluasi hasil pelatihan penggunaan APD pada staf.	Staf dapat melaksanakan penggunaan dan melepaskan APD sesuai langkah dengan indikasinya	Seluruh staf rawat inap dapat melaksanakan penggunaan APD dan pelepasan APD 100% benar	Resosialisasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan



2	Beri feedback pada hasil temuan.	Ruangan dapat mengetahui apa yang harus diperbaiki	All ruangan yang di audit	Pemberian feedback	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
3	Kolaborasi dengan komite keperawatan untuk review kebatuhan penggunaan APD tangan di setiap pelatihan KDPK.	Menjalin koordinasi secara kesinambungan antar komite	Komite keperawatan dapat ikut serta dalam pemantauan kebersihan utamanya perawat	Rapat dengan komite keperawatan	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan
4	Lakukan monitoring evaluasi kepatuhan di setiap briefing.	Memastikan bahwa kepatuhan APD tangan sudah dilakukan	All petugas melaksanakan penggunaan APD tangan sesuai moment dan langkahnya	Monitoring dan evaluasi	Ka. Ruang Tim IPCLN	Satu bulan

g. EVALUASI JADWAL KEGIATAN KOMITE

Jadwal kegiatan Komite Medik adalah :

No	Kegiatan	Pemenuhan*
1	Rapat rutin tiap bulan	Rapat koordinasi by WA dan Zoom meeting

3.14 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kes lain

Selama Tahun 2023 Komite Kesehatan Lain tidak berjalan dikarenakan ketidakpahaman anggota terkait jobdesc Komite Tenaga Kesehatan Lain di Rumah Sakit, untuk tahun 2024 akan dilakukan perubahan anggota serta sosialisasi kembali mengenai jobdesc dari komite.

BAB IV

KINERJA KEUANGAN

4.1 PENDAPATAN TAHUN 2023 (Tarif RS)

No	Jaminan	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER		TOTAL PENDAPATAN	
		RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI	RJ	RI
1	Umum	379.778.951	707.828.312	307.089.303	333.799.458	346.574.151	576.236.166	253.676.339	320.364.960	342.294.293	334.844.433	313.354.908	395.932.782	341.756.346	352.897.380	346.214.295	552.391.727	350.042.427	552.391.727	363.353.321	338.856.991	371.990.688	367.699.465	372.122.859	399.449.042	4.088.247.882	5.232.692.443
2	BPJS Kes	2.294.071.420	7.015.361.852	2.216.459.419	6.865.497.489	2.431.381.983	7.274.700.187	1.831.105.694	6.667.266.596	2.691.156.243	8.473.937.375	2.500.821.969	7.646.243.996	2.613.805.732	7.228.166.281	2.822.282.256	6.957.984.997	2.309.426.555	6.957.984.997	2.507.272.781	7.217.165.768	2.404.932.963	7.519.256.002	2.194.539.251	7.222.319.385	28.817.256.266	87.045.884.925
3	Obat Kronis	875.359.292	-	874.566.677	-	983.765.652	-	856.649.271	-	1.131.043.736	-	1.150.611.803	-	1.296.742.723	-	-	1.507.119.518	-	839.550.677	-	899.437.313	-	848.834.489	-	715.619.112	7.168.739.154	4.810.561.109
4	Lupis	-	23.973.436	-	28.387.672	-	25.606.904	-	29.610.336	-	28.361.440	-	34.916.804	-	37.250.636	-	40.061.561	-	53.805.864	-	44.504.820	-	40.128.189	-	-	-	386.607.662
5	BPJSTK	39.296.458	228.913.308	25.961.068	328.728.372	28.318.167	224.815.881	16.406.859	310.237.271	25.159.087	77.205.715	23.892.882	230.848.314	28.854.508	262.134.729	40.248.891	387.109.426	49.739.221	387.109.426	35.309.979	478.268.268	39.880.639	369.548.178	208.657.244	455.403.605	561.725.001	3.740.322.493
6	Jasa Raharja	-	187.968.037	-	237.001.514	-	396.298.008	-	325.831.837	4.392.650	324.988.953	4.539.763	287.641.786	7.922.609	170.400.839	6.524.971	135.136.412	2.132.549	135.136.412	1.189.144	122.225.233	5.035.053	132.195.166	4.253.998	307.147.952	35.990.736	2.761.972.150
7	Kemenkes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Asuransi swasta admedika	27.687.863	75.134.591	28.527.587	119.580.270	38.069.254	37.774.299	18.200.546	44.573.799	25.716.518	32.253.972	29.509.603	68.059.250	36.367.342	154.401.107	41.535.488	142.497.920	45.515.974	142.497.920	56.373.938	100.629.710	45.570.508	96.138.429	49.896.226	76.309.564	442.970.848	1.089.850.831
9	Asuransi Swasta	48.714.735	268.459.999	33.704.689	144.533.480	44.737.473	211.291.839	46.874.859	116.893.217	81.679.228	165.815.528	63.799.400	259.394.727	36.321.362	170.400.839	29.143.831	190.392.289	35.763.542	190.392.289	48.730.502	255.999.823	47.571.576	154.541.950	50.417.382	116.850.133	567.458.580	2.244.966.112
10	Perusahaan	14.625.416	114.766.726	2.517.845	127.568.223	43.614.780	165.636.457	4.761.120	52.329.777	-	51.003.510	26.242.127	136.883.058	11.958.158	79.780.319	3.953.950	177.099.147	19.453.457	177.099.147	8.609.655	179.525.058	19.088.565	178.444.718	19.300.817	254.983.593	174.125.890	1.695.119.732
Total		3.679.534.135	8.622.406.260	3.488.826.589	8.185.096.477	3.916.461.460	8.912.359.740	3.027.674.686	7.867.107.793	4.301.441.754	9.488.410.926	4.112.772.455	9.059.920.717	4.373.728.779	8.455.432.129	3.289.903.682	10.089.792.997	2.812.073.727	9.435.968.459	3.020.839.320	9.636.612.984	2.934.069.991	9.706.786.586	2.899.187.778	9.548.082.386	41.856.514.357	109.007.977.455

Analisa :

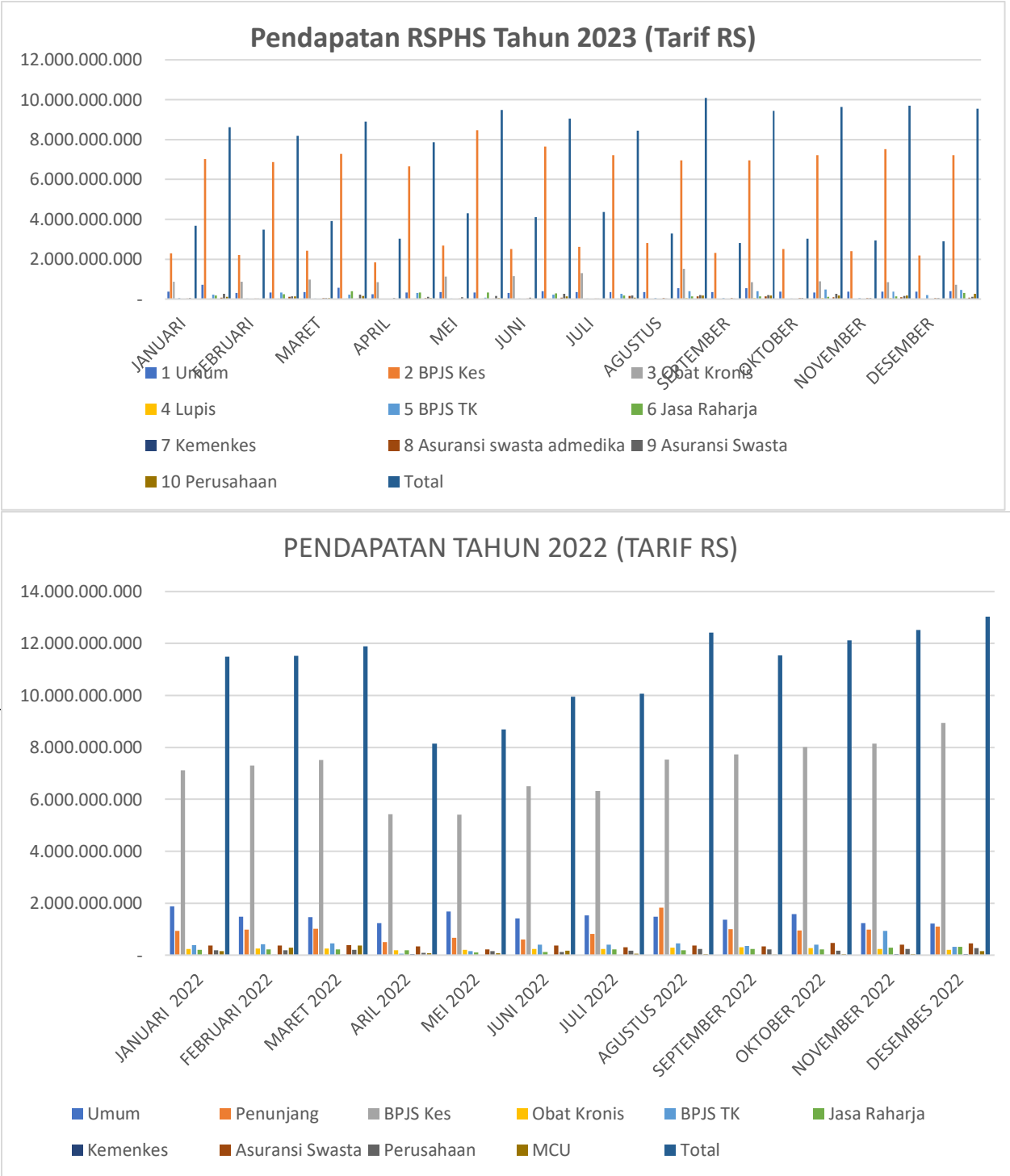
- Pendapatan terbesar RS Prima Husada Sukorejo 77% adalah BPJS Kesehatan termasuk obat kronis yang ditagihkan terpisah dari regular (rawat inap dan rawat jalan).
- Pendapatan umum memiliki proporsi 6,1 % termasuk pemeriksaan penunjang dan termasuk jasa dokter.
- Pendapatan BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2,8%, terdapat klaim periode januari – agustus 2023 yang belum terbayarkan (ada hold payment dari pusat).
- Pendapatan lainnya adalah Jasa Raharja 2% yang memiliki tingkat pembayaran paling lancar dari asuransi lainnya.
- Pendapatan asuransi swasta sebesar 2,8% dan perusahaan sebesar 1,2%, untuk penagihan di lakukan setiap minggu dalam 1 bulan.

PENDAPATAN	TOTAL	PROSENTASE
Obat - obatan	39.313.157.517	34,81%
Laboratorium	8.252.112.503	7,31%
Radiologi	5.459.335.720	4,83%
IKO	57.881.209.601	51,25%
MCU	794.970.869	0,70%
Ambulance	153.762.913	0,14%
Home Care	-	0,00%
Parkir	984.454.000	0,87%
Sewa ATM	13.270.432	0,01%
Lain - Lain	87.219.737	0,08%
GRAND TOTAL		100,0%

Analisa :

1. Pendapatan terbesar RS Prima Husada Sukorejo adalah IKO dengan presentase 51%.
2. Pendapatan terbesar berikutnya adalah obat obatan/farmasi dengan nilai presentase 34%
3. Berikutnya adalah Laboratorium memiliki nilai presentase 7%, radiologi 4%
4. MCU memiliki nilai presentase 0.70%
5. Pendapatan parker memiliki nilai presentase 0.87%
6. Biaya sewa ATM memiliki nilai presentase 0.01%
7. Biaya lain lain merupakan pendapatan yang terekap di setoran kasir memiliki nilai presentase 0.08%

4.2 Grafik pendapatan Tahun 2023 RS Prima Husada Sukorejo



- Analisa :
1. Terdapat kenaikan pendapatan sebesar 12% dari tahun sebelumnya 2022.
 2. Perbedaan yang terlihat dari grafik tahun 2022 dan 2023 adalah, pada bulan desember tahun 2023 terdapat penurunan pasien

4.3 KINERJA PIUTANG RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Nama Asuransi	Total Tagihan 2023	Pembayaran tahun 2023	Sisa Piutang
A.J CENTRAL ASIA RAYA (CAR)	42.878.449	22.240.979	20.637.469
ASURANSI AIA FINANCIAL - ADMEDIKA	2.029.387	1.410.968	618.419
ASURANSI ALLIANZ - ADMEDIKA	13.983.617	2.406.137	11.577.480
ASURANSI BRINGIN LIFE - ADMEDIKA	2.646.979	2.646.979	-
ASURANSI HANWHA LIFE - ADMEDIKA	25.649.565	4.365.484	21.284.081
ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA - ADMEDIKA	149.022.763	68.992.171	80.030.592
ASURANSI PACIFIC CROSS - ADMEDIKA	105.198	-	105.198



ASURANSI RELIANCE - ADMEDIKA	14.154.201	3.718.517	10.435.685
AVRIST ASSURANCE - ADMEDIKA	28.358.180	4.106.292	24.251.888
CAR - ADMEDIKA	193.173	193.173	-
EQUITY LIFE INDONESIA - ADMEDIKA	5.787.750	-	5.787.750
FWD - ADMEDIKA	1.832.960	330.472	1.502.488
KLINIK RAMA MEDIKA	219.000	219.000	-
MANDIRI INHEALTH	70.902.774	28.042.156	42.860.619
MANDIRI INHEALTH INDEMNITY	24.412.271	2.392.336	22.019.935
MANDIRI INHEALTH OBAT RI	5.876.785	4.669.397	1.207.388
MANDIRI INHEALTH OBAT RJ	12.911.010	3.992.832	8.918.178
MEDIKA PLAZA (PT KARTIKA BINA MEDIKATAMA)	200.000	200.000	-
OWLEXA HEALTHCARE - PT. APLIKANUSA LINTASARTA	1.437.317	1.437.317	-
PETROCHINA-SKKMIGAS ADMEDIKA	127.754	127.754	-
PLN PUSDIKLAT - UIT JBTB 1	241.016	241.016	-
PT ANDALAN FLUID SISTEM	667.000	-	667.000
PT ASURANSI JIWA ASTRA- ADMEDIKA	6.260.740	5.116.173	1.144.567
PT ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL (PLN INSURANCE) ADMEDIKA	13.635.303	12.115.762	1.519.541
PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA	88.722.275	50.360.863	38.361.412
PT ATOMIZATION TEKNOLOGI INDONESIA	32.377.202	32.377.202	-
PT Behaestex Pandaan	426.930	-	426.930
PT BIO FARMA (Persero)	11.791.000	-	11.791.000
PT CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA (CMWI)	21.899.347	8.349.366	13.549.981
PT NAYAKA ERA HUSADA	1.265.269	480.430	784.839
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE	56.674.958	-	56.674.958
PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO - LOTUS PROJECT	5.431.560	-	5.431.560
PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO - PLANT	5.844.680	-	5.844.680
PT TASPEN	179.000	-	179.000
PT. ANEKA TUNA INDONESIA	895.515	620.915	274.600
PT. APLN (ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL) - PUSDIKLAT	16.734.345	8.349.279	8.385.065
PT. APLN (ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL) - UID JABAR	758.598	758.598	-
PT. APLN (ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL) - UID JATIM	16.104.870	10.316.245	5.788.625
PT. APLN (ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL) - UID SULUTTENGGO	270.984	270.984	-
PT. APLN (ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL) - UIT JBB	811.973	-	811.973
PT. APLN (ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL) - UIT JBTB	3.122.609	637.095	2.485.514
PT. APLN (ASURANSI PERISAI LISTRIK NASIONAL) - UIW SULSELBAR	596.476	345.880	250.596
PT. ASABRI (PERSERO)	28.855.994	28.855.994	-



PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA	7.923.544	-	7.923.544
PT. ASURANSI JIWA GENERALI INDONESIA	550.000	-	550.000
PT. Cargill Indonesia	275.000	-	275.000
PT. CENTRAL MOTOR WHEEL INDONESIA	14.118.000	-	14.118.000
PT. CIMORY HOSPITALITY SEJAHTERA (PRIGEN)	99.000	-	99.000
PT. COMETA CAN METAL PRINTING AND CAN MAKING	458.000	-	458.000
PT. CS2 POLA SEHAT	4.270.751	4.270.751	-
PT. DISA PRIMA MEDIKA	34.358.596	21.524.823	12.833.774
PT. EASTERNTEX	73.000	-	73.000
PT. FULLERTON HEALTH INDONESIA	18.438.062	6.885.183	11.552.879
PT. GARDA MEDIKA	6.895.916	336.946	6.558.970
PT. HM. SAMPOERNA	326.174.630	115.712.693	210.461.937
PT. INFOMEDIA SOLUSI HUMANIKA (ISH) - ADMEDIKA	653.235	653.235	-
PT. ISS INDONESIA	730.000	-	730.000
PT. JAPFA COMFEED INDONESIA	1.137.500	487.500	650.000
PT. JASA RAHARJA	289.944.128	29.428.220	260.515.908
PT. JATIM AUTOCOMP INDONESIA (JAI)	21.396.687	19.887.038	1.509.649
PT. KARTIKA BINA MEDIKATAMA (MEDIKA PLAZA) BELTWAY OFFICE PARK, ANNEX BUILDING	275.000	-	275.000
PT. LIPPO GENERAL INSURANCE,Tbk	86.064.854	75.925.129	10.139.726
PT. MITRA TATA KERJA	89.500	-	89.500
PT. NAYAKA ERA HUSADA	275.000	-	275.000
PT. NESTLE INDONESIA - GEMPOL DC	275.000	-	275.000
PT. NPR Manufacturing Indonesia	706.350	-	706.350
PT. PANVERTA PANDAAN	8.880.000	8.880.000	-
PT. RAPID PLAST INDONESIA – PLANT 4	4.940.750	-	4.940.750
PT. SINTESIS SELARAS SINERGI	825.000	-	825.000
PT. SORINI AGRO ASIA CORPORINDO - PLANT	1.375.000	-	1.375.000
PT. SUPRA ALUMINIUM INDUSTRI	262.900	262.900	-
PT. TOTAL FIRE INDONESIA	297.000	-	297.000
PT. Uniplastindo Interbuana	508.000	-	508.000
PT. WISATA SAPTA PESONA	73.000	-	73.000
PT. YADIN (YANMAR DIESEL INDONESIA) - DEPOK	312.000	-	312.000
PT. YAMAHA MUSICAL PRODUCTS INDONESIA	890.000	-	890.000
PT. Yamaha Musical Products Indonesia (YMPI)	18.290.500	14.826.000	3.464.500
SMA Advent (SMA ADVENT)	1.696.589	-	1.696.589

TAMAN SAFARI INDONESIA 2	67.772.133	52.438.000	15.334.133
Grand Total	1.637.601.400	662.206.183	975.395.217

NAMA PERUSAHAAN	Total Tagihan	Jumlah Bayar	SISA PIUTANG
BPJS KETENAGAKERJAAN	1.972.895.016	421.024.880	1.551.870.136

Analisa Progress Piutang :

1. Rata rata penambahan nilai piutang RS Prima Husada Sukorejo sebesar 1.3 M setiap bulan untuk non BPJS Kesehatan.
2. Jumlah piutang asuransi dan perusahaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 975.395.217
3. Jumlah piutang BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2023 Rp. 1.551.870.136
4. Jumlah piutang periode desember 2023 adalah Rp. 2.527.265.465

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELANCARAN PEMBAYARAN PIUTANG

1. Kelengkapan Berkas Tagihan baik dari Rekam Medis maupun kelengkapan dari perusahaan rekanan khusus tagihan BPJS Ketenagakerjaan. Piutang per periode januari – agustus 2023 ada hold pembayaran dari pusat BPJS Ketenagakerjaan.
2. Ketepatan Waktu pengiriman berkas tagihan sesuai MOU/PKS antara Asuransi& Perusahaan dengan Fasilitas Kesehatan.
3. Kesesuaian antara PKS dengan Fasilitas yang diberikan kepada pihak customer asuransi (Pasien) dengan PKS yang sudah disepakati. Dalam hal ini Kesesuaian Hak Kelas pasien & Tarif Pelayanan.
4. Adanya Kontrol berlanjut dan berjenjang dari unit awal pasien masuk (Pendaftaran) → Poliklinik&IGD → Rawat Inap → Unit Penunjang → Kasir → Asuransi Center → Keuangan di Fasilitas Kesehatan.
5. Kesesuaian Pre admission dengan Tagihan Klaim.
6. Adanya kontrol secara berlanjut terhadap pembukuan piutang.
7. Faktor Eksternal yakni kesanggupan pembayaran oleh pihak rekanan asuransi & Perusahaan.

4.4 FPK ATAS TAGIHAN BPJS KESEHATAN RS PRIMA HUSADA SUKOREJO TAHUN 2023

Jenis Pelayanan		Bulan Pelayanan	Nilai FPK	Tgl FPK	Tgl Bayar
Januari	RJ	Januari	1.930.278.100	02/06/2023	21/2/2023
Januari	RI		4.656.104.400	02/06/2023	21/2/2023
PENDING KE 1	RJ		-	-	-
PENDING KE 1	RI		185.732.700	28/3/2023	04/07/2023
PENDING KE 2	RJ		-	-	-
PENDING KE 2	RI		59.486.400	29/5/2023	06/06/2023
Apotek Online			332.403.251	20/5/20223	25/5/2023
Alkes			2.870.000	02/06/2023	17/2/2023
Ambulance			23.973.436	02/06/2023	17/2/2023
Februari	RJ	Februari	1.934.039.100	03/06/2023	19/3/2023
Februari	RI		4.617.304.900	03/06/2023	19/3/2023
PENDING KE 1	RJ		-	-	-
PENDING KE 1	RI		283.482.000	29/5/2023	06/06/2023
PENDING KE 2	RJ		-		-
PENDING KE 2	RI		4.796.800	27/6/2023	07/09/2023
Apotek Online			317.885.870	15 juni 2023	21/6/2023
Alkes			5.005.000	03/06/2023	18/3/2023
Ambulance			28.387.672	03/06/2023	18/3/2023
Maret	RJ	Maret	2.134.602.500	04/06/2023	13/4/2023
Maret	RI		5.062.142.800	04/06/2023	13/4/2023



PENDING KE 1	RJ		201.000	29/5/2023	06/06/2023
PENDING KE 1	RI		619.456.632	29/5/2023	06/06/2023
PENDING KE 2	RJ		-	-	-
PENDING KE 2	RI		111.328.100	27/6/2023	07/09/2023
PENDING KE 3	RJ		-	-	-
PENDING KE 3	RI		192.400	19/9/2023	24/9/2023
Apotek Online			344.127.724	14/7/2023	24/7/2023
Alkes			5.005.000	04/06/2023	13/4/2023
Ambulance			25.606.904	04/06/2023	13/4/2023
April	RJ	April	1.581.876.100	05/06/2023	22/5/2023
April	RI		4.611.480.900	05/06/2023	22/5/2023
PENDING KE 1	RJ		301.400	27/6/2023	07/09/2023
PENDING KE 1	RI		430.292.700	27/6/2023	07/09/2023
PENDING KE 2	RJ		-	-	-
PENDING KE 2	RI		75.485.062	28/7/2023	08/08/2023
PENDING KE 2	RJ		-	-	-
PENDING KE 2	RI		27.749.500	19/9/2023	21/9/2023
Apotek Online			304.641.906	20/9/2023	25/9/2023
Alkes			3.850.000	05/06/2023	22/5/2023
Ambulance			29.610.336	05/06/2023	22/5/2023
MEI	RJ	MEI	2.354.993.600	06/06/2023	19/6/2023
MEI	RI		5.892.833.800	06/06/2023	19/6/2023
PENDING KE 1	RJ		196.100	28/7/2023	08/08/2023
PENDING KE 1	RI		381.079.388	28/7/2023	08/08/2023
PENDING KE 2	RJ		-	-	-
PENDING KE 2	RI		132.446.400	08/09/2023	21/9/2023
Apotek Online			387.227.707	16/10/2023	26/10/2023
Alkes			5.005.000	06/06/2023	15/6/2023
Ambulance			28.361.440	06/06/2023	15/6/2023
JUNI	RJ	JUNI	2.127.869.900	07/10/2023	17/7/2023
JUNI	RI		5.408.354.400	07/10/2023	17/7/2023
PENDING KE 1	RJ		-		
PENDING KE 1	RI		391.172.700	28/7/2023	08/08/2023
PENDING KE 2	RJ		-	-	-
PENDING KE 2	RI		221.973.300	19/9/2023	21/9/2023
Apotek Online			382.865.180	11/09/2023	16/11/2023
Alkes			5.775.000	07/10/2023	17/7/2023
Ambulance			34.916.804	07/10/2023	17/7/2023
JULI	RJ	JULI	2.241.421.200	08/08/2023	20/8/2023
JULI	RI		5.436.009.900	08/10/2023	20/8/2023
PENDING KE 1	RJ		196.100	19/9/2023	21/9/2023
PENDING KE 1	RI		448.412.051	19/9/2023	21/9/2023
PENDING KE 2	RJ		-		
PENDING KE 2	RI		21.069.300	30/10/2023	11/09/2023
Apotek Online			395.421.413	12/01/2023	12/07/2023
Alkes			5.940.000	03/07/2023	16/8/2023
Ambulance			37.250.636	08/07/2023	16/8/2023
AGUSTUS	RJ	AGUSTUS	2.372.220.100	09/08/2023	17/9/2023
AGUSTUS	RI		6.002.074.400	09/08/2023	17/9/2023
PENDING KE 1	RJ		196.100	30/10/2023	11/09/2023
PENDING KE 1	RI		350.279.500	30/10/2023	11/09/2023
Apotek Online					
Alkes			2.695.000	09/08/2023	14/9/2023
Ambulance			40.061.561	09/08/2023	14/9/2023
SEPTEMBER	RJ	SEPTEMBER	2.216.093.300	10/09/2023	19/10/2023



SEPTEMBER	RI		6.401.780.700	10/09/2023	19/10/2023
PENDING KE 1	RJ		-		
PENDING KE 1	RI		458.394.100	12/01/2023	12/12/2023
Apotek Online					
Alkes			2.863.000	10/09/2023	16/10/2023
Ambulance			53.805.864	10/09/2023	16/10/2023
OKTOBER	RJ	OKTOBER	2.348.752.700	11/10/2023	22/11/2023
OKTOBER	RI		6.670.831.600	11/10/2023	22/11/2023
Apotek Online					
Alkes			4.620.000	12/01/2023	12/11/2023
Ambulance			44.504.820	11/10/2023	22/11/2023
NOVEMBER	RJ	NOVEMBER	2.361.591.900		
NOVEMBER	RI		7.070.720.500		
Apotek Online					
Alkes			3.465.000	12/12/2023	
Ambulance			40.128.189	12/12/2023	

(Apotek online untuk periode bulan agustus – desember 2023, belum terselesaikan. Data klaim pending bulan desember juga belum terselesaikan dari asuransi center).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

1. Terjadinya peningkatan kunjungan yang signifikan pada seluruh bidang pelayanan yang berdampak pada peningkatan pendapatan di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo
2. Adanya peningkatan pemahaman mutu pada setiap unit dan kesadaran dalam pelaporannya
3. Adanya pengembangan pelayanan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat

1.2 Saran

1. Dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan harus diimbangi dengan supervise berjenjang dan bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku agar dapat memberikan pelayanan yang terstandart akreditasi
2. Peningkatan supervise pelaksanaan mutu dan diimbangi dengan fasilitas secara digital melalui SIMRS agar lebih memudahkan unit dalam pelaksanaanya
3. Pengembangan pelayanan perlu diimbangi dengan monitoring dan supervisi manajemen agar dapat berjalan sesuai standart.



BAB VI PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami buat sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo pada tahun 2023, peningkatan kunjungan di tahun 2023 menunjukkan RSPH mampu bersaing dan tetap menjadi pilihan bagi masyarakat. Namun masih ada beberapa target yang belum tercapai sesuai standard namun upaya selalu kami lakukan secara terus menerus. Perbaikan dan pengembangan pelayanan akan terus kami lakukan seoptimal mungkin untuk pemenuhan pelayanan sesuai standart di 2024.

Pasuruan, 01 Januari 2024
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS